



**GUÍA DE MANEJO PARA EL
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y PALIACIÓN DEL
CÁNCER DE COLON Y RECTO,
ADAPTADA A LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA**

CALI - COLOMBIA

**GUÍA DE MANEJO PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y PALIACIÓN DEL CÁNCER DE
COLON Y RECTO, ADAPTADA A LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA**

AVISO

Se debe valorar la pertinencia de los conocimientos científicos publicados en cualquier libro sobre salud y práctica clínica. Quien use esta obra debe consultar diferentes fuentes de información para tener la seguridad de que sus decisiones contengan actualizaciones sobre cambios en procedimientos, indicaciones y contraindicaciones, o inclusión de nuevas tecnologías. Por tanto, es el lector (no los autores ni el editor) el responsable del uso de la información aquí publicada y de los resultados que obtenga de ella.

**GUÍA DE MANEJO PARA EL DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y PALIACIÓN
DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, ADAPTADA
A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA**

Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca

Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali

Centro Médico Imbanaco

Clínica de Occidente

Fundación Valle del Lili

Hemato Oncólogos SA

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E

Con el apoyo y asesoría de:
City Cancer Challenge Foundation

GRUPO DESARROLLADOR DE LA GUÍA

EXPERTOS CLÍNICOS

*Pedro Arguello
Cirujano gastrointestinal
Fundación Valle del Lili*

*Sandra Avendaño
Coloproctóloga
Hemato Oncologos SA - Centro Médico
Imbanaco*

*Ana Cristina Avendaño
Oncóloga clínica
Hemato Oncologos SA - Centro Médico
Imbanaco*

*Juan Carlos Bravo
Patólogo
Fundación Valle del Lili*

*Carlos Buelvas
Oncólogo radioterápico
Fundación Valle del Lili*

*Frank Carrera-Gil
Nutricionista, MSc
Fundación Valle del Lili*

*Rodrigo Cárdenas
Médico nuclear
Centro Médico Imbanaco – Clínica de
Occidente*

*Juliana Escobar
Patóloga
Fundación Valle del Lili*

*Gabriel Marín
Oncólogo radioterápico
Fundación Valle del Lili*

*Juan Fernando Medina
Cirujano coloproctólogo
Clínica de Occidente*

*Andrés Monroy
Cirujano coloproctólogo
Clínica de Occidente*

*María Claudia Moreno
Patóloga
Hemato Oncologos SA – Hospital
Universitario del Valle*

*Juan Manuel Muñoz Acosta
Médico nuclear
Centro Médico Imbanaco*

*Alexander Obando
Coloproctólogo
Fundación Valle del Lili*

*Eduardo José Ortiz Hormaza
Radiólogo, fellow en imágenes
en oncología
Fundación Valle del Lili*

*Luz Maritza Pabón Castilla
Médica nuclear
Fundación Valle del Lili*

*Juan Carlos Quesada
Hemato-oncólogo
Hospital Universitario del Valle*

*Eliana Rojas
Gastroenteróloga
Fundación Valle del Lili*

*Oscar Rojas
Cirujano gastrointestinal
Fundación Valle del Lili*

Angela Regina Zambrano Harvey
Hemato-Oncóloga
Fundación Valle del Lili

EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS

Julián Agudelo Jiménez
Médico familiar, Especialista
en Cuidados Paliativos
Clínica de Occidente

Carlos Chavarro
Médico familiar, Especialista
en Cuidados Paliativos
Fundación Valle del Lili

Diego Villegas
Especialista en Cuidados Paliativos,
Magíster en epidemiología
Hemato Oncólogos SA

EQUIPO DE ENFERMERÍA

María Angélica Daza
Enfermería, Especialista en Oncología,
MSC Epidemiología
Clínica de Occidente

Yaira Gil
Enfermera
Fundación Valle del Lili

Hilda Mary Gómez Herrera
Enfermera, Especialista en Administración
Hospital Universitario del Valle

Viviana Linares
Enfermera

Marcela Melo
Enfermera, MSc Epidemiología
Medicips

Vivian Carolina Piedrahita
Enfermera, Especialista en Oncología,
MSc Epidemiología
Fundación POHEMA

REVISIÓN INTERNACIONAL

Eloy Espín
Surgery - Val'd Hebron (Barcelona, España)

Francisca Redondo
Nuclear medicine - Instituto Oncológico
Fundación Arturo López Pérez (Chile).

Higinia Cárdenas
Radiotherapy - Weill Cornell
Medical College (EUA)

Luz Esperanza Ayala
Nursing - International Society of Nursing
in Cancer Care

Mike Cusnir
Systemic treatment) - Mount
Sinai, (Miami, EUA)

Paola Ruiz
Supportive and palliative care – Asociación
Latinoamericana de Cuidados Paliativos
ALCP

Pepe Jessurun
Pathology – Cornell (EUA)

ASESOR METODOLÓGICO

*Francisco Antonio Escobar Aguilón
Médico, candidato a Magister en Salud Pública
ProPacífico*

*Jairo Celis
Representante EAPB Comfenalco Valle*

*Ximena Piedrahita
Representante EAPB Comfenalco Valle*

COLABORADORES ESPECIALES

*Daniel Echeverri
Director de Salud, MD, MSc Epidemiólogo
ProPacífico*

*Jhon Bolaños
Representante EAPB Coomeva*

*Margarita Castro
Representante EAPB Coomeva*

*Julieth Andrea López Arias
Consultor Senior C/Can, Medico Magister
en Derecho Medico
ProPacífico*

*Leidy Delgado
Representante EAPB Emssanar*

*Ileana de la Espriella
Representante EAPB Servicio Occidental
de Salud*

*Johan Sebastián Loaiza
Consultor Proyecto de Salud
ProPacífico*

*Haiberth Giovanni Muñoz
Experto en gestión de riesgo en cáncer*

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos todo el apoyo y la contribución de los expertos temáticos durante el desarrollo de la presente guía, por su activa participación y constante compromiso en las reuniones de socialización y debate, así como su interés en llevar a feliz término este proyecto de ciudad.

Así mismo, agradecemos el apoyo institucional entre City Cancer Challenge y ProPacífico por forjar y mantener este acuerdo colaborativo que ha permitido llevar a feliz término el desarrollo de la presente guía. Y de manera especial a:

Maria Isabel Ulloa

Directora Ejecutiva
ProPacífico

María Fernanda Navarro

Directora Latinoamérica
City Cancer Challenge

La presente ***guía de manejo para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y paliación del cáncer de colon y recto*** fue posible gracias a la cooperación técnica y el apoyo de la asociación de City Cancer Challenge Foundation (C/Can).

Acerca de City Cancer Challenge (C / Can)

C/Can apoya a ciudades de todo el mundo en su labor para mejorar el acceso a una atención oncológica equitativa y de calidad. Desde su lanzamiento en 2017 por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), C/Can ha desarrollado un nuevo modelo para abordar el acceso a la atención del cáncer que, por primera vez, posiciona a la ciudad como un facilitador clave en la respuesta de los sistemas de salud hacia el cáncer. Más información (<https://citycancerchallenge.org>).



DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Todos los miembros del grupo desarrollador, así como los colaboradores, realizaron una declaración de conflicto de intereses antes o durante las sesiones para la elaboración de las recomendaciones. Cada una de estas declaraciones fue debidamente registrada y analizada. El resultado de dicho proceso puede verificarse en el Anexo 01.

FINANCIACIÓN

La presente guía hace parte de un proyecto auspiciado por City Cancer Challenge y en trabajo colaborativo con ProPacífico, cuya participación en el desarrollo de las recomendaciones de la presente guía

fueron de carácter orientador y facilitador, y en ningún momento influenciaron las recomendaciones finales.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EDITORIAL

El proceso de preparación y desarrollo de las recomendaciones y sus soportes, así como la elaboración del manuscrito, fue elaborado de manera independiente por el Grupo Desarrollador de la Guía. La entidad financiadora realizó un seguimiento en el proceso general de la guía, así como de la gestión documental del mismo, sin injerencia sobre el contenido. Adicionalmente, todos los participantes declararon conflicto de intereses.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AGREE II	Del inglés, Appraisal of Guidelines Research and Evaluation
C/CAN	City Cancer Challenge
CAE	Antígeno carcinoembrionario
EAPB	Entidad administradora del plan de beneficios
EPS	Empresa promotora de salud, actualmente EAPB
GLOBOCAN	Del inglés, Global Cancer Observatory
GPC	Guía de práctica clínica
ICER	Razón incremental de costo-efectividad
IPS	Institución prestadora de servicios de salud
PET	Tomografía por emisión de positrones
RMN	Resonancia magnética nuclear
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
TAC	Tomografía axial computarizada
TC	Tomografía computarizada
TNT	Terapia Neoadyuvante Total
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
5-FU	5-Fluorouracilo
RT	Radioterapia

TABLA DE CONTENIDO

GRUPO DESARROLLADOR DE LA GUÍA	5
EXPERTOS CLÍNICOS	5
EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS	6
EQUIPO DE ENFERMERÍA	6
REVISIÓN INTERNACIONAL	6
ASESOR METODOLÓGICO	7
COLABORADORES ESPECIALES	7
AGRADECIMIENTOS	8
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	9
FINANCIACIÓN	9
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EDITORIAL	9
SIGLAS Y ABREVIATURAS	9
TABLA DE CONTENIDO	10
1. INTRODUCCIÓN	18
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA	20
1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS	21
1.2.1. Objetivo general	21
1.2.2. Objetivos específicos.	21
1.3. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA GUÍA.	22
1.4. USUARIOS DE LA GUÍA	22
2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA	23
2.1. COMFORMACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE TRABAJO	23
2.2. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	23
2.3. PROCESO DE ADAPTACION	24
2.3.1. Selección de guías de práctica clínica	24
2.3.2. Evaluación de la calidad de las GPC seleccionadas	25
2.4. FORMULACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	27
2.5. INCORPORACIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS DE LA LITERATURA GENERAL	27
2.6. INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES PARES NACIONALES E INTERNACIONALES	28
3. PREGUNTAS CLÍNICAS DE LA GUÍA	29
4. RESUMEN EJECUTIVO	31
4.1. RECOMENDACIONES	31
4.1.1. BLOQUE: PROCESO DIAGNÓSTICO	31
¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?	31
Puntos de buena práctica clínica:	31
¿Cuáles son los estándares de calidad de la colonoscopia para ser considerada óptima?	32

Puntos de buena práctica clínica:	33
En caso de que la colonoscopia no se pueda realizar o sea incompleta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado para cáncer colorrectal?	34
4.1.2. BLOQUE: ESTRATIFICACIÓN	35
¿Cuáles son los estudios para estadificación (de extensión) en pacientes con cáncer colorrectal?	35
Puntos de buena práctica clínica:	36
4.1.3. BLOQUE: DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO	36
¿Cuáles deben ser los estándares de calidad del reporte histopatológico en el cáncer colorrectal en biopsias diagnósticas, resección de pólipos, piezas quirúrgicas (colon y recto), y otros especímenes (mucosectomía)?	36
Puntos de buena práctica clínica:	37
4.1.4. BLOQUE: GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO	37
¿Cuál debe ser la preparación preoperatoria de los pacientes con cáncer colorrectal que van a cirugía electiva?	37
¿Cuál es el mejor manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon resecable con obstrucción?	38
¿En qué casos está indicada la cirugía abierta o cirugía laparoscópica en pacientes con cáncer colorrectal?	38
4.1.5. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR IN SITU	38
¿Cuál es el manejo quirúrgico indicado en pacientes con cáncer colorrectal estadio 0 (TisN0)?	38
Puntos de buena práctica clínica:	39
4.1.6. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR EN ESTADIO TEMPRANO	39
¿Cuál es el manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal estadio temprano?	39
Cáncer de colon	39
Cáncer de recto	39
Puntos de buena práctica clínica:	40
4.1.7. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR LOCALMENTE AVANZADO	41
¿En qué casos está indicado el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?	41
¿En qué casos está indicada la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?	41
¿En qué casos está indicada la realización de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto?	41
ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de colon y recto	41
ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de recto solamente	41
Puntos de buena práctica clínica:	42
ESQUEMA DE TERAPIA NEOADYUVANTE TOTAL (TNT): Cáncer de recto solamente	43
Puntos de buena práctica clínica:	43
4.1.8. BLOQUE: MANEJO EN CÁNCER METASTÁSICO	43
¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer colorrectal metastásico?	43

¿Cuáles son las opciones de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer colorrectal metastásico?	44
Puntos de buena práctica clínica:	45
¿Cuáles estudios de biología molecular deben realizarse al espécimen quirúrgico de los pacientes con cáncer colorrectal y cuáles son las opciones de terapia dirigida (target)?	45
4.1.9. BLOQUE: SEGUIMIENTO	46
¿Cuál es la mejor estrategia de seguimiento y con qué periodicidad debe realizarse en pacientes con cáncer colorrectal tratado?	46
Puntos de buena práctica clínica:	47
4.1.10. BLOQUE: CUIDADOS PALIATIVOS	47
¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para lograr el empoderamiento del paciente, mayor introspección de la enfermedad y disminución del temor al tratamiento instaurado?	47
¿Cuáles serían los criterios de derivación temprana al programa de cuidados paliativos?	48
¿Cuál es el impacto de la derivación temprana (o acceso temprano) al programa de cuidados paliativos respecto al control de síntomas, introspección de la enfermedad, tolerancia, adherencia y continuidad al tratamiento?	48
¿Cuál es la efectividad de la intervención psicosocial respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?	48
¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?	49
¿Cuál es la efectividad de la terapia enterostomal respecto al cuidado de la ostomía y prevención de complicaciones de la misma?	49
¿Cuál es la indicación del soporte transfusional en relación con el manejo de síntomas de anemia?	49
¿Cuál es el beneficio del soporte de hidratación?	49
Puntos de buena práctica clínica:	49
¿Cuál es la indicación de la sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios?	50
Puntos de buena práctica clínica:	50
¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico y no farmacológico en el manejo del síndrome de anorexia-caquexia?	50
Puntos de buena práctica clínica:	51
¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico en el manejo del dolor?	51
Puntos de buena práctica clínica:	52
¿Cuál es la efectividad de las terapias invasivas en el manejo del dolor?	53
¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo del estreñimiento?	53
Puntos de buena práctica clínica:	53
¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo de la diarrea?	54
¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el manejo de la disnea?	55
¿Cuál es el efecto del uso de diuréticos en comparación con paracentesis para el manejo de la ascitis?	55
¿Cuáles serían las indicaciones de un dren peritoneal permanente para el manejo de ascitis?	55
4.1.11. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL PACIENTES CON CÁNCER.	56

¿Cuál es la indicación y beneficio de las intervenciones nutricionales en el paciente con cáncer avanzado?	56
Puntos de buena práctica clínica:	56
4.2. FLUJOGRAMAS	57
5. RECOMENDACIONES	63
5.1. PROCESO DIAGNÓSTICO.	63
¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?	63
Puntos de buena práctica clínica:	63
Evidencia seleccionada.	63
¿Cuáles son los estándares de calidad de la colonoscopia para ser considerada óptima?	64
Puntos de buena práctica clínica:	65
Evidencia seleccionada.	67
En caso de que la colonoscopia no se pueda realizar o sea incompleta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado para cáncer colorrectal?	69
Evidencia seleccionada.	69
5.1.1. Consideraciones para la implementación.	70
5.2. ESTRATIFICACIÓN	70
¿Cuáles son los estudios para estadificación (de extensión) en pacientes con cáncer colorrectal?	70
Puntos de buena práctica clínica:	72
Evidencia seleccionada.	72
5.2.1. Consideraciones para la implementación	73
5.3. DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO	74
¿Cuáles deben ser los estándares de calidad del reporte histopatológico en el cáncer colorrectal en biopsias diagnósticas, resección de pólipos, piezas quirúrgicas (colon y recto), y otros especímenes (mucosectomía)?	74
Puntos de buena práctica clínica:	74
Evidencia seleccionada.	75
5.3.1. Consideraciones para la implementación.	75
5.4. GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO	77
¿Cuál debe ser la preparación preoperatoria de los pacientes con cáncer colorrectal que van a cirugía electiva?	77
Evidencia seleccionada.	77
¿Cuál es el mejor manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon resecable con obstrucción?	78
Evidencia seleccionada.	78
¿En qué casos está indicada la cirugía abierta o cirugía laparoscópica en pacientes con cáncer colorrectal?	79
Evidencia seleccionada.	79
5.5. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL IN SITU	80

¿Cuál es el manejo quirúrgico indicado en pacientes con cáncer colorrectal estadio 0 (TisN0)?	80
Puntos de buena práctica clínica:	81
Evidencia seleccionada	81
5.6. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL ESTADIO TEMPRANO	82
¿Cuál es el manejo quirúrgico para el tratamiento	
de pacientes con cáncer colorrectal estadio temprano?	82
Cáncer de colon	82
Cáncer de recto	83
Puntos de buena práctica clínica:	83
Evidencia seleccionada	83
5.6.1. Consideraciones para la implementación.	87
5.7. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL ESTADIO LOCALMENTE AVANZADO	87
¿En qué casos está indicado el tratamiento neoadyuvante	
en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?	87
¿En qué casos está indicada la quimioterapia adyuvante	
en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?	87
¿En qué casos está indicada la realización de	
radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto?	87
ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de colon y recto	87
ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de recto solamente.	88
Puntos de buena práctica clínica:	89
Evidencia seleccionada	89
ESQUEMA DE TERAPIA NEOADYUVANTE TOTAL (TNT): Cáncer de recto solamente	95
Puntos de buena práctica clínica:	95
Evidencia seleccionada	95
5.7.1. Consideraciones para la implementación.	96
5.8. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL CON METÁSTASIS	97
¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico	
para pacientes con cáncer colorrectal metastásico?	97
¿Cuáles son las opciones de tratamiento sistémico	
en pacientes con cáncer colorrectal metastásico?	98
Puntos de buena práctica clínica:	99
¿Cuáles estudios de biología molecular deben realizarse al espécimen quirúrgico de los	
pacientes con cáncer colorrectal y cuáles son las opciones de terapia dirigida (target)?	99
Evidencia seleccionada	99
5.8.1. Consideraciones para la implementación	104
5.9. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON CÁNCER COLORRECTAL	105
¿Cuál es la mejor estrategia de seguimiento y con qué	
periodicidad debe realizarse en pacientes con cáncer colorrectal tratado?	105

Evidencia seleccionada	106
5.9.1. Consideraciones para la implementación	108
5.10. CUIDADOS PALIATIVOS	108
¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para lograr el empoderamiento del paciente, mayor introspección de la enfermedad y disminución del temor al tratamiento instaurado?	108
Evidencia seleccionada	109
¿Cuáles serían los criterios de derivación temprana al programa de cuidados paliativos?	110
Evidencia seleccionada	111
¿Cuál es el impacto de la derivación temprana (o acceso temprano) al programa de cuidados paliativos respecto al control de síntomas, introspección de la enfermedad, tolerancia, adherencia y continuidad al tratamiento?	112
Evidencia seleccionada	112
¿Cuál es la efectividad de la intervención psicosocial respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?	112
Evidencia seleccionada	113
¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?	113
Evidencia seleccionada	113
¿Cuál es la efectividad de la terapia enterostomal respecto al cuidado de la ostomía y prevención de complicaciones de la misma?	114
Evidencia seleccionada.	114
¿Cuál es la indicación del soporte transfusional en relación con el manejo de síntomas de anemia?	115
Evidencia seleccionada.	115
¿Cuál es el beneficio del soporte de hidratación?	115
Puntos de buena práctica clínica:	115
Evidencia seleccionada.	115
¿Cuál es la indicación de la sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios?	117
Puntos de buena práctica clínica:	117
Evidencia seleccionada.	117
¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico y no farmacológico en el manejo del síndrome de anorexia-caquexia?	121
Puntos de buena práctica clínica:	121
Evidencia seleccionada	122
¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico en el manejo del dolor?	124
Puntos de buena práctica clínica:	125
Evidencia seleccionada.	125
¿Cuál es la efectividad de las terapias invasivas en el manejo del dolor?	128
Evidencia seleccionada.	128

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo del estreñimiento?	129
Puntos de buena práctica clínica:	130
Evidencia seleccionada	130
¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo de la diarrea?	131
Evidencia seleccionada.	132
¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el manejo de la disnea?	133
Evidencia seleccionada	133
¿Cuál es el efecto del uso de diuréticos en comparación con paracentesis para el manejo de la ascitis?	134
Evidencia seleccionada	134
¿Cuáles serían las indicaciones de un dren peritoneal permanente para el manejo de ascitis?	134
Evidencia seleccionada	134
5.11. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL PACIENTES CON CÁNCER	135
¿Cuál es la indicación y beneficio de las intervenciones nutricionales en el paciente con cáncer avanzado?	135
Puntos de buena práctica clínica:	136
Evidencia seleccionada	136
6. ROL Y PERSPECTIVAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	138
Programa de navegación.	141
Plan de manejo de enfermería para el paciente oncológico.	142
7. REVISIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS	144
7.1. COSTO-EFECTIVIDAD DE LA COLONOSCOPIA VERSUS COLONOGRFIA POR TC	145
Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali.	146
7.2. COSTO-EFECTIVIDAD DEL BEVACIZUMAB	146
Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali	147
7.3. COSTO-EFECTIVIDAD DEL HIPEC O CIRUGIA CITORREDUCTIVA CON QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA.	148
Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali.	148
8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	149
8.1. ASPECTOS GENERALES	149
8.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES	151
8.3. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS	152
8.4. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS O FACILITADORES PARA RESOLVER LAS BARRERAS	154
8.5. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN	158
Indicadores de proceso	158
Indicadores de resultado	160

9. PLAN DE ACTUALIZACIÓN	160
ANEXOS	161
ANEXO 01. Declaración de conflicto de interés.	161
ANEXO 02. Puntajes AGREE II	167
ANEXO 03. CONSENSO DE EXPERTOS.	182
Del bloque de proceso diagnóstico:	183
Del bloque de estratificación:	186
Del bloque de diagnóstico patológico:	188
Del bloque de Generalidades del tratamiento	189
Del bloque de manejo in situ	189
Del bloque de manejo temprano.	190
Del bloque de manejo localmente avanzado	190
Del bloque de manejo metastásico.	193
Del bloque de seguimiento	196
ANEXO 04. RECOMENDACIONES NO VALIDADAS PARA SER ADAPTADAS.	200
ANEXO 05. PROTOCOLO DE PATOLOGÍA	204
Protocolo para resecciones de carcinoma primario de colon y recto	204
ANEXO 06. REVISIÓN DE PARES EXTERNOS	208
ANEXO 07. REVISIÓN DE PARES EXTERNOS INTERNACIONALES	211
BIBLIOGRAFÍA	256

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer hace parte del grupo de enfermedades no transmisibles, las cuales son responsables de gran parte de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y generan una importante presión sobre los sistemas de salud de cualquier país. Se espera que el cáncer se convierta en la primera causa de muerte y la única barrera para mejorar la expectativa de vida a nivel global (1). Además, de acuerdo con lo reportado por GLOBOCAN, la incidencia en cáncer y su tasa de mortalidad están aumentando rápidamente, en parte por la transición demográfica y envejecimiento de la población, así como por la mayor exposición a factores de riesgo.

A nivel de Latinoamérica, en 2012 se registraron cerca de 1.1 millones de casos nuevos en el año, lo que representó el 7.8% de todos los casos de cáncer globalmente en ese año. La incidencia y mortalidad ha presentado una tendencia ascendente para los tipos de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, y cáncer colorrectal. Por el contrario, se ha documentado una disminución gradual en los tipos de cáncer de estómago y cáncer de cérvix (2).

Por otro lado, en Colombia, el comportamiento del cáncer es similar al de la región. De acuerdo con los datos de los registros poblacionales del país, la incidencia anual ajustada por edad es de 151.5 casos por cada 100.000 hombres, y de 145.6 casos por cada 100.000 mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por edad es de 82.3 muertes por cada 100.000 hombres y 73.2 muertes por cada 100.000 mujeres (3). Un estudio realizado con el registro poblacional de Cali, con un seguimiento de más de 50 años, mostró que el comportamiento de la incidencia y la mortalidad entre 1962 y 2007 ha aumentado para

los cáncer de colon y recto, mama, próstata y testicular; una tendencia a la disminución para los cáncer de oro-faringe, cérvix; y una tendencia relativamente estable para los cáncer de bronquios y pulmón (4).

El cáncer de colon y recto da cuenta del 10% de todos los tipos de cáncer (5). En el mundo y en América latina, es el tercero en términos de incidencia y el segundo en mortalidad (1,2), y en los últimos años ha presentado una tendencia ascendente (2,4,6). Un estudio realizado con datos de la población de Cali exploró el comportamiento del cáncer colorrectal entre 1962 y 2007, encontrando que la tendencia va en aumento, comportamiento similar a la región (7). En este estudio, la tasa de incidencia en hombres pasó de 7.3 por cada 100.000 en 1962 a ser de 15.8 por cada 100.000 en el año 2007; de mismo modo, la tasa de incidencia en mujeres aumentó de 7.0 por cada 100.000 a 14.1 por cada 100.000 durante el mismo periodo. La tasa de mortalidad paso de 5.2 a 9.6 por cada 100.000 en hombres, y de 6.0 a 7.1 por cada 100.000 en mujeres.

En Colombia, desde el 2015 la Cuenta de Alto Costo lleva un registro anual del cáncer en Colombia, basado en reportes de las IPS y EPS. En el último informe de la situación en cáncer en Colombia del 2018, se reporta una prevalencia de cáncer de colon y recto de 40.2 por cada 100.000 afiliados (al sistema de salud), y una proporción de casos nuevos reportados (que hace las veces de incidencia acumulada anual) de 6.4 casos nuevos por cada 100.000 afiliados durante un año (8). Estos valores son diferentes a los reportados desde los registros poblacionales debido a que la metodología de medición es diferente y por tanto, no son comparables (9). No obstante, corroboran la tendencia

ascendente: entre 2015 a 2018, la prevalencia aumentó de 21.2 a 38.0, y la proporción de casos nuevos también aumento de 4.1 a 6.4 durante este cuatrienio (8).

Desde una perspectiva de salud pública, las medidas preventivas están dirigidas hacia dos líneas de acción: reducir la exposición de factores de riesgo modificables, y desarrollar programas de tamización para cáncer colorrectal (5). En la primera, se abordan todos los esfuerzos e intervenciones diseñadas a modificar conductas no saludables desde lo individual, y el diseño de políticas públicas en salud que aborden el problema desde una visión más macro y poblacional (10,11). La segunda línea, que cuenta con mayor investigación, es la que ha tenido mayor atención debido a que ha mostrado que un adecuado programa de tamización puede reducir la mortalidad entre un 16% a un 50% (12–14).

Para afrontar la carga de enfermedad que conlleva el cáncer y gestionar adecuadamente la presión que ejerce sobre el sistema de salud, Colombia elaboró un Plan Decenal para el Control del Cáncer, programado para ejecutarse entre 2012 al 2021. Este plan decenal establece la hoja de ruta a seguir por parte de los actores del sistema de salud colombiano, y tiene como objetivos reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables, reducir las muertes evitables por cáncer, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes, garantizar la gestión del conocimientos para la toma de decisiones, y fortalecer la gestión del recurso humano, todo esto apalancado las estrategias de: control del riesgo (prevención primaria); detección temprana de la enfermedad; atención, recuperación y superación de los daños causados por el cáncer; mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes con cáncer mediante intervenciones de cuidado paliativo (15).

Este plan cuenta con el respaldo de normas con categoría de ley, como lo es la Ley 1384 de 2010 (conocida también como Ley “Sandra Ceballos”), en la cual se establece las acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana, apuntando de igual manera a reducir la mortalidad y morbilidad por cáncer en la persona adulta (16).

En este orden de ideas, Colombia cuenta con una plataforma normativa y estratégica desde hace aproximadamente 10 años encaminada hacia el control del cáncer. Algunos estudios han mostrado un impacto favorable en desenlaces duros como lo es la supervivencia global. En lo referente a cáncer de colon y recto, un estudio estimó la supervivencia global a dos años tomando como muestra 383 pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, tratadas en el Instituto Nacional de Cancerología en 2012, con base en el registro hospitalario de cáncer y registro de mortalidad, encontrando como resultado que la supervivencia global a dos años fue de 54.1% para los hombres y 74% para las mujeres (17).

Otro estudio de tipo cohorte retrospectiva, evaluó la supervivencia global de 824 pacientes con cáncer colon y 676 con cáncer de recto, basados en historias clínicas y del registro poblacional del Instituto de Cancerología Las Américas de la ciudad de Medellín entre los años 2011 y 2015, reportando como hallazgo una supervivencia global a 2 años de 68.4% para ambos tipos de cáncer, y a 5 años de 45.5%, con una diferencia estadísticamente significativa para una mejor supervivencia para el cáncer de colon en comparación con el cáncer de recto (51.7% vs 37.5% a 5 años, respectivamente) (18). Estas tasas de supervivencia global son similares a las reportadas en el estudio CONCORD-3, estudio que estimó una supervivencia global a 5 años para América Central y Suramérica, entre 26.8 – 63.4% para cáncer de colon, y entre

32.7 – 59.0% para cáncer de recto, estimaciones basadas en datos recopilados entre 2010 al 2014 (19).

Desde la perspectiva económica en salud, el manejo del cáncer conlleva una carga económica importante (20). Por ejemplo, el costo promedio de un caso de cáncer de colon en estadio I es de \$5,099,760, para el estadio II-IIC es de \$17,165,865, para el estadio III es de \$51,348,984, y para el estadio IV de \$76,418,512 (valores monetarios del 2013). Similares proporciones tiene el costo asociado a cáncer de recto. Por otro lado, el manejo de una recaída puede llevar a valores de 107 millones de pesos (21). De este costo, cerca del 97% son costos directos (asociados al cuidado del paciente) y el resto a costos indirectos (asociados a la pérdida de productividad por morbilidad); de estos costos directos, cerca de dos terceras partes están relacionados al manejo de quimioterapia (22).

Queda claro que todas las estrategias encaminadas a la detección temprana del cáncer colorrectal tienen el potencial de ser costo-efectivas, toda vez que el costo asociado al manejo integral en estadios tempranos es significativamente menor que el costo incurrido cuando el cáncer está avanzado. Lograr este objetivo, que por demás redundará en un beneficio sobre la morbimortalidad general, depende de varios factores como la organización de la red de prestadores (23), así como la oferta de servicios oncológicos en los territorios (24,25), y la coordinación efectiva con un programa de cuidado paliativos, en especial aunque no únicamente, para aquellos que requieren cuidados al final de la vida (26).

Dos indicadores sensibles a la efectividad de articulación y coordinación del cuidado del paciente con cáncer colorrectal en particular, y del cáncer en general, es la oportunidad de diagnóstico y oportunidad de inicio de

tratamiento. Desde una visión de procesos, cada paso entre un servicio y otro, entre un procedimiento administrativo y otro, existe potenciales riesgos de falla de la ruta, con las consecuentes demoras en la atención. El informe de la Cuenta de Alto Costo refiere que la oportunidad diagnóstica es de 8.5 días (mediana) y de oportunidad de tratamiento de 5 días (mediana); no obstante, la media fue de 22 y 20.5 días, respectivamente. Esto se debe a que existe una dispersión de datos hacia la derecha. Dicho en otros términos, cerca del 5% de los casos reportados tuvieron una oportunidad superior a los 50 días (8).

Si bien como dato agregado se cumple con la meta de una oportunidad menor de 30 días para ambos indicadores, hay personas que no se benefician de esto, y sólo el 5% de esas personas pueden tener consecuencias en salud lo suficientemente severas como para requerir más del 50% de todo el gasto en salud para cáncer colorrectal (27).

Existen muchas oportunidades de mejoramiento en el proceso de atención integral en el paciente con cáncer de colon y recto, pero requiere de un esfuerzo multisectorial y participativo para lograr obtener los mejores resultados de salud, que el paciente perciba una atención de alta calidad, a la vez que se hace un uso eficiente de los recursos del sistema y los profesionales en salud se sientan satisfechos con su ejercicio clínico del día a día (28,29).

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA

El desarrollo de la presente guía de práctica clínica surge desde la iniciativa de City Cancer Challenge. Lanzado en 2017 por la Unión para el Control Internacional del Cáncer, City Cancer Challenge (C/CAN) es ahora una fundación independiente activa en nueve ciu-

dades de todo el mundo, en las que se encuentra la ciudad de Santiago de Cali (30). C/CAN tiene como propósito generar estrategias e intervenciones encaminadas a mejorar el acceso a la atención de calidad del cáncer mediante la transformación de la gestión que ejecutan los actores e interesados del sistema de salud en el marco contextual de la ciudad. Con el propósito de implementar acciones clave en la ciudad, C/CAN estableció un acuerdo de colaboración con PROPACÍFICO con el fin de consolidar esta iniciativa.

Parte de las acciones clave a ser llevadas a cabo, se encuentra el desarrollo de las guías de práctica clínica para los cánceres priorizados. Este paso es fundamental para ofrecer una atención de alta calidad en el cuidado del paciente con cáncer, ya que permite que los actores interesados tomen decisiones informadas en la evidencia, logrando así mejores resultados en salud, impactando favorablemente en la experiencia del usuario y su calidad de vida, a su vez que se promueve el uso adecuado de los recursos del sistema y proporciona un marco para reducir la variabilidad de la práctica médica.

Considerando que una guía de práctica clínica se define como “un conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base en la revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y perjuicios de distintas opciones terapéuticas, diagnósticas, entre otras, en la atención en salud” (31), y que un proceso de adaptación de una guía es “modificar una GPC que ha sido elaborada en un contexto cultural y organizacional determinado, y adaptarla a otro contexto diferente dando como resultado una nueva GPC” (31), el presente documento corresponde al desarrollo de una guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y paliación del cáncer de colon y recto, contextualizada

a la ciudad de Santiago de Cali, mediante la adaptación de GPC previamente diseñadas en el ámbito nacional e internacional.

1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS

La presente guía de manejo provee recomendaciones derivadas de la adaptación de Guías de práctica clínica y Guías de manejo nacionales e internacionales, para el diagnóstico, manejo y seguimiento del paciente con cáncer de colon y recto, ajustadas al contexto de la ciudad de Cali. No se incluyen aspectos de tamización.

Para ello se plantean los siguientes objetivos:

1.2.1. Objetivo general

Proveer recomendaciones clínicas para el diagnóstico, estadificación, tratamiento, seguimiento y paliación para cáncer de colon y recto, para la ciudad de Cali.

1.2.2. Objetivos específicos

- Elaborar recomendaciones acerca del proceso diagnóstico para identificar y reducir las potenciales demoras o barreras para un diagnóstico histopatológico y estadificación oportunos.
- Formular las intervenciones terapéuticas que cuenten con la mejor evidencia disponible de eficacia y seguridad, adaptadas al contexto de la ciudad de Cali, con el fin de reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y promover el uso eficiente de los recursos del sistema.
- Identificar estrategias de seguimiento y de cuidados paliativos con el fin de impactar favorablemente en la calidad de vida del paciente con cáncer de colon y recto.

1.3. POBLACIÓN OBJETIVO DE LA GUÍA

Las recomendaciones van dirigidas a toda persona con sospecha diagnóstica o confirmación de cáncer colon o cáncer de recto, residente de la ciudad de Cali.

No incluyen recomendaciones sobre tamización, manejo de las complicaciones relacionadas con el tratamiento ni rehabilitación.

- Especialistas y subespecialistas en el campo de la oncología. Incluye oncólogos clínicos, hemato-oncólogos, cirujanos oncológicos, coloproctólogos, gastroenterólogos, cirujanos de hígado y vías biliares, oncólogos radioterápicos, paliativistas, así como las especialidades encargadas de la estadificación (o seguimiento) como son los profesionales formados en patología, radiología, medicina nuclear.

1.4. USUARIOS DE LA GUÍA

Se pretende que las recomendaciones planteadas en esta guía sean utilizadas por los actores del sistema de salud cuya toma de decisiones influyan, directa o indirectamente, en los desenlaces en salud de la población con cáncer de colon y recto. En este sentido, van dirigidas a:

- Profesionales de la salud que participan en el cuidado del adulto, como internistas, médicos familiares, geriatras, gerontólogos, médicos generales, y en general, todos aquellos que tienen como una de sus responsabilidades iniciar el proceso diagnóstico ante la sospecha de un cáncer colorrectal.

- Profesionales involucrados en el proceso de atención integral como lo son los nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, y químicos farmacéuticos.

- Profesionales administrativos de las IPS de segundo y tercer nivel de complejidad.

- Médicos en entrenamiento de primera y segunda especialidad.

- Profesionales administrativos de las EAPB. Incluye profesionales encargados de los procesos de auditoría clínica, garantía de la calidad y seguridad del paciente, gestión del riesgo, vigilancia epidemiológica, entre otros.

2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA

La metodología con la cual se desarrollaron las recomendaciones incorporadas en la presente guía consistió en la revisión y validación de recomendaciones procedentes de Guías de Práctica Clínica y Guías de Manejo tanto nacionales como internacionales, junto con ajustes al contexto para la ciudad de Cali. Esta revisión y validación tomó en cuenta conceptos y lineamientos de las guías metodológicas del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente la guía para la adopción – adaptación de GPC basadas en la evidencia (31,32), así como en la directriz de la OPS para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías informadas en la evidencia (33), los cuales fueron modificados y ajustados a las necesidades del grupo desarrollador y a lo propuesto en el marco del proyecto C/Can.

2.1. COMFORMACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE TRABAJO

El equipo multidisciplinario de trabajo estuvo conformado por expertos clínicos en las áreas relacionadas con la atención del paciente con cáncer: hemato-oncología, oncología clínica, cirugía gastrointestinal, coloproctología, oncología radioterápica, medicina nuclear, radiología, patología, cuidados paliativos. Los expertos clínicos fueron profesionales vinculados a las siguientes instituciones de la ciudad de Cali:

- Centro Médico Imbanaco
- Clínica de Occidente
- Fundación Valle del Lili
- Hemato Oncólogos SA
- Hospital Universitario del Valle

De igual manera, el equipo contó con la participación de un asesor metodológico, quien brindó apoyo técnico y editorial del presente documento.

También se contó con la participación de representantes de las principales EAPB de la ciudad de Cali, quienes brindaron aportes solamente en el apartado de plan de mejoramientos en cuanto a identificación de barreras y facilitadores y propuestas de estrategias de solución.

2.2. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los miembros del grupo desarrollador, así como los colaboradores, realizaron una declaración de conflicto de intereses antes o durante las sesiones para la elaboración de las recomendaciones. Para ello, se utilizó el formato propuesto por la guía metodológica del Ministerio de Salud (32).

Se presentaron conflictos de interés principalmente de tipo económico personal de acuerdo con la clasificación dada por la guía metodológica del Ministerio. En este sentido, y en el marco de la metodología empleada, así como la construcción de las recomendaciones, ninguno de los conflictos de interés declarados se consideró que representaran algún tipo de limitación o exclusión para participar en el desarrollo de las recomendaciones.

Cada una de estas declaraciones fue debidamente registrada y analizada. El resultado de dicho proceso puede verificarse en el Anexo 01.

2.3. PROCESO DE ADAPTACION

Se realizó un proceso de adaptación de las recomendaciones descritas en guías nacionales e internacionales, las cuales fueron llevadas a revisión por parte del grupo de expertos clínicos, con el fin de seleccionarlas y modificarlas, teniendo presente el contexto y necesidades en la atención del paciente con cáncer de la ciudad de Cali.

En una primera fase, se seleccionó el grupo de expertos clínicos a través de una convocatoria abierta y voluntaria realizada desde ProPacífico, facilitadas por el coordinador de la presente guía, la Dra. Ángela Zambrano. Posteriormente, se establece el alcance, objetivos y preguntas que serían incluidas en la guía de manejo. Simultáneamente, se realiza la declaración de conflicto de interés por parte de todos los participantes.

La segunda fase consistió en la búsqueda y selección de las guías nacionales e internacionales a ser adaptadas. Para ello, se realizó inicialmente una reunión presencial (por medio virtual) en la que los expertos clínicos propusieron las guías a ser seleccionadas teniendo en cuenta su uso más frecuente, su reconocimiento en el medio profesional y que a su criterio fueran las más completas y claras en cuanto a la estructura de las recomendaciones y sustentas la toma de decisiones de su práctica diaria.

Se complementó con una búsqueda no sistemática de desarrolladores/compiladores de guías:

- NICE
- NCCN
- ASCO
- ESMO
- Guía salud

Se aplicó el instrumento AGREE II, y con la calificación obtenida de los dominios 3 (rigor en la elaboración), dominio 6 (independencia editorial) y dominio 5 (aplicabilidad), se tomó la decisión en reunión con los expertos cuáles guías serían seleccionadas para la siguiente fase.

La tercera fase consistió en la evaluación de las recomendaciones de las guías seleccionadas. Teniendo en cuenta las preguntas orientadoras “¿está recomendación sigue siendo válida en la práctica clínica actual?” y “en su opinión, ¿la recomendación requiere de ajustes o modificaciones para ser adaptadas al contexto de la ciudad de Cali?”, se realizaron reuniones sucesivas con el equipo de expertos clínicos para escribir las recomendaciones preliminares.

Para la escritura de las recomendaciones se procuró mantener el lenguaje propuesto por el grupo GRADE para facilitar la interpretación de las mismas.

Finalmente, con las recomendaciones preliminares elaboradas, se llevaron a una fase final de validación por parte de pares externos de ciudad, sociedades científicas, instituciones nacionales y un par externo internacional.

2.3.1. Selección de guías de práctica clínica

Se realizó un consenso informal con el grupo de expertos clínicos para preseleccionar las GPC que posteriormente serían evaluadas en su calidad y rigor metodológico. Se decantó por un proceso de consenso como medio para seleccionar las guías potencialmente a ser adoptadas/adaptadas fundamentado en que los expertos clínicos representan a los profesionales de la ciudad de Cali y, por tanto, reconocen que existen GPC que son más referenciadas para la toma de decisiones, o

que cuenta con un nivel de reputación en el medio que les genera confianza en el que soportar su actuar clínico.

En este sentido, involucrar guías diferentes a las más utilizadas o referenciadas puede generar una primera barrera para la implementación, y es que al no reconocer otras guías (como ejemplo ilustrativo, guías chilenas, guías mexicanas, o guías neozelandesas) y adaptar tales recomendaciones, puede generar barreras de tipo falta de familiaridad, desacuerdo general con guías diferentes a las reconocidas en el medio local, o falta de motivación para cambiar sus referentes de práctica (34).

Es por ello que, en consenso con los expertos clínicos, se pre-seleccionaron las siguientes GPC:

- ASCO 2019: Treatment of Patients With Early-Stage Colorectal Cancer: ASCO Resource-Stratified Guideline (35)
- ASCRS colon 2017: The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Colon Cancer (36)
- ASCRS recto 2013: Practice Parameters for the Management of Rectal Cancer (Revised) (37)
- COL AMER PATOL 2020: Protocol for the Examination of Specimens From Patients With Primary Carcinoma of the Colon and Rectum (38)
- COL MINSALUD 2017: Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de colon y recto (39)
- ESGAR 2018: Magnetic Resonance Imaging for Clinical Management of Rectal Cancer: Updated Recommendations From the 2016 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Consensus Meeting (40)

gy (ESGAR) Consensus Meeting (40)

- ESMO colon temp 2013: Early Colon Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-Up (41)
- ESMO colon Mt 2014: Metastatic Colorectal Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-Up (42)
- ESMO recto 2017: Rectal Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-Up (43)
- JSCCR 2019: Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) Guidelines 2019 for the Treatment of Colorectal Cancer (44)
- NCCN colon 2020: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) - Colon cancer (45)
- NCCN recto 2020: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) - Rectal cancer (46)
- NICE 2020: Colorectal cancer. NICE guideline [NG151] (47)
- SAR 2017: Use of Magnetic Resonance Imaging in Rectal Cancer Patients: Society of Abdominal Radiology (SAR) Rectal Cancer Disease-Focused Panel (DFP) Recommendations 2017 (48)

2.3.2. Evaluación de la calidad de las GPC seleccionadas

Una vez pre-seleccionadas las GPC mediante el consenso, se procedió a evaluar la calidad metodológica de las mismas a través de la aplicación del instrumento AGREE II, y en resultado por parte de los evaluadores de las GPC se describe en la siguiente tabla:

Tabla 1 Puntaje AGREE II para las GPC evaluadas

	Dominio 1 Alcance y objetivo	Dominio 2 Participación de los implicados o grupos de interés	Dominio 3 Rigor en la elaboración	Dominio 4 Claridad de presentación	Dominio 5 Aplicabilidad	Dominio 6 Independencia editorial
ASCO 2019	100%	91%	91%	100%	67%	100%
ASCRS colon 2017	92%	78%	75%	97%	60%	71%
ASCRS recto 2013	92%	78%	70%	97%	60%	71%
COL AMER PATOL 2020	100%	100%	98%	100%	93%	100%
COL MINSALUD 2017	100%	100%	98%	100%	100%	100%
ESGAR 2018	97%	71%	66%	85%	36%	100%
ESMO colon temp 2013	67%	28%	33%	89%	17%	67%
ESMO colon Mt 2014	72%	28%	33%	89%	17%	67%
ESMO recto 2017	78%	22%	8%	94%	17%	75%
JSCCR 2019	100%	97%	59%	89%	69%	100%
NICE 2020	100%	100%	92%	100%	92%	100%
NCCN colon 2020	100%	83%	91%	97%	75%	100%
NCCN recto 2020	100%	97%	98%	100%	75%	100%
SAR 2017	100%	80%	83%	96%	51%	100%

NOTA: se genera una semaforización para fines de visualización: Verde es $\geq 60\%$, Amarillo es 60%-50%, Rojo es $<50\%$

Los resultados de los puntajes obtenidos por cada dominio fueron discutidos con el equipo de expertos clínicos. En consenso informal, se tomaron en cuenta aquellas GPC con puntajes más elevados en el Dominio 3, y se le dio especial relevancia al Dominio 5. La decisión final fue que se llevaron a adopción y/o adaptación las GPC

de Colombia, la GPC del NICE, y las GPC de la NCCN. En el consenso también se estableció que la GPC del Colegio Americano de Patología cumple un rol más de protocolo, así que será ajustada a formato de recomendaciones y se dejará como anexo. Para revisión de los puntajes AGREE II por cada GPC, remitirse al Anexo 02.

2.4. FORMULACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

La formulación de las recomendaciones se siguió en dos momentos. En primera instancia, se analizaron las recomendaciones de las GPC seleccionadas para determinar:

- Validez en la práctica clínica actual.
- Recomendaciones para adoptar, es decir, sin cambios.
- Recomendaciones para adaptar, es decir, con modificaciones de forma y fondo.
- Recomendaciones no válidas.

Lo anterior se realizó a través de un consenso informal mediante reuniones periódicas a través de medios virtuales.

Posteriormente, se elaboraron las recomendaciones preliminares considerando la calidad de la evidencia aportada por las GPC, evaluando la posibilidad de incluir evidencia reciente que fuese relevante a consideración de los expertos clínicos, además de considerar el balance riesgo-beneficio de la tecnología en salud a recomendar, uso de recursos y definiendo aspectos de aceptabilidad y viabilidad.

En una segunda instancia, las recomendaciones fueron llevadas a consenso formal ante el panel de expertos clínicos mediante metodología Delphi modificado. Se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo con las conclusiones arrojadas por el consenso (ver Anexo 03).

Del mismo modo, se elaboraron “Puntos de buena práctica clínica”. Este tipo de recomendaciones están diseñadas como sugerencias operativas que, si bien no es-

tán basadas en la evidencia, se consideran prácticas con un obvio efecto beneficioso sin requerirse de estudios que respalden estas afirmaciones.

Cada bloque temático finaliza con un apartado de “Evidencia seleccionada” en el que se resumen los principales estudios que sustentan las recomendaciones. Estas referencias derivan de las guías seleccionadas, principalmente de la guía NCCN y la guía colombiana. Se describieron preferentemente revisiones sistemáticas.

La escritura de las recomendaciones se intentó ajustar al lenguaje de la metodología GRADE (“se recomienda...”, “se sugiere...”), de acuerdo con el grado de fuerza de consenso.

2.5. INCORPORACIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS DE LA LITERATURA GENERAL

En el desarrollo de las recomendaciones, se identificaron aspectos de índole económico que pueden llegar a influir, positiva o negativamente, en la implementación de alguna de las recomendaciones, dado que se propende por el uso de alguna tecnología en salud en particular.

Por este motivo, se efectuó una revisión general de la literatura de evaluaciones económicas, con el fin de aportar elementos de juicio a los tomadores de decisión para el proceso de implementación de esta guía.

Se aclara que esta revisión no pretende sustituir los ejercicios de costo-efectividad y análisis presupuestal de los actores que fungen un rol de pagadores, sino que, por el contrario, busca señalar los elementos clave que determinan si una tecnología aporta una adecuada relación costo-beneficio.

2.6. INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES PARES NACIONALES E INTERNACIONALES

Como parte del proceso de validación de calidad de la guía, la presente guía fue evaluada por pares externos expertos temáticos, tanto nacionales como internacionales, de manera independiente del grupo desarrollador multidisciplinario, con el fin de que brindaran aportes, comentarios y sugerencias respecto a las recomendaciones desarrolladas.

Para sintetizar las observaciones de los pares externos, así como el registro de los resultados de la evaluación de la opinión, se utilizó la siguiente herramienta adaptada de la guía metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social (32):

Tabla 2 Herramienta de agregación y calificación de opiniones por los Pares Externos

No.	Nombre del Par Externo	Institución a la que representa	Opinión	Categoría de la opinión*	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión**	Resultado de la evaluación de la opinión***

* Edición, aclaración de términos, aporte, comentario positivo, comentario negativo-

** Sección, página de la guía.

*** Incluida, No Incluida.

3. PREGUNTAS CLÍNICAS DE LA GUÍA

Las preguntas clínicas de la presente guía se adaptaron de las preguntas de la guía de práctica clínica colombiana (39). Estas son:

Preguntas del bloque de diagnóstico:

- ¿Cuáles son los signos y síntomas de sospecha de cáncer colorrectal para realizar estudios diagnósticos?
- ¿Cuáles son las pruebas que existen para diagnosticar cáncer colorrectal?
- ¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?
- ¿Cuáles son las pruebas que existen para diagnosticar cáncer colorrectal?
- ¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?
- ¿Cuáles son los estándares de calidad de la colonoscopia para ser considerada óptima?
- En caso de que la colonoscopia no se pueda realizar o sea incompleta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado para cáncer colorrectal?

Preguntas del bloque de estratificación:

- ¿Cuáles son los estudios para estadificación (de extensión) en pacientes con cáncer colorrectal?

Preguntas del bloque de diagnóstico histopatológico:

- ¿Cuáles deben ser los estándares de calidad del reporte histopatológico en el cáncer colorrectal en biopsias diagnósticas, resección de pólipos, piezas quirúrgicas (colon y recto), y otros especímenes (mucosectomía)?

Preguntas de los bloques de manejo:

- ¿Cuál debe ser la preparación preoperatoria de los pacientes con cáncer colorrectal que van a cirugía electiva?
- ¿Cuál es el mejor manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon resecable con obstrucción?
- ¿Cuál es la cirugía indicada según la localización del tumor rectal?
- ¿Cuál es el manejo quirúrgico indicado en pacientes con cáncer colorrectal estadio 0 (TisN0)?
- ¿Cuál es el manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal estadio temprano?
- ¿En qué casos está indicada la cirugía abierta o cirugía laparoscópica en pacientes con cáncer colorrectal?
- ¿En qué casos está indicado el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?

- ¿En qué casos está indicada la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?
- ¿En qué casos está indicada la realización de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto?
- ¿Cuáles son las opciones de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer colorrectal metastásico?
- ¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer colorrectal metastásico?
- ¿Cuáles son las opciones de tratamiento inicial en pacientes con cáncer colorrectal irresecable no metastásico?
- ¿Cuáles estudios de biología molecular deben realizarse al espécimen quirúrgico de los pacientes con cáncer colorrectal y cuáles son las opciones de terapia dirigida (target)?

Preguntas del bloque de seguimiento:

- ¿Cuál es la mejor estrategia de seguimiento y con qué periodicidad debe realizarse en pacientes con cáncer colorrectal tratado?

Para el bloque de Cuidados Paliativos, se desarrollaron preguntas estructuradas y se realizó una revisión rápida de la literatura, por lo que las recomendaciones en su mayoría son de novo, si bien otras derivan de dos guías de práctica clínica. Las preguntas para este bloque temático fueron:

- ¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para lograr el empoderamiento del paciente, mayor introspección

de la enfermedad y disminución del temor al tratamiento instaurado?

- ¿Cuáles serían los criterios de derivación temprana al programa de cuidados paliativos?
- ¿Cuál es el impacto de la derivación temprana (o acceso temprano) al programa de cuidados paliativos respecto al control de síntomas, introspección de la enfermedad, tolerancia, adherencia y continuidad al tratamiento?
- ¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?
- ¿Cuál es la efectividad de la terapia enteroestomal respecto al cuidado de la ostomía y prevención de complicaciones de la misma?
- ¿Cuál es la indicación del soporte transfusional en relación con el manejo de síntomas de anemia?

- ¿Cuál es el beneficio del soporte de hidratación?

- ¿Cuál es la indicación de la sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios?

- ¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico y no farmacológico en el manejo del síndrome de anorexia-caquexia?

- ¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico en el manejo del dolor?

- ¿Cuál es la efectividad de las terapias invasivas en el manejo del dolor?

- ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para el manejo del estreñimiento?

- ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para el manejo de la diarrea?
- ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el manejo de la disnea?
- ¿Cuál es el efecto del uso de diuréticos en comparación con paracentesis para el manejo de la ascitis?
- ¿Cuáles serían las indicaciones de un dren peritoneal permanente para el manejo de ascitis?

Finalmente, para el abordaje de los aspectos nutricionales:

- ¿Cuál es la indicación y beneficio de las intervenciones nutricionales en el paciente con cáncer avanzado?

4. RESUMEN EJECUTIVO

4.1. RECOMENDACIONES

4.1.1. BLOQUE: PROCESO DIAGNÓSTICO

¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?

N	RECOMENDACIÓN
1	Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico.
2	Se sugiere una colonografía por tomografía computarizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible con enema de bario, siempre y cuando las IPS cuenta con personal entrenado y capacitado para la realización e interpretación de Colonografías por TC. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se sugiere ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado.

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere advertir al paciente que más de un examen puede ser necesario para confirmar o excluir un diagnóstico de cáncer colorrectal, como lo es un TAC, RMN o colonoscopia. Explicar al paciente que es posible que sea necesario repetir un mismo examen.

¿Cuáles son los estándares de calidad de la colonoscopia para ser considerada óptima?

N	RECOMENDACIÓN
3	Se recomienda ofrecer sedación a todos los pacientes, a menos que esté contraindicada, lo cual está determinado por el profesional en Anestesiología. Los pacientes deben ser conscientes de que tienen el derecho de rechazar la sedación si así lo desean.
4	Se recomienda que los pacientes sometidos a procedimientos con sedación consciente o profunda tengan una monitorización continua antes, durante y después de la administración de la sedación.
5	Se recomienda la monitorización de todos los pacientes, incluida la presión arterial, pulso, respiración, nivel de conciencia y grado de incomodidad al inicio, durante y al final del procedimiento. Dependiendo de la respuesta del paciente, la evaluación puede necesitar ser más frecuente. Estos datos deben registrarse en el nivel del servicio de endoscopia digestiva, utilizando un sistema elegido por el servicio.
6	Se sugiere monitorización continua con electrocardiograma en pacientes de alto riesgo. Este subgrupo incluye aquellos que tienen antecedentes de enfermedad cardíaca o pulmonar, adultos mayores y pacientes para los que se espera un procedimiento prolongado.
7	Se sugiere que el equipo debe tener la capacidad de crear registros fotográficos, ya sean de papel o digitales, con el propósito de conservar documentación fotográfica auditable de que la colonoscopia fue completa: fotodocumentación de la válvula ileo -cecal y el ciego, o un videoclip con su respectiva foto instantánea. Así mismo, se debe realizar registro fotográfico así no haya hallazgos patológicos
8	Se sugiere que los especialistas que realizan la endoscopia monitoricen sus tasas individuales de detección de adenomas, en pacientes sometidos a colonoscopia de tamización, y correlación con las biopsias positivas para cáncer. Así mismo, es deseable que cada centro o profesional, audite la tasa de detección de pólipos y la tasa de resección de pólipos en la población de tamizaje.
9	Se sugiere, cuando sea posible, la preparación intestinal con dosificación dividida para mejorar la efectividad de la preparación intestinal. Esto está condicionado a la hora de programación de la colonoscopia y a las comorbilidades (por ej., insuficiencia cardíaca). De igual manera, se sugiere que los exámenes se realicen solamente después de una adecuada preparación del intestino, es decir, sin ningún residuo fecal o líquido en el lumen que pudiera enmascarar cualquier área sospechosa.
10	Se sugiere un tiempo de retiro mínimo de 6 minutos, como indicador de calidad auditable, para colonoscopias de detección de cáncer colorrectal.
11	Se sugiere como indicador de calidad, una frecuencia de perforación en las colonoscopias no mayor de un caso por cada 1000 colonoscopias*. * Se debe tener en cuenta que las afecciones colónicas que se sabe afectan el riesgo de perforación incluyen pseudo-obstrucción, isquemia, colitis grave, cambios inducidos por radiación, estenosis, las formas más severas de enfermedad diverticular y uso crónico de corticosteroides.

- | | |
|----|--|
| 12 | Para lograr un examen colonoscópico de alta calidad, se recomienda realizar una intubación completa del colon hasta el ciego e inspeccionar cuidadosamente la mucosa durante la retirada. |
| 13 | Si el especialista que realiza la endoscopia duda de su capacidad para remover una lesión de alto riesgo, se sugiere documentar apropiadamente la lesión, si es necesario, marcar su posición con un tatuaje y remitir al paciente a otra institución o profesional para que la lesión sea removida endoscópica o quirúrgicamente. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Todos los pacientes deben recibir una evaluación previa al procedimiento y cualquier pregunta que el paciente pueda tener debe ser respondida en ese momento. El paciente debe tener una comprensión suficiente del proceso de preparación intestinal, ya que un intestino mal preparado implica suspender y reprogramar el procedimiento.
- No es necesario realizar dos procedimientos separados: uno detección y otro para biopsia. Para ello, se recomienda garantizar que la emisión de autorizaciones, si aplica el caso, tengan en cuenta este punto y se evite diferir el procedimiento de toma de biopsia.
- Se recomienda que cada IPS dentro de su Manual de Calidad y Protocolos Institucionales, establezca un programa completo de aseguramiento de la calidad y seguridad, así como procedimientos para monitorizar el cumplimiento del programa, incluyendo procedimientos operativos estándar para la preparación de endoscopias y procedimientos de aseguramiento de calidad para el reprocesamiento de endoscopios y accesorios.
- Deben realizarse capacitaciones y reentrenamientos del personal involucrado en el cuidado del endoscopio, acorde a los lineamientos de la OMS. Así mismo debe mantenerse una cadena clara de rendición de cuentas para los procedimientos de procesamiento endoscópico.
- La sedación durante la colonoscopia debe ser administrada por un anestesiólogo en los pacientes con alguna de las siguientes características:
 - *Poco colaboradores*
 - *Con edades extremas*
 - *Morbilidad grave (cardíaca, pulmonar, hepática, renales o del sistema nervioso central)*
 - *Cualquier alteración del estado de conciencia*
 - *Obesidad mórbida*
 - *Apnea del sueño*
 - *Embarazo*
 - *Abuso de alcohol u otras drogas*
 - *Antecedente de sedación fallida*
 - *Antecedente de reacción adversa a cualquier medicamento utilizado en la sedación*
- El servicio de endoscopia digestiva debe tener un proceso formal para documentar la sedación y el confort del paciente usando el sistema de elección del servicio. El servicio debe auditar el uso de la sedación por parte de sus médicos.
- Considere incluir en el informe de la colonoscopia la utilización o no de la sedación,

el tipo de ésta y la existencia o no de complicaciones inmediatas.

- Se debe utilizar una lista de criterios como la puntuación de Aldrete (respiración, saturación de oxígeno, conciencia, circulación y niveles de actividad) para determinar la posibilidad de dar de alta al paciente.
- Antes de la sedación y antes de la aprobación del alta, debe informarse al paciente respecto a su capacidad de realizar tareas que requieran atención y la toma de decisiones que requieran juicio. La información impartida debe ser escrita y dada al paciente antes del alta.
- Se recomienda que el paciente asista con acompañante.
- Debido a que el período de amnesia que sigue a la administración de sedación es variable, se deben dar instrucciones por escrito al paciente, incluyendo los procedimientos a seguir si surge una emergencia.
- Todas las colonoscopias deben realizarse utilizando un colonoscopio con capacidad de video, que pueda mantenerse dentro de las especificaciones de los fabricantes.

- Los especialistas que realizan la endoscopia deben esforzarse por una preparación intestinal adecuada, y la calidad de la preparación intestinal debe ser registrada y monitorizada usando una escala estandarizada a elección del servicio de endoscopia digestiva, como lo es la escala de Boston.

- Debido a que la perforación es un evento raro, las tasas de perforación deben vigilar-se a nivel de la institución o del sistema. Es probable que las mediciones a nivel individual del especialista que realiza la endoscopia sean muy variables.

- Considere la tasa de intubación cecal sin ajustar como un indicador primario de la calidad de la colonoscopia. El estándar aceptable es mayor al 90%; el deseable es mayor al 95%.

- Considere conservar documentación y revisión de las razones para una colonoscopia incompleta.

- Los servicios de endoscopia deben tener procesos para identificar y registrar desenlaces adversos que se producen después de que el paciente deja el servicio de endoscopia.

En caso de que la colonoscopia no se pueda realizar o sea incompleta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado para cáncer colorrectal?

N RECOMENDACIÓN

- | | |
|----|--|
| 14 | Si una colonoscopia completa no se ha realizado ya sea porque la lesión primaria impide la colonoscopia total, o por cualquier otra razón, se sugiere visualizar radiológicamente el resto del colon antes de la cirugía, si es posible. Se sugiere que este procedimiento sea realizado idealmente por colonografía por tomografía computarizada, o si no está disponible, por enema de bario de doble contraste de alta calidad. |
|----|--|

- | | |
|----|--|
| 15 | Se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la colectomía, en aquellos casos en que no se logró visualización del colon antes de la cirugía. |
|----|--|

4.1.2. BLOQUE: ESTRATIFICACIÓN

¿Cuáles son los estudios para estadificación (de extensión) en pacientes con cáncer colorrectal?

N	RECOMENDACIÓN
16	Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.
17	Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste
18	Se recomienda las siguientes consideraciones para estadificar con TAC de tórax y abdomen (o RMN): • Evaluar la extensión local del tumor o infiltración a estructuras adyacentes. • Evaluar la presencia de metástasis distantes en pulmón, nódulos linfáticos del tórax y abdomen, hígado, cavidad peritoneal, y otros órganos. • La realización del TAC debe ser con contraste oral e intravenoso. • Considerar RMN con gadolinio en caso de alergia o contraindicación a los medios de contraste yodados. • Tomar las precauciones necesarias para pacientes con Enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 sin diálisis. • En caso de que haya contraindicación tanto para medio yodados como agentes basados en gadolinio, considere realizar RMN sin contraste IV.
19	Se sugiere realizar RMN de pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de recto.
20	Se sugiere realización de RMN de pelvis para valorar el estado del margen mesorrectal.
21	Se sugiere ofrecer estadiaje local preoperatorio por medio de resonancia magnética de pelvis a los pacientes con cáncer de recto detectado por tamización, aunque también la tomografía computarizada multicorte contrastada de alta calidad puede dar información adecuada.
22	Se sugiere realizar a todos los pacientes con cáncer de recto resonancia magnética para valorar el riesgo de recurrencia local, determinado por el margen de resección distal, el tumor (T) y el estadiaje nodular (N), a menos que esté contraindicado
23	Se sugiere usar los resultados de un examen digital rectal como parte complementaria de los demás estudios. El examen digital rectal es de especial valor para el equipo de cirugía en relación con el explorar movilidad del recto, altura del tumor respecto al pubo-rectal, así como corroborar los hallazgos de la RMN de pelvis.

24	Se sugiere ofrecer tomografía axial computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis a pacientes que están siendo evaluados por cáncer colorrectal metastásico.
25	Se sugiere ofrecer RMN o TAC de abdomen en lugar de ecografía para la detección de metástasis hepáticas. Si se evidencien lesiones inespecíficas en el TAC, se sugiere realizar RMN de abdomen.
26	Si la TAC muestra que el paciente puede presentar metástasis extra-hepáticas que sean susceptibles de cirugía radical, se sugiere que un equipo multidisciplinario decida si una tomografía por emisión de positrones- tomografía computarizada (PET-CT) de cuerpo completo es adecuada.
27	En los casos de cáncer de colon, si la TAC con contraste es sugestiva de enfermedad metastásica en la pelvis, se sugiere una resonancia magnética de pelvis y la discusión de sus resultados con el equipo multidisciplinario.
28	No se sugiere el uso rutinario de la tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico o estadiaje clínico del cáncer colorrectal en los estadios I a III.
29	Se sugiere ofrecer tomografía por emisión de positrones para determinar el manejo y el pronóstico si la imagen convencional es equívoca para la presencia de enfermedad metastásica.
30	Se sugiere ofrecer tomografía por emisión de positrones para la evaluación preoperatoria de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal antes de la resección quirúrgica.

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere discutir todas las imágenes con el paciente luego de la revisión por un apropiado equipo multidisciplinario.

4.1.3. BLOQUE: DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

¿Cuáles deben ser los estándares de calidad del reporte histopatológico en el cáncer colorrectal en biopsias diagnósticas, resección de pólipos, piezas quirúrgicas (colon y recto), y otros especímenes (mucosectomía)?

31	Se sugiere utilizar sólo dos grados en el reporte de neoplasia intraepitelial colorrectal (bajo grado y alto grado), para reducir al mínimo el error intraobservador e interobservador.
32	Se sugiere reportar los adenocarcinomas colorrectales de acuerdo con la clasificación TNM establecida la 8ª edición (o la que la sustituya) y al protocolo del College of American Pathologist, al momento del diagnóstico.
33	Se sugiere que el patólogo verifique la remoción completa de las lesiones neoplásicas (márgenes libres) y la ausencia de invasión de la submucosa en especímenes de biopsias, de acuerdo con la orientación dada por el endoscopista. Si hay resección fragmentada, no se puede describir márgenes.

- | | |
|----|--|
| 34 | Se sugiere reportar las características de alto riesgo para enfermedad residual de acuerdo con el Protocolo de resección establecido por el Colegio Americano de Patólogos. |
| 35 | Dadas las pequeñas dimensiones de la capa submucosa, la infiltración dentro del nivel de la submucosa se sugiere medir en milímetros o en micras desde la línea de fondo de la muscularis mucosae. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debería consultar un equipo multidisciplinario sobre si es recomendable o no realizar resección quirúrgica de un adenocarcinoma pT1; si la resección quirúrgica se recomienda, se debe considerar la posibilidad de obtener la opinión de un segundo patólogo dado que existe variación en la evaluación de las características de alto riesgo. Esta evaluación la realiza la IPS que va a manejar el paciente por lo que se debe garantizar el envío de los bloques de parafina y láminas histológicas si la histopatología se realizó en una institución diferente.
- Todas las biopsias y las lesiones identificadas en un programa de tamización y la subsecuente resección de especímenes deberían ser reportadas en un informe o formato electrónico de manera oportuna en el 100% de los casos. El formato debería ser enviado al médico tratante, al registro de cáncer pertinente y al programa de tamización.
- Considere reportar la correlación entre el diagnóstico histológico de biopsias y las resecciones. Cualquier falta de correlación, si bien son excepcionales, debería ser discutida por un equipo multidisciplinario y los resultados de esta discusión deberían documentarse.

4.1.4. BLOQUE: GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

¿Cuál debe ser la preparación preoperatoria de los pacientes con cáncer colorrectal que van a cirugía electiva?

- | | |
|----|--|
| 36 | Se recomienda que el cirujano considere, según su juicio, el beneficio de la preparación intestinal mecánica en cada paciente que será llevado a cirugía electiva para cáncer colorrectal. |
| 37 | En pacientes que son sometidos a cirugía oncológica abdominal o pélvica, se recomienda profilaxis farmacológica postoperatoria con duración extendida (cuatro semanas) con heparinas de bajo peso molecular en lugar de la profilaxis con duración limitada. |

¿Cuál es el mejor manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon resecable con obstrucción?

- 38 No se sugiere utilizar estudios de contraste con enema como la única modalidad de imagen en pacientes con obstrucción aguda del intestino grueso.

¿En qué casos está indicada la cirugía abierta o cirugía laparoscópica en pacientes con cáncer colorrectal?

- 39 Se sugiere la resección laparoscópica (incluida la laparoscopia asistida) como una alternativa a la resección abierta para individuos con cáncer colorrectal en quienes tanto la cirugía laparoscópica como la cirugía abierta se consideran adecuadas.
- 40 Para pacientes con cáncer de colon resecable que esté causando obstrucción manifiesta, se puede considerar como opción la inserción de un stent (en pacientes seleccionados) seguido de colectomía. Los stent colónicos están reservados generalmente para aquellos casos con lesiones distales en las cuales el stent puede permitir la descompresión del colon proximal con posterior colectomía electiva con anastomosis primaria.

4.1.5. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR IN SITU

¿Cuál es el manejo quirúrgico indicado en pacientes con cáncer colorrectal estadio 0 (TisNO)?

- 41 Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) en pacientes con cáncer de colon que tengan las siguientes características:
1. Tumores bien o moderadamente diferenciados
 2. Tumores no ulcerados
 3. Tumores menores de 3 centímetros, si bien la determinación de resecabilidad es la base de implantación
 4. Con viabilidad técnica para su realización
 5. Que levante a la infiltración y no presente una separación de las capas mucosas y submucosa para una resección segura.
 6. Se prefiere la resección en bloque a la resección fragmentada.
- 42 En pacientes con estadio 0 (tumores In situ) de cáncer colorrectal se sugiere hacer resección endoscópica o local corroborando con patología sus márgenes laterales y profundos negativos.
- 43 Si hay sospecha clínica de un cáncer colorrectal pT1, se sugiere que el sitio de la escisión sea marcado con tinta china en la submucosa
- 44 En pacientes con cáncer de colon que fueron llevados a resección local, con hallazgos patológicos de alto riesgo (márgenes no claros e invasión del tercio profundo de la submucosa (T1/sm3) o más profundo (T2)), se sugiere realizar resección radical.

- | | |
|----|---|
| 45 | En pacientes con cáncer de colon, con lesiones más grandes (2 a 3 centímetros), altamente sospechosas de ser estadio 0 (tumor in situ) y que no sean susceptibles de polipsectomía o resección local, se sugiere realizar resección segmentada. |
| 46 | En pacientes con cáncer de recto, con lesión estadio 0 o T1 sm1 (hasta tercio superficial de la submucosa) no susceptibles de resección local endoscópica, se sugiere realizar resección local transanal si la lesión es cercana al ano. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Para que el paciente pueda tomar una decisión informada, el médico tratante debería explicarle la posibilidad de hacer una escisión local como tratamiento para el cáncer de recto, incluyendo los riesgos referentes a la morbilidad operatoria y la recurrencia.

4.1.6. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR EN ESTADIO TEMPRANO

¿Cuál es el manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal estadio temprano?

Cáncer de colon

- | | |
|----|---|
| 47 | En pacientes con cáncer de colon estadio 0-I, con indicación de cirugía radical pero con baja expectativa de vida o alto riesgo quirúrgico, se sugiere llevar caso a Junta Multidisciplinaria e individualizar cada caso para determinar balance beneficio/riesgo entre la intervención quirúrgica y dejar en observación. |
| 48 | En pacientes con cáncer de colon se sugiere considerar la cirugía abierta o mínimamente invasiva como opciones para llevar a cabo la resección quirúrgica oncológica, dependiendo de la disponibilidad del recurso tecnológico y el entrenamiento del personal médico. |
| 49 | Se sugiere que el cáncer de colon sea tratado con cirugía radical con escisión mesocólica completa. La extensión de la disección de los ganglios linfáticos durante la cirugía está determinada por los hallazgos clínicos pre-operatorios y la extensión de las metástasis linfáticas y en la profundidad de invasión del tumor observada intra-operatoriamente. |

Cáncer de recto

- | | |
|----|--|
| 50 | <p>Se sugiere realizar resección local (polipsectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) abierta o con técnicas endoscópicas, en pacientes con cáncer de recto que tengan las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumores que comprometan hasta T1 sm2 2. Tumores bien o moderadamente diferenciados 3. Tumores no ulcerados 4. Tumores menores de 3 centímetros 5. Con viabilidad técnica para su realización 6. Que levante a la infiltración |
|----|--|

51	Se sugiere realizar resección radical en pacientes con cáncer de recto y alguna de las siguientes características: • Lesiones T2 • Tumor mal diferenciado • Tumor ulcerado • Invasión perineural – linfovascular
52	En pacientes con cáncer de recto que fueron llevados a resección local, con hallazgos patológicos como márgenes no claros e invasión del tercio profundo de la submucosa (T1/sm3) o más profundo (T2), mala diferenciación, o invasión linfovascular o perineural, se sugiere realizar resección radical, quimiorradioterapia o ambas.
53	En los pacientes con cáncer de recto con un tumor resecable, se sugiere cirugía con escisión total del mesorrecto. La escisión del mesorrecto debería ser total para los tumores de los tercios medio e inferior del recto, con cuidado de preservar los nervios autonómicos pélvicos siempre que ello sea posible sin comprometer la resección del tumor.
54	Con una anastomosis rectal baja (menor de 5 cm de la unión anorrectal) se recomienda realizar un estoma desfuncionalizante.
55	Con una anastomosis rectal baja después de una escisión total del mesorrecto (TME), se sugiere considerar un reservorio colónico.

Puntos de buena práctica clínica:

- En el manejo del cáncer de recto temprano, un equipo multidisciplinario debería discutir el esquema de tratamiento a ofrecer a los pacientes con diagnóstico de novo.
- Todos los pacientes sometidos a cirugía radical para cáncer rectal deberían ser sometidos a escisión del mesorrecto por un cirujano con experiencia en cirugía colorrectal.
- Se recomienda utilizar la RMN durante la evaluación de las lesiones tempranas del recto, antes de la resección quirúrgica, con el fin de definir la invasión de la lesión y determinar la estrategia terapéutica indicada.
- La ultrasonografía endoscópica rectal podría ser una opción dependiendo de la disponibilidad de centros con endosonógrafos y con experiencia en el contexto clínico de cáncer de recto.
- Después de la extirpación de un cáncer colorrectal pT1, se debería establecer un régimen de seguimiento estandarizado, con colonoscopia, antígeno carcinoembrionario e imágenes (ver recomendaciones de Seguimiento).
- La política de vigilancia empleada de un cáncer colorrectal pT1 de riesgo bajo es apropiada para el seguimiento después de la extirpación para los adenomas de riesgo alto.
- Solamente considere escisión total del mesorrecto por vía trans-anal para realizarse en un Centro de Excelencia en los cuales haya: un escenario de seguimiento estricto por auditoría y gobernanza clínica; por cirujanos experimentados en este tipo de procedimiento y que hayan tenido entrenamiento específico en esta técnica quirúrgica; y que se cuente con un mecanismo de monitoreo de los resultados.

4.1.7. BLOQUE: MANEJO DE TUMOR LOCALMENTE AVANZADO

En este bloque se abordan las siguientes preguntas clínicas:

¿En qué casos está indicado el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?

¿En qué casos está indicada la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?

¿En qué casos está indicada la realización de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto?

ENFOQUE CONVENCIONAL: *cáncer de colon y recto*

- | | |
|----|--|
| 56 | Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante posterior a cirugía en pacientes con cáncer de colon estadio II de alto riesgo. Se deberían discutir todos los riesgos y beneficios con el paciente. |
| 57 | Se sugiere evaluar la estadificación patológica posterior a cirugía antes de decidir ofrecer o no quimioterapia adyuvante. |
| 58 | Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT) |
| 59 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo, se sugiere considerar el uso de capecitabina como alternativa al 5-fluorouracilo en terapia adyuvante, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT) |
| 60 | Para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer colorrectal estadio III posterior a cirugía para esta condición, se sugiere el uso de oxaliplatino en combinación con 5-fluorouracilo y ácido folínico, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT) |
| 61 | Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino. |
| 62 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino. |

ENFOQUE CONVENCIONAL: *cáncer de recto solamente*

- | | |
|----|--|
| 63 | En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento es la quimiorradioterapia como terapia preoperatoria en pacientes estadios T3 y T4, con cualquier N. |
|----|--|

64	Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento: • 5-fluorouracilo infusional continuo o • 5-fluorouracilo/Leucovorina o • Capecitabina.
65	Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal estadio II de alto riesgo y en todos los estadios III para reducir el riesgo de recurrencia sistémica, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT).
66	Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
67	En pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo, se sugiere considerar el uso de capecitabina como alternativa al 5-fluorouracilo en terapia adyuvante, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
68	Para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer colorrectal estadio III posterior a cirugía para esta condición, se sugiere el uso de oxaliplatino en combinación con 5-fluorouracilo y ácido folínico, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
69	Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino.
70	En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino.
71	Se recomienda radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal con tumor residual irresecable (márgenes positivos), según reporte de hallazgos anatomopatológicos del espécimen quirúrgico, o en pacientes con riesgo moderado o alto que no han recibido neoadyuvancia, si bien el mayor beneficio se obtiene con Radioterapia en neoadyuvancia.
72	Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con quimiorradioterapia concomitante.

Puntos de buena práctica clínica:

- La elección del tratamiento adyuvante debería realizarse a través de un enfoque multidisciplinario. La Junta Multidisciplinaria debe tener en cuenta las contraindicaciones y el perfil de efectos secundarios del (los) agente(s) y el método de administración, como también el estado clínico y las preferencias del paciente.

ESQUEMA DE TERAPIA NEOADYUVANTE TOTAL (TNT): Cáncer de recto solamente

737	En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento consiste en un curso corto de Radioterapia, el cual brinda un control local de la enfermedad con un impacto similar en la supervivencia global en comparación con el esquema convencional.
74	En paciente con cáncer de recto con T3 o T4, con cualquier N, una opción apropiada es ofrecer un curso corto de Radioterapia (25 Gy en 5 fracciones) seguida por 12-16 semanas de quimioterapia con FOLFOX o CAPEOX.
75	Se recomienda que, luego de aplicar el curso corto de radioterapia y las 12-16 semanas de quimioterapia, se realice una re-estadificación del paciente antes del tratamiento quirúrgico. La resección debe realizarse luego de 5-12 semanas de haberse completado la terapia neoadyuvante.
76	Si luego del tratamiento primario, la resección está contraindicada, el paciente debería ser tratado con el régimen sistémico para enfermedad avanzada.
77	Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con radioterapia de curso corto en centros donde se pueda ofrecer radioterapia con acelerador lineal con técnica conformacional (IMRT).

Puntos de buena práctica clínica:

- La evaluación de la RT de corta duración debe realizarse dentro de un equipo multidisciplinario, con una discusión sobre la necesidad de reducir el estadio y la posibilidad de toxicidad a largo plazo.

4.1.8. BLOQUE: MANEJO EN CÁNCER METASTÁSICO

¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer colorrectal metastásico?

78	Si tanto el tumor primario como el metastásico son resecables, se sugiere que el equipo multidisciplinario considere tratamiento sistémico inicial seguido de cirugía, después de una discusión exhaustiva con el paciente. La decisión sobre si las cirugías se realizan al mismo tiempo o de manera separada, debería ser evaluada por el equipo multidisciplinario, en conjunto con el paciente, considerando si se trata de un paciente oligometastásico o no.
----	--

79	En pacientes con cáncer de colon o de recto superior y medio, se sugiere la citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), como una opción de tratamiento en pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria al cáncer colorrectal, quienes cumplan todos los siguientes criterios: • Pacientes entre 18 y 70 años. • Sin comorbilidad de alto riesgo. • Con índice de carcinomatosis ≤ 17 en la presentación inicial, luego de la neoadyuvancia y en caso de una recidiva tardía. • Enfermedad confinada en el abdomen. • Menos de tres metástasis hepáticas fácilmente resecables. • Sin enfermedad retroperitoneal extensa. • ECOG < 2. • Sin oclusión intestinal.
80	En pacientes con cáncer de colon estadio IV por carcinomatosis peritoneal que requieren cirugía de urgencia, se sugiere confirmar diagnóstico histopatológico, derivar, y posteriormente definir si es candidato o no a procedimiento de HIPEC.
81	Se sugiere realizar biopsia en aquellos pacientes con una única lesión pulmonar para descartar cáncer de pulmón primario.

¿Cuáles son las opciones de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer colorrectal metastásico?

82	Se sugiere considerar terapia sistémica perioperatoria si la resección hepática es susceptible de tratamiento.
83	Se sugiere quimioterapia con técnicas de ablación local para pacientes con cáncer colorrectal con metástasis hepáticas que no son susceptibles de resección. El caso debe ser discutido por el equipo multidisciplinario.
84	Se sugiere realizar metastasectomía o radiación corporal estereotáctica para pacientes con oligo-metástasis pulmonares que son susceptibles de manejo local. El caso debe ser discutido por el equipo multidisciplinario.
85	Al ofrecer múltiples drogas quimioterapéuticas a pacientes con cáncer colorrectal avanzado, irrecable o metastásico, se recomienda considerar una de las siguientes secuencias de quimioterapia, a menos que estén contraindicadas: • FOLFOX (folinato de calcio más fluorouracilo más oxaliplatino) o XELOX (capecitabina más oxaliplatino) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en irinotecán (irinotecán o FOLFIRI) como tratamiento de segunda línea. • FOLFIRI (folinato de calcio más fluorouracilo más irinotecán) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en oxaliplatino (FOLFOX o XELOX) como tratamiento de segunda línea. Se debería decidir la combinación y secuencia de quimioterapia a emplear después de una evaluación y discusión completa de los posibles efectos secundarios y las preferencias del paciente.

- | | |
|----|--|
| 86 | Se sugiere considerar la terapia oral con capecitabina o infusión de 5-FU como tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico. |
| 87 | El FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico se recomienda como alternativa al uso de FOLFOX (ácido folínico más fluorouracilo más oxaliplatino) o FOLFIRI (ácido folínico más fluorouracilo más irinotecan) en pacientes seleccionados con excelente estado funcional, después de discutir con el paciente los posibles efectos secundarios y los beneficios del tratamiento. |
| 88 | El uso de FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) se sugiere como una opción quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, en casos seleccionados. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere dar prioridad al tratamiento para el paciente con cáncer colorrectal presenta controlar los síntomas si en algún momento síntomas del tumor primario.

¿Cuáles estudios de biología molecular deben realizarse al espécimen quirúrgico de los pacientes con cáncer colorrectal y cuáles son las opciones de terapia dirigida (target)?

- | | |
|----|---|
| 89 | En cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable) se sugiere realizar estudio de biología molecular para determinar mutación de RAS (RAS extendido) y BRAF. |
| 90 | En pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable), se sugiere considerar como factor predictivo favorable de la respuesta al tratamiento con anticuerpos anti-EGFR, la presencia de KRAS y NRAS nativos o no mutados. |
| 91 | Se sugiere la determinación rutinaria de la inestabilidad microsatelital como estudio molecular predictor de respuesta en pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable). |
| 92 | Bevacizumab en combinación con regímenes de quimioterapia basados en fluoropirimidina, oxaliplatino y/o irinotecán en primera o segunda línea de tratamiento, es recomendado como opción de tratamiento para pacientes con cáncer colorrectal avanzado en quienes los beneficios exceden los riesgos de toxicidad. |
| 93 | La monoterapia con cetuximab o panitumumab se recomienda como una opción de tratamiento en tercera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con KRAS y NRAS nativos que han fallado a otros tratamientos previos. |
| 94 | En pacientes con cáncer colorrectal metastásico o irresecable, se recomienda la terapia de mantenimiento con una monoterapia: fluoropirimidina y/o un anticuerpo monoclonal después de haber sido utilizados como parte de quimioterapia de combinación en primera línea de tratamiento. |
| 95 | En pacientes llevados a cirugía de resección de metástasis y que posterior a ésta no tienen evidencia de enfermedad residual macroscópica, se recomienda tratamiento complementario postoperatorio con 3 a 6 meses de quimioterapia basada en fluoropirimidina +/- oxaliplatino (según régimen previo). En estos pacientes no se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales como parte de la quimioterapia postoperatoria. |

4.1.9. BLOQUE: SEGUIMIENTO

¿Cuál es la mejor estrategia de seguimiento y con qué periodicidad debe realizarse en pacientes con cáncer colorrectal tratado?

96	Luego de haber terminado el tratamiento potencialmente curativo, se sugiere programar visita de seguimiento a todos los pacientes con cáncer colorrectal que incluya exploración física y prueba de antígeno carcinoembrionario, en las siguientes frecuencias por periodo: • Año 1 y 2: cada 3-6 meses. • Año 3, 4 y 5: cada 6 meses.
97	En paciente con cáncer colorrectal con estadios II-III que se encuentran en seguimiento, se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen-pelvis cada año durante 5 años. En estadio IV, se sugiere toma de TAC cada 6 meses durante los primeros 2 años. Luego cada año hasta completar 5 años.
98	En paciente con cáncer de recto estadios II, III y IV, se recomienda la toma de RMN cada 3-6 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta completar 5 años, únicamente en aquellos en que se les haya realizado una escisión local trans-anal.
99	En casos excepcionales y como última opción, si los recursos locales y/o las preferencias del paciente excluyen el uso de la tomografía axial computarizada, se sugiere sustituir con un ultrasonido la tomografía de abdomen y de pelvis y sustituir con una radiografía de tórax la tomografía de tórax.
100	Se sugiere realizar una colonoscopia de seguimiento aproximadamente un año después de la cirugía inicial. La frecuencia de las colonoscopias de vigilancia posteriores debería depender de los resultados de la anterior, esto es, repetir al año si se evidenció adenoma avanzado, de lo contrario, repetir al 3er año, y después cada 5 años.
101	Si una colonoscopia completa no se realizó en el transcurso del diagnóstico y la estadificación (por ejemplo, debido a una obstrucción), la evidencia sugiere hacer una colonoscopia dentro de los seis meses siguientes de haber completado la terapia primaria.
102	No se sugiere la tomografía con emisión de positrones como parte de la vigilancia de rutina en pacientes con cáncer colorrectal tratados con cirugía curativa.
103	Se sugiere realizar tomografía con emisión de positrones para determinar el sitio de recurrencia en pacientes que tienen aumento del antígeno carcinoembrionario con imágenes convencionales que no identifican enfermedad metastásica.
104	Se sugiere considerar una recurrencia con cualquier síntoma nuevo y persistente o que empeore, en el contexto de elevación del CAE y otros paraclínicos. Entre los síntomas sugerentes de recurrencia se encuentran: • Dolor abdominal, particularmente en el cuadrante superior derecho o en el flanco derecho (área hepática). • Tos seca. • Síntomas vagos constitucionales como fatiga o náuseas. • Pérdida de peso inexplicable. • Signos y/o síntomas específicos para cáncer rectal: dolor pélvico, ciática, dificultad para orinar o defecar. • No hay señales de síntomas específicos para el cáncer de colon que no fueran aplicables también al cáncer de recto.

105

En pacientes con cáncer colorrectal a quienes se haya realizado tratamiento con preservación de esfínter anal, se sugiere realizar valoración especializada por fisiatría, o terapia de piso pélvico, para direccionar el proceso de rehabilitación. Así mismo, se sugiere la realización de ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico direccionados por terapeuta e idealmente a través de la realización de terapia biofeedback del piso pélvico como estrategia de rehabilitación para el manejo de incontinencia esfinteriana.

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere iniciar una nueva investigación si existe alguna sospecha clínica, radiológica o bioquímica de enfermedad recurrente.
- Considere detener el seguimiento regular cuando el paciente y el médico tratante han discutido y acordado que los posibles beneficios no compensan los riesgos de nuevas pruebas o cuando el paciente no puede tolerar otros tratamientos, luego de 5 años desde la culminación de tratamiento primario.
- Los pacientes con cáncer colorrectal podrían beneficiarse de un programa de rehabilitación basado en actividad física cardiovascular y rehabilitación de piso pélvico (si aplica), que se encuentre dentro de un programa integral de manejo.
- Para la medición de la calidad de vida de pacientes con cáncer colorrectal considere el uso de instrumentos validados en la población colombiana.

4.1.10. BLOQUE: CUIDADOS PALIATIVOS

¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para lograr el empoderamiento del paciente, mayor introspección de la enfermedad y disminución del temor al tratamiento instaurado?

106

Se recomienda la utilización del Protocolo SPIKES como herramienta de comunicación con los pacientes oncológicos con el fin de evaluar las percepciones del paciente respecto a su enfermedad, activar mecanismos de resiliencia, informar, y valorar su respuesta emocional.

107

Se sugiere la utilización de ayudas para la toma de decisiones para mejorar la comunicación entre el paciente y el equipo de cuidados paliativos y médicos tratantes.

108

Se recomienda que unos de los temas de comunicación con el paciente con cáncer y su familia sea sobre el pronóstico de su enfermedad, con el fin de que se exista un entendimiento apropiado del mismo y comprenda el plan de manejo a seguir, en especial cuando el tratamiento instaurado no tiene intención curativa.

¿Cuáles serían los criterios de derivación temprana al programa de cuidados paliativos?

- | | |
|-----|---|
| 109 | Se recomienda remitir al Equipo Cuidados Paliativos a todo paciente con diagnóstico de cáncer localmente avanzado o metastásico. |
| 110 | <p>En paciente con estadio temprano de la enfermedad, se sugiere realizar interconsulta al Equipo de Cuidados Paliativos, si presenta uno o más de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Síntomas incontrolados. • Angustia de moderada a grave relacionada con el diagnóstico y la terapia del cáncer. • Enfermedades físicas y psicosociales comórbidas graves. • Necesidades psicosociales complejas. • Conciencia de pronóstico pobre. • Enfermedad potencialmente fatal o de alta mortalidad. • Inquietudes del paciente / familia / cuidador sobre el curso de la enfermedad y la toma de decisiones. • Solicitud de cuidados paliativos del paciente / familia / cuidador. • Solicitud del paciente de muerte anticipada. <p>(Criterios adoptados de la NCCN 2020)</p> |
| 111 | Se sugiere el uso del instrumento NECPAL CCOMS-ISO como estrategia complementaria para identificar pacientes que requieren de cuidados paliativos. |

¿Cuál es el impacto de la derivación temprana (o acceso temprano) al programa de cuidados paliativos respecto al control de síntomas, introspección de la enfermedad, tolerancia, adherencia y continuidad al tratamiento?

- | | |
|-----|---|
| 112 | Se recomienda la derivación temprana de pacientes para cuidados paliativos con el fin de mejorar la calidad de vida, brindar bienestar al paciente y sus familiares, mejorar el control de los síntomas, mejorar la adherencia a los tratamientos instaurados, y mejorar las complicaciones afectivas y socio-familiares. |
|-----|---|

¿Cuál es la efectividad de la intervención psicosocial respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?

- | | |
|-----|---|
| 113 | Se recomienda que las intervenciones psicosociales relacionadas con el manejo de la colostomía incluyan aspectos de auto-imagen, auto-estima, vida sexual, y adaptación psico-social. |
| 114 | Se sugiere que las intervenciones psicosociales relacionadas con el manejo de la colostomía se realicen previo al procedimiento quirúrgico. |
| 115 | Se sugiere brindar educación e información acerca del cuidado de la ostomía, en especial en lo relacionado con evitar fugas, manejo de los olores y cuidados de la piel periestomal. |

¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?

- | | |
|-----|---|
| 116 | Se sugiere la vinculación de pares como intervención complementaria a las acciones individuales del equipo psicosocial, encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento médico. |
|-----|---|

¿Cuál es la efectividad de la terapia enterostomal respecto al cuidado de la ostomía y prevención de complicaciones de la misma?

- | | |
|-----|--|
| 117 | Se recomienda la implementación de un programa del cuidado del estoma, en el que se incluya intervenciones educativas, con el fin de reducir las complicaciones, mejorar la adaptación psicosocial y mejorar la adherencia a los tratamientos oncológicos. |
|-----|--|

¿Cuál es la indicación del soporte transfusional en relación con el manejo de síntomas de anemia?

- | | |
|-----|--|
| 118 | Se recomienda individualizar cada paciente frente a la necesidad de soporte transfusional en aquellos pacientes con anemia y síntomas asociados (fatiga, disnea) de acuerdo con sus características clínicas, estado funcional, pronóstico y preferencias. |
|-----|--|

¿Cuál es el beneficio del soporte de hidratación?

- | | |
|-----|---|
| 119 | Se sugiere administrar soporte de hidratación de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente, intensidad de síntomas asociados a deshidratación, pronóstico y preferencias. En caso de que el médico tratante lo indique, se preferirá la vía oral a la vía parenteral. |
| 120 | Se sugiere que la cantidad de líquidos administrados para el soporte de hidratación debe ser en la cantidad mínima posible. |
| 121 | En paciente con cáncer avanzado con buen grado de funcionalidad (IK>50), se sugiere brindar soporte de hidratación por vía oral, en el contexto de soporte nutricional. |
| 122 | En paciente con cáncer avanzado con deterioro de su funcionalidad (IK<50), se sugiere optimizar la vía oral. Si se requiere de hidratación parenteral, se puede efectuar una hidratación durante 24 horas y luego revalorar clínicamente. |

Puntos de buena práctica clínica:

- El médico tratante determinará, acorde a su criterio y valoración de las condiciones actuales del paciente, la vía de elección para el soporte de hidratación parenteral (endovenosa vs subcutánea), así como el tipo de líquidos a administrar.

¿Cuál es la indicación de la sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios?

- | | |
|-----|---|
| 123 | Se recomienda el uso de sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios, esto es, síntomas que no han podido tratarse adecuadamente a pesar de cuidados paliativos integrales e interdisciplinarios.

(Adaptado de la guía NCCN Palliative Care v1.2020) |
| 124 | Se recomienda el uso de sedación paliativa en el contexto de un paciente con indicios de sufrimiento intenso y que se encuentra al final de la vida. |
| 125 | Se sugiere definir el plan de sedación paliativa de acuerdo con la respuesta del paciente a medicamentos previos y actuales, considerando como primera opción el uso de midazolam. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debe garantizar analgesia y sedación teniendo en cuenta síntomas fisiológicos (presencia de tensión arterial, taquicardia, taquipnea, diaforesis, contracturas musculares, mioclonías, estado de conciencia).
- Se debe comentar ampliamente con el paciente y sus cuidadores acerca de en qué consiste la sedación paliativa, lo que representa los síntomas refractarios y el sufrimiento intenso, y que frecuentemente se acompaña del retiro de medidas que prolongan la vida (nutrición/hidratación artificial) incluyendo reanimación cardiopulmonar. Para esto último se debe tener en cuenta las consideraciones sobre el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), reglamentado por la Resolución 2665 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya.
- Se debe continuar con los tratamientos para el dolor y manejo sintomático, y titular de acuerdo con la respuesta del paciente.

¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico y no farmacológico en el manejo del síndrome de anorexia-caquexia?

- | | |
|-----|--|
| 126 | Considere el diagnóstico de síndrome de anorexia-caquexia cuando se evidencia una pérdida de peso >5% durante los últimos 6 meses (en ausencia de inanición); o un Índice de masa corporal <20 kg/m ² y con cualquier grado de pérdida de peso >2% |
| 127 | Se recomienda evaluar para condiciones o sintomatología que pueda interferir con la ingesta: <ul style="list-style-type: none"> • Disgeusia • Xerostomia • Mucositis • Candidiasis oro-faríngea • Depresión • Saciedad temprana por gastroparesis • Náusea o vómito • Disnea • Constipación |

- Dolor
- Fatiga
- Insuficiencia enzimática del páncreas exocrino
- Trastornos de la alimentación/alteraciones de la autoimagen
- Medicamentos que interfieran con la alimentación
- Hipogonadismo
- Disfunción tiroidea
- Anormalidades metabólicas (v.g., hipercalcemia)

(Adoptada de la guía NCCN Palliative Care v1.2020)

128

Se sugiere iniciar tratamiento farmacológico con corticoesteroides, acetato de megestrol u otros estimulantes del apetito. La elección del medicamento estará bajo el criterio del médico tratante y de acuerdo con la condición general del paciente, expectativa de vida, comorbilidades (si hay infección estaría contraindicado el uso de esteroides, o hemorragia uterina no debe administrarse megestrol), así como preferencias del paciente.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

129

Se sugiere ofrecer medidas no farmacológicas como son: educación e información sobre la disminución del apetito y sed en la persona que se encuentra al final de la vida y que el soporte nutricional no revertirá la pérdida de peso, medidas para el cuidado de la mucosa oral y labios, fraccionamiento de las comidas, dieta hiposódica e hipograsa, y soporte psicológico al paciente, familia y cuidadores.

(Adaptada de la guía NCCN Palliative Care v1.2020)

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debe tener en cuenta la condición de pre-caquexia (pérdida de peso <5%, anorexia y cambios metabólicos como intolerancia a la glucosa) como parte del espectro clínico de caquexia, con el propósito de iniciar medidas terapéuticas de manera anticipada.

¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico en el manejo del dolor?

130

Se sugiere realizar una valoración integral del dolor así como el uso de escalas validadas para la cuantificación de la intensidad del dolor como lo son las escalas visuales análogas (EVA), escala de dolor de pacientes con demencia (PAINAD), cuestionario breve del dolor (CBD) o con la que el médico tratante se encuentre más familiarizado.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

131

Se recomienda el uso de la escalera analgésica de la OMS como herramienta para orientar la toma de decisiones respecto al tratamiento farmacológico a seguir.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

132	Se recomienda el uso de morfina oral como el medicamento de primera línea para el alivio del dolor moderado o severo o dolor irruptivo, y si hay falla renal, ajustar de acuerdo con la tasa de filtración glomerular.
133	En paciente en situación terminal con dolor intenso no controlado a pesar del tratamiento inicial, se sugiere una rotación o cambio de opioide, teniendo en cuenta equipotencia analgésica, iniciar con un 25% menos de la dosis calculada para el nuevo opioide, y ajustar según eventos adversos. (Adoptada de la guía colombiana 2016)
134	Se recomienda descenso progresivo de analgésicos y adecuar dosis de según respuesta del paciente en caso de que se decida reducir dosis ante desaparición del dolor. Con el fin de evitar síndrome de abstinencia a opioides, se debe prescribir siempre dosis de rescate. (Adaptada de la guía colombiana 2016)
135	Se sugiere complementar el manejo con opioides con medidas preventiva para estreñimiento (ver apartado de recomendaciones sobre estreñimiento) (Adaptada de la guía colombiana 2016)
136	Se sugiere el uso de amitriptilina, gabapentina o pregabalina como tratamiento de primaria línea para el manejo de dolor neuropático oncológico, salvo en neuralgia del trigémino en el que la opción iniciar es carbamazepina. (Adaptada de la guía colombiana 2016)
137	En caso de que no haya adecuada respuesta al manejo inicial, se sugiere complementar con opioides fuertes con perfil de manejo de dolor neuropático: metadona, oxicodona, tapendadol u opioides débiles como el tramadol. (Adaptada de la guía colombiana 2016)

Puntos de buena práctica clínica:

- Los opioides más utilizados en Colombia son (en orden alfabético): buprenorfina transdérmica, codeína, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, tapendadol y tramadol. Se debe verificar las actualizaciones de las indicaciones INVIMA y de la incorporación de nuevos medicamentos en el mercado colombiano respecto a este grupo farmacológico.
- Se debe tener en cuenta las contraindicaciones del uso de amitriptilina en pacientes mayores a 50 años.

¿Cuál es la efectividad de las terapias invasivas en el manejo del dolor?

- | | |
|-----|---|
| 138 | Se recomienda remitir a consulta especializada en intervencionismo para alivio del dolor en aquellos pacientes en que haya persistencia de dolor intenso a pesar de analgesia adecuada y/o presencia de efectos adversos intolerables.

(Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |
| 139 | Se debe evaluar riesgo / beneficio del manejo intervencionista de acuerdo con las preferencias del paciente, expectativa de vida y comorbilidades que impiden el aumento de dosis de opioides (insuficiencia renal, insuficiencia hepática).

(Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |
| 140 | Se debe considerar la reducción de opioides en caso de que el manejo intervencionista resulte exitoso en aliviar el dolor.

(Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo del estreñimiento?

- | | |
|-----|---|
| 141 | De acuerdo con el estado clínico del paciente, se recomienda el uso de laxantes orales junto con una dieta alta en fibra y adecuada hidratación, y ejercicio ajustado al paciente.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 142 | En caso de impactación fecal, puede utilizarse productos rectales (supositorios o enemas), con especial precaución en pacientes con riesgo de citopenia.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |

Puntos de buena práctica clínica:

- En caso de realizar desimpactación fecal manualmente, considere sedación con benzodicepinas.
- Antes de prescribir laxantes, evalúe la presencia de causas secundarias:
 - Obstrucción intestinal
 - Inflamación recto-anal
 - Hipercalcemia
 - Hipokalemia
 - Hiponatremia
 - Hipotiroidismo
 - Diabetes mellitus
 - Medicamentos (opioides, anticolinérgicos, antihipertensivos, AINEs, agentes con suplementos de aluminio, calcio, hierro).

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo de la diarrea?

- | | |
|-----|---|
| 143 | <p>Se sugiere determinar el grado de diarrea por toxicidad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado 1: incremento de <4 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento leve de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 2: incremento de 4-6 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos moderados que no interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento moderado de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 3: incremento de ≥7 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos severos e incontinencia que interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento severo de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 4: incremento de >10 deposiciones al día y puede acompañarse de sangrado rectal o franca hematoquecia y requiere de soporte parenteral. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento que puede comprometer el estado hemodinámico del paciente y requerir de manejo hospitalario. <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 144 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 1, se recomienda brindar hidratación oral y reposición de electrolitos, e inicie loperamida (si no está recibiendo opioides).</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 145 | <p>Se sugiere administrar loperamida hasta conseguir 12 horas sin deposiciones y en el caso de la radioterapia, durante el tiempo que dure el tratamiento. No debe superarse la dosis máxima de 16 mg día.</p> <p>(Adoptada de la guía colombiana 2016)</p> |
| 146 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 2, se recomienda administrar líquidos vía endovenosa si no hay tolerancia a la vía oral, continuar con loperamida (o iniciarla) y considere uso de anticolinérgicos. Si se sospecha de diarrea por inmunoterapia o radioterapia, considere utilizar corticoesteroides.</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 147 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 3 o 4, se recomienda considerar hospitalizar de acuerdo con el criterio del médico tratante y plan de cuidados del final de vida, continuar anti-diarreicos y/o anticolinérgicos, y considerar como alternativa el uso de análogos de somatostatina ante diarrea refractaria.</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el manejo de la disnea?

- | | |
|-----|---|
| 148 | Se sugiere evaluar por causas potencialmente reversibles de disnea, como lo son las exacerbaciones de EPOC, crisis asmática, condiciones cardíacas, derrame pleural o pericárdico, síndrome de vena cava superior, u obstrucción de vía aérea.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 149 | Se recomienda el uso de morfina como medicamento de primera elección para el manejo de la disnea.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 150 | Se sugiere el uso de benzodiacepinas si coexiste trastorno de ansiedad. Se debe tomar medidas para prevenir el riesgo de depresión respiratoria si el paciente ya viene recibiendo opioides.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |
| 151 | Se sugiere el uso de oxígeno solo en aquellos casos de hipoxia sintomática.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |
| 152 | Se puede complementar el manejo de disnea con medidas no farmacológicas como lo son: los abanicos, aires acondicionados, medidas de relajación y confort físico.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |

¿Cuál es el efecto del uso de diuréticos en comparación con paracentesis para el manejo de la ascitis?

- | | |
|-----|---|
| 153 | Se sugiere el uso de paracentesis para el manejo sintomático de la ascitis peritoneal.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 154 | Se sugiere el uso de diuréticos solamente en casos muy seleccionados, en los que se sospeche hipertensión portal concomitante.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |

¿Cuáles serían las indicaciones de un dren peritoneal permanente para el manejo de ascitis?

- | | |
|-----|--|
| 155 | Se sugiere el uso de catéter peritoneal permanente en casos muy seleccionados en los que se haya documentado ascitis recurrente y refractaria al tratamiento, con el fin de evitar urgencias, complicaciones peritoneales por paracentesis a repetición, mejor confort en domicilio (con cuidador entrenado). Se debe descartar contraindicaciones como son: ascitis loculada, coagulopatía o infección de cavidad peritoneal. |
|-----|--|

4.1.11. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL PACIENTES CON CÁNCER

¿Cuál es la indicación y beneficio de las intervenciones nutricionales en el paciente con cáncer avanzado?

156	Se sugiere explicar como el peso corporal, los alimentos y la actividad física afectan el cáncer de colon y su tratamiento.
157	Se recomienda impartir consejos de alimentación dirigida por nutricionista en la que permita una adecuada tolerancia pensando siempre en el confort del paciente
158	Se sugiere remitir los enfermos con obesidad, desnutrición, sarcopenia o caquexia a nutricionistas, idealmente, con experiencia o entrenamiento acreditado en Oncología.
159	Se recomienda adaptar la intervención dietética a la situación individual, teniendo en cuenta las alteraciones metabólicas causados por el tumor y el tratamiento oncológico, y las propiedades nutraceuticas de los alimentos para regular el metabolismo celular.
160	Se recomienda evitar los regímenes hipercalóricos ricos en grasas saturadas y azúcares para mantener o recuperar el peso corporal.
161	Se recomienda ofrecer consejo personalizado para el uso correcto de suplementos nutricionales orales en situaciones de desnutrición e incapacidad de cubrir los requisitos nutricionales — los Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APMES) ordenados deben estar aprobados por el INVIMA para pacientes oncológicos.
162	Se sugiere pesquisar y corregir la deficiencia de vitamina D.
163	Se recomienda evitar dosis elevadas de elementos traza y vitaminas.

Puntos de buena práctica clínica:

- Las intervenciones dietéticas y el soporte nutricional artificial antes, durante y después de la fase aguda del tratamiento, requiere un enfoque centrado en el paciente (evaluación de actitudes, creencias, motivaciones y deseos), y comprensión de los mecanismos plausibles por los cuales los alimentos influyen en el control del cáncer colorrectal, teniendo en cuenta la fisiopatología, etapa de la enfermedad, modalidad e intención del tratamiento.
- Se debe desaconsejar la automedicación de suplementos y vitaminas.
- De acuerdo con la funcionalidad del tracto digestivo, brindar apoyo nutricional perioperatorio a los enfermos desnutridos, o aquellos con inhabilidad para comer durante siete días luego de la cirugía.
- Se debe orientar el cuidado nutricional a satisfacer los deseos de pacientes en estado terminal.

4.2. FLUJOGRAMAS

Ilustración 1 Flujoograma de diagnóstico y estratificación

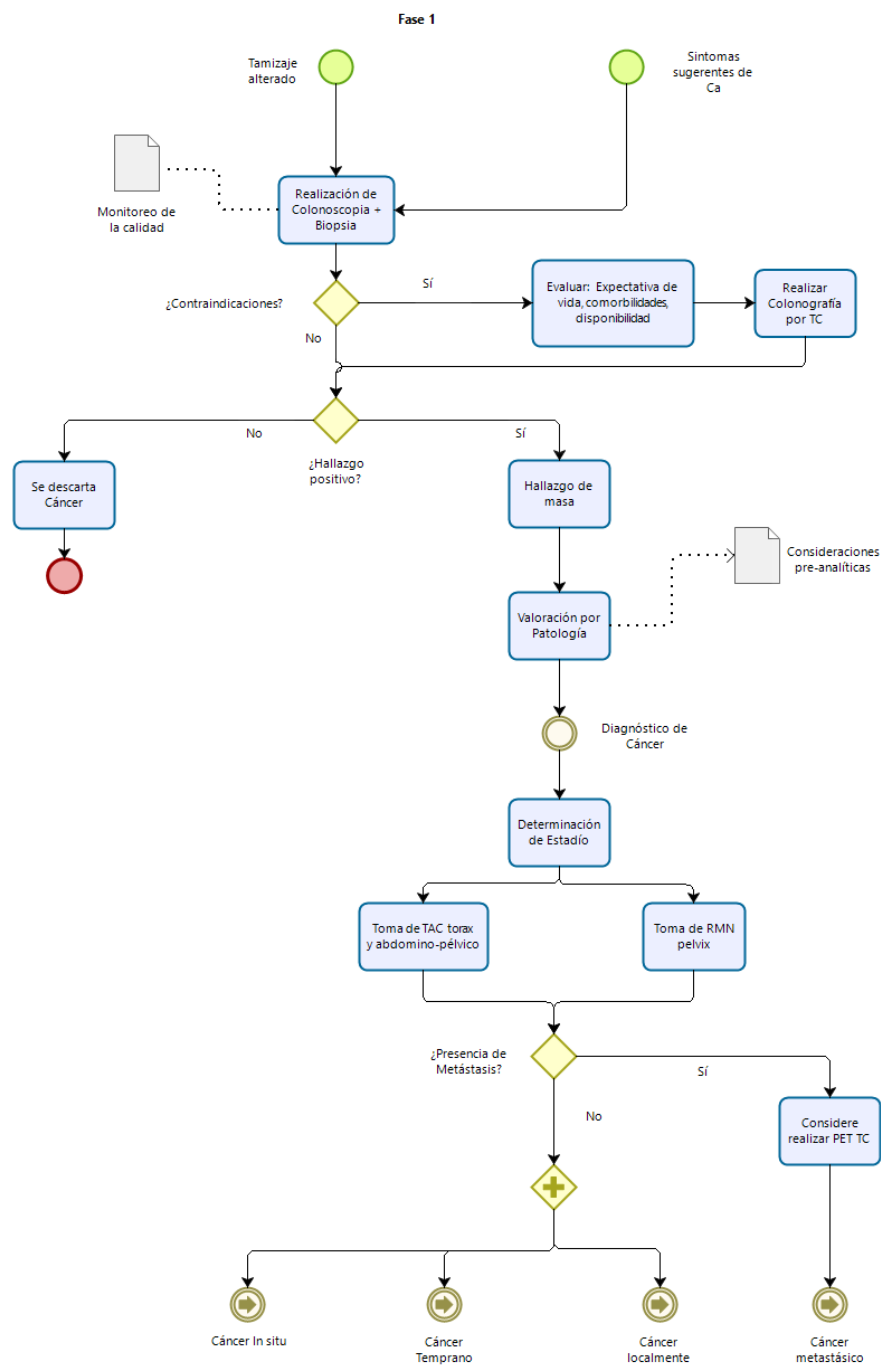


Ilustración 2 Flujograma de Cáncer in situ

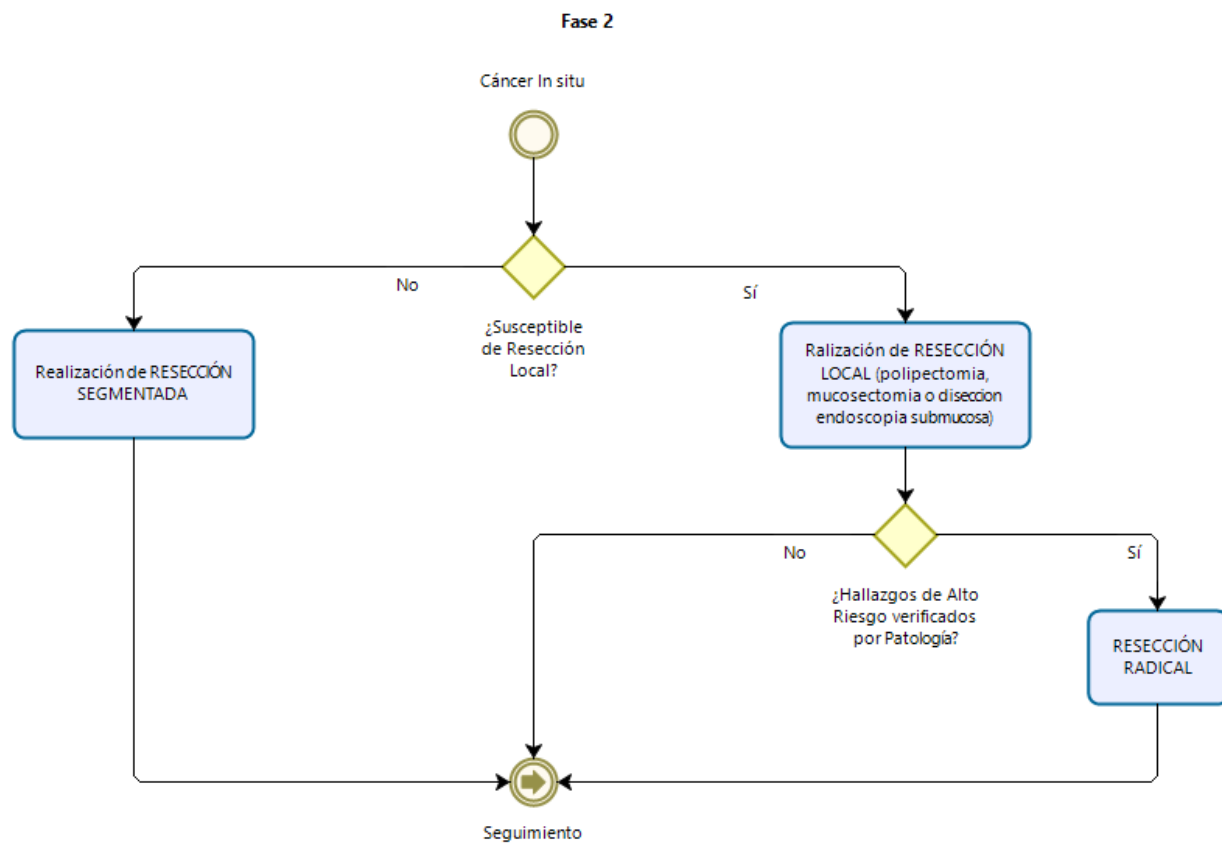


Ilustración 3 Flujograma de Cáncer temprano

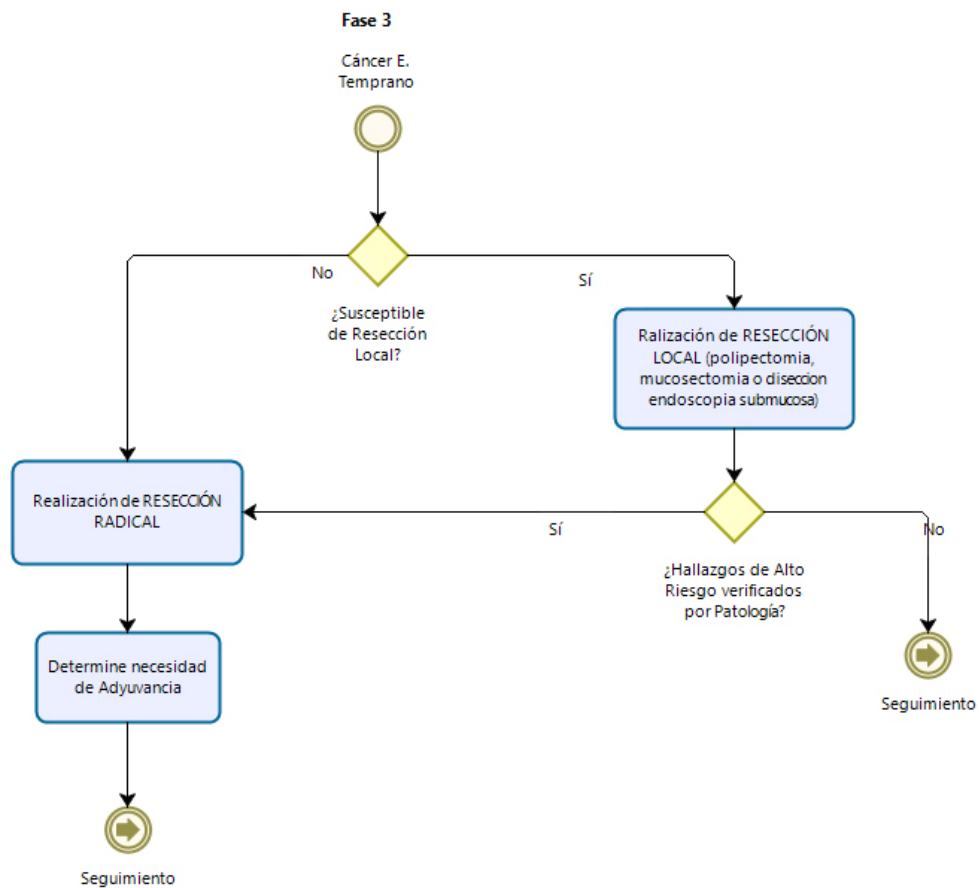


Ilustración 4 Flujoograma de Cáncer localmente avanzado

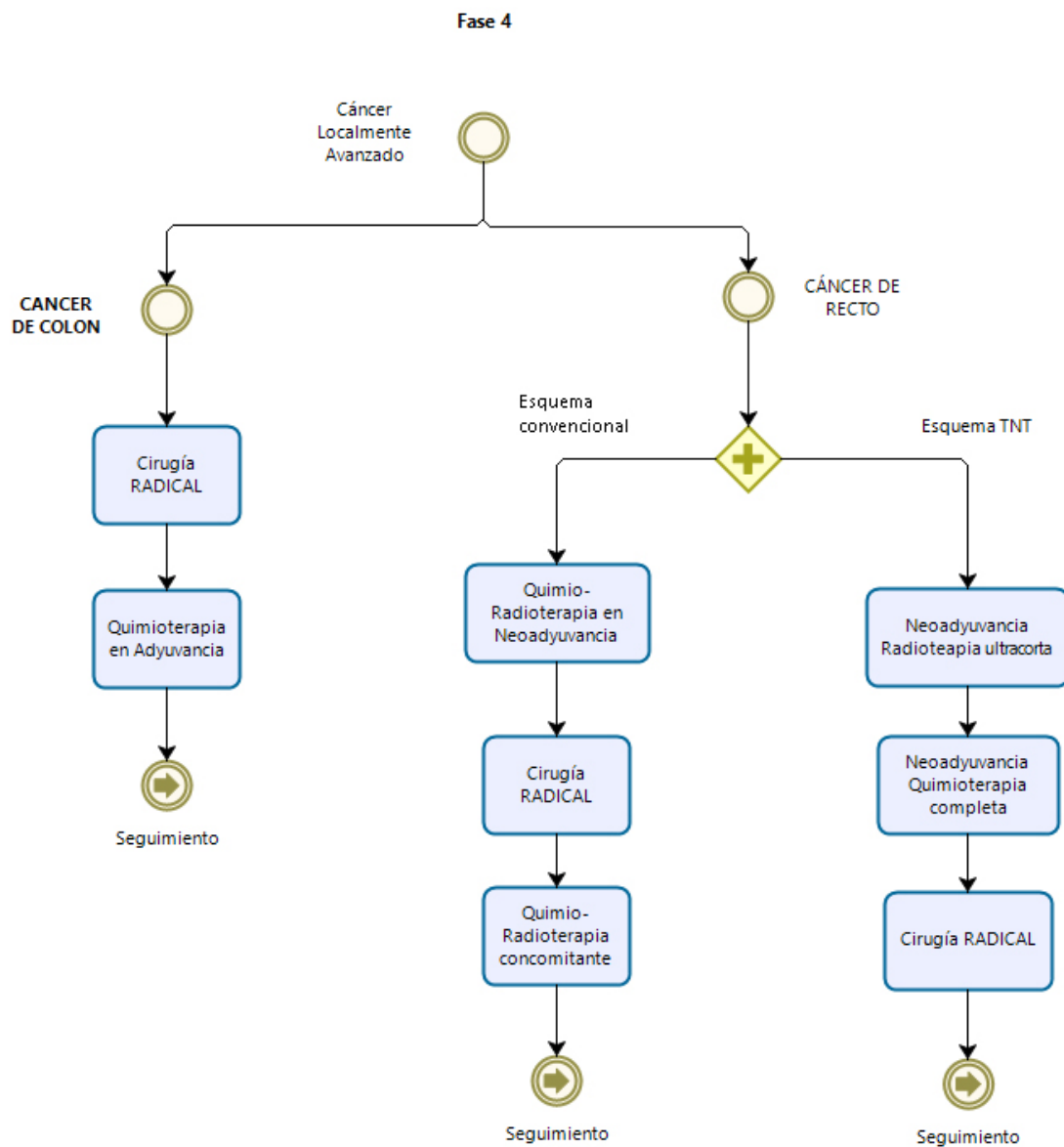


Ilustración 5 Flujograma de Cáncer metastásico

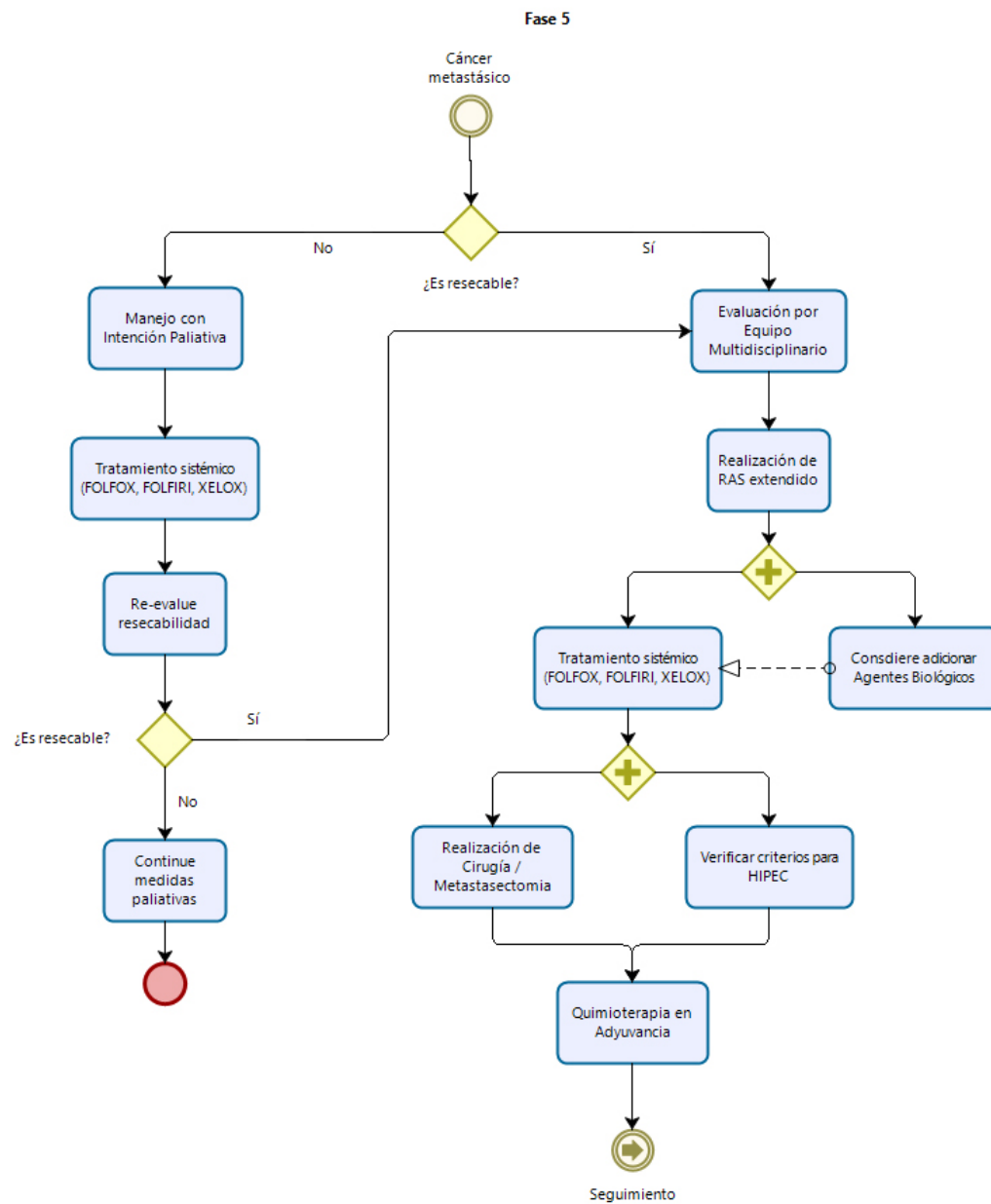
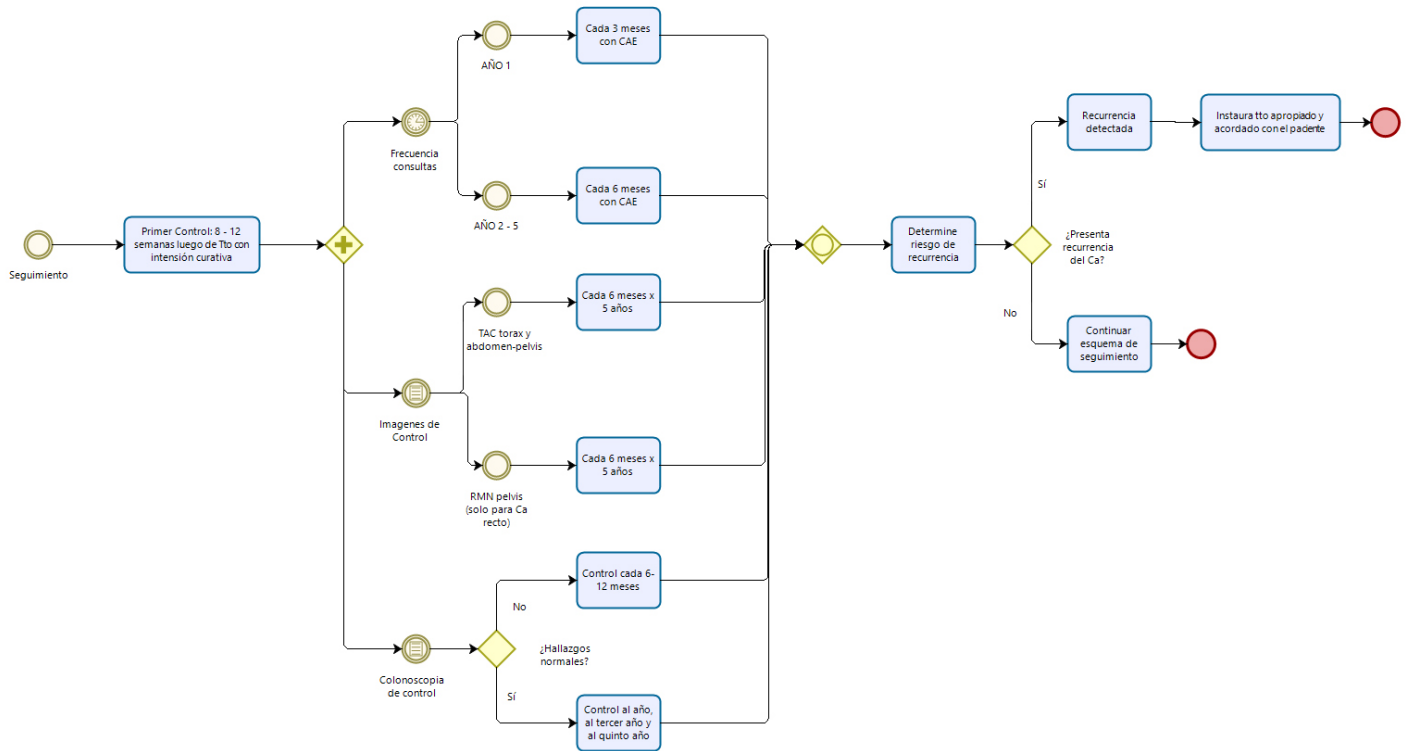


Ilustración 6 Flujograma de Seguimiento



5. RECOMENDACIONES

5.1. Diagnóstico

¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?

N	RECOMENDACIÓN
1	Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico.
1	Se sugiere una colonografía por tomografía computarizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible con enema de bario, siempre y cuando las IPS cuenta con personal entrenado y capacitado para la realización e interpretación de Colonografías por TC. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se sugiere ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado.

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere advertir al paciente que más de un examen puede ser necesario para confirmar o excluir un diagnóstico de cáncer colorrectal, como lo es un TAC, RMN o colonoscopia. Explicar al paciente que es posible que sea necesario repetir un mismo examen.

Evidencia seleccionada

Recomendación adaptada de la guía colombiana, la cual fue a su vez modificada de una recomendación de la guía NICE 2011. Se fundamenta en una revisión sistemática con meta-análisis realizada por Pickhardt y colaboradores publicada en 2011 (49), en la cual evaluó la sensibilidad de la colonoscopia y de la colonografía por tomografía computarizada mediante la síntesis de evidencia derivada de 49 estudios luego del proceso de inclusión. Encontraron para la colonoscopia una sensibilidad de 94.7% (IC95% 90.4%, 97.2%) basado en 25 estudios

de los 49, con una heterogeneidad (I²) de 50% entre los estudios. Por otro lado, la sensibilidad para la colonografía por TC fue de 96.1% (IC95% 93.8%, 97.7%) basado en los 49 estudios, con una I² de 0%. Lo anterior corresponde a una alta sensibilidad para ambos estudios diagnósticos. La limitación de este estudio radica en que no se considera otros desenlaces como lo es la especificidad ni el valor predictivo positivo, así como la limitación de poder efectuar subanálisis según estadio.

En cuanto a la seguridad de la colonoscopia, Reumkens y colaboradores publicaron en 2016 una revisión sistemática con metaanálisis de estudio con base poblacional para determinar la prevalencia agregada de complicaciones posteriores a colonoscopia (50). Se incluyeron 21 estudios para analizar. La tasa global de perforación a los 30 días fue de 0.5/1.000 colonoscopias (IC95% 0.4, 0.7), la tasa global de sangrado a los 30 días fue de 2.6/1.000 colonoscopias (IC95% 1.7, 3.7). Se documentó una tasa de “mortalidad a los 3 meses” de 2.9/100.000 colonoscopias (1.1, 5.5). El estudio incluyó un análisis de tendencia de tiempo, en el que se evidenció una disminución en las tasas de sangrados entre 2001 a 2010, pasando de 6.4 a 1.0 por cada 1.000 colonoscopias, si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa ($p=0.07$). Las tasas

de perforación y mortalidad se mantuvieron estables. Los autores concluyen que las complicaciones post-colonoscopia han permanecido relativamente estables, con cierta tendencia a disminuir, en el contexto de un aumento considerable en el número de colonoscopia realizadas por año, lo que implica que la colonoscopia es un procedimiento seguro para la población general.

Una revisión de la literatura publicada en 2019 sintetiza de maneja narrativa la evidencia de las múltiples técnicas de tamización, en la que la colonoscopia sigue siendo la mejor alternativa diagnóstica, pues no solo detecta lesiones de diverso tamaño ante la visualización directa de las lesiones, sino que es el paso final ante la positividad de otros estudios adicionales (sangre oculta en heces, colonografía por TC, enema de bario) (51).

¿Cuáles son los estándares de calidad de la colonoscopia para ser considerada óptima?

- 3 Se recomienda ofrecer sedación a todos los pacientes, a menos que esté contraindicada, lo cual está determinado por el profesional en Anestesiología. Los pacientes deben ser conscientes de que tienen el derecho de rechazar la sedación si así lo desean.
 - 4 Se recomienda que los pacientes sometidos a procedimientos con sedación consciente o profunda tengan una monitorización continua antes, durante y después de la administración de la sedación.
 - 5 Se recomienda la monitorización de todos los pacientes, incluida la presión arterial, pulso, respiración, nivel de conciencia y grado de incomodidad al inicio, durante y al final del procedimiento. Dependiendo de la respuesta del paciente, la evaluación puede necesitar ser más frecuente. Estos datos deben registrarse en el nivel del servicio de endoscopia digestiva, utilizando un sistema elegido por el servicio.
 - 6 Se sugiere monitorización continua con electrocardiograma en pacientes de alto riesgo. Este subgrupo incluye aquellos que tienen antecedentes de enfermedad cardíaca o pulmonar, adultos mayores y pacientes para los que se espera un procedimiento prolongado.
 - 7 Se sugiere que el equipo debe tener la capacidad de crear registros fotográficos, ya sean de papel o digitales, con el propósito de conservar documentación fotográfica auditable de que la colonoscopia fue completa: fotodocumentación de la válvula ileo-cecal y el ciego, o un videoclip con su respectiva foto instantánea.
- Así mismo, se debe realizar registro fotográfico así no haya hallazgos patológicos

- | | |
|----|--|
| 8 | <p>Se sugiere que los especialistas que realizan la endoscopia monitoricen sus tasas individuales de detección de adenomas, en pacientes sometidos a colonoscopia de tamización, y correlación con las biopsias positivas para cáncer.</p> <p>Así mismo, es deseable que cada centro o profesional, audite la tasa de detección de pólipos y la tasa de resección de pólipos en la población de tamizaje.</p> |
| 9 | <p>Se sugiere, cuando sea posible, la preparación intestinal con dosificación dividida para mejorar la efectividad de la preparación intestinal. Esto está condicionado a la hora de programación de la colonoscopia y a las comorbilidades (por ej., insuficiencia cardíaca).</p> <p>De igual manera, se sugiere que los exámenes se realicen solamente después de una adecuada preparación del intestino, es decir, sin ningún residuo fecal o líquido en el lumen que pudiera enmascarar cualquier área sospechosa.</p> |
| 10 | <p>Se sugiere un tiempo de retiro mínimo de 6 minutos, como indicador de calidad auditable, para colonoscopias de detección de cáncer colorrectal.</p> |
| 11 | <p>Se sugiere como indicador de calidad, una frecuencia de perforación en las colonoscopias no mayor de un caso por cada 1000 colonoscopias*.</p> <p><i>* Se debe tener en cuenta que las afecciones colónicas que se sabe afectan el riesgo de perforación incluyen pseudo-obstrucción, isquemia, colitis grave, cambios inducidos por radiación, estenosis, las formas más severas de enfermedad diverticular y uso crónico de corticosteroides.</i></p> |
| 12 | <p>Para lograr un examen colonoscópico de alta calidad, se recomienda realizar una intubación completa del colon hasta el ciego e inspeccionar cuidadosamente la mucosa durante la retirada.</p> |
| 13 | <p>Si el especialista que realiza la endoscopia duda de su capacidad para remover una lesión de alto riesgo, se sugiere documentar apropiadamente la lesión, si es necesario, marcar su posición con un tatuaje y remitir al paciente a otra institución o profesional para que la lesión sea removida endoscópica o quirúrgicamente.</p> |

Puntos de buena práctica clínica:

- Todos los pacientes deben recibir una evaluación previa al procedimiento y cualquier pregunta que el paciente pueda tener debe ser respondida en ese momento. El paciente debe tener una comprensión suficiente del proceso de preparación intestinal, ya que un intestino mal preparado implica suspender y reprogramar el procedimiento.
- No es necesario realizar dos procedimientos separados: uno detección y otro para biopsia. Para ello, se recomienda garantizar que la emisión de autorizaciones, si aplica el caso, tengan en cuenta este punto y se evite diferir el procedimiento de toma de biopsia.
- Se recomienda que cada IPS dentro de su Manual de Calidad y Protocolos Institucionales, establezca un programa completo de aseguramiento de la calidad y seguridad, así como procedimientos para monitorizar el cumplimiento del programa, incluyendo procedimientos operativos estándar para la preparación de endoscopias y procedimientos de aseguramiento de ca-

lidad para el reprocesamiento de endoscopios y accesorios.

- Deben realizarse capacitaciones y reen-trenamientos del personal involucrado en el cuidado del endoscopio, acorde a los lineamientos de la OMS. Así mismo debe mantenerse una cadena clara de rendición de cuentas para los procedimientos de procesamiento endoscópico.
- La sedación durante la colonoscopia debe ser administrada por un anestesiólogo en los pacientes con alguna de las siguientes características:

- Poco colaboradores
- Con edades extremas
- Morbilidad grave (cardíaca, pulmonar, hepática, renales o del sistema nervioso central)
- Cualquier alteración del estado de conciencia
- Obesidad mórbida
- Apnea del sueño
- Embarazo
- Abuso de alcohol u otras drogas
- Antecedente de sedación fallida
- Antecedente de reacción adversa a cualquier medicamento utilizado en la sedación

• El servicio de endoscopia digestiva debe tener un proceso formal para documentar la sedación y el confort del paciente usando el sistema de elección del servicio. El servicio debe auditar el uso de la sedación por parte de sus médicos.

• Considere incluir en el informe de la colonoscopia la utilización o no de la sedación, el tipo de ésta y la existencia o no de complicaciones inmediatas.

• Se debe utilizar una lista de criterios como

la puntuación de Aldrete (respiración, saturación de oxígeno, conciencia, circulación y niveles de actividad) para determinar la posibilidad de dar de alta al paciente.

• Antes de la sedación y antes de la aprobación del alta, debe informarse al paciente respecto a su capacidad de realizar tareas que requieran atención y la toma de decisiones que requieran juicio. La información impartida debe ser escrita y dada al paciente antes del alta.

• Se recomienda que el paciente asista con acompañante.

• Debido a que el período de amnesia que sigue a la administración de sedación es variable, se deben dar instrucciones por escrito al paciente, incluyendo los procedimientos a seguir si surge una emergencia.

• Todas las colonoscopias deben realizarse utilizando un colonoscopio con capacidad de video, que pueda mantenerse dentro de las especificaciones de los fabricantes.

• Los especialistas que realizan la endoscopia deben esforzarse por una preparación intestinal adecuada, y la calidad de la preparación intestinal debe ser registrada y monitorizada usando una escala estandarizada a elección del servicio de endoscopia digestiva, como lo es la escala de Boston.

• Debido a que la perforación es un evento raro, las tasas de perforación deben vigilarse a nivel de la institución o del sistema. Es probable que las mediciones a nivel individual del especialista que realiza la endoscopia sean muy variables.

• Considere la tasa de intubación cecal sin ajustar como un indicador primario de la calidad de la colonoscopia. El estándar

aceptable es mayor al 90%; el deseable es mayor al 95%.

- Considere conservar documentación y revisión de las razones para una colonoscopia incompleta.

- Los servicios de endoscopia deben tener procesos para identificar y registrar desenlaces adversos que se producen después de que el paciente deja el servicio de endoscopia.

Evidencia seleccionada

La evidencia de las anteriores recomendaciones deriva la elaboración de una guía de práctica para garantizar la calidad de las colonoscopia en Ontario, realizada por Tinmouth y col en 2014 (52). Las recomendaciones desarrolladas en esta guía están basadas en una revisión sistemática de la literatura realizada por los autores, organizadas en tres aspectos clave: entrenamiento del endoscopista y mantenimiento de su competencia, parámetros institucionales de garantía de la calidad, e indicadores de calidad y desenlaces auditables para colonoscopia.

Se destaca la siguiente evidencia presentada en esta guía:

- **Entrenamiento del endoscopista y mantenimiento de su competencia:** se identificaron tres estudios que evaluaban el número de procedimientos necesarios a realizar durante la formación académica para alcanzar un adecuado nivel de competencia endoscópica. Un estudio mostró que los residentes/fellow de gastroenterología de primer año alcanzaban una tasa de intubación cecal del 94% cuando habían realizado 200 colonoscopias, y un 98% cuando completaban 250. Otro estudio halló que se requiere de un promedio de 275 procedimientos para alcance un nivel de competencia en colonoscopia y lograr

un 85% de tasa de intubación cecal, en un tiempo menor de 16 minutos.

- **Parámetros institucionales de garantía de la calidad:** la revisión de la literatura sólo encontró documento tipo guías y protocolos, mas no un estudio primario. Se mencionan que las instituciones deben considerar mecanismos de medición del procedimiento junto con valoraciones pre-colonoscopia, que incluyen historia clínica, respuesta a procedimientos previos, diligenciamiento del consentimiento informado, educación e instrucciones para la preparación. Una guía propone que menos del 10% de los pacientes debería requerir una repetición de la colonoscopia por motivos de pobre preparación. Así mismo, se debe documentar aspectos o variables que pueden aumentar el riesgo de eventos adversos, como lo es la toma actual de anticoagulantes, edad del paciente, antecedente de procedimientos quirúrgicos abdominales, IMC, presencia de enfermedad diverticular, y clasificación ASA por parte de anestesiología.

- En relación con el control de infecciones, se enfatiza el hecho de que los endoscopios son elementos semi-críticos por tener contacto con mucosas, por lo que se requiere un alto nivel de desinfección de los instrumentos.

- En cuanto a calidad de la sedación, se reconoce que cada vez más los pacientes solicitan este procedimiento para la realización de la colonoscopia, recomendándose que se efectúe una sedación moderada (consciente) de tal forma que permita a los pacientes responder ante ordenes verbales, y que no sea necesario activar medidas de mantenimiento de la vía aérea. Para ello, se requiere de una valoración completa antes del procedimiento, valoración por anestesiología para clasificación ASA, y monitorización durante la sedación que incluya presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, entre otros. Se debe disponer de un equipo de reanimación en la sala de endoscopia.
- **Indicadores de calidad y desenlaces auditables para colonoscopia:** se identificaron 13 estudios. A pesar de su alta heterogeneidad, se establecieron los siguientes indicadores más recurrente para evaluar la calidad de la realización de la colonoscopia:
 - *Tasa de intubación cecal*, definido como el paso del endoscopio proximal a la válvula ileocecal que permita visualizar por completo el ciego, con metas del 90% para pacientes sintomáticos y 95% para pacientes en tamización;
 - *Tasa de detección de adenomas*, considerado un indicador de calidad robusto, pero con estudio que han mostrado importante variabilidad, con tasas entre 12% al 62%, por lo que no se pudo definir una meta;
 - *Tasa de polipectomía*, indicador que se correlaciona con la tasa de detección de adenomas, con $r=0.88$ (IC95% 0.78%, 0.94%) en población promedio asintomática, por lo que se pudo proponer una meta de 40% para hombres y 30% para mujeres, lo anterior basado en los endoscopistas que alcanzaban esta meta lograban una tasa de detección de adenomas superior a 25% y 15% en hombres y mujeres, respectivamente;
 - *Tiempo de retiro*, pues se asocia positivamente con la tasa de detección de adenomas y, por tanto, puede ser un proxy a ésta última. Esta medición sólo aplica a aquellos en que no se realiza polipectomía. Un estudio encontró que el grupo que tenía un promedio de tiempo de retiro de 4.2 min tenía una tasa de detección de pólipos significativamente menor en comparación con el grupo que tenía un tiempo de retiro promedio de 5.7 min (55.4% vs 42.4%, $p=0.004$).

En caso de que la colonoscopia no se pueda realizar o sea incompleta, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico recomendado para cáncer colorrectal?

- 14 Si una colonoscopia completa no se ha realizado ya sea porque la lesión primaria impide la colonoscopia total, o por cualquier otra razón, se sugiere visualizar radiológicamente el resto del colon antes de la cirugía, si es posible. Se sugiere que este procedimiento sea realizado idealmente por colonografía por tomografía computarizada, o si no está disponible, por enema de bario de doble contraste de alta calidad.
- 15 Se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la colectomía, en aquellos casos en que no se logró visualización del colon antes de la cirugía.

Evidencia seleccionada

Rosman y Korsten en 2007 publicaron una revisión sistemática con metaanálisis para determinar la precisión diagnóstica de la colonografía por TC en comparación con la colonoscopia y el enema de bario, mediante curvas ROC (53). Se incluyeron 30 estudios. La evidencia agregada por metaanálisis determinó que la sensibilidad de la colonografía por TC fue de 82% para pólipos de 10 mm o más (IC95% 0.76, 0.88), de 63% para pólipos con tamaño de 6-10 mm (IC95% 0.52, 0.75), y de 56% para pólipos de menos de 5 mm (IC95% 0.42, 0.70). Las curvas ROC para la colonografía por CT fueron de un AUC=0.830 para pólipos de cualquier tamaño.

En cuanto al enema de bario, se estimó una sensibilidad de 38% y una especificidad de 86%, para detectar pólipos de cualquier tamaño. Si se trata de un pólipo de 5 mm o mayor, la sensibilidad y especificidad estimada fue de 41% y 82%, respectivamente. Y para pólipos de mas de 10 mm, la sensibilidad y especificidad fue de 48% y 90%, respectivamente. En relación con la colonoscopia convencional, se encontró una sensibilidad agregada de 98% para pólipos mayores de 10 mm (IC95% 0.96, 1.0), y de

97% para pólipos de mas de 5 mm (IC95% 0.94, 1.0). La especificidad agregada tanto para pólipos de 5 mm o de mas de 10 mm fue de 99%. Cuando se compararon los AUC entre la colonoscopia convencional y colonografía por TC, se evidenció que, para pólipos de 5mm o mayores, había un AUC 0.999 vs 0.888 ($p<0.001$) respectivamente, a favor de la colonoscopia. Para pólipos mayores de 10 mm, se calculó un AUC de 0.999 vs 0.928 ($p=0.05$), a favor de la colonoscopia.

Los autores concluyen que la colonografía por TC tiene una sensibilidad y especificidad superior al enema de bario. La colonografía por TC tiene una alta sensibilidad para pólipos de gran tamaño, pero es menor precisa en cuanto al diagnóstico de pólipos pequeños en comparación con la colonoscopia convencional.

Otro estudio, publicado en 2014, realizado por Plumb y colaboradores, buscó estimar la sensibilidad y especificidad de la colonografía por TC para cáncer colorrectal y pólipos adenomatosos luego de una prueba de sangre oculta en heces positiva, a través de una revisión sistemática de la literatura (54). Se identificaron 122 potenciales que luego de los respectivos filtros, quedaron 5

para inclusión en el análisis. Se documentó una sensibilidad para la colonografía por TC de 88.8% (IC95% 83.6%, 92.5%) y una especificidad de 75.4% (IC95% 58.6%, 86.8%). Los autores concluyen que la colonografía por TC puede ser considerada como sustituto de la colonoscopia cuando esta no es preferible o fue incompleta, en el contexto de detectar adenomas de más de 6 mm y cáncer colorrectal.

5.1.1. Consideraciones para la implementación

Durante las discusiones con los expertos temáticos, uno de los elementos a considerar para la implementación fundamental es la adecuada articulación entre los programas de tamización de cáncer colorrectal, que generalmente están a cargo de las IPS primarias, con los prestadores que realizan la colonoscopia, con el fin de asegurar los tiempos de oportunidad para diagnóstico. Para ello, los médicos generales o especialistas generalistas deben tener capacitación constante en la adecuada interpretación de las pruebas tanto de tamización

como diagnósticas. Los procesos administrativos deben garantizar que estos procesos de articulación, sobre todo en el marco de redes integrales de atención, surtan su cometido, así como brindar los espacios y educación continuada al personal médico, de enfermería y de todo aquel que participen en la transición tamización alterada/diagnóstico.

En cuanto al balance de riesgos y beneficios, actualmente la realización de colonoscopia y biopsia ofrece un alto grado de seguridad para el paciente, inclusive ante la presencia de comorbilidades como coagulopatías o consumo actual de antiagregantes plaquetarios. No obstante, se deben tomar todas las medidas de mitigación del riesgo para evitar complicaciones, especialmente sangrado o perforación. Por ello, los expertos están de acuerdo con las recomendaciones y puntos de buenas prácticas clínicas relacionadas con la calidad del procedimiento de colonoscopia, el cual debe ser monitoreado tanto por el proceso de garantía de la calidad de la institución, como por el personal de auditoría de la EAPB.

5.2. Estratificación

¿Cuáles son los estudios para estadificación (de extensión) en pacientes con cáncer colorrectal?

- | | |
|----|--|
| 16 | Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon. |
| 17 | Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste |

- 18 Se recomienda las siguientes consideraciones para estadificar con TAC de tórax y abdomen (o RMN):
 - Evaluar la extensión local del tumor o infiltración a estructuras adyacentes.
 - Evaluar la presencia de metástasis distantes en pulmón, nódulos linfáticos del tórax y abdomen, hígado, cavidad peritoneal, y otros órganos.
 - La realización del TAC debe ser con contraste oral e intravenoso.
 - Considerar RMN con gadolinio en caso de alergia o contraindicación a los medios de contraste yodados.
 - Tomar las precauciones necesarias para pacientes con Enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 sin diálisis.
 - En caso de que haya contraindicación tanto para medio yodados como agentes basados en gadolinio, considere realizar RMN sin contraste IV.
- 19 Se sugiere realizar RMN de pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de recto.
- 20 Se sugiere realización de RMN de pelvis para valorar el estado del margen mesorrectal.
- 21 Se sugiere ofrecer estadiaje local preoperatorio por medio de resonancia magnética de pelvis a los pacientes con cáncer de recto detectado por tamización, aunque también la tomografía computarizada multicorte contrastada de alta calidad puede dar información adecuada.
- 22 Se sugiere realizar a todos los pacientes con cáncer de recto resonancia magnética para valorar el riesgo de recurrencia local, determinado por el margen de resección distal, el tumor (T) y el estadiaje nodular (N), a menos que esté contraindicado
- 23 Se sugiere usar los resultados de un examen digital rectal como parte complementaria de los demás estudios. El examen digital rectal es de especial valor para el equipo de cirugía en relación con el explorar movilidad del recto, altura del tumor respecto al pubo-rectal, así como corroborar los hallazgos de la RMN de pelvis.
- 24 Se sugiere ofrecer tomografía axial computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis a pacientes que están siendo evaluados por cáncer colorrectal metastásico.
- 25 Se sugiere ofrecer RMN o TAC de abdomen en lugar de ecografía para la detección de metástasis hepáticas.

Si se evidencien lesiones inespecíficas en el TAC, se sugiere realizar RMN de abdomen.
- 26 Si la TAC muestra que el paciente puede presentar metástasis extra-hepáticas que sean susceptibles de cirugía radical, se sugiere que un equipo multidisciplinario decida si una tomografía por emisión de positrones- tomografía computarizada (PET-CT) de cuerpo completo es adecuada.
- 27 En los casos de cáncer de colon, si la TAC con contraste es sugestiva de enfermedad metastásica en la pelvis, se sugiere una resonancia magnética de pelvis y la discusión de sus resultados con el equipo multidisciplinario.
- 28 No se sugiere el uso rutinario de la tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico o estadiaje clínico del cáncer colorrectal en los estadios I a III.
- 29 Se sugiere ofrecer tomografía por emisión de positrones para determinar el manejo y el pronóstico si la imagen convencional es equívoca para la presencia de enfermedad metastásica.
- 30 Se sugiere ofrecer tomografía por emisión de positrones para la evaluación preoperatoria de metástasis hepáticas de cáncer colorrectal antes de la resección quirúrgica.

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere discutir todas las imágenes con el paciente luego de la revisión por un apropiado equipo multidisciplinario.

Evidencia seleccionada

Niekel y colaboradores publicaron en 2010 una revisión sistemática cuyo objetivo fue determinar el desempeño diagnóstico de la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones con fluorin-18-deoxiglucosa para la detección de metástasis hepática en paciente con cáncer colorrectal sin tratamiento previo (55). Se incluyeron 39 estudios de tipo prospectivo luego del proceso de selección, para un total de 3391 paciente para ser incluidos en el metaanálisis. La sensibilidad estimada por lesión para el TC fue de 74.4% (basado en 38 conjuntos de datos), para la RMN de 80.3% (basado en 61 conjunto de datos), para el PET FDG de 81.4% (basado en 8 conjunto de datos). Los autores concluyen que las tres modalidades de imagen cuentan con una alta sensibilidad para detectar metástasis hepáticas, pero es la RMN el estudio de preferencia ya que tiene una de las sensibilidades mas altas y puede detectar lesiones menores a 10 mm, además de proveer información anatómica adicional. Como alternativa se propone el PET FDG dado que también cuenta con una alta sensibilidad, con la adición de que juega un papel importante en la detección de metástasis extra-hepáticas.

En este mismo sentido, un metaanálisis de 2012 evaluó el desempeño de estas ayudas de imagenología en el contexto de un paciente para re-estadificar previo a la cirugía y luego de neoadyuvancia (56). En este contexto clínico, y basado en la revisión de 11 es-

tudios (223 pacientes), se encontró una sensibilidad agrupada de la RMN, TC, PET-FDG y el TC/PET-FDG de 85.7% (IC95% 69.7%, 94%), 69.9% (IC95% 65.6%, 73.9%), 54.5% (IC95% 46.7%, 62.1%) y 51.7% (IC95% 37.8%, 65.4%), respectivamente. Los autores concluyen que la RMN es el estudio mas apropiado, seguido del TC, para diagnosticar metástasis hepáticas en un paciente pre-operatorio tratado con quimioterapia en neoadyuvancia. Se descarta la utilidad del PET en este contexto clínico en particular.

Por otro lado, en relación con la utilización de la ultrasonografía hepática, una revisión sistemática desarrollada por Floriani y colaboradores, publicada en 2010, realizó una revisión de 25 estudios, y una de las modalidades de imagenología fue la ultrasonografía (57). En este estudio se encontró que la ultrasonografía tuvo una sensibilidad de 63% (56.0-70.0) en comparación con la sensibilidad de la TC, la RMN y el PET-FDG que fueron de 74.8% (71.2-78.3), 81.1% (76.0-86.1) y 93.8% (90.0-97.7), respectivamente. La especificidad de la US, TC, RMN y PETFDG fueron de 97.6% (95.6-99.5), 95.6 (93.4-97.8), 97.2% (94.5-99.9) y 98.7% (97.2-100), respectivamente.

Respecto al papel de la RMN para estratificar el paciente con cáncer de recto, Al-Sukhni y colaboradores realizaron en 2012 una revisión sistemática con metaanálisis acerca de la precisión diagnóstica de la RMN para determinar la categoría T, metástasis a ganglios linfáticos, y compro-

miso del margen de resección circunferencial (58). Incluyeron 21 estudios que cumplieron los criterios de inclusión propuestos por los autores. La sensibilidad estimada para determinar la categoría T, compromiso ganglionar y compromiso del margen de resección circunferencial fue de 87% (IC95% 81%, 92%), 77% (IC95% 69%, 84%) y 77% (IC95% 57%, 90%) respectivamente. Las respectivas especificidades fueron de 75% (IC95% 68%, 80%), 71% (IC95% 59%, 81%) y 94% (IC95% 88%, 97%). Con base en lo anterior, los autores concluyen que la RMN es muy específica para valorar el margen de resección circunferencial, y su sensibilidad para este parámetro es similar a la definición de categoría T, ambos necesarios para la planeación quirúrgica del paciente. Por el contrario, la RMN tiene un pobre desempeño para determinar el compromiso de ganglios linfáticos.

En cuanto a la limitación de la RMN para evaluar si hay compromiso de los ganglios linfáticos en cáncer rectal, Hoshino y colaboradores en 2019 publican una revisión sistemática con metaanálisis acerca de la precisión diagnóstica para detectar metástasis linfáticas, en comparación con la TC (59). Basados en 11 estudios, se encontró que la sensibilidad y especificidad agregadas de la RMN fueron de 0.72 (IC95% 0.66, 0.78) y de 0.80 (IC95% 0.73, 0.85) respectivamente, para detectar metástasis en ganglios linfáticos laterales. Por la escasez de estudios para la TC (sólo tres), no se logró realizar un análisis agregado, pero se documentó una sensibilidad entre 0.62 a 0.95 y una especificidad entre 0.90 a 0.97.

Si bien el TC podría cumplir un rol en la estratificación del paciente con cáncer rectal, dos artículos de revisión de literatura recientes establecen que es la RMN el estudio de elección para este fin, inclusive fren-

te a la UER, teniendo en cuenta que tiene las ventajas de no ser invasivo y por tanto brinda mayor confort al paciente, otorga mayor detalle anatómico de la pelvis y evalúa el estado del esfínter anal (60,61).

En la revisión rápida de literatura sobre el examen por tacto rectal, se encontró un estudio de 2018 realizado por Tanaka y colaboradores, en el que se evaluó la precisión de la colonoscopia para identificar la localización del cáncer rectal, en comparación con la proctoscopia rígida y el tacto rectal (62). En este estudio se evidenció una adecuada correlación entre las tres modalidades diagnósticas. Entre la proctoscopia rígida y el tacto rectal se estimó una diferencia de medias de 0.3 cm (IC95% -1.9, 2.4 cm) con un coeficiente de correlación de Pearson $r=0.92$ (0.89-0.94). Entre la colonoscopia y el tacto rectal se estimó una diferencia de medias de -0.3 cm (IC95% -2.9, 2.2 cm) con un $r=0.89$ (0.85-0.92). El punto de referencia para ambas mediciones fue el borde anal. En este sentido, el tacto rectal ofrece información comparable con la proctoscopia y colonoscopia, excepto cuando el tumor tiene una localización más alta, en la que el margen de error del tacto rectal es mayor, del orden de -2.7 cm.

5.2.1. Consideraciones para la implementación

Para las consideraciones de este apartado, los expertos hicieron especial énfasis en la RMN para cáncer de recto. Si bien esto puede representar un aumento de los costos en salud, la evidencia y el consenso de expertos está de acuerdo con las limitaciones técnicas del TAC de pelvis, que son subsanadas por la resolución que ofrece la RMN en relación con los tejidos blandos. Teniendo en cuenta las implicaciones de la estratificación del estadio clínico en cán-

cer de recto, los beneficios se consideraron superiores al riesgo de omitir compromiso del mesorrecto. Es fundamental que, para lograr la implementación de la RMN de pelvis para estratificar cáncer de recto, los actores del sistema de salud puedan dar respuesta a la demanda esperada por la elección de esta imagen.

En este mismo orden de ideas, se debe verificar las posibles (raras pero factibles)

contraindicaciones para la realización de una RMN, especialmente en pacientes con marcapasos, para lo que se recomienda valoración previa por electrofisiología. Así mismo, en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 o mayor, se prefiere la RMN sin contraste a no realizarla. Se enfatiza en que se debe tener una creatinina reciente al momento de ordenar los estudios de extensión.

5.3. DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

¿Cuáles deben ser los estándares de calidad del reporte histopatológico en el cáncer colorrectal en biopsias diagnósticas, resección de pólipos, piezas quirúrgicas (colon y recto), y otros especímenes (mucosectomía)?

- | | |
|----|---|
| 31 | Se sugiere utilizar sólo dos grados en el reporte de neoplasia intraepitelial colorrectal (bajo grado y alto grado), para reducir al mínimo el error intraobservador e interobservador. |
| 32 | Se sugiere reportar los adenocarcinomas colorrectales de acuerdo con la clasificación TNM establecida la 8ª edición (o la que la sustituya) y al protocolo del College of American Pathologist, al momento del diagnóstico. |
| 33 | Se sugiere que el patólogo verifique la remoción completa de las lesiones neoplásicas (márgenes libres) y la ausencia de invasión de la submucosa en especímenes de biopsias, de acuerdo con la orientación dada por el endoscopista. Si hay resección fragmentada, no se puede describir márgenes. |
| 34 | Se sugiere reportar las características de alto riesgo para enfermedad residual de acuerdo con el Protocolo de resección establecido por el Colegio Americano de Patólogos. |
| 35 | Dadas las pequeñas dimensiones de la capa submucosa, la infiltración dentro del nivel de la submucosa se sugiere medir en milímetros o en micras desde la línea de fondo de la muscularis mucosae. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debería consultar un equipo multidisciplinario sobre si es recomendable o no realizar resección quirúrgica de un adenocarcinoma pT1; si la resección quirúrgica se recomienda, se debe considerar la posibilidad de obtener la opinión de un segundo patólogo dado que existe variación en

la evaluación de las características de alto riesgo. Esta evaluación la realiza la IPS que va a manejar el paciente por lo que se debe garantizar el envío de los bloques de parafina y láminas histológicas si la histopatología se realizó en una institución diferente.

- Todas las biopsias y las lesiones identificadas en un programa de tamización y la subsecuente resección de especímenes deberían ser reportadas en un informe o formato electrónico de manera oportuna en el 100% de los casos. El formato debería ser enviado al médico tratante, al registro de cáncer pertinente y al programa de tamización.

- Considere reportar la correlación entre el diagnóstico histológico de biopsias y las resecciones. Cualquier falta de correlación, si bien son excepcionales, debería ser discutida por un equipo multidisciplinario y los resultados de esta discusión deberían documentarse.

Evidencia seleccionada

Las recomendaciones de la guía colombiana están basadas en las recomendaciones europeas para la garantía de la calidad en patología en cuanto a la tamización y diagnóstico de cáncer colorrectal, elaboradas por Quirke y colaboradores en 2011 (63). Estas recomendaciones resultan de un proceso de desarrollo revisión de la literaria y desarrollo de guías basadas en la evidencia, con el propósito de promover la discusión y colaboración internacional en tamización y diagnóstico de cáncer colorrectal.

Una de las recomendaciones de esta guía europea fue en relación al sistema de clasificación de las lesiones adenoma-carcinoma, en la que se recomienda el uso de la clasificación revisada de Vienna (64), la cual fue adaptada en esta guía, que busca obtener sólo dos grados en el reporte de neoplasia intraepitelial, a saber, neoplasia de bajo grado y neoplasia de alto grado. Esta clasificación buscaba minimizar la variación intra- e inter-observador y facilitar el manejo endoscópico de las lesiones reseadas al mejorar la correlación entre histopatología de las biopsias y los especímenes. Sin embargo, hay otras clasificaciones como la de la OMS (65), la de Paris para clasificar la apariencia endoscópica de las

lesiones (66), así como otras desarrolladas en Japón (67).

5.3.1. Consideraciones para la implementación

En cuanto a la implementación de las intervenciones relacionadas con el proceso de diagnóstico por patología, se debe garantizar la efectiva articulación entre la IPS que toma la muestra y al IPS que tiene el laboratorio de patología. En circunstancias en que no son el mismo prestador, uno de los factores pre-analíticos a tener en cuenta es el tiempo de isquemia y tiempo de fijación. La prolongación de estos tiempos puede alterar la muestra, lo que repercute en una interpretación parcial por parte del profesional de patología, o inclusiva, tener la necesidad de repetir la biopsia. Así mismo, las instituciones y aseguradores deben garantizar el manejo integral de la histopatología, esto es, los procedimientos de tinción convencional más la inmunohistoquímica, idealmente en un mismo laboratorio. Se reconoce que la parte de biología molecular podría estar por fuera de este procesamiento inicial, ya que depende del concepto del oncólogo tratante una vez valore al paciente por primera vez.

El panel de experto recomienda que se estandarice los procesos de fijación con formalina buferizada al 10%, junto con un control de calidad institucional.

Igualmente, uno de los mecanismos para lograr la articulación entre prestadores, y que no medie el paciente ni soportes físicos de historia clínica o notas quirúrgicas, es la comunicación entre patología con el médico tratante y endoscopista, ya que, por ejemplo, si hay sospecha de carcinoma, se debe ampliar muestreo. Así mismo, se debe tener en cuenta los alcances de patologías, es decir, reconocer que la biopsia da el diagnóstico y dirige la conducta médica, pero la resección quirúrgica da pronóstico.

Todos los especímenes enviados a patología requieren ser manejados cumpliendo de manera adecuada unas condiciones pre-analíticas y analíticas para poder obtener resultados óptimos que logren un diagnóstico completo y acertado.

En los reportes de patología se registran algunas variables específicas que pueden afectar los resultados de las pruebas como son: el tiempo de isquemia fría (tiempo entre la extracción del tejido y el inicio de la fijación), el tipo de fijador, el tiempo total de fijación y si requirió o no decalcificación.

Por lo cual se recomienda que una vez obtenido, el espécimen debe ser fijado en formalina al 10% bufferada con sales amortiguantes y una proporción de volumen mayor a 10:1, en un recipiente de boca ancha para que pueda ser retirado fácilmente sin distorsionar su arquitectura. El tiempo de fijación puede ser entre 6 y 72 horas (tiempo promedio 24 horas).

La orden de solicitud del estudio debe tener unos datos básicos de identificación,

datos clínicos, sospecha diagnóstica, lateralidad, localización y orientación de la lesión, adjuntar estudios imagenológicos; fecha y hora de la extracción quirúrgica, fecha y hora del inicio de la fijación para poder contabilizar el tiempo total en fijación y datos del médico tratante para comunicación en caso necesaria.

El reporte de patología provee el diagnóstico, así como indicaciones de tratamiento y datos pronósticos; por lo cual debe estandarizarse por los laboratorios de la ciudad que contenga como mínimo los siguientes datos:

- Tipo de procedimiento
- Tamaño y localización del tumor
- Perforación del espécimen
- Tipo y grado histológico
- Extensión tumoral
- Invasión linfovascular y perineural
- Estado y distancia de los bordes quirúrgicos
- Estado de los ganglios linfáticos
- Estadío TNM (en caso de que se tengan los datos clínicos necesarios)

Se adopta el protocolo del Colegio Americano de Patología (ver Anexo 05) para los reportes de carcinoma invasivo en especímenes de colectomía o especímenes de mucosectomía endoscópica / polipectomía. Todos los tumores deben ser evaluados para la detección de inestabilidad microsatelital a través de inmunohistoquímica. Esto puede hacerse en material de biopsia o en la resección quirúrgica. En tumores avanzados o metastásicos, es conveniente realizar estudios moleculares para la detección de mutaciones en oncogenes, sobre todo KRAS, ya que esta información se utiliza para el diseño del plan terapéutico.

5.4. GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO

¿Cuál debe ser la preparación preoperatoria de los pacientes con cáncer colorrectal que van a cirugía electiva?

- | | |
|----|--|
| 36 | Se recomienda que el cirujano considere, según su juicio, el beneficio de la preparación intestinal mecánica en cada paciente que será llevado a cirugía electiva para cáncer colorrectal. |
| 37 | En pacientes que son sometidos a cirugía oncológica abdominal o pélvica, se recomienda profilaxis farmacológica postoperatoria con duración extendida (cuatro semanas) con heparinas de bajo peso molecular en lugar de la profilaxis con duración limitada. |

Evidencia seleccionada

Güenaga y colaboradores, en 2011, publicaron una revisión sistemática con el objetivo de determinar la seguridad y efectividad de la preparación intestinal mecánica en cirugía colorrectal (68). Basados en el análisis de 18 estudios (5805 participantes) determinaron que, frente a la comparación de realizar preparación intestinal mecánica vs no hacerla un OR 0.88 (IC95% 0.55, 1.40) para fuga anastomótica para resección anterior baja; un OR 0.85 (0.58, 1.26) para fuga anastomótica para cirugía de colon; un OR 0.99 (0.74, 1.31) para fuga anastomótica en general; y para infección de sitio operatorio un OR 1.16 (0.95, 1.42). Para la comparación entre de realizar preparación intestinal mecánica vs colocación de enema rectal, encontraron un OR 0.93 (0.34, 2.52) para fuga anastomótica luego de cirugía rectal; un OR 2.15 (0.79, 5.84) para fuga anastomótica luego de cirugía de colon; un OR 1.32 (0.74, 2.36) para fuga anastomótica en general; y para infección de sitio operatorio un OR 1.26 (0.85, 1.88). Los autores concluyen que no hubo diferencias estadísticamente significativas para demostrar un beneficio de la preparación intestinal mecánica, ni el uso de enemas.

En 2019, Koskenvuo y colaboradores lleva-

ron a cabo un ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico, con único enmascaramiento para comparar la eficacia de la preparación intestinal mecánica y antibiótico oral frente a no realizar preparación para colectomía electiva -estudio MOBILE- (69). Contaron con la participación de 738 pacientes que fueron aleatorizados al grupo intervención (preparación intestinal) y al grupo control (sin preparación intestinal), de los cuales el 78% presentaban cáncer como comorbilidad. Los resultados fueron un OR 1.65 (IC95% 0.80-3.40, p=0.17) para infección en sitio operatorio; para dehiscencia de la anastomosis se halló un OR 1.13 (0.40-3.16, p=0.82); reoperación OR 0.78 (0.37-1.67, p=0.53); readmisión OR 1.07 (0.47-2.40, p=0.88); mortalidad a 30 día OR 4.95 (0.24-103.77, p=0.50); mortalidad a 90 días OR 4.95 (0.24-103.77, p=0.50). Con base en lo anterior, los autores concluyen que la preparación intestinal no reduce el riesgo de infección de sitio operatorio ni la mortalidad en general por cirugía de colon, en comparación con no realizar preparación.

Por otro lado, en relación con la tromboprofilaxis, Gould y col elaboraron las recomendaciones de la 9ª edición de la guía de la American College of Chest Physician para

terapia anti-trombótica referente a la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes quirúrgicos no ortopédicos (70). En esta guía, se establece que los pacientes con cáncer en quienes se les va a realizar una cirugía abdominal o pélvica tienen un

alto riesgo para eventos tromboembólicos. Por tanto, siempre y cuando alto riesgo para sangrado, se recomienda el uso de profilaxis antitrombótica por 4 semanas con heparinas de bajo peso molecular (recomendación graduada como 1B).

¿Cuál es el mejor manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer de colon resecable con obstrucción?

- 36 | No se sugiere utilizar estudios de contraste con enema como la única modalidad de imagen en pacientes con obstrucción aguda del intestino grueso.

Evidencia seleccionada

En 2015, Matsuda y col realizaron una revisión sistemática con metaanálisis con el objetivo de evaluar los desenlaces a largo plazo de la inserción del stent colónico (puente a cirugía) seguido de cirugía para obstrucción maligna de intestino grueso (71). Se incluyeron 11 estudios (1136 participantes) que cumplieron con los criterios. Los resultados respecto del procedimiento de puente a cirugía fueron similares a la cirugía de emergencia para supervivencia global, con un $RR=0.95$ (IC95% 0.75, 1.21; $p=0.66$). Respecto al desenlace de tiempo libre de enfermedad el RR calculado fue de 1.06 (0.91, 1.24; $p=0.43$). Con base en lo anterior, los autores concluyen que este metaanálisis sugiere que el puente a cirugía con stent colónico podría ser una estrategia de manejo alternativa para pacientes con obstrucción maligna.

En este mismo sentido, el estudio ESCO, desarrollado por Arezzo y col en 2017 (72), comparó la morbilidad después de colocación del stent colónico como terapia puente a cirugía frente a la cirugía de emergencia, en el contexto clínico de pacientes con

obstrucción maligna del colon izquierdo. Se trató de un ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, en el que incorporaron la participación de 144 pacientes. El desenlace primario fue cualquier causa de morbilidad a 60 días relacionada con la cirugía, es decir, cualquier complicación directa o indirecta al procedimiento quirúrgico. Los resultados fueron una tasa de complicaciones del 51.8% en el grupo del stent en comparación con el 57.6% en el grupo de cirugía de emergencia ($p=0.529$). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global a los 3 años, ni en el tiempo libre de enfermedad. Sí se encontró una diferencia significativa en relación con realización del estoma, el cual fue realizado en el 22.2% (11 pacientes) de los pacientes del grupo del stent, en comparación con el 39% (23 pacientes), para una $p=0.031$. Con base en lo expuesto, los autores concluyen que los dos procedimientos son equivalentes, sin diferencias en desenlaces, con cierta tendencia a requerir menos coloscotomías en el grupo que se le realiza stent colónico.

¿En qué casos está indicada la cirugía abierta o cirugía laparoscópica en pacientes con cáncer colorrectal?

- 36 Se sugiere la resección laparoscópica (incluida la laparoscopia asistida) como una alternativa a la resección abierta para individuos con cáncer colorrectal en quienes tanto la cirugía laparoscópica como la cirugía abierta se consideran adecuadas.
- 36 Para pacientes con cáncer de colon resecable que esté causando obstrucción manifiesta, se puede considerar como opción la inserción de un stent (en pacientes seleccionados) seguido de colectomía. Los stent colónicos están reservados generalmente para aquellos casos con lesiones distales en las cuales el stent puede permitir la descompresión del colon proximal con posterior colectomía electiva con anastomosis primaria.

Evidencia seleccionada

Hay abundante literatura respecto a la efectividad comparativa de la cirugía abierta frente a la cirugía laparoscópica. A continuación se describen los estudios más recientes y relevantes sobre este tema.

Deijen y colaboradores publicaron en 2017 los hallazgos del estudio COLOR (Colon cancer Laparoscopic or Open Resection) luego de 10 años de seguimiento (73), cuyo desenlace primario fue la sobrevida libre de enfermedad, como desenlaces secundarios, la supervivencia global y recurrencia, comparando las dos técnicas quirúrgicas. Con una mediana de seguimiento de 112 meses (9.33 años), la tasa libre de sobrevida libre de enfermedad fue de 45.2% para el grupo de cirugía por laparoscopia, frente al 43.2% del grupo de cirugía abierta (diferencia 2%, IC95% -10.3 a 14.3, para una $p=0.96$). Las tasas de supervivencia global fueron de 48.4% y 46.7%, respectivamente (diferencia 1.7%, IC95% -10.6 a 14.0, $p=0.83$). Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas para el riesgo de recurrencia. Los autores concluyeron que la cirugía laparoscópica para cáncer de colon no-metastásico tuvo tasas similares a la cirugía abierta luego de casi 10 años de seguimiento.

Kennedy y col publican en 2014 el estudio EnROL (Enhanced Recovery Open versus Laparoscopic), el cual estaba dirigido a examinar los desenlaces postoperatorios entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta convencional en el contexto de resección de cáncer colorrectal (74). Participaron 204 pacientes los cuales fueron aleatorizados a dos grupos, 103 al grupo de cirugía abierta, y 101 al grupo de cirugía laparoscópica. El desenlace primario fue fatiga física; los desenlaces secundarios fueron estancia hospitalaria, complicaciones, desenlaces reportados por los pacientes, y función física. Los resultados fueron un puntaje de fatiga física similares en ambos grupos; el promedio de la estancia hospitalaria fue significativamente menor en el grupo de laparoscopia que en el grupo de cirugía abierta (5 vs 7 días, $p=0.033$). No hubo diferencias en los otros desenlaces.

Theophilus y colaboradores, en 2014, realizaron un metaanálisis con únicamente ensayos clínicos aleatorizados con el fin de valorar la supervivencia a largo plazo entre la laparoscopia y la colectomía abierta para cáncer de colon (75). Con base en el análisis de 5 ensayos (3152 pacientes) encontraron una supervivencia global equivalente entre

los procedimientos (HR=0.93, IC95% 0.80-1.07), con un I2=32%.

Finalmente, Simillis y colaboradores publicaron en 2019 una revisión sistemática con el objetivo de comparar las técnicas de laparoscopia, cirugía abierta, cirugía robótica, y escisión transanal en el contexto de cáncer de recto (76). Incluyeron 29 estudios para el análisis (6237 participantes), todos ensayos clínicos aleatorizados. Comparando la cirugía laparoscopia, robótica y transanal frente a la cirugía abierta, se encontraron los siguientes hallazgos para morbilidad intraoperatoria unos OR de 1.04 (0.78-1.37), 1.15 (0.66-2.01) y 1 (0-452.22), respectivamente. Así mismo, para mortalidad se obtuvieron unos OR de 0.64 (0.33-1.23), 0.61 (0.08-4.73) y de 0.09 (0-10.35). Se encontró que la morbilidad postoperatoria fue un 47% menor para cirugía laparoscópica

en comparación con la abierta con un OR de 0.53 (0.33-0.85), sin diferencias frente a la robótica ni a la transanal. Así mismo, hubo diferencia a favor de la cirugía laparoscópica frente a abierta en cuanto a riesgo de infección de sitio operatorio, con un OR de 0.61 (0.46-0.81). En relación con desenlaces histopatológicos, la cirugía laparoscópica tuvo una escisión mesorrectal total incompleta o casi completa que la abierta, con un OR 1.52 (1.19-1.93). No se encontraron diferencias en supervivencia global ni en tiempo libre de enfermedad. Con todos lo expuesto, los autores concluyeron que las diferentes técnicas resultan comparables en cuanto a morbilidad perioperatoria y supervivencia a largo plazo, por lo que sugieren que la selección de la técnica debe basarse en los beneficios esperados individualmente por cada paciente.

5.5. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL IN SITU

¿Cuál es el manejo quirúrgico indicado en pacientes con cáncer colorrectal estadio 0 (TisN0)?

- 41 Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) en pacientes con cáncer de colon que tengan las siguientes características:
 1. Tumores bien o moderadamente diferenciados
 2. Tumores no ulcerados
 3. Tumores menores de 3 centímetros, si bien la determinación de resecabilidad es la base de implantación
 4. Con viabilidad técnica para su realización
 5. Que levante a la infiltración y no presente una separación de las capas mucosas y submucosa para una resección segura.
 6. Se prefiere la resección en bloque a la resección fragmentada.
- 42 En pacientes con estadio 0 (tumores In situ) de cáncer colorrectal se sugiere hacer resección endoscópica o local corroborando con patología sus márgenes laterales y profundos negativos.
- 43 Si hay sospecha clínica de un cáncer colorrectal pT1, se sugiere que el sitio de la escisión sea marcado con tinta china en la submucosa

- | | |
|----|---|
| 44 | En pacientes con cáncer de colon que fueron llevados a resección local, con hallazgos patológicos de alto riesgo (márgenes no claros e invasión del tercio profundo de la submucosa (T1/sm3) o más profundo (T2)), se sugiere realizar resección radical. |
| 45 | En pacientes con cáncer de colon, con lesiones más grandes (2 a 3 centímetros), altamente sospechosas de ser estadio 0 (tumor in situ) y que no sean susceptibles de polipectomía o resección local, se sugiere realizar resección segmentada. |
| 46 | En pacientes con cáncer de recto, con lesión estadio 0 o T1 sm1 (hasta tercio superficial de la submucosa) no susceptibles de resección local endoscópica, se sugiere realizar resección local transanal si la lesión es cercana al ano. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Para que el paciente pueda tomar una decisión informada, el médico tratante debería explicarle la posibilidad de hacer una escisión local como tratamiento para el cáncer de recto, incluyendo los riesgos referentes a la morbilidad operatoria y la recurrencia.

Evidencia seleccionada

Yoshii y colaboradores en 2014 publican un estudio retrospectivo acerca de los factores asociados al riesgo de recurrencia de cáncer colorrectal luego de resección endoscópica de tumores T1 (77). Compararon los desenlaces de 205 pacientes con cáncer colorrectal T1 manejados con resección endoscópica y que posteriormente se les realizó cirugía frente a 184 pacientes que sólo se les realizó resección endoscópica. Entre aquellos pacientes que tenían indicación de cirugía (según las guías japonesas, ya que el estudio fue realizado en Sapporo, Japón) encontraron que para el grupo que solamente se le realizó resección endoscópica el riesgo de recurrencia acumulado fue de 20.7% en comparación con el riesgo de 3.7% para el grupo que sí se le realizó resección endoscópica + cirugía ($p=0.001$). El motivo principal por el que los pacientes requirieron cirugía posterior fue la presencia de invasión profunda de la submucosa

y el hallazgo de un pólipo sésil, con elevación plana o deprimido, que representan factores de riesgo elevado para recurrencia para los pacientes del grupo resección endoscópica únicamente. Por el contrario, los autores no encontraron diferencias entre los grupos de resección endoscópica y resección + cirugía cuando se trataba de pacientes que tenían no indicación de cirugía (riesgo de recurrencia fue de 2.3% para ambos grupos, $p=0.577$).

Complementando lo anterior, Kouyama y colaboradores publicaron en 2018 un estudio tipo cohorte prospectivo que buscaba valorar los factores pronóstico para recurrencia en pacientes con cáncer colorrectal T1 (78). Incorporaron la participación de 930 pacientes, los cuales se dividieron en dos grupos: los que se les realizó únicamente resección endoscópica, y el grupo que se les realizó resección quirúrgica.

Con una mediana de 41.5 a 57.5 meses de seguimiento, hallaron una tasa de recurrencia de 1.34% para el grupo de resección endoscópica, y de 0.95% para el grupo de resección quirúrgica, sin ser estadísticamente significativa esta diferencia ($p=0.32$). La resección endoscópica, localización rectal, y diferenciación pobre o mucinosa (Por/Muc) fueron factores pronósticos para recurrencia en ambos grupos. Así mismo, el género femenino, morfología deprimida e invasión linfática fueron factores pronósticos de recurrencia en el grupo de resección endoscópica, pero no el grupo de resección quirúrgica. Los autores concluyen con la sugerencia de que se realice resección en bloque en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para recurrencia.

En 2016, De Ceglie y colaboradores elaboraron una revisión sistemática sobre la resección endoscópica de la mucosa (REM) y disección endoscópica de la submucosa

(DES) en lesiones de colon (79). El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de ambos procedimientos endoscópicos en el manejo de lesiones grandes (>20 mm) colorrectales. Se incluyeron 66 estudios de los cuales 3 eran ensayos clínicos aleatorizados, 22 estudios prospectivos y 41 retrospectivos. Encontraron una tasa de recurrencia mayor para REM que para DES con un OR de 8.19 (IC95% 6.2-10.9, $p<0.001$). En cuanto a resección en bloque, esta fue lograda en el 62.8% de las lesiones con REM, en comparación con el 90.5% con DES (OR 0.18, IC95% 0.16-0.20, $p<0.001$). La perforación ocurrió con mayor frecuencia con DES que con REM (OR 0.19, IC95% 0.15-0.24, $p<0.001$). Los autores concluyeron que la resección endoscópica de lesiones grandes es segura y efectiva; comparada con la REM, la DES tiene mayor tasa de resección “en bloc” y menor recurrencia, pero tiene mayor tasa de complicaciones.

5.6. MANEJO EN PACIENTE CON CÁNCER COLORRECTAL ESTADIO TEMPRANO

¿Cuál es el manejo quirúrgico para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal estadio temprano?

Cáncer de colon

- | | |
|----|---|
| 47 | En pacientes con cáncer de colon estadio 0-I, con indicación de cirugía radical pero con baja expectativa de vida o alto riesgo quirúrgico, se sugiere llevar caso a Junta Multidisciplinaria e individualizar cada caso para determinar balance beneficio/riesgo entre la intervención quirúrgica y dejar en observación. |
| 48 | En pacientes con cáncer de colon se sugiere considerar la cirugía abierta o mínimamente invasiva como opciones para llevar a cabo la resección quirúrgica oncológica, dependiendo de la disponibilidad del recurso tecnológico y el entrenamiento del personal médico. |
| 49 | Se sugiere que el cáncer de colon sea tratado con cirugía radical con escisión mesocólica completa. La extensión de la disección de los ganglios linfáticos durante la cirugía está determinada por los hallazgos clínicos pre-operatorios y la extensión de las metástasis linfáticas y en la profundidad de invasión del tumor observada intra-operatoriamente. |

Cáncer de recto

- | | |
|----|--|
| 50 | Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) abierta o con técnicas endoscópicas, en pacientes con cáncer de recto que tengan las siguientes características: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumores que comprometan hasta T1 sm2 2. Tumores bien o moderadamente diferenciados 3. Tumores no ulcerados 4. Tumores menores de 3 centímetros 5. Con viabilidad técnica para su realización 6. Que levante a la infiltración |
| 51 | Se sugiere realizar resección radical en pacientes con cáncer de recto y alguna de las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Lesiones T2 • Tumor mal diferenciado • Tumor ulcerado • Invasión perineural – linfovascular |
| 52 | En pacientes con cáncer de recto que fueron llevados a resección local, con hallazgos patológicos como márgenes no claros e invasión del tercio profundo de la submucosa (T1/sm3) o más profundo (T2), mala diferenciación, o invasión linfovascular o perineural, se sugiere realizar resección radical, quimiorradioterapia o ambas. |
| 53 | En los pacientes con cáncer de recto con un tumor resecable, se sugiere cirugía con escisión total del mesorrecto. La escisión del mesorrecto debería ser total para los tumores de los tercios medio e inferior del recto, con cuidado de preservar los nervios autonómicos pélvicos siempre que ello sea posible sin comprometer la resección del tumor. |
| 54 | Con una anastomosis rectal baja (menor de 5 cm de la unión anorrectal) se recomienda realizar un estoma desfuncionalizante. |
| 55 | Con una anastomosis rectal baja después de una escisión total del mesorrecto (TME), se sugiere considerar un reservorio colónico. |

Puntos de buena práctica clínica:

- En el manejo del cáncer de recto temprano, un equipo multidisciplinario debería discutir el esquema de tratamiento a ofrecer a los pacientes con diagnóstico de novo.
- Se recomienda utilizar la RMN durante la evaluación de las lesiones tempranas del recto, antes de la resección quirúrgica, con el fin de definir la invasión de la lesión y determinar la estrategia terapéutica indicada.
- Todos los pacientes sometidos a cirugía radical para cáncer rectal deberían ser sometidos a escisión del mesorrecto por un cirujano con experiencia en cirugía colorrectal.
- La ultrasonografía endoscópica rectal podría ser una opción dependiendo de la disponibilidad de centros con endosonógrafos y con experiencia en el contexto clínico de cáncer de recto.

- Después de la extirpación de un cáncer colorrectal pT1, se debería establecer un régimen de seguimiento estandarizado, con colonoscopia, antígeno carcinoembrionario e imágenes (ver recomendaciones de Seguimiento).
- La política de vigilancia empleada de un cáncer colorrectal pT1 de riesgo bajo es apropiada para el seguimiento después de la extirpación para los adenomas de riesgo alto.
- Solamente considere escisión total del mesorrecto por vía trans-anal para realizarse en un Centro de Excelencia en los cuales haya: un escenario de seguimiento estricto por auditoría y gobernanza clínica; por cirujanos experimentados en este tipo de procedimiento y que hayan tenido entrenamiento específico en esta técnica quirúrgica; y que se cuente con un mecanismo de monitoreo de los resultados.

Evidencia seleccionada

Manejo quirúrgico en cáncer de colon temprano

El manejo quirúrgico es la piedra angular del tratamiento con intención curativa en cáncer colorrectal (5), el cual ha sido optimizado mediante el uso de la disección precisa de los planos embriológicos junto con la interfase mesofascial, de acuerdo con el llamado principio de escisión mesocólica completa.

La guía japonesa de 2020 (44), en el apartado de principios de cirugía, establece un algoritmo que orienta el tipo de abordaje quirúrgico en cáncer colorrectal no metastásico. Este algoritmo establece lo siguiente:

- Para pacientes en quienes no se les detecta compromiso linfático, con un estadio cT1, es suficiente una resección radical con disección D2.
- Para pacientes en quienes no se les detecta compromiso linfático (cN-), pero con un estadio cT2, se puede considerar resección más disección D2, aunque una disección D3 también podría efectuarse debido a

que cerca del 1% de los cT2 se acompañan de metástasis a ganglios linfáticos principales y porque el diagnóstico preoperatorio de invasión profunda no es muy preciso.

- Para pacientes en quienes se les ha detectado compromiso linfático (cN+), se recomienda resección radical más disección D2.

La clasificación del tipo de disección D hace referencia a la extensión de la disección de ganglios linfáticos, la cual corresponde a cinco categorías (67):

- DX: la extensión de disección linfática no puede ser valorada.
- D0: disección linfática perocólica/perirrectal incompleta
- D1: disección linfática perocólica/perirrectal completa
- D2: disección linfática perocólica/perirrectal e intermedia completa.
- D3: disección linfática perocólica/perirrectal, intermedia de ganglios principales (de la raíz de la arteria) completa.

West y colaboradores, en 2012, publican un

estudio observacional tipo serie de casos, con el objetivo de describir y comparar las características físicas, planos de resección y retiro de ganglios linfáticos entre el abordaje japonés D3 y el europeo de escisión mesocólica completa, en cirugía para cáncer de colon. El estudio mostró que ambas técnicas realizan una resección de planos mesocólicos altos, con buena producción de especímenes oncológicos. Las diferencias principales estuvieron en la longitud de la resección siendo más largas y, por tanto, con mayor contenido mesentérico y de ganglios linfático, en el abordaje europeo.

Por otro lado, Kotake y colaboradores publicaron en 2014 un estudio que buscó determinar el impacto de la disección linfática D3 en la supervivencia de pacientes con cáncer de colon T3 y T4 (80). Mediante un estudio observacional retrospectivo de 6,580 pacientes en quienes se les realizó colectomía radical para pT3 y pT4 entre 1985 y 1994, compararon los desenlaces entre el grupo que se le realizó disección D3 frente al grupo que se le realizó disección D2. Se estimó un HR para supervivencia global de 0.827 (IC95% 0.757-0.904) entre D3 vs D2. El análisis multivariado de la cohorte completa mostró un HR 0.810 (0.741-0.886) entre D3 frente a D2. Los autores concluyeron que la disección linfática D3 estuvo asociada a mayor supervivencia que la disección linfática D2, en pacientes con cáncer de colon pT3 y pT4.

Kontovounisios y colaboradores realizaron en 2015 una revisión sistemática sobre la escisión mesocólica completa en cáncer colorrectal (81). Incluyeron 34 estudios, todos observacionales (12 retrospectivos, 9 prospectivos, 13 serie de casos) en los que se evidenció que la escisión mesocólica completa remueve más tejido alrededor del tumor incluyendo un aclaramiento máximo de ganglios linfáticos.

En cuanto a la eficacia del abordaje laparoscópico, un metaanálisis realizado por Athanasiou y col publicado en 2016 (82), mostró que no hubo diferencias en mortalidad (OR=2.16, IC95% 0.73-6.41, $p=0.16$) cuando se comparó con cirugía abierta. Tampoco hubo diferencias en fuga anastomótica o infección de sitio operatorio, con OR de 1.31 (0.84-2.04) y de 1.75 (0.91-3.35), respectivamente. Hubo diferencias en cuanto al tiempo de cirugía, a favor de la laparoscopia. Con base en lo anterior, los autores concluyen que la técnica laparoscópica parece ser tan efectiva y segura como la técnica abierta para realizar linfadenectomías extendidas.

Manejo quirúrgico en cáncer de recto temprano

El manejo quirúrgico en cáncer rectal es más complejo debido a la accesibilidad limitada y la anatomía intrincada de la pelvis, en el que el manejo estándar es la escisión mesorrectal total (EMT), y su extensión dependerá del compromiso del esfínter anal o estructuras adyacentes (5). En esencia, la escisión mesorrectal total parte del supuesto que los ganglios linfáticos están distribuidos aleatoriamente en el mesorrecto, y por tanto, no son visibles ni palpables (83). Se estima que los pacientes con cáncer rectal temprano sometidos a EMT tiene una reducción del riesgo de recurrencia local de un 6-12%, y una supervivencia global a 5 años de 53-87% (83).

Kidane y colaboradores, en 2015, realizaron un metaanálisis al comparar la resección local frente a la resección radical (EMT) en el contexto clínico de tratamiento de adenocarcinoma rectal T1N0M0 (84). Incluyeron 39 estudios para el análisis. Respecto al desenlace de supervivencia global a 5 años, encontraron un RR 1.46 (IC95% 1.19-1.77) a

favor de la resección radical (I2=15%). Para el desenlace de tiempo libre de enfermedad, se encontró un RR 1.54 (1.15-2.05) a favor de la resección radical (I2=1%). La resección local estuvo asociada a mayor recurrencia local, aunque con menor riesgo de complicaciones postoperatorias. Como dato interesante, la meta-regresión sugirió que la mayor supervivencia global de la resección radical podría ser explicada por el aumento en el uso de resección local para tumores del tercio inferior del recto, los cuales tienen peor pronóstico. Los autores concluyen que la resección local no ofrece un control oncológico comparable con la resección radical, con excepción del sub-grupo de microcirugía endoscópica transanal que parece ofrecer un efecto similar a la resección radical, con las ventajas de tratarse de un enfoque local en el contexto de un cáncer de recto temprano.

Por otro lado, respecto a la vía quirúrgica para realizar la escisión mesorrectal total, Vennix y col realizaron una revisión sistemática en 2014, cuyo objetivo fue evaluar las diferencias en el corto y largo plazo de la EMT por laparoscopia frente a la EMT abierta para el manejo de cáncer rectal (85). Incluyeron 14 estudios (3258 pacientes), todos ensayos clínicos. Encontraron que la EMT laparoscópica y abierta tienen efectos similares en cuanto a supervivencia global (OR 1.02, IC95% 0.76-1.38), así como en riesgo de recurrencia local, número de ganglios resecados y márgenes quirúrgicos. La EMT laparoscópica mostró una reducción media de 2 días en la estancia hospitalaria en comparación con la EMT abierta, así como una reducción significativa del riesgo de infección (OR 0.68, IC95% 0.50-0.93) y menor tasa de sangrados (OR 0.30, IC95% 0.10-0.93). Los autores concluyeron que hay evidencia de moderada calidad de que la escisión mesorrectal total por laparoscopia

tiene efectos similares a la vía abierta en cuanto a desenlaces a largo plazo. En relación con desenlaces postoperatorios de corto plazo, la vía laparoscópica tiene mejores resultados que la vía abierta.

Lei y colaboradores publicaron en 2018 un metaanálisis con el fin de comparar los desenlaces perioperatorios de los abordajes trans-anal frente al transabdominal para la realización de escisión mesorrectal total (86). Basados en el análisis de 17 estudios (1346 pacientes), hallaron que la EMT transabdominal estuvo asociada a una reducción significativa de sangrado, estancia hospitalaria, tasas de readmisión, y complicaciones postquirúrgicas en general. Adicionalmente, el abordaje transabdominal demostró márgenes de resección circunferencial más prolongados. En este sentido, los autores concluyeron que la EMT transabdominal tiene resultados similares a la laparoscópica, con la ventaja adicional de mejores sangrados, menor estancia hospitalaria, menor readmisión, y márgenes de resección circunferencial más seguros.

Sajid y col realizaron una revisión sistemática con metaanálisis con el fin de comparar la efectividad de la microcirugía endoscópica transanal y la resección radical en el manejo de cáncer rectal temprano, publicada en 2014 (87). Se incluyeron 10 estudios (942 pacientes) para el análisis. Encontraron que el riesgo de recurrencia local era mayor con el enfoque transanal con un OR de 2.78 (IC95% 1.42-5.44, $p<0.003$); el riesgo de recurrencia a distancia fue similar entre los dos enfoques quirúrgicos, con un OR de 0.87 (0.41-1.83, $p=0.71$); la supervivencia global fue similar en ambos enfoques, así como la mortalidad general, con OR de 0.90 (0.49-1.66, $p=0.74$) y de 0.70 (0.29-1.70, $p=0.43$), respectivamente. El riesgo de complicaciones postoperatorias fue mayor con resección

radical que con el enfoque transanal, con un OR 0.89 (0.08-0.44, $p<0.0001$). Con base en lo anterior, los autores concluyeron que la microcirugía endoscópica transanal no es superior a la resección radical si bien se requiere de más evidencia para emitir una recomendación.

Finalmente, en relación con al tiempo de cierre de ileostomías desfuncionalizante en pacientes que se les realizó resección colorrectal distal, Farag y colaboradores abordaron esta cuestión al realizar una revisión sistemática en 2017 (88). Analizaron 4 estudios tipo ensayos clínicos aleatorizados (para 446 pacientes), encontrando que el riesgo de fuga anastomótica, estenosis de la anastomosis y de complicaciones postoperatorias fueron similares cuando se reali-

zaba un cierre temprano que en uno diferido, concluyendo que el cierre temprano de una ileostomía desfuncionalizante es factible, con resultados comparables al cierre diferido.

5.6.1. Consideraciones para la implementación

Las consideraciones de implementación para este apartado se focalizaron en el desafío que implica el manejo del cáncer de recto temprano. El panel de experto reconoce que hay poca experiencia, por lo que se recomienda tener en cuenta la factibilidad de uso de la RMN para la estratificación en vez de otras modalidades de imagen (TC, ultrasonografía endorrectal).

5.7. MANEJO EN PACIENTE CON CÁNCER COLORRECTAL ESTADIO LOCALMENTE AVANZADO

En este bloque se abordan las siguientes preguntas clínicas:

¿En qué casos está indicado el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?

¿En qué casos está indicada la quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadio localmente avanzado?

¿En qué casos está indicada la realización de radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto?

ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de colon y recto

- | | |
|----|--|
| 56 | Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante posterior a cirugía en pacientes con cáncer de colon estadio II de alto riesgo. Se deberían discutir todos los riesgos y beneficios con el paciente. |
| 57 | Se sugiere evaluar la estadificación patológica posterior a cirugía antes de decidir ofrecer o no quimioterapia adyuvante. |

- 58 | Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
- 59 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo, se sugiere considerar el uso de capecitabina como alternativa al 5-fluorouracilo en terapia adyuvante, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
- 60 | Para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer colorrectal estadio III posterior a cirugía para esta condición, se sugiere el uso de oxaliplatino en combinación con 5-fluorouracilo y ácido folínico, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
- 61 | Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino.
- 62 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino.

ENFOQUE CONVENCIONAL: cáncer de recto solamente

- 63 | En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento es la quimio-radioterapia como terapia preoperatoria en pacientes estadios T3 y T4, con cualquier N.
- 64 | Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento:
 - 5-fluorouracilo infusional continuo o
 - 5-fluorouracilo/Leucovorina o
 - Capecitabina.
- 65 | Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal estadio II de alto riesgo y en todos los estadios III para reducir el riesgo de recurrencia sistémica, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT).
- 66 | Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
- 67 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo, se sugiere considerar el uso de capecitabina como alternativa al 5-fluorouracilo en terapia adyuvante, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)
- 68 | Para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer colorrectal estadio III posterior a cirugía para esta condición, se sugiere el uso de oxaliplatino en combinación con 5-fluorouracilo y ácido folínico, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)

- | | |
|----|--|
| 69 | Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino. |
| 70 | En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino. |
| 71 | Se recomienda radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal con tumor residual irresecable (márgenes positivos), según reporte de hallazgos anatomopatológicos del espécimen quirúrgico, o en pacientes con riesgo moderado o alto que no han recibido neoadyuvancia, si bien el mayor beneficio se obtiene con Radioterapia en neoadyuvancia. |
| 72 | Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con quimiorradioterapia concomitante. |

Puntos de buena práctica clínica:

- La elección del tratamiento adyuvante debería realizarse a través de un enfoque multidisciplinario. La Junta Multidisciplinaria debe tener en cuenta las contraindicaciones y el perfil de efectos secundarios del (los) agente(s) y el método de administración, como también el estado clínico y las preferencias del paciente.

Evidencia seleccionada

Terapia adyuvante en cáncer de colon no metastásico

André y colaboradores publicaron en 2009 el seguimiento del estudio MOSAIC (Multicenter International Study of Oxaliplatin/5-Fluorouracil/Leucovorin in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer) en relación con la supervivencia global a 6 años luego de quimioterapia en adyuvancia con infusión de fluorouracilo más leucovorina con adición de oxaliplatino -FOLFOX- (89). En esta publicación se reportó el seguimiento de 2246 pacientes, 60% con estadio III y 40% con estadio II. Los resultados de supervivencia global a 6 años (mediana de seguimiento 81.9 meses) fue de 78.5% para el grupo que recibió FOLFOX y 76.0%

para el grupo que recibió LV5FU2 (5-FU + leucovorina), para un HR=0.84 (IC95% 0.71-1.00, p=0.046), lo que corresponde a una reducción del riesgo de muerte en un 16% a favor del grupo FOLFOX. Teniendo en cuenta que el estadio de la enfermedad fue un factor pronóstico para la supervivencia, se realizó un análisis independiente para estadio II y estadio III. En paciente con estadio III, la supervivencia global fue de 72.9% para FOLFOX y 68.7% para LV5FU2, para un HR=0.80 (0.62-.97, p=0.023), lo que representa una reducción significativa de un 20% del riesgo de muerte a favor del FOLFOX. Para pacientes en estadio II, la supervivencia global fue de 86.9% para FOLFOX y 86.8% para LV5FU2, para un HR=1.00 (0.70-1.41, p=0.986) lo que significa que no

hubo diferencias entre los dos grupos. La mediana de tiempo libre de enfermedad para el grupo FOLFOX fue de 73.5 meses, en comparación con la mediana del grupo LV5FU2 que fue de 73.4 meses. Respecto a temas de seguridad, se documentó neuropatía sensorial periférica grado 3 en el 12.5% de los pacientes tratados con FOLFOX, y de 0.2% de los pacientes tratados con LV5FU2. Los autores concluyeron que adicionar oxaliplatino al esquema LV5FU2 mejoraba de manera significativa la supervivencia global a 5 y 6 años en el contexto de adyuvancia para cáncer de colon en estadio II o III.

André y demás colaboradores publicaron en 2015 una actualización del estudio pivotal MOSAIC, esta vez, para reportar la supervivencia global a 10 años (90), a la vez que consideraban los desenlaces de acuerdo con la presencia de mutación del BRAF y estado de desapareamiento de bases. Respecto a la supervivencia global a 10 años fue de 67.1% para el grupo LV5FU2 y 71.7% para el grupo FOLFOX (HR=0.85; IC95% 1.47-2.34; $p<0.001$). De igual manera, para pacientes en estadio II, la supervivencia global fue de 79.5% y 78.4% para los grupos LV5FU2 y FOLFOX respectivamente (HR=1.00; IC95% 0.74-1.35; $p=0.980$). Para pacientes en estadio III, la supervivencia fue de 59.0% y 67.1% para los grupos LV5FU2 y FOLFOX respectivamente (HR=0.80; IC95% 0.66-0.96; $p=0.016$). Por otro lado, en pacientes con mutación del BRAF el FOLFOX mostró una tendencia no significativa hacia un mejor efecto en la supervivencia (HR=0.66; IC95% 0.31-1.42) al igual que en pacientes con defecto en el desapareamiento de bases (HR=0.41; IC95% 0.16-1.07).

Haller y colaboradores publicaron en 2011 un estudio que buscaba evaluar la eficacia de adicionar oxaliplatino a una terapia basada en fluoropirimidina oral en el contexto

de adyuvancia para cáncer de colon, desarrollando el esquema XELOX (oxaliplatino+capecitabina) y comparándolo con bolos de 5-fluorouracilo/ácido folínico (5-FU/FA), en pacientes en estadio III (91). Este ensayo clínico fase III contó con la participación de 1886 pacientes. En cuando al desenlace de tiempo libre de enfermedad a 3 años, el XELOX fue superior a los bolos de 5-FU/FA con un HR=0.80 (IC95% 0.69-0.93; $p=0.0045$), lo que corresponde a una reducción del 20% del riesgo de recaída. En relación con la supervivencia global a 5 años, con una mediana de seguimiento de 57 meses, fue de 77.6% para el grupo XELOX y 77.2% para el grupo 5-FU/FA, diferencia no significativa. Con base en lo anterior, los autores concluyeron que la adición de oxaliplatino a la capecitabina mejora el tiempo libre de enfermedad en estadio III de cáncer de colon en el contexto de adyuvancia.

Biagi y colaboradores publicaron en 2011 una revisión sistemática con metaanálisis con el fin de determinar la relación entre el tiempo de la quimioterapia adyuvante y la supervivencia (92). Incluyeron 10 estudios para el análisis (para 15,410 pacientes). Encontraron que un aumento de 4 semanas en el tiempo de quimioterapia adyuvante (es decir, un retraso en iniciar la terapia) estuvo asociado a una disminución significativa de la supervivencia global (HR 1.14; IC95% 1.10-1.17; I²=15.3%) y del tiempo libre de enfermedad (HR 1.14; IC95% 1.10-1.18; I²=0%). Con esto, se demostró que tiempos prolongados de quimioterapia adyuvante estuvo asociado a peor supervivencia entre pacientes con cáncer colorrectal.

Respecto a la duración de la quimioterapia en adyuvancia, Grothey y colaboradores publicaron en 2018 una serie de estudios para abordar la cuestión de si hay diferencias entre dar quimioterapia por 3 meses

versus 6 meses, ya sea XELOX o CAPEOX (capecitabina + oxaliplatino) (93). Desarrollaron 6 ensayos clínicos aleatorizados, reclutando un total de 12,834 participantes. El desenlace primario fue tiempo libre de enfermedad. Como se trató de un estudio con metodología de intención-a-tratar, infortunadamente no alcanzaron el número de eventos para brindarle poder estadístico al estudio, si bien los análisis sugerían que el FOLFOX a 6 meses era superior a 3 meses (HR 1.16; IC95% 1.06-1.26; $p=0.001$), mientras que no hubo diferencias con el CAPEOX (HR 0.95; IC95% 0.85-1.06). Así, los autores concluyen que no se logró establecer la no inferioridad de la quimioterapia en adyuvancia por 3 meses comparada con administrarla por 6 meses.

Terapia neoadyuvante en cáncer de recto no metastásico

Madoff en 2004 escribió un editorial en el NEJM sobre la investigación creciente del impacto de la radioterapia y quimio-radioterapia en el manejo del cáncer rectal (94). En esta publicación, comenta la historia a principios de los años 90 en el surgían dudas acerca del beneficio de la quimio-radioterapia en adyuvancia considerando la efectividad de la cada vez más aceptada cirugía de escisión mesorrectal total, tanto que algunos grupos de especialistas abogaban por la desaparición de la radioterapia en absoluto. Sin embargo, se comenzó a acumular evidencia del impacto positivo de la quimio-radioterapia pero en el contexto de neoadyuvancia y de la diseminación de la radioterapia neoadyuvante en esquemas cortos, conducta propuesta desde los grupos radioterápicos de Europa. Actualmente, se considera que la quimio-radioterapia en neoadyuvancia es el estándar de manejo en cáncer de recto localmente avanzado (5).

McCarthy y colaboradores elaboraron una revisión sistemática en 2012 con el objetivo de determinar la eficacia de la quimio-radioterapia preoperatoria comparada con radioterapia sola, en cáncer rectal localmente avanzado en relación a supervivencia global, recurrencia local y mortalidad a 30 días (95). Se incluyeron 6 estudios de tipo ensayo clínico aleatorizado. La recurrencia local se redujo en el grupo de quimio-radioterapia en comparación con el grupo de radioterapia sola en un 44% (OR=0.56; IC95% 0.42-0.75; $p<0.0001$). no hubo diferencias en cuanto a la supervivencia global (OR=1.01; IC95% 0.85-1.20; $p=0.88$). La mortalidad a 30 días fue similar en ambos grupos, así como la incidencia de toxicidad. Los autores concluyen que la radioterapia sola es comparable en eficacia con la quimio-radioterapia pero con la ventaja de esta última de reducir el riesgo de recurrencia local.

Rahbari y col en 2013 publicaron una revisión sistemática para determinar la eficacia de la radioterapia neoadyuvante en cáncer de recto (96). En esta revisión, y con base en el análisis de 22 estudios, todos ensayos clínicos, hallaron que la radioterapia neoadyuvante, comparada con cirugía sola, mejora el control local (HR 0.59; IC95% 0.48-0.72) si bien no alcanzó a tener una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la supervivencia global (HR 0.93; IC95% 0.85-1.00). hubo 5 estudios de los 22 que abordó la comparación entre radioterapia sola y quimio-radioterapia en el contexto de neoadyuvancia, en el que la evidencia mostró un mejor control local a favor de la quimio-radioterapia (HR=0.53; 0.39-0.72), sin diferencias en desenlaces perioperatorios ni en supervivencia global. Así las cosas, los autores concluyeron que la radioterapia neoadyuvante es eficaz en el control local de la enfermedad, sobre todo cuando se adiciona quimioterapia.

En este mismo orden de ideas, De Caluwé y col elaboraron una revisión sistemática con el fin de comparar la radioterapia preoperatoria con la quimio-radioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer rectal resecable estadio II y III, publicada en 2013 (97). Incluyeron 5 estudios para el análisis. La adición de quimioterapia a la radioterapia preoperatoria implicó un aumento en la toxicidad aguda grado 3 y 4 (OR 4.1; IC95% 1.68-10.0). Comparada con la radioterapia sola, la quimio-radioterapia preoperatoria aumenta significativamente la tasa de respuesta patológica completa (OR 3.52; IC95% 2.12-5.84), aunque esto no se trasladó a mayor tasa de preservación del esfínter anal. El riesgo de recurrencia local a 5 años fue menor en el grupo de quimio-radioterapia comparada con radioterapia sola (OR 0.53; 0.39-0.75). No se evidenciaron diferencias en tiempo libre de enfermedad ni en supervivencia global. Esta revisión aporta evidencia respecto a mejores resultados intermedios (respuesta patológica y control local) de la quimio-radioterapia neoadyuvante en comparación con la radioterapia sola, sin hallarse diferencias en desenlaces de largo plazo como el tiempo libre de enfermedad ni supervivencia global.

En 2014, utilizando la base de datos SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) de los Estados Unidos, Peng y col desarrollaron un estudio retrospectivo con 4724 pacientes con cáncer rectal T3N0, con el objetivo de examinar los resultados según el tratamiento recibido, esto es, cirugía sola, radioterapia neoadyuvante (RT-neo), o radioterapia adyuvante (RT-ad). Los resultados fueron una supervivencia específica de enfermedad de 66.1% para el grupo de cirugía sola, 73.5% para RT-neo, y 76.1% para RT-ad. Con el análisis multivariado, la RT-ad estuvo asociada a una disminución significativa del riesgo de muerte por cáncer

(HR=0.863; IC95% 0.578-0.819; $p<0.0001$), lo que no se evidenció con la RT-neo. Este estudio aporta evidencia que sugiere algún beneficio de la radioterapia adyuvante en la supervivencia global en la población de pacientes con cáncer rectal T3N0.

Sauer y colaboradores realizaron un seguimiento a 11 años del estudio alemán CAO/ARO/AIO-94, estudio tipo ensayo clínico aleatorizado, con el fin de determinar el impacto a largo plazo de la quimio-radioterapia preoperatoria vs post-operatoria (98). Este estudio no estuvo incluido en las revisiones Cochrane de McCarthy (95) ni De Caluwé (97). Contaron con la participación de 823 pacientes con cáncer rectal estadios II y III, los cuales fueron asignados aleatoriamente a los dos grupos pre- y post-operatorios; el esquema utilizó 5-fluorouracilo en la quimioterapia, y la cirugía fue escisión mesorrectal total. Los resultados fueron una supervivencia global a 10 años de 59.6% en el grupo preoperatorios, y de 59.9% en el grupo postoperatorio ($p=0.85$). Hubo diferencias estadísticamente significativas para la incidencia acumulada a 10 años de recaída local, con un 7.1% para el grupo preoperatorio y de 10.1% para el grupo postoperatorio ($p=0.048$). Los autores concluyen que hay una mejoría significativa de la quimio-radioterapia preoperatoria en cuanto al control local, aunque no hubo diferencias en la supervivencia global.

En cuanto al tipo de quimioterapia utilizada en concomitancia con radioterapia neoadyuvante, Gérard y col en 2006 estudiaron el efecto de incluir o no 5-fluorouracilo mas leucovorina con radioterapia preoperatoria (99). Elaboraron un ensayo clínico con 733 pacientes con cáncer rectal T3 y T4 resecable sin metástasis, los distribuyeron aleatoriamente a un grupo intervención (quimio-radioterapia) y al grupo

control (radioterapia sola). La supervivencia global a 5 años fue de 67.4% para el grupo quimio-RT y de 67.9% para el grupo de solo RT, sin ser estadísticamente diferentes. El HR para quimio-RT fue de 0.96 (IC95% 0.73-1.27). el tiempo libre de progresión a 5 años fue similar entre los grupos. El riesgo de recurrencia local para el grupo de quimio-RT fue de un RR=0.50 (0.31-0.80), lo que implica una reducción del riesgo de recurrencia en un 50% a favor de la quimio-radioterapia neoadyuvante. En cuanto al perfil de seguridad, se reportó un 2.9% de eventos grado 3-4 para el grupo de RT sola, y de 14.9% para el grupo de quimio-RT.

Hofheinz y col publicaron en 2012 un ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico, fase 3, del uso de capecitabina en quimio-radioterapia comparándola con fluorouracilo, para cáncer de recto localmente avanzado (100). Participaron 392, que fueron aleatorizados a dos grupos: grupo capecitabina, y grupo fluorouracilo, ambos recibieron radioterapia con dosis total de 50.4 Gy. Así mismo, se distribuyeron cada grupo en dos cohortes, una para neoadyuvancia, y otra para adyuvancia. La mediana de seguimiento fue de 52 meses. La supervivencia global a 5 años en el grupo capecitabina no fue inferior que el grupo fluorouracilo, con HR=1.5 (IC95% 1.00-2.28), p de no-inferioridad fue de 0.004. Así mismo, no hubo diferencias en cuanto a tiempo libre de enfermedad a 3 años, ni entre subgrupos adyuvante vs neoadyuvante. El perfil de seguridad fue esencialmente similar, excepto por la incidencia de proctitis y reacciones cutánea mano-pie que fueron significativamente mayores en grupo capecitabina. Con base en los resultados de este estudio de no inferioridad, los autores concluyeron que es factible la sustitución de fluorouracilo por capecitabina en el esquema de quimio-radioterapia, tanto para neoadyuvancia como adyuvancia.

Allegra y col en 2015 publicaron un ensayo clínico en que compararon capecitabina oral y fluorouracilo, con o sin oxaliplatino, en el contexto de neoadyuvancia para cáncer rectal estadio II y III (101). Co la participación de 1608 pacientes, hallaron que no hubo diferencias entre el grupo capecitabina y fluorouracilo en cuanto a recurrencia, tiempo libre de enfermedad a 3 años, o supervivencia global a 5 años. La adición de oxaliplatino no ofrecía beneficio adicional, pero sí aumentaba la incidencia de eventos adversos grado 3-4.

Terapia adyuvante en cáncer de recto no metastásico

La quimioterapia adyuvante se ha establecido como pilar terapéutico en cáncer de colon estadio II de alto riesgo y estadio III dada la evidencia de reducir el riesgo de recurrencia y muerte, y cuando se adiciona oxaliplatino, el beneficio se incrementa, pero no sin aumentar de igual manera el riesgo de eventos adversos serios (102). Para el caso del cáncer de recto, los estudios no parecen apoyar el uso de quimioterapia adyuvante postoperatoria en pacientes que previamente han recibido quimio-radioterapia preoperatoria, en parte por el escaso beneficio, si es que hay alguno, en el subgrupo de estadio II, y en parte por sesgos en los estudios, modificaciones impredecibles que tiene la quimio-radioterapia sobre el tumor, así como no considerar aspectos de calidad de la cirugía y la heterogeneidad del cáncer rectal en subtipos moleculares (102). Es por ello que no hay evidencia definitiva para recomendar o rechazar el uso de quimioterapia adyuvante en cáncer de recto. Esto se soporta en las siguientes revisiones sistemáticas.

Petersen y col en 2012 publican una revisión sistemática con el objetivo de sinteti-

zar la evidencia disponible acerca del impacto de la quimioterapia adyuvante en la supervivencia de pacientes con cáncer rectal resecable (103). Analizaron 21 estudios (9785 pacientes). El metaanálisis mostró una reducción significativa del riesgo de muerte en aquellos que recibieron quimioterapia adyuvante comparada con los que solo tuvieron manejo expectante (HR=0.83; IC95% 0.76-0.91), con heterogeneidad moderada ($I^2=30\%$). Se halló una reducción del riesgo de recurrencia de la enfermedad entre los que recibieron quimioterapia adyuvante frente a los que solo estuvieron en observación (HR=0.75; IC95% 0.68-0.83), con un $I^2=41\%$. Este primer estudio aporta evidencia de la eficacia de la quimioterapia en adyuvancia.

Bujko y col en 2015 realizan una revisión sistemática con metaanálisis de únicamente ensayos clínicos, para abordar la cuestión de cuál es el rol de la quimioterapia postoperatoria en cáncer rectal (104). Incluyeron 5 ensayos clínicos aleatorizados para el análisis. Ninguno mostró diferencias estadísticamente significativas acerca del beneficio de la quimioterapia en cuanto a supervivencia global ni en tiempo libre de enfermedad, con HR de 0.95 (IC95% 0.82-1.10; $p=0.49$) y de 0.92 (0.80-1.04; $p=0.19$), respectivamente. Así, los autores concluyen que el uso de quimioterapia postoperatoria en pacientes con cáncer rectal, que previamente han recibido quimio-radioterapia preoperatoria, no parece tener beneficio dada la evidencia analizada.

En ese mismo año, Breugon y col realizaron una revisión sistemática con metaanálisis con el objetivo de comparar la quimioterapia adyuvante frente a observación en cáncer rectal (105). Se incluyeron 4 estudios para el análisis. No se encontraron diferencias en términos de supervivencia global (HR=0.97;

IC95% 0.81-1.17; $p=0.775$). Tampoco hubo diferencias en el tiempo libre de enfermedad. No obstante, en el análisis de sub-grupos, se encontró evidencia a favor de la quimioterapia adyuvante en pacientes con tumores de 10-15 cm desde el borde anal en quienes el tiempo libre de enfermedad fue significativamente mejor (HR 0.59; IC95% 0.40-0.85; $p=0.005$) así como menor incidencia de recurrencia distal. Con base en lo anterior, los autores concluyen que, si bien la quimioterapia adyuvante no mejora la supervivencia global ni el tiempo libre de enfermedad, parece que hay un beneficio en una subpoblación de pacientes con cáncer rectal con tumores de 10-15 cm del borde anal. Este estudio aporta evidencia a favor, aunque en un grupo seleccionado de pacientes.

También en 2015, Petrelli y col elaboraron una revisión sistemática con el fin de valorar si la quimioterapia adyuvante mejora los desenlaces después de terapia neoadyuvante y cirugía radical en cáncer de recto (106). Se incluyeron 16 estudios en el análisis. Encontraron que la quimioterapia adyuvante mejora la supervivencia global (OR 0.64; IC95% 0.46-0.88; $p=0.006$) y mejora el tiempo libre de enfermedad a 5 años (OR 0.71; IC95% 0.6-0.83; $p<0.0001$). A diferencia de los anteriores estudios descritos, este expone evidencia a favor del uso de quimioterapia adyuvante en pacientes que han recibido quimio-radioterapia neoadyuvante, si bien los autores reconocen que la principal evidencia deriva de estudios observacionales (10 de los 16 estudios analizados).

A pesar de que hay evidencia discordante respecto a la eficacia y seguridad de la quimioterapia en adyuvancia para cáncer de recto, las guías NCCN (46) y ASCO (35) avalan su uso, justificando las recomendación con base en la evidencia indirecta proveniente de los resultados en cáncer de colon.

ESQUEMA DE TERAPIA NEOADYUVANTE TOTAL (TNT): Cáncer de recto solamente

73	En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento consiste en un curso corto de Radioterapia, el cual brinda un control local de la enfermedad con un impacto similar en la supervivencia global en comparación con el esquema convencional.
74	En paciente con cáncer de recto con T3 o T4, con cualquier N, una opción apropiada es ofrecer un curso corto de Radioterapia (25 Gy en 5 fracciones) seguida por 12-16 semanas de quimioterapia con FOLFOX o CAPEOX.
75	Se recomienda que, luego de aplicar el curso corto de radioterapia y las 12-16 semanas de quimioterapia, se realice una re-estadificación del paciente antes del tratamiento quirúrgico. La resección debe realizarse luego de 5-12 semanas de haberse completado la terapia neoadyuvante.
76	Si luego del tratamiento primario, la resección está contraindicada, el paciente debería ser tratado con el régimen sistémico para enfermedad avanzada.
77	Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con radioterapia de curso corto en centros donde se pueda ofrecer radioterapia con acelerador lineal con técnica conformacional (IMRT).

Puntos de buena práctica clínica:

- La evaluación de la RT de corta duración debe realizarse dentro de un equipo multidisciplinario, con una discusión sobre la necesidad de reducir el estadio y la posibilidad de toxicidad a largo plazo.

Evidencia seleccionada

Desde hace principios de la década de 2010, se han desarrollado estudios pequeños que buscan evaluar el efecto de un esquema de terapia sistémica en neoadyuvancia total antes de cirugía, esto es, sin requerirse terapia adyuvante. Cercek y colaboradores en 2014 publicaron un estudio tipo serie de casos, con 300 pacientes con cáncer rectal localmente avanzado, de los cuales 61 recibieron inducción con FOLFOX seguido de quimio-radioterapia, y posteriormente cirugía de escisión mesorrectal total (107). Encontraron que este esquema de Terapia

Neoadyuvante Total (TNT) fue bien tolerado, resultando en una regresión de tumor antes de la EMT, con una buena tasa de respuesta clínica patológica.

En 2014, Bujko y col realizaron una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de evaluar la eficacia del curso corto de radioterapia, esto es, 5 ciclos de 5 Gy, y posterior cirugía (108). Incluyeron 16 estudios para la síntesis de evidencia. Se encontró un beneficio en términos de menor tasa de toxicidad post-radiación en el grupo de

curso corto. La respuesta patológica completa fue 10% mayor en el grupo de esquema corto de RT. No hubo diferencias en cuanto a preservación de esfínter. Los autores concluyeron que el esquema corto de RT y cirugía diferida parecer tener un efecto beneficioso y lo plantean como un tratamiento prometedor, incluso en estadio IV.

A pesar de tratarse de estudios pequeños, observacionales principalmente, la mejor evidencia actual deriva del estudio RAPIDO. El estudio RAPIDO es un ensayo clínico, multicéntrico, internacional, que tiene como objetivo evaluar la falla al tratamiento relacionada con la enfermedad (DrTF, del inglés disease-related treatment failure), definida como falla locorregional o metástasis distantes, ante el manejo con esquema de TNT, es decir, radioterapia de curso corto seguido de cirugía diferida con, en el periodo de espera, quimioterapia (109). Esta propuesta de tratamiento surgió como alternativa ante las recaídas en cáncer de recto a pesar de la terapia sistémica postoperatoria.

Un abstract publicado en mayo de 2020 (109), reporta aspectos metodológicos y resultados del estudio RAPIDO. Entre 2011 y 2016 se reclutaron 920 pacientes con cáncer rectal cT4a/b, con invasión vascular extramural, cN2, compromiso de la fascia mesorrectal o con ganglios linfáticos laterales, quienes fueron aleatorizados hacia dos grupos: al grupo intervención de RT curso corto (5x5 Gy) con subsecuentes 6 ciclos de CAPOX o 9 de FOLFOX, seguidos de escisión mesorrectal total; o al grupo control, con quimio-radioterapia basada en capecitabina (y 25-28 x 2.0-1.8 Gy) seguido de escisión mesorrectal total y como opción, predeterminada por los protocolos de la institución hospitalaria, 8 ciclos de quimioterapia postoperatoria con CAPOX o 12 ci-

clos de FOLFOX. Los resultados reportados fueron unas tasas de respuesta patológica completa del 27.7% vs 13.8% (OR 2.40; IC95% 1.70-3.39; $p<0.001$) entre el grupo intervención frente al grupo control. A 3 años, la probabilidad de falla al tratamiento relacionada con la enfermedad fue de 23.7% en el grupo intervención y de 30.4% en el grupo control (HR 0.76; IC95% 0.60-0.96; $p=0.02$). Lo autores concluyeron que se puede obtener una menor DrTF en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado debido a RT de curso corto seguido por quimioterapia y escisión mesorrectal total, que con la quimio-radioterapia convencional, además de altas tasas de respuesta patológica completa.

En junio de 2020, van der Valk y col publicaron un estudio que aborda aspectos de adherencia y tolerabilidad del estudio RAPIDO (110). Encontraron todos los pacientes que se les administró el esquema TNT (grupo intervención) recibieron radioterapia de curso corto, el 84% de éstos recibió al menos un 75% de la quimioterapia prescrita. En cuanto al grupo control, la adherencia a la quimio-radioterapia fue del 94% y del 57% de la quimioterapia postoperatoria. Por otro lado, el 48% del grupo intervención reportó eventos adversos grado ≥ 3 , en comparación con el 25% de los pacientes del grupo control en neoadyuvancia y 35% en adyuvancia.

5.6.1. Consideraciones para la implementación

Esta bloque sobre el manejo del paciente con cáncer de colon y recto localmente avanzado tuvo en consideración los avances recientes en el tratamiento del cáncer de recto con el esquema TNT (terapia neoadyuvante total). Este relativo nuevo enfoque terapéutico busca brindar

la radioterapia y quimioterapia completa en neoadyuvancia, por lo que las consideraciones para la implementación son en dos puntos del proceso de atención. El primero, es con respecto a la coordinación de la atención entre la radioterapia para luego pasar sin retrasos a la quimioterapia, ya que se propone un esquema corto de radioterapia (o ultra-corto como se pueden encontrar también en la literatura) seguido de la quimioterapia. Al no ser concurrente sino secuencial, los programas de navegación se vuelve un elemento crítico para lograr el éxito de este enfoque.

En segundo lugar, es las consideraciones para la efectiva transferencia del cuidado entre la quimioterapia y a la cirugía. Hay evidencia que diferir por mas de 4 semanas

el tratamiento quirúrgico generar de manera negativa el pronóstico del paciente. Nuevamente los programas de navegación son fundamentales en este paso.

Complementando lo anterior, las EAPB y las IPS oncológica deben acordar procesos administrativos y de autorización, rutas de atención, coordinación de la red (si la atención no es efectiva en un prestador integral), y quizás facilitar la activación de mecanismos de pago prospectivos que incentiven la adecuada articulación de todos los actores para lograr el cumplimiento de metas terapéuticas a la vez que se promueve una optimización de recursos, pues el esquema TNT promete una reducción del costo per paciente.

5.8. MANEJO EN PACIENTE CON CANCER COLORRECTAL CON METÁSTASIS

¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer colorrectal metastásico?

- | | |
|----|---|
| 78 | <p>Si tanto el tumor primario como el metastásico son resecables, se sugiere que el equipo multidisciplinario considere tratamiento sistémico inicial seguido de cirugía, después de una discusión exhaustiva con el paciente.</p> <p>La decisión sobre si las cirugías se realizan al mismo tiempo o de manera separada, debería ser evaluada por el equipo multidisciplinario, en conjunto con el paciente, considerando si se trata de un paciente oligometastásico o no.</p> |
| 79 | <p>En pacientes con cáncer de colon o de recto superior y medio, se sugiere la citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), como una opción de tratamiento en pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria al cáncer colorrectal, quienes cumplan todos los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacientes entre 18 y 70 años. • Sin comorbilidad de alto riesgo. • Con índice de carcinomatosis ≤ 17 en la presentación inicial, luego de la neoadyuvancia y en caso de una recidiva tardía. • Enfermedad confinada en el abdomen. • Menos de tres metástasis hepáticas fácilmente resecables. • Sin enfermedad retroperitoneal extensa. • ECOG < 2. • Sin oclusión intestinal. |

- | | |
|----|---|
| 80 | En pacientes con cáncer de colon estadio IV por carcinomatosis peritoneal que requieren cirugía de urgencia, se sugiere confirmar diagnóstico histopatológico, derivar, y posteriormente definir si es candidato o no a procedimiento de HIPEC. |
| 81 | Se sugiere realizar biopsia en aquellos pacientes con una única lesión pulmonar para descartar cáncer de pulmón primario. |

¿Cuáles son las opciones de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer colorrectal metastásico?

- | | |
|----|---|
| 82 | Se sugiere considerar terapia sistémica perioperatoria si la resección hepática es susceptible de tratamiento. |
| 83 | Se sugiere quimioterapia con técnicas de ablación local para pacientes con cáncer colorrectal con metástasis hepáticas que no son susceptibles de resección. El caso debe ser discutido por el equipo multidisciplinario. |
| 84 | Se sugiere realizar metastasectomía o radiación corporal estereotáctica para pacientes con oligo-metástasis pulmonares que son susceptibles de manejo local. El caso debe ser discutido por el equipo multidisciplinario. |
| 85 | <p>Al ofrecer múltiples drogas quimioterapéuticas a pacientes con cáncer colorrectal avanzado, irreseccable o metastásico, se recomienda considerar una de las siguientes secuencias de quimioterapia, a menos que estén contraindicadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOLFOX (folinato de calcio más fluorouracilo más oxaliplatino) o XELOX (capecitabina más oxaliplatino) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en irinotecán (irinotecán o FOLFIRI) como tratamiento de segunda línea. • FOLFIRI (folinato de calcio más fluorouracilo más irinotecán) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en oxaliplatino (FOLFOX o XELOX) como tratamiento de segunda línea. <p>Se debería decidir la combinación y secuencia de quimioterapia a emplear después de una evaluación y discusión completa de los posibles efectos secundarios y las preferencias del paciente.</p> |
| 86 | Se sugiere considerar la terapia oral con capecitabina o infusión de 5-FU como tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico. |
| 87 | El FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico se recomienda como alternativa al uso de FOLFOX (ácido folínico más fluorouracilo más oxaliplatino) o FOLFIRI (ácido folínico más fluorouracilo más irinotecan) en pacientes seleccionados con excelente estado funcional, después de discutir con el paciente los posibles efectos secundarios y los beneficios del tratamiento. |
| 88 | El uso de FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) se sugiere como una opción quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, en casos seleccionados. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Considere dar prioridad al tratamiento para controlar los síntomas si en algún momento el paciente con cáncer colorrectal presenta síntomas del tumor primario.

¿Cuáles estudios de biología molecular deben realizarse al espécimen quirúrgico de los pacientes con cáncer colorrectal y cuáles son las opciones de terapia dirigida (target)?

- | | |
|----|---|
| 89 | En cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable) se sugiere realizar estudio de biología molecular para determinar mutación de RAS (RAS extendido) y BRAF. |
| 90 | En pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable), se sugiere considerar como factor predictivo favorable de la respuesta al tratamiento con anticuerpos anti-EGFR, la presencia de KRAS y NRAS nativos o no mutados. |
| 91 | Se sugiere la determinación rutinaria de la inestabilidad microsatelital como estudio molecular predictor de respuesta en pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable). |
| 92 | Bevacizumab en combinación con regímenes de quimioterapia basados en fluoropirimidina, oxaliplatino y/o irinotecán en primera o segunda línea de tratamiento, es recomendado como opción de tratamiento para pacientes con cáncer colorrectal avanzado en quienes los beneficios exceden los riesgos de toxicidad. |
| 93 | La monoterapia con cetuximab o panitumumab se recomienda como una opción de tratamiento en tercera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con KRAS y NRAS nativos que han fallado a otros tratamientos previos. |
| 94 | En pacientes con cáncer colorrectal metastásico o irresecable, se recomienda la terapia de mantenimiento con una monoterapia: fluoropirimidina y/o un anticuerpo monoclonal después de haber sido utilizados como parte de quimioterapia de combinación en primera línea de tratamiento. |
| 95 | En pacientes llevados a cirugía de resección de metástasis y que posterior a ésta no tienen evidencia de enfermedad residual macroscópica, se recomienda tratamiento complementario postoperatorio con 3 a 6 meses de quimioterapia basada en fluoropirimidina +/- oxaliplatino (según régimen previo). En estos pacientes no se recomienda el uso de anticuerpos monoclonales como parte de la quimioterapia postoperatoria. |

Evidencia seleccionada

Manejo de las metástasis

Kanas y col realizaron una revisión sistemática con metaanálisis en 2012 (111), con el objetivo de evaluar la supervivencia luego de resección de metástasis hepáticas por cáncer colorrectal. Se incluyeron 54 estudios para el análisis. La supervivencia

a 5 años estuvo entre 16% a 74% (mediana 38%), con una mediana de tiempo de 3.6 años. Los riesgos meta-relativos por factor pronóstico fueron: ganglio positivo primario, 1.16 (IC95% 1.5-1.7); nivel de antígeno carcinoembrionario, 1.9 (1.1-3.2); enfermedad

extra-hepática, 1.9 (1.5-2.4); grado de tumor pobre, 1.9 (1.3-2.7); márgenes positivos, 2.0 (1.7-2.5); >1 metástasis hepática, 1.6 (1.4-1.8).

Gonzalez y col en 2013 publicaron una revisión sistemática con metaanálisis con el fin de clarificar cuáles factores de riesgo preoperatorios son determinantes en la supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico luego de metasta-sectomía pulmonar (112). Se incluyeron 25 estudios para el análisis. Se encontró que 4 parámetros estuvieron asociados a peor pronóstico: un intervalo libre de enfermedad corte entre la resección del tumor primario y el desarrollo de metástasis pulmonar (HR 1.59, IC95% 1.27-1.98); múltiples metástasis pulmonares (HR 2.04; IC95% 1.72-2.41); nódulos linfáticos mediastinales y/o hiliares (HR 1.65; IC95% 1.35-2.02); y antígeno carcinoembrionario elevado pre-toracotomía (HR 1.91; IC95% 1.57-2.32). El antecedente de resección de metástasis hepáticas no alcanzó significancia estadística (HR 1.22; IC95% 0.91-1.64).

Citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC)

En el contexto de carcinomatosis peritoneal, en 2003 se publica el estudio de Verwaal y colaboradores, cuyo propósito fue desarrollar un ensayo clínico fase III para determinar la eficacia de un procedimiento previamente propuesto para manejar la carcinomatosis peritoneal (llamado procedimiento de Sugarbaker en su momento) (113). Realizaron un ensayo clínico con 105 pacientes quienes asignados aleatoriamente a dos grupos: un grupo control, que recibió manejo estándar con cirugía en caso de obstrucción y quimioterapia con 5-FU y leucovorina; y al grupo intervención, que consistía en una cirugía citorreductiva

para luego efectuar una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Los resultados fueron una mediana de supervivencia de 12.6 meses para el grupo control y de 22.3 meses para el grupo intervención ($p=0.032$).

Verwaal y su equipo de investigación publicó en 2008 un seguimiento a 8 años de su estudio primario (114). Con una mediana de seguimiento de 8 años (rango 72-115 meses) se evidenció un tiempo libre de enfermedad de 7.7 meses en el grupo control y de 12.6 meses en el grupo intervención ($p=0.020$). La supervivencia fue esencialmente igual, con 12.6 meses para el grupo control y de 12.2 meses para el grupo intervención.

Complementario a los estudios de Verwaal, Yan y col publicaron en 2006 una revisión sistemática de la eficacia de la cirugía citorreductiva combinada con HIPEC para carcinomatosis peritoneal secundario a cáncer colorrectal (115). Incluyeron 14 estudios para el análisis. Encontraron una mediana de supervivencia de 13 a 29 meses, y una supervivencia global a 5 años del 11% al 19%. Concluyeron que la cirugía citorreductiva más HIPEC mejora la supervivencia en comparación con la quimioterapia sistémica, sin bien mencionar que hubo una baja calidad de la evidencia en 13 de los 14 estudios.

Sugarbaker y Ryan en 2012 publica un artículo de discusión (116), en el que aborda la disyuntiva que enfrentan los médicos al tener evidencia de estudios pequeños o se diseñen observacionales, en el que tienen la opción de esperar a que se acumule más evidencia so peso de restringir el beneficio potencial del HIPEC, o por el contrario, con la opción de ir a la vanguardia de esta nueva alternativa so peso de aportar mayor carga de eventos adversos. Sugarbaker y Ryan

entonces exponen diferentes argumentos para discutir si la citorreducción peritoneal mas HIPEC es un procedimiento eficaz o experimental, sobre todo con evidencia reciente que ha optimizado la quimioterapia sistémica. Concluyen que este procedimiento tiene a su favor evidencia que al menos el 30% de los pacientes tiene una supervivencia prolongada, siendo los pacientes con mínima carcinomatosis lo que tiene mejor pronóstico, con una morbilidad general del 12% y mortalidad del 1% en centro con experiencia, y que los estudios con efecto positivo se han replicado en diferentes centros oncológicos en el mundo. Por otro lado, el procedimiento tiene en su contra que se trata de una tecnología compleja y que requiere de una amplia curva de aprendizaje, algunas series muestras que se siguen esquemas de quimioterapia diferentes, un ensayo clínico mostró un resultado negativo asociado a la inclusión de tumores del apéndice, y el potencial sesgo de selección (por parte del cirujano) que puede influir en aquellos estudios con resultados positivos. Al final, dejan la puerta abierta ante la espera de nuevos estudios con mayor número de pacientes y de diseños prospectivos.

Finalmente, en 2015, van Oudheusden y col elaboraron una revisión sistemática para determinar la incidencia de recurrencia de enfermedad luego de cirugía citoreductiva más quimioterapia intraperitoneal (117). Se incluyeron 28 estudios para el análisis. La tasa de recurrencia global estuvo entre 22.5% a 82%. La mediana de tiempo de recurrencia fue de 9 a 23 meses. El tiempo libre de enfermedad a 3 años estuvo entre 14% a 41.5%. La mediana de supervivencia fue de 18 a 55.7 meses. Con base en lo anterior, los autores concluyeron que la recurrencia es un evento común y se requieren de estrategias preventivas para afrontar el riesgo de recurrencia.

Terapia sistémica en cáncer colorrectal metastásico

Brandi y col en 2016 publicaron una revisión sistemática con el objetivo de revisar el estado del arte de la quimioterapia sistémica en el manejo de pacientes luego de resección de metástasis por cáncer colorrectal (118). En su síntesis narrativa de la literatura, construyen las siguientes consideraciones:

- La terapia sistémica en pacientes con cáncer colorrectal avanzado debería considerar si la enfermedad es potencialmente curable con una combinación de quimioterapia y cirugía, mediante la denominada terapia de conversión con el fin de reducir el tamaño del tumor hasta que sea considerado resecable.
- Los estudios muestran efectos positivos que sustentan la recomendación de resección quirúrgica radical de lesiones aisladas en pulmón e hígado como opción curativa.
- Considerando que cerca del 80% de los pacientes con cáncer colorrectal tienen enfermedad resecable al momento del diagnóstico, y que la cirugía es el principal tratamiento con intención curativa, y que, por otro lado, el riesgo de recurrencia depende del estadio patológico del tumor primario, es justificable el uso de terapia adyuvante dirigida a reducir este riesgo.

Respecto a la evidencia del tipo de agente quimioterápico, hay abundante literatura publicada en los últimos 15 años. Se mencionan algunos que apoyan el uso de esquemas específicos.

Tournigand y col publicaron en 2004 los resultados del estudio GERCOR (119). Se trató de un ensayo clínico fase III cuyo objetivo fue evaluar la mejor secuencia de

tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal. Participaron 109 pacientes quienes fueron asignados a dos grupos de forma aleatoria: el grupo intervención, que consistió en la administración de fluorouracilo (FU) con leucovorina (LV) en combinación con irinotecan u oxaliplatino; y al grupo control, en el que se administró FU + LV solamente. Las secuencias que se investigaron fueron: brazo A con FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo, e irinotecán) seguido por LV, FU y oxaliplatino (FOLFOX); brazo B, primero FOLFOX y luego FOLFIRI. La mediana de supervivencia fue de 21.5 meses en el grupo de FOLFIRI luego FOLFOX versus 20.6 meses en el grupo FOLFOX luego FOLFIRI ($p=0.99$). La mediana de tiempo libre de segunda progresión fue de 14.2 meses para el brazo A y de 10.9 meses para el brazo B ($p=0.64$). La incidencia de eventos adversos fue diferente según el esquema utilizado: mayor ocurrencia de mucositis grado 3/4 y náusea-vómito y grado 2 de alopecia para FOLFIRI; mayor ocurrencia de neutropenia grado 3/4 y toxicidad neurológica para FOLFOX. Los autores concluyeron que ambas secuencias son de eficacia similar en prolongar la supervivencia.

Koopman y col publicaron en 2009 los resultados del estudio CAIRO (120). Elaboraron un ensayo clínico aleatorizado fase III, con el objetivo de determinar si la combinación en primera línea es mejor que la administración secuencial en términos de supervivencia. Participaron 820 que fueron asignados a dos grupos: el grupo intervención, que recibieron la combinación de capecitabina mas irinotecán como primera línea, y capecitabina mas oxaliplatino como segunda línea; y el grupo control, que recibieron de manera secuencial capecitabina como primera línea, luego irinotecán como segunda línea, y capecitabina+oxaliplatino como tercera línea. La mediana de supervivencia

fue de 16.3 meses para el grupo control (secuencial) en comparación con los 17.4 meses del grupo intervención (combinación), para un $HR=0.92$ entre intervención vs control (IC95% 0.79-1.08; $p=0.3281$). La conclusión del estudio fue que el esquema de combinación no mejora significativamente la supervivencia comparada con el esquema secuencial, por lo que es una opción válida de tratamiento en cáncer colorrectal avanzado.

Cassidy y col publicaron en 2008 un estudio fase III, desarrollado para evaluar si la capecitabina mas oxaliplatino (XELOX) no es inferior al fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino (FOLFOX) como primera línea de tratamiento en cáncer colorrectal metastásico (121). Participaron 634 pacientes. La mediana de tiempo libre de progresión fue de 8 meses en el grupo XELOX frente a los 8.5 meses del grupo FOLFOX ($HR 1.04$; IC95% 0.93-1.16). La mediana de supervivencia fue de 19.8 para XELOX y de 19.6 meses para FOLFOX ($HR 0.99$; IC95% 0.88-1.12). El estudio concluye que el XELOX no es inferior al FOLFOX como primera línea en el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico.

Biomarcadores para terapia sistémica

Allegra y colaboradores en 2016, publican un artículo que actualiza la opinión clínica provisional de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) acerca de la realización de pruebas para RAS extendido (122). Esta recomendación deriva de una revisión de la literatura sobre los resultados de ensayos clínicos fase II y III que han demostrado que tumores con mutaciones del RAS en los exones 2, 3 y 4 no responden adecuadamente a la terapia con anticuerpos monoclonales dirigidos contra EGFR (epidermal growth factor receptor) cuando se usan en

monoterapia o combinados con quimioterapia. Los autores sintetizan la evidencia derivada de 11 revisiones sistemáticas, 2 estudios retrospectivos y 2 evaluación de tecnologías sanitarias, sobre los resultados de pacientes con cáncer colorrectal metastásico con y sin mutación detectada. Concluyen que todos los pacientes con cáncer colorrectal metastásico que son candidatos para anticuerpos anti-EGFR deberían ser testeados para mutaciones tanto de KRAS como de NRAS ya que el agregado de evidencia muestra que esta terapia solo debería ser considerada en pacientes con tumores sin mutaciones.

En este mismo sentido, en 2017 se publica la guía de los grupos de la American Society for Clinical Pathology, el College of American Pathologist, la Association for Molecular Pathology y la American Society of Clinical Oncology, sobre la utilización de biomarcadores moleculares para evaluación del cáncer colorrectal (123). Mediante un proceso de desarrollo de guía de práctica clínica basada en la evidencia, establecen las siguientes recomendaciones:

- Todo paciente con cáncer colorrectal que sea considerado para terapia anti-EGFR debe realizársele prueba mutacional de RAS, que incluya KRAS y NRAS (RAS "extendido").
- Estudio de análisis mutacional del BRAF debería realizarse en tejidos de cáncer colorrectal para estratificación pronóstica, así como en tumores con déficit de desapareamiento de bases

Terapia con agentes biológicos (target therapy)

Kirstein y colaboradores realizaron una revisión sistemática, publicada en 2014, con el fin de sintetizar la evidencia relacionada con el efecto de agentes moleculares en cáncer colorrectal metastásico (124). Se incluyeron 40 estudios para el análisis. La síntesis narrativa de esta revisión mostró:

- El bevacizumab aumenta la eficacia de la quimioterapia con irinotecán, fluorouracilo o capecitabina, tanto en primera como en líneas subsecuentes.
- El cetuximab es efectivo con fluoropirimidinas, leucovorina e irinotecán (FOLFIRI) en el contexto de primera línea y como agente único en últimas líneas.
- La eficacia de panitumumab se ha evidenciado con oxaliplatino con fluoropirimidina en primera línea, así como en segunda, y en monoterapia en últimas líneas.
- La terapia anti-EGFR (cetuximab, panitumumab) está restringida a pacientes con tumores que no conllevan mutaciones del KRAS.

Pientrantonio y col elaboraron una revisión sistemática sobre los anticuerpos anti-EGFR en primera línea, publicada en 2015 (125). Se incluyeron 7 estudios tipo ensayos clínicos aleatorizados para el análisis. En la población con RAS wild-type o no mutado los anticuerpos anti-EGFR mejoraron significativamente la supervivencia global (HR=0.81; IC95% 0.71-0.92; p=0.002), y mejoró el tiempo libre de progresión (HR=0.77; IC95% 0.60-0.98; p=0.03). La adición de un anti-EGFR a la quimioterapia mejoraba el tiempo libre de progresión. Comparados con bevacizumab, los anti-EGFR me-

mejoraban la supervivencia global (HR=0.80; IC95% 0.69-0.92; p=0.003), pero no el tiempo libre de enfermedad (HR=0.94; IC95% 0.74-1.19; p=0.59).

Botrel y col publicaron en 2016 una revisión sistemática sobre la eficacia y seguridad del bevacizumab más quimioterapia, en comparación con la quimioterapia sola en pacientes sin previo tratamiento con cáncer colorrectal metastásico (126). Incluyeron 9 estudios (para 3914 pacientes). Encontraron que aquellos pacientes que recibieron la combinación de quimioterapia con bevacizumab tuvieron una mayor tasa de respuesta (RR=0.89; IC95% 0.82-0.96; p=0.003), mayor tiempo libre de progresión (HR=0.69; IC95% 0.63-0.75; p<0.00001) y mayor tasa de supervivencia global (HR=0.87; IC95% 0.80-0.95; p=0.002). En cuanto al perfil de seguridad, el grupo de terapia combinada tuvo mayor ocurrencia de eventos grado ≥ 3 , entre ellos, hipertensión (RR=3.56; IC95% 2.58-4.92), proteinuria (RR=1.89; IC95% 1.26-2.84), perforación gastrointestinal (RR=3.63; IC95% 1.31-10.09), eventos tromboembólicos (RR=1.44; IC95% 1.20-1.73) y sangrado (RR=1.81; IC95% 1.22-2.67). El análisis de subgrupos mostró mayor eficacia en aquellos pacientes que recibieron bolos de 5-FU o capecitabina. Por otro lado, los esquemas que contienen irinotecán o monoterapia de fluoropirimidinas mostraron mejores resultados en comparación con la terapia sistémica asociada a bevacizumab.

5.8.1. Consideraciones para la implementación

Si bien se hace las siguientes consideraciones en este apartado, las discusiones también tuvieron lugar en los otros bloques temáticos, y es en relación con el papel que juega las Juntas Multidisciplinarias. Hay evidencia que sugiere que los Equipos

Multidisciplinarios pueden mejorar los desenlaces más relevantes de los pacientes con cáncer. En este sentido, el panel de expertos está de acuerdo con la extensión de este tipo de intervención para, idealmente, todo paciente con diagnóstico de novo de cáncer colorrectal.

Para lograr la implementación en todas las IPS oncológicas, se propone inicialmente llevar a todo paciente con diagnóstico de cáncer metastásico, ya que, en colon y recto en particular, se deben tener en cuenta las posibilidades de resecabilidad y posible conversión hacia un manejo con intención curativo. En caso de que la Junta dictamine que no es candidato a manejo curativo, igualmente se debe activar las medidas paliativas para impactar sobre la calidad de vida del paciente, en particular si se considera intervención quirúrgica con intención paliativa.

Varios de los expertos consideran que hay experiencias en otros centros oncológicos en los cuales todo paciente, sin importar el estadio, es llevado a junta multidisciplinaria. Las ventajas de ello es que se tiene un abordaje integral del paciente y sus necesidades en salud, junto con la activación temprana del equipo de cuidados paliativos. Las limitantes corresponden a la logística necesaria para llevar a todos los pacientes con diagnóstico reciente de cáncer, no sólo colorrectal. En la medida que se puedan implementar instrumentos de estratificación del riesgo, se podrá realizar un proceso de priorización que impacte de forma significativa.

Adicionalmente, la implementación extensa de las Juntas Multidisciplinarias son el elemento clave de programas de gestión de enfermedades crónicas, que junto con actividades de autocuidado, fortalecimien-

to de la práctica clínica y rediseño de la organización de la prestación de servicios, se puede lograr la creación de un modelo de atención integral y de servicios integrados dirigido a la población oncológica de la ciudad de Cali. La Junta Multidisciplinaria vie-

ne a ser ese paso de punto crítico del proceso de atención, pues determina la ruta terapéutica a seguir, activando no solo al paciente, sino a los demás actores del sistema de salud de la ciudad.

5.9. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON CÁNCER COLORRECTAL

¿Cuál es la mejor estrategia de seguimiento y con qué periodicidad debe realizarse en pacientes con cáncer colorrectal tratado?

- | | |
|-----|--|
| 96 | <p>Luego de haber terminado el tratamiento potencialmente curativo, se sugiere programar visita de seguimiento a todos los pacientes con cáncer colorrectal que incluya exploración física y prueba de antígeno carcinoembrionario, en las siguientes frecuencias por periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Año 1 y 2: cada 3-6 meses. • Año 3, 4 y 5: cada 6 meses. |
| 97 | <p>En paciente con cáncer colorrectal con estadios II-III que se encuentran en seguimiento, se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen-pelvis cada año durante 5 años.</p> <p>En estadio IV, se sugiere toma de TAC cada 6 meses durante los primeros 2 años. Luego cada año hasta completar 5 años.</p> |
| 98 | <p>En paciente con cáncer de recto estadios II, III y IV, se recomienda la toma de RMN cada 3-6 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta completar 5 años, únicamente en aquellos en que se les haya realizado una escisión local trans-anal.</p> |
| 99 | <p>En casos excepcionales y como última opción, si los recursos locales y/o las preferencias del paciente excluyen el uso de la tomografía axial computarizada, se sugiere sustituir con un ultrasonido la tomografía de abdomen y de pelvis y sustituir con una radiografía de tórax la tomografía de tórax.</p> |
| 100 | <p>Se sugiere realizar una colonoscopia de seguimiento aproximadamente un año después de la cirugía inicial. La frecuencia de las colonoscopias de vigilancia posteriores debería depender de los resultados de la anterior, esto es, repetir al año si se evidenció adenoma avanzado, de lo contrario, repetir al 3er año, y después cada 5 años.</p> |
| 101 | <p>Si una colonoscopia completa no se realizó en el transcurso del diagnóstico y la estadificación (por ejemplo, debido a una obstrucción), la evidencia sugiere hacer una colonoscopia dentro de los seis meses siguientes de haber completado la terapia primaria.</p> |
| 102 | <p>No se sugiere la tomografía con emisión de positrones como parte de la vigilancia de rutina en pacientes con cáncer colorrectal tratados con cirugía curativa.</p> |

- 103 Se sugiere realizar tomografía con emisión de positrones para determinar el sitio de recurrencia en pacientes que tienen aumento del antígeno carcinoembrionario con imágenes convencionales que no identifican enfermedad metastásica.
- 104 Se sugiere considerar una recurrencia con cualquier síntoma nuevo y persistente o que empeore, en el contexto de elevación del CAE y otros paraclínicos. Entre los síntomas sugerentes de recurrencia se encuentran:
- Dolor abdominal, particularmente en el cuadrante superior derecho o en el flanco derecho (área hepática).
 - Tos seca.
 - Síntomas vagos constitucionales como fatiga o náuseas.
 - Pérdida de peso inexplicable.
 - Signos y/o síntomas específicos para cáncer rectal: dolor pélvico, ciática, dificultad para orinar o defecar.
 - No hay señales de síntomas específicos para el cáncer de colon que no fueran aplicables también al cáncer de recto.
- 105 En pacientes con cáncer colorrectal a quienes se haya realizado tratamiento con preservación de esfínter anal, se sugiere realizar valoración especializada por fisioterapia, o terapia de piso pélvico, para direccionar el proceso de rehabilitación. Así mismo, se sugiere la realización de ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico direccionados por terapeuta e idealmente a través de la realización de terapia biofeedback del piso pélvico como estrategia de rehabilitación para el manejo de incontinencia esfinteriana.

Evidencia seleccionada

Seo y colaboradores en 2013 publicaron un estudio observacional con el objetivo de lograr distinguir las características del cáncer colorrectal recurrente que ocurrió en más de 5 años, o menos de 5 años, después de la resección curativa (127). Contaron con la participación de 835 pacientes. Encontraron que el 4.3% de la cohorte tuvo una recurrencia pasados 5 años. Este grupo (de recurrencia tardía) mostraba niveles menores de antígeno carcinoembrionario, tumores bien diferenciados y ausencia de metástasis en ganglios linfáticos. La metástasis a pulmón fue el sitio más prevalente de recurrencia en el grupo de más de 5 años. Los autores concluyen que luego de 5 años de seguimiento parecen ser suficientes, aunque la posibilidad de recurrencia tardía (en especial para recurrencia en pulmón) deben ser considerada.

En 2015, Pita-Fernández y colaboradores elaboraron una revisión sistemática con metaanálisis con el fin de evaluar las estrategias de seguimiento utilizadas en el monitoreo de pacientes con cáncer colorrectal no metastásico después de cirugía curativa que puedan tener asociación con disminución en la mortalidad (128). Incluyeron 11 estudios (4055 pacientes) en el análisis. Encontraron una mejora significativa en la supervivencia global en pacientes con un seguimiento más intenso (aunque no se define con claridad en el estudio) con un HR=0.75 (IC95% 0.66-0.86), con alta probabilidad de detección de recurrencias asintomáticas (RR=2.59; IC95% 1.66-4.06) y mayor probabilidad de cirugía con intención curativa en la recurrencia. Los autores describen que el seguimiento intensivo en los

estudios analizados consiste en seguimiento de cada 3-4 meses durante los primeros años, acompañado de estudios de CAE con colonoscopia e imágenes de manera sistemática, mientras que los de “menos intensidad” son esquemas de seguimiento de 6 meses o con únicamente laboratorios, con colonoscopia o imagenología ocasional no-sistemática.

Duineveld y col publicaron un estudio tipo cohorte retrospectiva con el propósito de valorar que tan recurrente es el cáncer colorrectal y su diagnóstico de acuerdo con los seguimientos programados (129). Con base en la información recolectada de 446 pacientes con cáncer colorrectal que fueron llevados a cirugía curativa, el 17% tuvo recurrencia. El 58% de éstos fue detectada en los seguimientos programados, y el 95% fue asintomática. Del 5% restante de recurrencia sintomática, los síntomas más frecuentes fueron dolor abdominal (57%), alteraciones en la defecación (42%), pérdida de peso (23%), dolor lumbar o pélvico (15%), fatiga (7%), disnea (7%), y otros un 11% (que incluían hematuria y tos).

Lepage y col están desarrollando actualmente un ensayo clínico fase III, el estudio PRODIGE 13, que busca evaluar el efecto a 5 años del seguimiento imagenológico y de antígeno carcinoembrionario (CAE) para detectar recurrencia en cáncer colorrectal, comparando un seguimiento estándar frente a un seguimiento “reforzado” (130). Este estudio se estima culminará en Junio de 2021.

Por otro lado, Nicholson y col publicaron una revisión sistemática en 2014, cuyo objetivo fue determinar el desempeño diagnóstico de los diferentes niveles de antígeno carcinoembrionario (CAE) en cuanto a la identificación de recurrencia por cáncer

colorrectal (131). Se incluyeron 52 estudios para el análisis. Para un umbral de 2.5 µg/L, la sensibilidad agregada fue de 82% (IC95% 78% a 86%) y una especificidad agregada de 80% (59% a 92%). Para umbral de 5 µg/L, la sensibilidad agregada fue de 71% (IC95% 64% a 76%) y una especificidad agregada de 88% (84% a 92%). Para umbral de 10 µg/L, la sensibilidad agregada fue de 68% (IC95% 53% a 79%) y una especificidad agregada de 97% (90% a 99%). Los autores concluyen que el uso aislado del CAE es insuficientemente sensible, incluso con umbrales bajos, por lo que sugieren complementar el seguimiento de CAE con otras modalidades diagnósticas y aplicando un umbral de 10 µg/L, y no se recomienda utilizar como estrategia para aumentar la sensibilidad la disminución del umbral, dado el alto número de falsos positivos que se pueden generar.

Kahi y col publicaron en 2016 las recomendaciones del US Multi-Society Task Force acerca del seguimiento de colonoscopia en cáncer colorrectal luego de resección (132). Basados en una revisión de la literatura, emiten las siguientes recomendaciones:

- En pacientes con cáncer colorrectal se recomienda realizar colonoscopia perioperatoria, en 3 a 6 meses luego de la intervención quirúrgica.
- En pacientes que se les realizó una cirugía curativa, se recomienda colonoscopia de seguimiento al cabo de 1 año después de la cirugía.
- Se recomienda que luego de la colonoscopia del primer año, el intervalo de la siguiente colonoscopia sea de 3 años (es decir, 4 años después de la cirugía) y luego a los 5 años (es decir, luego de 9 años de la cirugía)

Por otro lado, en cuanto al uso de PET CT en el seguimiento, Patel y col publicaron una revisión sistemática en 2013 que abordó este tema (133). Basados en la revisión de 12 estudios, hallaron que la mayoría reportaba una sensibilidad con rango de 90-100%, si bien los estudios eran muy heterogéneos entre sí. En este orden de ideas, Lu y demás publicaron en ese mismo año una revisión sistemática con metaanálisis (134), la cual evidenció que, para detección de recurrencia de cáncer colorrectal, el PET CT con FDG y elevación de CAE muestra una sensibilidad de 94.1 (IC95% 89.4-97.1) y una especificidad de 77.2% (IC95% 66.4-85.9). Este último estudio aporta evidencia de la utilidad diagnóstica del PET CT en el contexto de elevación del CAE.

5.9.1. Consideraciones para la implementación

Las consideraciones para implementar las recomendaciones de seguimiento están

relación con garantizar el acceso a los controles de acuerdo con la frecuencia planteada. Desde las EAPB ya se han tomado medida para garantizar el acceso en cuanto a mecanismos que evitan el vencimiento de las órdenes, así como el monitoreo del cumplimiento y adherencia por parte del paciente a las consultas de control.

El desafío actual de la ciudad de Cali está en relación con aquellos casos en que el paciente cambia de IPS oncológica, ya sea por cambio de la red contratada por parte de la EPAB, por cambio de afiliación que hace el paciente. Mientras no exista una historia clínica unificada, el proceso de seguimiento recae en la gestión documentar entre las EAPB, entre las IPS oncológicas, y la proactividad del paciente. Si bien hay propuestas de solución a este problema, se requiere de la presencia de canales de comunicación a nivel institucional que permitan una verdadera transferencia de la atención del paciente con cáncer colorrectal.

5.10. CUIDADOS PALIATIVOS

¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para lograr el empoderamiento del paciente, mayor introspección de la enfermedad y disminución del temor al tratamiento instaurado?

- | | |
|-----|--|
| 106 | Se recomienda la utilización del Protocolo SPIKES como herramienta de comunicación con los pacientes oncológicos con el fin de evaluar las percepciones del paciente respecto a su enfermedad, activar mecanismos de resiliencia, informar, y valorar su respuesta emocional. |
| 107 | Se sugiere la utilización de ayudas para la toma de decisiones para mejorar la comunicación entre el paciente y el equipo de cuidados paliativos y médicos tratantes. |
| 108 | Se recomienda que unos de los temas de comunicación con el paciente con cáncer y su familia sea sobre el pronóstico de su enfermedad, con el fin de que se exista un entendimiento apropiado del mismo y comprenda el plan de manejo a seguir, en especial cuando el tratamiento instaurado no tiene intención curativa. |

Evidencia seleccionada

La comunicación entre el equipo de profesionales de salud y el paciente con cáncer implica ciertos retos, ya que un paciente adecuadamente informado tendrá más herramientas de conocimiento, participación y empoderamiento del manejo de su enfermedad. Sin embargo, dar un diagnóstico de cáncer es una tarea de comunicación compleja, así como abordar el plan terapéutico a seguir. Esto se debe a la respuesta emocional del paciente por la incertidumbre que genera la enfermedad y el pronóstico de esta, entre otros elementos de estrés propios de recibir malas noticias, esto es, el choque entre el diagnóstico recibido y la expectativa del paciente sobre la causa de su dolencia.

Es en este escenario que se ha propuesto el Protocolo SPIKES como una serie de pasos que permite al médico tratante y al equipo de salud abordar de una forma sistemática los retos y complejidades que impone el acto de dar malas noticias, a la vez que cumple con la responsabilidad de brindar una comunicación que aborda de manera holística e integral al paciente, bajo los principios de beneficencia, no maleficiencia y autonomía.

El Protocolo SPIKES consiste en seis pasos (135):

- Paso 1: Estableciendo el escenario de la entrevista (Setting)
- Paso 2: Valorando la percepción del paciente (Perception)
- Paso 3: Obteniendo la invitación del paciente (Invitation)
- Paso 4: Brindando conocimiento e información al paciente (Knowledge)
- Paso 5: Direccionando las emociones del paciente con respuesta empáticas (Emotions)
- Paso 6: Estrategia y resumen (Strategy and Summary)

Una revisión de la literatura acerca de la evidencia del protocolo SPIKE mostró que, sin bien hay una importante adherencia por parte de los médicos al protocolo, justificado por brindar pautas dirigidas para dar malas noticias, no existe evidencia sobre el impacto que tiene sobre la experiencia del paciente (136). Esto se debe, según los autores de esta revisión, a la complejidad de evaluar o medir la subjetividad de la respuesta individual del paciente ante un evento estresante como lo es recibir un diagnóstico ominoso. A pesar de todo, la evidencia hasta el momento desarrollada apunta a que el protocolo SPIKES es una herramienta valiosa para la práctica médica en cuanto a permite al médico abordar sistemáticamente la situación por la que atraviesa el paciente.

Por otro lado, una forma de mejorar la comunicación con el paciente es a través de ayudas para la toma de decisiones. Una revisión sistemática publicada en 2009 evaluó la efectividad de las ayudas para la toma de decisiones para abordar el nivel de conocimiento del paciente, su ansiedad, y la toma de decisiones por parte del paciente (137). Se consideró como “ayuda para la toma de decisiones” a toda intervención diseñada principalmente para ayudar a los pacientes y a sus médicos para tomar decisiones juntos. Estas ayudas podían ser folletos, consejería, tabla de alternativas (un instrumento más visual), software con fines similares, libretos estandarizados, video clips, y talleres. El estudio involucró 34 ensayos clínicos aleatorizados, y se logró hacer un metaanálisis de los datos. El

estudio concluyó que las ayudas para decisiones relacionadas con la atención en cáncer son efectivas para adquirir conocimiento (tamaño del efecto estimado 0.50, IC95% 0.31-0.70), sin evidenciarse un efecto estadísticamente significativo para el manejo de la ansiedad o apoyo en la toma de decisiones por parte del paciente.

Dentro de los temas más relevantes dentro del proceso de comunicación con el paciente, es el relacionado con el pronóstico de la enfermedad. Una encuesta realizada a 50 pacientes ambulatorios del Massachusetts General Hospital Cancer Center buscó evaluar la percepción del pronóstico y preferencias de información sobre el pronóstico entre paciente con cáncer avanzado, y explorar la asociación entre entendimiento del pronóstico y la calidad de vida y estado de ánimo (138). Si bien para el 64% de los encuestados era importante conocer acerca del pronóstico, el 54% creían que su cáncer se iba curar si bien su manejo no era con intención curativa. Este estudio observacional mostró que los pacientes con una percepción de incurabilidad o de enfermedad terminal, presentaban mayor deterioro en su calidad de vida y mayor nivel de ansiedad, por lo que los autores

concluyen que se debe proveer una información adecuada del pronóstico a la vez que se brinda apoyo psicosocial.

Del mismo modo, una revisión narrativa y sistemática de la literatura publicada en 2009 (139) sobre comunicación médico-paciente, valoró 9 ensayos clínicos, cuatro guías, y ocho revisiones sistemáticas, encontrando que hay cierto psicológico cuando se discute sobre el pronóstico y la expectativa de vida, aunque la preferencia a recibir este tipo de información fue proveniente principalmente de mujeres y de personas con bajos niveles de ansiedad. Por el contrario, algunas investigaciones indicaron que la preferencia por una comunicación del pronóstico fue menor cuando el pronóstico y el estadio de la enfermedad eran peores.

Así mismo, las técnicas para aumentar la participación del paciente en la toma de decisiones se asociaron con una mayor satisfacción, aunque no necesariamente disminuyeron la angustia. Las ayudas para la toma de decisiones pueden facilitar el conocimiento y la participación del paciente en el proceso de toma de decisiones, pero su utilidad puede variar según la etapa de la enfermedad (139).

¿Cuáles serían los criterios de derivación temprana al programa de cuidados paliativos?

- | | |
|-----|---|
| 109 | Se recomienda remitir al Equipo Cuidados Paliativos a todo paciente con diagnóstico de cáncer localmente avanzado o metastásico. |
| 110 | <p>En paciente con estadio temprano de la enfermedad, se sugiere realizar interconsulta al Equipo de Cuidados Paliativos, si presenta uno o más de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Síntomas incontrolados. • Angustia de moderada a grave relacionada con el diagnóstico y la terapia del cáncer. • Enfermedades físicas y psicosociales comórbidas graves. • Necesidades psicosociales complejas. • Conciencia de pronóstico pobre. • Enfermedad potencialmente fatal o de alta mortalidad. |

- Inquietudes del paciente / familia / cuidador sobre el curso de la enfermedad y la toma de decisiones.
- Solicitud de cuidados paliativos del paciente / familia / cuidador.
- Solicitud del paciente de muerte anticipada.

(Criterios adoptados de la NCCN 2020)

- 111 Se sugiere el uso del instrumento NECPAL CCOMS-ISO como estrategia complementaria para identificar pacientes que requieren de cuidados paliativos.

Evidencia seleccionada

La guía de la NCCN sobre cuidados paliativos, versión 1.2020 (140), establece un listado de criterios para identificar aquellos pacientes que requiere de los servicios de Cuidados Paliativos. Estos criterios van de acuerdo con aquellos establecidos en el consenso internacional en el cual participaron varias instituciones como lo son la ESMO, ASCO, WHO, y la NCCN (141). En este consenso, se acordaron criterios basados en la necesidad del paciente, y criterios basados en tiempo, considerados criterios mayores ya que la presencia de uno solo es suficiente para remitir al equipo de cuidados paliativos.

El instrumento NECPAL es una evaluación cuanti-cualitativa multifactorial, cuyo propósito es la identificación de paciente oncológico y no oncológico con necesidades en salud diferentes al tradicional y que permite incorporar medidas paliativas (142). En este sentido, es un instrumento que complementa los criterios antes mencionados, ya que tiene en cuenta elementos adicional como lo son la multimorbilidad, fragilidad, funcionalidad, estado nutricional, y distrés emocional. Este instrumento fue desarrollado por el equipo de expertos del Instituto Catalán de Oncología, basado en instrumentos previos como lo son el Prognostic Indicator Guidance (PIG) británico

y el Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT) escocés, ambos dirigidos a personas en situación de enfermedad avanzada terminal.

Este instrumento se ha validado en varios escenarios. Un estudio observacional tipo cohorte prospectivo a 24 meses de seguimiento, con 1059 pacientes con enfermedad crónica avanzada, se les aplicó el instrumento NECPAL para explorar la validez predictiva de mortalidad a 12 y 24 meses (143). Se determinó una correlación positiva con el riesgo de mortalidad a 24 meses (HR=2.4, IC95% 1.8 – 3.3), una sensibilidad de 87.5% (IC: 87.2 – 94.2), una especificidad de 35% (IC: 31.3 – 38.7), y un valor predictivo negativo de 81.7% (IC: 77.2 – 86.2). Los autores concluyen que el NECPAL es un instrumento de tamizaje adecuado para identificar paciente con un pronóstico de vida limitado y que puede requerir cuidados paliativos. Es importante mencionar que el instrumento, si bien se ha utilizado para evaluar factores pronósticos en el ámbito ambulatorio y hospitalario (144,145), no es una herramienta pronóstica propiamente dicha, sino que su propósito es identificar tempranamente pacientes que se beneficiarían de un programa de cuidados paliativos.

¿Cuál es el impacto de la derivación temprana (o acceso temprano) al programa de cuidados paliativos respecto al control de síntomas, introspección de la enfermedad, tolerancia, adherencia y continuidad al tratamiento?

- 112 Se recomienda la derivación temprana de pacientes para cuidados paliativos con el fin de mejorar la calidad de vida, brindar bienestar al paciente y sus familiares, mejorar el control de los síntomas, mejorar la adherencia a los tratamientos instaurados, y mejorar las complicaciones afectivas y socio-familiares.

Evidencia seleccionada

Una revisión sistemática realizada por el grupo Cochrane y publicada en 2017, tuvo como objetivo comparar el efecto de intervenciones tempranas en cuidado paliativo frente al tratamiento usual o estándar sobre la calidad de vida, depresión, intensidad de síntomas, y sobrevida general en paciente con cáncer avanzado (146). Se definió como intervención temprana como aquellas acciones en cuidado paliativo aplicadas en fases tempranas del curso de la enfermedad, en comparación con intervenciones “tardías” que sólo se habían enfocado en el control de síntomas o a intervenciones aplicadas cuando el paciente se encontraba en la fase final de su vida. Se incluyeron 7 estudios tipo ensayo clínico, que involucraban un agregado de 1614 paciente. En cuanto al desenlace de calidad de vida, se reportó una diferencia media estándar (SMD en in-

glés) pequeña, pero a favor del cuidado paliativo temprano, con un SMD=0.27 (IC95% 0.15, 0.38), con una heterogeneidad $I^2=0\%$. En relación con la sobrevida general, se reportó un HR=0.85 (IC95% 0.56, 1.28), con un $I^2=81\%$, esto es, una tendencia de mejora en la sobrevida, pero sin lograr una diferencia estadísticamente significativa. El impacto sobre los síntomas de depresión, la intervención temprana mostró un SMD de -0.11 (IC95% -0.26, +0.03), con un $I^2=0\%$; así, no hubo un cambio en los síntomas depresivos con la intervención temprana, si bien la tendencia es favorable. Por el contrario, en relación con el control de la intensidad de los síntomas, la intervención temprana mostro un SMD de -0.23 (IC95% -0.35, -0.10) con un $I^2=0\%$, lo sugiere un efecto beneficioso pequeño pero significativo.

¿Cuál es la efectividad de la intervención psicosocial respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?

- 113 Se recomienda que las intervenciones psicosociales relacionadas con el manejo de la colostomía incluyan aspectos de auto-imagen, auto-estima, vida sexual, y adaptación psico-social.
- 114 Se sugiere que las intervenciones psicosociales relacionadas con el manejo de la colostomía se realicen previo al procedimiento quirúrgico.
- 115 Se sugiere brindar educación e información acerca del cuidado de la ostomía, en especial en lo relacionado con evitar fugas, manejo de los olores y cuidados de la piel periestomal.

Evidencia seleccionada

Una revisión de la literatura acerca de los problemas psicosociales de los paciente con ostomías (147), mostró que la depresión, la ansiedad, cambios en la imagen corporal, baja autoestima, sentimientos de incertidumbre, y problemas sociales fueron los problemas más comúnmente reportados por estudios de corte cuantitativo a través de multiplicidad de escalas. Esta revisión también abordó estudios cualitativos, en los que se pudo una visión complementaria, en la que los pacientes asociación la presencia del estoma con problemas de adaptación, estimatización, perturbación de su vida sexual y vida social, así como dificultades para desarrollar mecanismos de resiliencia.

Así mismo, una revisión integrativa de 27 estudios que abordaron los aspectos psicológicos de paciente con estomas (148), encontrando que existe una brecha de conocimiento en lo referente a intervenciones pre-quirúrgicas y su impacto en la salud mental del paciente ostomizado, pues

la mayoría de los estudios fueron realizados en el ámbito hospitalario (en un tiempo intra-operatorio) y en intervenciones post-operatorias. Sin embargo, los pocos estudios sobre intervenciones anteriores a la cirugía sugieren que pueden reducirse las complicaciones y mejorar el proceso de adaptación del paciente, además de brindar elementos para enfrentar los desafíos que conlleva el cuidado de un estoma.

Un estudio de corte cualitativo, realizado en pacientes supervivientes de cáncer, exploró los retos y desafíos que tiene el paciente en cuanto al autocuidado de la ostomía (149). Este estudio encontró que los pacientes manifiestan dificultades para lidiar con las fugas de materia fecal, y cuidados de la piel alrededor del estoma. Las principales causas de ansiedad estuvieron relacionadas con mal función del estoma lo que generaba fujas, olores, e irritación, que a su vez limitaba de manera importante su vida social y afectaba negativamente su autoconfianza.

¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?

116

Se sugiere la vinculación de pares como intervención complementaria a las acciones individuales del equipo psicosocial, encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento médico.

Evidencia seleccionada

Un estudio observacional publicado en 2018, tuvo como objetivo evaluar el efecto del apoyo del par sobre las actitudes del paciente con cáncer colorrectal hacia la quimioterapia y su adherencia (150). Se realizaron 1301 encuesta a paciente con cáncer

colorrectal estadio III (se excluyeron a paciente con estadio IV). Se consideró como apoyo de un par como todo soporte dado, al paciente, por una persona con cáncer colorrectal. En comparación con paciente que no tuvieron un apoyo de un par, se

encontró que la exposición a un par estaba asociada mayor adherencia a la quimioterapia (OR=2.94, IC95% 1.89-4.55, $p<0.001$), y esto se relaciona con apoyo en la toma de decisiones ($p=0.008$), ayuda para saber qué esperar del tratamiento ($p<0.001$) y con ayudar a sobrellevar los efectos secunda-

rios del tratamiento ($p=0.043$). Si bien este estudio tiene las limitaciones propias de su diseño, es sugerente que un par adecuado que brinde apoyo a los pacientes podría ser una forma de mejorar la adherencia al tratamiento instaurado.

¿Cuál es la efectividad de la terapia enterostomal respecto al cuidado de la ostomía y prevención de complicaciones de la misma?

117

Se recomienda la implementación de un programa del cuidado del estoma, en el que se incluya intervenciones educativas, con el fin de reducir las complicaciones, mejorar la adaptación psicosocial y mejorar la adherencia a los tratamientos oncológicos.

Evidencia seleccionada

Un estudio cuasi-experimental, con diseño antes-después, publicado a principios del 2020, analizó el impacto en los cuidados y resultados en salud en los pacientes luego de que se implementara una guía para el cuidado y manejo de ostomías (151), dirigido por personal de enfermería especializado. En el estudio participaron 8 centros hospitalarios de España, y se determinaron tres momentos: primer año de haberse implementado la guía, al 3er año desde la implementación, y al 4º año desde la implementación. Los resultados fueron: la educación preoperatoria pasó de 36.7 al 47.3%, la educación post-operatoria pasó de 75.5 al 91.9%, las complicaciones en piel periestomal pasaron de 16.6 a 10.9% ($p=0.0005$), y las complicaciones en la ostomía pasaron de 21.8 a 27.9% ($p=0.0052$), lo que representó un aumento inesperado al que los autores le atribuyen mayor identificación y reporte.

Un estudio publicado en 2017 abordó las intervenciones educativas en pacientes con cáncer colorrectal con estoma, mediante una revisión sistemática de la literatura, encontrando 13 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión (152). El objetivo fue describir los diferentes tipos de educación para examinar sus efectos sobre la calidad de vida, habilidades psicosociales y habilidades de autocuidado. Los autores encontraron que la evidencia sugiere que las intervenciones educativas, en general, mejoran la calidad de vida, las habilidades psicosociales y de autocuidado, con hallazgos contradictorios en lo relacionado con estrés emocional, tiempo de estancia hospitalaria, re-ingreso hospitalario, y complicaciones del estoma. El estudio concluye que la educación parece tener un efecto positivo en el manejo del estoma por parte del paciente, con efectos adicionales en la esfera mental, si bien se requiere más estudios.

¿Cuál es la indicación del soporte transfusional en relación con el manejo de síntomas de anemia?

- 118 Se recomienda individualizar cada paciente frente a la necesidad de soporte transfusional en aquellos pacientes con anemia y síntomas asociados (fatiga, disnea) de acuerdo con sus características clínicas, estado funcional, pronóstico y preferencias.

Evidencia seleccionada

Preston y colaboradores publicaron en 2011 una revisión sistemática con el objetivo de sintetizar la evidencia disponible hasta ese momento sobre la transfusión sanguínea para tratar la anemia en pacientes con cáncer avanzado (153). Los autores no encontraron estudio tipo ensayo aleatorizados controlados, pero identificaron 12 estudios (para 653 participantes) de diseño antes y después, en los que se encontró que entre el 31% y el 70% de los pacientes con cáncer avanzado respondían a las transfusiones de sangre al mejorar el síntoma de fatiga (mediante la medición de las escalas ESAS y FACT), disnea y sensación de bienestar. El nivel medio de hemoglobina que motivaba la transfusión fue 7.9 g/dL y la mayoría de los pacientes recibieron cerca de 2 unidades. Cuando se determinaba el nivel de hemoglobina post-transfusión, éste era de alrededor de 10 g/dL.

Por otro lado, un estudio mostró que el 13.7% de los participantes (10 de 73) murió a los 7 días post-transfusión; otros estu-

dios encontraron que entre el 23% y 35% de los participantes murieron luego de 14 días de la transfusión. No se puede establecer un efecto causal pero los autores comentan que este hallazgo requiere de mayor investigación, pues hay factores de confusión a evaluar (muchos pacientes que recibieron la transfusión fueron paciente al final de la vida por su enfermedad terminal). De hecho, la supervivencia global de los pacientes que recibieron transfusión fue más baja en comparación con el grupo control (35 días frente a 86 días), pero de igual forma, se manifiesta la necesidad de un estudio prospectivo con este desenlace para determinar la razón de este hallazgo.

Los autores concluyen que los clínicos que requieren de brindar un tratamiento a los pacientes con cáncer avanzado que padece de anemia y sintomatología asociada, necesitan considerar estrategias de manejo alternativas antes de intentar prescribir una transfusión sanguínea.

¿Cuál es el beneficio del soporte de hidratación?

- 119 Se sugiere administrar soporte de hidratación de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente, intensidad de síntomas asociados a deshidratación, pronóstico y preferencias. En caso de que el médico tratante lo indique, se preferirá la vía oral a la vía parenteral.
- 120 Se sugiere que la cantidad de líquidos administrados para el soporte de hidratación debe ser en la cantidad mínima posible.

- | | |
|-----|---|
| 121 | En paciente con cáncer avanzado con buen grado de funcionalidad (IK>50), se sugiere brindar soporte de hidratación por vía oral, en el contexto de soporte nutricional. |
| 122 | En paciente con cáncer avanzado con deterioro de su funcionalidad (IK<50), se sugiere optimizar la vía oral. Si se requiere de hidratación parenteral, se puede efectuar una hidratación durante 24 horas y luego revalorar clínicamente. |

Puntos de buena práctica clínica:

- El médico tratante determinará, acorde a su criterio y valoración de las condiciones actuales del paciente, la vía de elección para el soporte de hidratación parenteral (endovenosa vs subcutánea), así como el tipo de líquidos a administrar.

Evidencia seleccionada

En la revisión con los expertos clínicos, se consideró adaptar las recomendaciones de la guía colombiana para la atención de pacientes en cuidados paliativos, publicada en el año 2016 (154), que a su vez es una adopción de dos guías españolas. En referencia al tema de manejo en deshidratación, se comentaron 4 revisiones sistemáticas. Sin embargo, la más reciente databa de 2004, y otras dos tenían fechas de 1998. Con el fin de actualizar la evidencia respecto a la pregunta planteada por los expertos para la presente guía, se hizo una revisión de nueva evidencia disponible.

Raijmakers y colaboradores publicaron en 2011 una revisión sistemática de la literatura acerca de las prácticas y efectos que tiene la nutrición artificial y la hidratación artificial en la última semana de vida de los paciente con cáncer (155). Se incluyeron 15 estudios para la síntesis de evidencia, encontrando que, respecto a la hidratación, la frecuencia de esta práctica en el ámbito hospitalario de 10-88% en comparación con los hospicios, con 33-44%. En cuanto a los efectos de la hidratación artificial sobre la calidad de vida

en la última semana de vida, ningún estudio seleccionado abordó este desenlace de manera analítica (con grupo control). Cinco estudios reportaron efectos de la hidratación sobre los síntomas, con un impacto limitado: un estudio halló menor náusea crónica y otro encontró mejoría de los signos de deshidratación.

Yamaguchi y colaboradores (156), en 2012, realizaron un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, con 161 pacientes, con el fin de explorar los efectos de la hidratación parenteral, basada en las guías japonesas, sobre la calidad de vida de pacientes con cáncer abdominal avanzado. La intervención consistía en administrar menos de 1000 mL/día según lo recomendaba la guía japonesa, y se comparaba con un grupo de pacientes que recibió más de 1000 mL/día. Los autores encontraron que el volumen promedio de hidratación parenteral fue de 912.3 ± 494 mL/día. El 52.8% de los pacientes recibieron más de 1500 mL al día, 37.9% se les administró por vía central, 50.9% por vía periférica, y 11.2% por ruta subcutánea. El efecto de la hidratación parenteral sobre la calidad de vida no pre-

sentó diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (Global QoL 3.60 ± 1.44 vs $3.17 \pm .31$, $p=0.091$). Así mismo, no hubo diferencias entre en la frecuencia de síntomas de retención de fluidos ni en la intensidad de otra sintomatología. Los autores concluyen que la terapia de hidratación parenteral, acorde a la guía mencionada, está asociada al mantenimiento de la calidad de vida sin empeorar los síntomas y signos relacionados con retención de líquidos.

Si bien los estudios observacionales conllevan limitaciones propia de su diseño, Bruera y colaboradores realizaron un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, multicéntrico para hidratación parenteral en pacientes con cáncer avanzado, publicado en 2013 (157). Se asignó de manera aleatoria a 129 paciente con cáncer avanzado (36% del tracto digestivo, 19% de pulmón, 15% del tracto genitourinario, entre otros) a dos grupos: grupo intervención en el que recibían 1000 mL/día, y grupo placebo en el que recibían 100 mL/día. Se encontró que, para el 4° día, hubo una mejoría significativa en los síntomas de fatiga, somnolencia, alucinaciones y mioclonías, tanto en el grupo intervención como en el grupo placebo, en comparación con sus respectivas líneas base. Por el contrario, no hubo diferencias entre los grupos al 4° día. Esta mejoría ya no era evidente cuando se comparaba el día 7° frente a la línea base, excepto en la mejora de náuseas, depresión/ansiedad y mioclonías. En relación con el puntaje de calidad de vida, se evidenció una mejora en el 7° día, estadísticamente significativas, con respecto a la línea base; nuevamente, no hubo diferencias entre el grupo intervención frente al grupo placebo. Tampoco hubo diferencias en relación con la supervivencia global (medianas del grupo intervención y placebo 21 días vs 15 días respectivamente, $p=0.83$). Los autores concluyen que la hidratación parenteral a 1000 mL/día no es superior al placebo

(100 mL/día), por lo que infieren que se apoya la práctica de no administrar de manera rutinaria líquidos parenterales, si bien se requiere de mayores estudios para evaluar sub-grupos de paciente que pudieran tener un beneficio.

En 2014, Good y colaboradores realizaron una revisión sistemática para determinar el efecto de la hidratación medicamente asistida en paciente bajo cuidados paliativos sobre su calidad de vida y prolongación de la misma (158), utilización como criterio de inclusión estudios de diseño ensayo clínico y estudios prospectivos controlados. Identificaron 6 estudios, 3 ensayos clínicos aleatorizados (incluyendo el de Bruera y col.) y 3 estudios prospectivos. Encontraron importante heterogeneidad de los datos, así como alto riesgo de sesgos. Se evidenció que, aparte de la mejoría en mioclonías y signos de deshidratación, no se encontraron beneficios adicionales. Por el contrario, en un estudio se documentó síntomas de retención de fluidos (derrame pleural, edema periférico y ascitis) en pacientes que recibieron la intervención, si bien los demás estudios no mostraron diferencias en cuanto a eventos adversos. Los autores concluyen que, dada la escasa evidencia disponible para ese momento, la hidratación medicamente asistida no parece tener un beneficio significativo en pacientes con cuidados paliativos, no obstante, se requiere de investigación adicional para emitir recomendaciones definitivas para orientar la práctica clínica.

Finalmente, Rajmakers y demás colaboradores (159), en 2011, publican una revisión sistemática enfocada en describir la evidencia disponible sobre las opiniones y actitudes hacia la hidratación parenteral en el cuidado al final de la vida, tanto por profesionales de salud como de los pacientes. Apoyados en la revisión y síntesis de evidencia de 13 estudio,

refiere que entre el 48% al 86% de los pacientes y familiares perciben la hidratación artificial como una intervención beneficiosa, y 86% de los familiares manifiestan el deseo de continuar con el soporte de hidratación

por periodos prolongados. Por otro lado, 1% al 43% de los profesionales de la salud consideran que los pacientes pueden beneficiarse de hidratación artificial, si bien no prolongará la supervivencia.

¿Cuál es la indicación de la sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios?

123 Se recomienda el uso de sedación paliativa para el manejo de síntomas refractarios, esto es, síntomas que no han podido tratarse adecuadamente a pesar de cuidados paliativos integrales e interdisciplinarios.

(Adaptado de la guía NCCN Palliative Care v1.2020)

124 Se recomienda el uso de sedación paliativa en el contexto de un paciente con indicios de sufrimiento intenso y que se encuentra al final de la vida.

125 Se sugiere definir el plan de sedación paliativa de acuerdo con la respuesta del paciente a medicamentos previos y actuales, considerando como primera opción el uso de midazolam.

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debe garantizar analgesia y sedación teniendo en cuenta síntomas fisiológicos (presencia de tensión arterial, taquicardia, taquipnea, diaforesis, contracturas musculares, mioclonías, estado de conciencia).
- Se debe comentar ampliamente con el paciente y sus cuidadores acerca de en qué consiste la sedación paliativa, lo que representa los síntomas refractarios y el sufrimiento intenso, y que frecuentemente se acompaña del retiro de medidas que

prolongan la vida (nutrición/hidratación artificial) incluyendo reanimación cardiopulmonar. Para esto último se debe tener en cuenta las consideraciones sobre el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), reglamentado por la Resolución 2665 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya.

- Se debe continuar con los tratamientos para el dolor y manejo sintomático, y titular de acuerdo con la respuesta del paciente.

Evidencia seleccionada

Maltoni y colaboradores publicaron en 2012 una revisión sistemática acerca de la sedación paliativa y su efecto sobre la sobrevivencia cuando el paciente presenta síntomas refractarios al tratamiento (160). Se incluye-

ron 11 estudios para la revisión, todos con diseño observacional, 7 prospectivos y 4 retrospectivos. Se halló que el delirium fue la indicación más frecuente para sedación paliativa, aunque con importante variabili-

dad entre los estudios (13.8% a 91.3%). 7 de 10 estudios reportaron el distrés psicológico como una de las principales razones para prescribir sedación paliativa. El 49% de los pacientes que recibieron sedación fue mediante la administración de midazolam, seguido por haloperidol (26%), otras benzodiazepinas (22%), clorpromazina (14%) y morfina (11%). Respecto al desenlace primario, la mediana de sobrevida entre pacientes sedados y no sedados variaba entre 7 a 36.5 días y de 4 a 39.5 días respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas.

Beller y colaboradores, en 2015, publican una revisión sistemática con el fin de evaluar la evidencia acerca del beneficio de la sedación paliativa farmacológica sobre la calidad de vida, sobrevida y síntomas refractarios específicos en pacientes con enfermedad terminal y durante sus últimos días de vida (161). Se definió sedación paliativa como “el uso de medicamentos sedantes para aliviar el sufrimiento intolerable de los síntomas refractarios mediante la reducción de la conciencia del paciente”. Se incluyeron 14 estudios (4167 pacientes de los cuales 1137 recibieron sedación, 95% tenían cáncer), todos observacionales. Ninguno de los estudios seleccionados incluyó aspectos de calidad de vida. 5 estudios abordaron el tema de control de síntomas, pero todos con métodos diferentes por lo que no se logró hacer un análisis agrupado. Sólo un estudio evaluó la incidencia de eventos adversos asociados a la sedación paliativa, con 6% de pacientes (4 de 70) que presentaron delirium relacionado con la medicación; no se reportó depresión respiratoria. El medicamento más utilizado fue el midazolam, seguido por haloperidol y clorpromazina. En cuanto a la sobrevida, medida como el tiempo desde la admisión a cuidados paliativos y la muerte, ningún

estudio mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que recibieron sedación en comparación con los que no la recibieron. Los autores concluyen que no hay evidencia para determinar el efecto sobre la calidad de vida, pero sí hay evidencia de que la sedación paliativa no acelera o adelanta la muerte, un tema de preocupación entre los médicos y los familiares.

En 2020, se publica una revisión exploratoria por parte de Ciancio y demás (162), con el propósito sondear aspectos o temas abordados por la literatura para responder la pregunta ¿la sedación paliativa es una intervención aceptable para tratar síntomas refractarios existenciales en adultos de 65 años o mayores? Se parte de la definición de que un síntoma refractario por sufrimiento existencial es una sensación de desesperanza, impotencia, temor a la muerte, decepción, pérdida de la autoestima, remordimiento, pérdida de falta de sentido, alteración de la identidad personal o pérdida de dignidad. Se incluyeron 20 artículos, identificándose cuatro hallazgos clave:

- Consideraciones éticas: los estudios abordaron la doctrina del doble efecto (es la idea de que las acciones tienen consecuencias tanto intensionales como no intensionales), y la proporcionalidad como principio ético para sopesar los pros y contras de la sedación paliativa.
- Dificultades por parte de los profesionales de salud: los estudios hacían referencias a que la sedación paliativa es relativamente nueva en términos de aceptabilidad en el cuidado en el final de vida, por lo que aún existen dificultades y barreras para ser interiorizada dentro de la práctica de los profesionales de la salud. Así mismo, se encon-

tró que la práctica de la sedación paliativa conlleva un grado significativo de subjetividad y, por tanto, falta de estandarización de la práctica lo que genera dificultades para su ejecución. También se identificó el tema de salud y bienestar de los médicos y enfermeros (en especial profesionales de enfermería, ya que se describe un vínculo mucho más cercano con el paciente), en el que varios estudios recomiendan que estos profesionales cuenten con un apoyo psicológico, manejo de sentimientos de culpa, creencias de que se acorta la vida del paciente, o caer en conductas que promueven la prolongación de vida y retraso de la enfermedad más allá de los objetivos del cuidado en el final de la vida.

- Equipos multidisciplinarios: los estudios promovían que el cuidado del paciente al final de la vida sea proveído por un equipo multidisciplinario (médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, consejeros espirituales) en apoyo del comité de ética institucional.
- Religión y espiritualidad: varios estudios identificaron el sufrimiento existencial como un sufrimiento espiritual o religioso, y se hacían sugerencias de manera repetitiva sobre la necesidad de contar con el apoyo de líderes religiosos o espirituales para el paciente. No obstante, otros estudios hacían énfasis en que se debe ofrecer primero un “tratamiento espiritual o religioso” antes de la sedación paliativa.

Es importante anotar que la normatividad colombiana cuenta una normatividad que aborda los aspectos de la práctica profesional como lo es la Ley 1733 de 2014, por la que se regula los servicios de cuidados paliativos, se define enfermo en fase terminal, se establecen los derechos de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida, así como las responsabilidades de las EAPB e IPS (163).

Finalmente, respecto a los medicamentos que pueden utilizarse para la sedación paliativa, una revisión de la literatura realizada por Sykes y Thorns en 2003 (164), sintetizaron la evidencia disponible hasta ese momento acerca del uso de opioides y sedantes en este contexto. Establecen una recomendación en la cual orientan que la sedación debería ser utilizada para síntomas específicos una vez las alternativas terapéuticas han sido ineficaces, o son aplicables a la situación actual del paciente. Las benzodicepinas son el grupo de medicamentos preferidos como agentes sedantes, en especial el midazolam, debido a sus efectos anticonvulsivantes, de relajante muscular y propiedades ansiolíticas. Los psicotrópicos como el haloperidol, levomepromazina y clorpromazina podrían ser más apropiados para el manejo específico de delirium, aunque pueden precipitar mioclonías, por lo que se sugiere combinarlos con benzodicepinas. El fenobarbital y el propofol se han utilizado como sedantes en casos seleccionados para manejo de agitación severa que no responde a otros sedantes.

¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico y no farmacológico en el manejo del síndrome de anorexia-caquexia?

126 Considere el diagnóstico de síndrome de anorexia-caquexia cuando se evidencia una pérdida de peso >5% durante los últimos 6 meses (en ausencia de inanición); o un índice de masa corporal <20 kg/m² y con cualquier grado de pérdida de peso >2%

127 Se recomienda evaluar para condiciones o sintomatología que pueda interferir con la ingesta:

- Disgeusia
- Xerostomia
- Mucositis
- Candidiasis oro-faríngea
- Depresión
- Saciedad temprana por gastroparesis
- Náusea o vómito
- Disnea
- Constipación
- Dolor
- Fatiga
- Insuficiencia enzimática del páncreas exocrino
- Trastornos de la alimentación/alteraciones de la autoimagen
- Medicamentos que interfieran con la alimentación
- Hipogonadismo
- Disfunción tiroidea
- Anormalidades metabólicas (v.g., hipercalcemia)

(Adoptada de la guía NCCN Palliative Care v1.2020)

128 Se sugiere iniciar tratamiento farmacológico con corticoesteroides, acetato de megesterol u otros estimulantes del apetito. La elección del medicamento estará bajo el criterio del médico tratante y de acuerdo con la condición general del paciente, expectativa de vida, comorbilidades (si hay infección estaría contraindicado el uso de esteroides, o hemorragia uterina no debe administrarse megesterol), así como preferencias del paciente.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

129 Se sugiere ofrecer medidas no farmacológicas como son: educación e información sobre la disminución del apetito y sed en la persona que se encuentra al final de la vida y que el soporte nutricional no revertirá la pérdida de peso, medidas para el cuidado de la mucosa oral y labios, fraccionamiento de las comidas, dieta hiposódica e hipograsa, y soporte psicológico al paciente, familia y cuidadores.

(Adaptada de la guía NCCN Palliative Care v1.2020)

Puntos de buena práctica clínica:

- Se debe tener en cuenta la condición de pre-caquexia (pérdida de peso <5%, anorexia y cambios metabólicos como intolerancia a la glucosa) como parte del espectro clínico de caquexia, con el propósito de iniciar medidas terapéuticas de manera anticipada

Evidencia seleccionada

Teniendo en cuenta que la caquexia ha sido reconocida como efecto directo de la condición oncológica de los pacientes, en 2011 se publica un consenso internacional orientado a proponer una definición, criterios diagnósticos y clasificación (165). En este consenso participaron organizaciones científicas de Europa y Estados Unidos. Los criterios consensuados para diagnóstico de caquexia fueron:

- Pérdida de peso >5% durante los últimos 6 meses (en ausencia de inanición); o
- Índice de masa corporal <20 y con cualquier grado de pérdida de peso >2%; o
- Índice de músculo esquelético apendicular con sarcopenia (hombres <7.26 kg/m², mujeres <5.45 kg/m²) con cualquier grado de pérdida de peso >2%.

Así mismo, la caquexia se considera que se encuentra en un espectro que permite una clasificación clínica:

- Pre-caquexia: pérdida de peso <5%, anorexia y cambios metabólicos (intolerancia a la glucosa).
- Caquexia: criterios ya mencionados.
- Caquexia refractaria: grado variable de caquexia relacionada con el cáncer por estados pro-catabólicos y sin respuesta al tratamiento anti-neoplásico.

La guía colombiana de cuidados paliativos, establece un escalonamiento terapéutico, consistente en esteroides y acetato de megestrol (154). La guía NCCN (140) adiciona los estudios recientes del papel de los derivados de cannabinoides. A continuación,

se revisa evidencia sintetizada al respecto.

Miller y colaboradores publicaron en 2014 una revisión sistemática sobre el uso de corticoesteroides para el manejo de anorexia en el contexto de medicina paliativa (166). Ocho estudios cumplieron con los criterios de inclusión para el análisis, encontrándose que todos mostraron alguna mejoría en el apetito, con significancia estadística variable. De especial mención, un estudio comparó el efecto entre diferentes corticoesteroides sin encontrar superioridad de uno frente a los otros.

Ruiz y colaboradores, en 2013, publican una revisión sistemática con el objetivo de evaluar la eficacia, efectividad y seguridad del acetato de megestrol en el manejo paliativo del síndrome anorexia-caquexia en pacientes con cáncer, SIDA y otras patologías (167). Se incluyeron 35 estudios (3963 pacientes). El metaanálisis mostró que el megestrol frente al placebo, en relación con el desenlace de mejoramiento de apetito, un RR agregado de 2.19 (IC95% 1.41, 3.4) a favor del megestrol, con un I²=59% (alta heterogeneidad). En cuanto a ganancia de apetito, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Respecto a la proporción de mejoría en el peso, se halló un RR de 1.51 (IC95% 1.08, 2.11) a favor del megestrol, con un I²=55%. Cuando se observa el subgrupo de cáncer, los RR fueron de 2.57 (1.48, 4.49), 1.55 (1.06, 2.26) para mejoramiento de apetito y mejoramiento del peso respectivamente (con sus respectivos I²=52% y I²=56%). Respecto a mejoría de la calidad de vida, se encontró un RR agregado de 1.78 (IC95% 1.09, 2.92) con I²=33%; el subgrupo de cáncer se encontró un RR de 1.91 (1.02, 3.59) con I²=33%. Adicionalmente, respecto al desenlace de seguridad, se

documentó que el edema (RR=1.36, IC95% 1.07-1.72), fenómenos tromboembólicos (RR=1.84, IC95% 1.07-3.18) y muerte (RR=1.42, IC95% 1.04-1.94) fueron más frecuentes y significativos en pacientes tratados con megestrol en comparación con los que recibieron placebo. Con base en lo anterior, los autores concluyen que el acetado de megestrol tiene evidencia que muestra un beneficio en cuanto a mejorar el apetito y leve ganancia de peso, pero a su vez considerando los riesgos.

Este mismo grupo de investigación actualizó esta revisión sistemática (168). Publicada en 2018, esta vez con 38 estudios incluidos para el análisis, en el que se corrobora los beneficios sobre el apetito y el peso, y se vuelve a obtener un mayor riesgo de efectos adversos (no se discriminó por tipo) cuando se compara con placebo. Pero a diferencia de la revisión de 2013, no hubo efecto sobre la calidad de vida ni sobre el riesgo de muerte.

En una revisión rápida de la literatura, no se identificó un estudio del tipo revisión sistemática acerca del uso de derivados cannabinoides y su uso en el síndrome anorexia-caquexia relacionada con cáncer. Se encontró un estudio que data del 2006, realizado por Strasser y colaboradores (169), y se incluye en esta descripción de la evidencia por tratarse de un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, fase III, con la participación de 289 pacientes con cáncer avanzado. El grupo intervención recibió 2 semanas de cápsulas de extracto

de planta *Cannabis sativa*, la cual contiene alrededor de 60 cannabinoides incluyendo el delta-9-tetrahidrocannabinol y cannabidiol, los dos componentes más activos de la planta de marihuana. Los resultados mostraron que, al cabo de 6 semanas de la administración de cannabinoides, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo intervención frente al grupo placebo.

Por otro lado, el estudio más reciente encontrado en PubMed sobre la eficacia del tetrahidrocannabinol y cannabidiol fue publicado en 2019, por Bar-Sela y colaboradores (170). El objetivo fue evaluar el efecto en función de la dosis de las cápsulas de cannabis sobre el síndrome de anorexia-caquexia en pacientes con cáncer avanzado, pero se trató de un estudio piloto, no controlado, involucrando solamente 11 pacientes.

Actualmente, en Colombia, la Ley 1787 de 2016 establece “marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano”, por el cual se crea una puerta para acceder al uso médico de los derivados de cannabinoides. El INVIMA ha dado la aprobación de dos presentaciones comerciales (Neviot® y Sativex®) para uso en espasticidad moderada secundaria a esclerosis múltiple. De momento, no hay alternativas autorizadas por el INVIMA para el uso en el síndrome de anorexia-caquexia en pacientes con cáncer.

¿Cuál es la efectividad del manejo farmacológico en el manejo del dolor?

- | | |
|-----|---|
| 130 | Se sugiere realizar una valoración integral del dolor así como el uso de escalas validadas para la cuantificación de la intensidad del dolor como lo son las escalas visuales análogas (EVA), escala de dolor de pacientes con demencia (PAINAD), cuestionario breve del dolor (CBD) o con la que el médico tratante se encuentre más familiarizado.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 131 | Se recomienda el uso de la escalera analgésica de la OMS como herramienta para orientar la toma de decisiones respecto al tratamiento farmacológico a seguir.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 132 | Se recomienda el uso de morfina oral como el medicamento de primera línea para el alivio del dolor moderado o severo o dolor irruptivo, y si hay falla renal, ajustar de acuerdo con la tasa de filtración glomerular. |
| 133 | En paciente en situación terminal con dolor intenso no controlado a pesar del tratamiento inicial, se sugiere una rotación o cambio de opioide, teniendo en cuenta equipotencia analgésica, iniciar con un 25% menos de la dosis calculada para el nuevo opioide, y ajustar según eventos adversos.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 134 | Se recomienda descenso progresivo de analgésicos y adecuar dosis de según respuesta del paciente en caso de que se decida reducir dosis ante desaparición del dolor. Con el fin de evitar síndrome de abstinencia a opioides, se debe prescribir siempre dosis de rescate.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 135 | Se sugiere complementar el manejo con opioides con medidas preventiva para estreñimiento (ver apartado de recomendaciones sobre estreñimiento)

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 136 | Se sugiere el uso de amitriptilina, gabapentina o pregabalina como tratamiento de primera línea para el manejo de dolor neuropático oncológico, salvo en neuralgia del trigémino en el que la opción inicial es carbamazepina.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 137 | En caso de que no haya adecuada respuesta al manejo inicial, se sugiere complementar con opioides fuertes con perfil de manejo de dolor neuropático: metadona, oxicodona, tapendadol u opioides débiles como el tramadol.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |

Puntos de buena práctica clínica:

- Los opioides más utilizados en Colombia son (en orden alfabético): buprenorfina transdérmica, codeína, hidromorfona, metadona, morfina, oxicodona, tapendao y tramadol. Se debe verificar las actualizaciones de las indicaciones INVIMA y de la incorporación de nuevos medicamentos

en el mercado colombiano respecto a este grupo farmacológico.

- Se debe tener en cuenta las contraindicaciones del uso de amitriptilina en pacientes mayores a 50 años.

Evidencia seleccionada

En 1996, la Organización Mundial de la Salud publica su guía “Alivio del dolor en el cáncer, una guía sobre la disponibilidad de opioides” (171), como respuesta a la necesidad de brindar un lineamiento respecto al manejo escalonado del dolor asociado al cáncer, de forma que la prescripción esté basada tanto en eficacia como en costo-efectividad, lo cual permitiría que no existan barreras para el acceso a medicamentos y se cumple el objetivo de aliviar el dolor (172). Para ello, la OMS propone la escalera de tres peldaños: no-opioide $\pm$ coadyuvante, opioides para dolor leve a moderado $\pm$ no-opioides $\pm$ coadyuvante, y opioide para dolor moderado a agudo $\pm$ no-opioides $\pm$ coadyuvante.

Azevedo y colaboradores en 2006 publican una revisión narrativa de la literatura respecto a la validez y efectividad de modelo de escalera analgésica de la OMS (172), incluyendo 17 estudios para la síntesis, encontrando que la analgesia adecuada era alcanzada entre el 45 al 100% de los estudios. Ante esta variabilidad de la efectividad de la escalera analgésica, los autores concluyen que se requiere de mayor investigación, si bien reconocen que este lineamiento de la OMS es un protocolo sencillo, clínicamente útil y explícito en cuanto al tratamiento a ofrecer.

Schüchen y colaboradores publicaron en 2018 una revisión sistemática con metaanálisis acerca de la utilidad de los analgésicos no-opioides en pacientes que se encuentra en cuidados paliativos (173). Incluyeron 24 estudios para el análisis. Encontraron lo siguiente:

- No hubo evidencia consistente en cuanto al efecto del acetaminofén.

- En halló evidencia a favor de los AINEs y dipirone para el alivio del dolor, aunque no se identificó que alguno fuera superior que otro en este contexto.

- Respecto a eventos adversos por AINEs, la duración de uso de estos medicamentos no superó los 7 días, por lo que no se pudo establecer una asociación del uso de AINEs e incidencia de eventos adversos.

- La combinación de AINEs con opioides de tercer escalón mostró un efecto beneficioso.

- No se identificaron estudios sobre el uso prolongado de analgésicos no-opioides.

Wiffen y colaboradores realizaron una revisión sistemática en 2017, con el objetivo de determinar la eficacia y seguridad del acetaminofén

en el contexto de dolor asociado a cáncer (174). Sólo 3 estudios cumplieron con los criterios de inclusión, encontrándose que ninguno de éstos consideraba los desenlaces primarios propuestos por los autores (participantes que el dolor reduce en más del 50%, participantes que el dolor reduce en más del 30%, o número de pacientes que no empeoraron del dolor). A pesar de lo anterior, describen que, en estos estudios, no hubo diferencias entre acetaminofén y placebo en el promedio de unas medidas de intensidad del dolor. La revisión concluye que no hay evidencia suficiente para apoyar o para rechazar el uso de acetaminofén para alivio del dolor en cáncer.

En este mismo sentido, Derry y colaboradores desarrollo otra revisión sistemática enfocada en la evidencia agregada respecto a los AINEs y dolor por cáncer, publicada en 2017 (175). Se incluyeron 11 estudios en el análisis, pero ninguno evaluó los desenlaces primarios propuestos por los autores y los estudios contenía alto riesgo de sesgos (tamaño muestra muy pequeño, data incompleta o ausencia de enmascaramiento). Ningún estudio tuvo comparación con un opioide. No obstante, en general, los AINEs obtenían alivio del dolor en el corto plazo.

Por otro lado, en la librería de la colaboración Cochrane se encuentra amplia literatura respecto a la eficacia de diferentes opioides para el manejo del dolor en cáncer. A continuación, se hace un resumen ejecutivo de las revisiones sistemáticas encontradas (organizadas en orden alfabético del principio activo):

- **Buprenorfina**, por Schmidt-Hansen y col. 2013 (176): 19 estudios fueron incluidos para el análisis, encontrándose que la buprenorfina fue tan efectiva como la morfina, aunque no tanto cuando se comparó con el fentanilo (tres estudios mostraron que era inferior).

- **Codeína**, por Straube y col. 2013 (177): 15 estudios fueron incluidos para el análisis, entrándose que la codeína, tanto sola como combinada con acetaminofén, fue eficaz frente a placebo; no hubo comparación con otros opioides.

- **Fentanil transdérmico**, por Skorga y col. 2013 (178): 9 estudios para el análisis, pero ninguno evaluó el desenlace de reducción de dolor o no empeoramiento del mismo en población con cáncer; sin embargo, los autores pudieron inferir de acuerdo a su juicio que los participantes reportaron niveles de intensidad baja de dolor, y que el efecto adverso más reportado fue estreñimiento y rash en la zona del parche.

- **Hidromorfona**, por Bao y col. 2016 (179): 4 estudios incluidos para el análisis, hallándose que la hidromorfona tiene un efecto similar la oxicodona y morfina en cuanto alivio del dolor. Así mismo fue su perfil de seguridad e incidencia de eventos adversos.

- **Metadona**, por Nicholson y col. 2017 (180): 6 estudios fueron incluidos para el análisis, encontrándose que la metadona tuvo un efecto similar que la morfina, así como en la incidencias de eventos adversos. Los estudios presentaban métodos tan diversos que no permitieron hacer análisis comparativos.

- **Morfina oral**, por Wiffen y col. 2016 (181): 62 estudios fueron incluidos para el análisis, encontrándose que no hubo diferencias en el efecto del alivio del dolor entre las presentaciones de morfina de liberación modificada frente a la morfina de liberación inmediata. El 90% de los participantes (agrupados) mostró alivio adecuado del dolor. La morfina oral fue tan efectiva para modular la intensidad del dolor como lo fueron la oxicodona, hidromorfona, fentanil transdérmico, y metadona. Ninguno mos-

tró superioridad frente a la morfina.

- **Oxicodona**, por Schmidt-Hansen y col. 2017 (182): 6 estudios incluidos para el análisis, hallándose que la oxicodona no fue inferior a la morfina en el alivio del dolor. No diferencias en efectos adversos, excepto en el riesgo de alucinaciones, el cual fue significativamente menor en los que recibieron oxicodona en comparación con morfina (RR 0.52, IC95% 0.28 – 0.97), aunque basado en evidencia de baja calidad. Las diferentes presentaciones de oxicodona (liberación controlada vs liberación inmediata) no mostraron que alguna fuera más eficaz que otra.

- **Tapentadol oral**, por Wiffen y col. 2015 (183): 4 estudios fueron incluidos para el análisis, encontrándose que el tapentadol no es ni más ni menos efectivo que la oxicodona o la morfina. La incidencia de eventos adversos fue similar que oxicodona y morfina.

- **Tramadol**, por Wiffen y col. 2017 (184): 10 estudios fueron incluidos para el análisis. Sin embargo, la evidencia presentada tenía alto riesgo de sesgos, así como un tamaño de participantes muy pequeño, por lo que no se logró realizar análisis agrupado. Sólo un estudio comparó el tramadol con la morfina y evaluó los desenlaces primarios de los autores, encontrándose el tramadol no fue efectivo en el alivio del dolor.

En relación con el dolor neuropático oncológico, Mishra y colaboradores en 2012 publicaron un estudio tipo ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego, para determinar la eficacia de la pregabalina en este contexto clínico en comparación con amitriptilina y gabapentina (185). Participaron 120 pacientes, que fueron aleatorizados en 4 grupos: grupo amitriptilina, grupo gabapentina, grupo pregabalina y grupo placebo (que recibía dosis de rescate de morfina

según intensidad del dolor). El desenlace primario fue el cambio en la escala global de intensidad del dolor por escala visual análoga de 100 mm luego de 4 semanas de tratamiento. Los resultados fueron una disminución significativa en el valor de la escala en los 4 grupos comparado con la línea base. El 100% del grupo placebo requirió dosis de rescate de morfina durante las visitas semanas, mientras que alrededor del 30% de los demás grupos requirió morfina luego de la segunda visita (2ª semana), siendo el grupo amitriptilina que más requirió dosis de rescate, y el grupo de pregabalina quien menos requirió. Los autores concluyen que los medicamentos antineuropáticos estudiados son eficaces en aliviar el dolor neuropático asociado a cáncer, siendo la pregabalina la que mostró mayor efecto beneficioso.

Jongen y colaboradores, en 2013, publican una revisión sistemática con el fin de evaluar la evidencia sobre el beneficio y seguridad del tratamiento del dolor neuropático oncológico (186). Se incluyeron 30 estudios para el análisis, y se evaluó mediante el estimador de Riesgo Absoluto de Beneficio (RAB, proporción de pacientes que obtuvieron alivio sobre el total de pacientes del grupo tratamiento). Se encontró que el RAB promedio para antidepresivos fue de 0.5510 (IC95% 0.4034 – 0.6906), para anticonvulsivantes fue de 0.5672 (0.4364 – 0.6973), y para opioides fue de 0.9499 (0.9320 – 0.9634). Los antidepresivos fueron amitriptilina, trazodona y venlafaxina. Los anticonvulsivantes fueron pregabalina, gabapentina, levetiracetam y lamotrigina. Los opioides fueron tramadol y oxicodona. La limitación de este estudio radica en que los estudios evaluados no fueron controlados, con desenlaces primarios diferentes, por lo que el análisis de los autores fue agregado por grupo farmacológico.

¿Cuál es la efectividad de las terapias invasivas en el manejo del dolor?

- | | |
|-----|--|
| 138 | Se recomienda remitir a consulta especializada en intervencionismo para alivio del dolor en aquellos pacientes en que haya persistencia de dolor intenso a pesar de analgesia adecuada y/o presencia de efectos adversos intolerables. |
| | (Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |
| 139 | Se debe evaluar riesgo / beneficio del manejo intervencionista de acuerdo con las preferencias del paciente, expectativa de vida y comorbilidades que impiden el aumento de dosis de opioides (insuficiencia renal, insuficiencia hepática). |
| | (Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |
| 140 | Se debe considerar la reducción de opioides en caso de que el manejo intervencionista resulte exitoso en aliviar el dolor. |
| | (Adaptada de la guía NCCN de dolor oncológico 2020) |

Evidencia seleccionada

Las recomendaciones de esta sección fueron tomadas de la guía de la NCCN sobre dolor oncológico en adultos (187).

Más del 90% de todos los pacientes con cáncer avanzado padecen algún grado de dolor, y si bien el uso de opioides es el principal bastión para el manejo farmacológico para aliviar el dolor, se estima que entre el 5% al 20% de los pacientes no logran un control adecuado del dolor (188–190). En este contexto, entran las técnicas intervencionistas como un “cuarto escalón” en el manejo del dolor, indicadas cuando el dolor es refractario al uso de opioides (188).

Una de las estrategias intervencionistas son los procedimientos neuroaxiales. Estos incluyen: inyecciones epidurales, neurolisis intratecal, ablación de la raíz del nervio o neurolisis química, y estimulación de las columnas dorsales o del ganglio dorsal (191).

Otro enfoque consiste en intervenciones quirúrgicas o de intervencionismo radiológico, entre las que se encuentran: infusión de medicamento intratecal, aumento vertebral, osteoplastia, cordotomía, lisis de las vías trigeminales, mielotomía, ablación por radiofrecuencia (incluye cordotomía percutánea), crioablación (188,189,191)

También se incluyen como intervencionismo para alivio del dolor los bloqueos neurolíticos de plexos (celíaco, hipogástrico superior), neurolisis del ganglion impar o de Walther, bloqueo de nervios periféricos e intercostales (188).

Vayne-Bossert y colaboradores, en 2016, publicaron una revisión de la literatura sobre la evidencia disponible acerca del rol del manejo intervencionista para alivio del dolor por cáncer (192). Se resumen los principales hallazgos:

- **Vertebrosplastia:** rol en enfermedad maligna ósea, que a través de la fijación de cemento óseo, provee alivio del dolor al estabilizar la estructura vertebral (o fijar fracturas vertebrales). La mayoría de la evidencia disponible es de baja calidad, limitándose a series de casos o estudios observacionales cortos y de poco tamaño, si bien se reporta que logra reducir el dolor, pero con una incidencia importante de eventos adversos.
- **Analgesia neuroaxial:** fundamentada en la administración epidural o intratecal de medicamentos analgésicos vía percutánea o por implantación de catéter (para bomba). Ha sido considerada el último recurso en pacientes con dolor refractario que no mejoraron con el tratamiento estándar o que presentaron efectos adversos intolerables. Si bien la evidencia ha mostrado que se trata de un procedimiento seguro, no está exento de eventos adversos serios (infección-meningitis). Varios estudios tipo ensayo clínicos mostraron que es eficaz en pacientes altamente seleccionados, con la limitante de que el tiempo de seguimiento fue corto.
- **Bloqueo de nervios:** intervención que se basa en la interrupción de la transmisión de señales nociceptivas, utilizado tanto a nivel central como periférico. Evidencia respecto al bloqueo paravertebral mostró que reducía el dolor durante 5-6 meses luego de la intervención, si bien los estudios son de calidad moderada por su pequeño tamaño muestral.
- **Procedimientos neurolíticos o neurodestructivos:** se trata de intervenciones de ablación o bloqueos neurolíticos que buscan la destrucción de las vías aferente o eferentes del dolor, siendo el método más utilizado la inyección de etanol o fenol, aunque también se puede realizar por radiofrecuencia. La evidencia muestra que se logra una reducción del dolor pero se asocia a eventos adversos serios como el desarrollo de dolor por desafrentización (reorganización del sistema nervioso después de la lesión) o diversos grados de paresia. Dada la irreversibilidad del procedimiento, se considera como último recurso en el tratamiento.

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo del estreñimiento?

- | | |
|-----|---|
| 141 | De acuerdo con el estado clínico del paciente, se recomienda el uso de laxantes orales junto con una dieta alta en fibra y adecuada hidratación, y ejercicio ajustado al paciente.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 142 | En caso de impactación fecal, puede utilizarse productos rectales (supositorios o enemas), con especial precaución en pacientes con riesgo de citopenia.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |

Puntos de buena práctica clínica:

- En caso de realizar desimpactación fecal manualmente, considere sedación con benzodiacepinas.
- Antes de prescribir laxantes, evalúe la presencia de causas secundarias:
 - Obstrucción intestinal
 - Inflamación recto-anal
 - Hipercalcemia
 - Hipokalemia
 - Hiponatremia
 - Hipotiroidismo
 - Diabetes mellitus
 - Medicamentos (opioides, anticolinérgicos, antihipertensivos, AINEs, agentes con suplementos de aluminio, calcio, hierro).

Evidencia seleccionada

Se estima que entre el 43% al 58% de los pacientes con cáncer avanzado refieren estreñimiento (el tercer síntoma más prevalente luego de dolor y anorexia), y en fases terminales, pueden llegar a ser el 80% (193). El estreñimiento en el paciente oncológico puede tener varias causas, las cuales pueden ser orgánicas, funcionales o relacionadas con el uso de ciertos medicamentos. Se ha propuesto varias alternativas de manejo, entre las que se encuentran:

- Laxantes orales: incluyen suplementos de fibra (psyllium), ablandadores de materia fecal (docusato de sodio, aceite mineral), estimulantes del peristaltismo (senósidos, bisacodilo), agentes osmóticos (sales de magnesio, sorbitol, lactulosa, polietilenglicol -PEG-).

- Antagonistas del receptor opioide mu: metilnaltrexona

- Productos rectales: incluyen estimulantes (supositorios de bisacodilo), lubricantes hiperosmóticos (supositorios de glicerina, enemas).

Candy y colaboradores, en 2015, publicaron una revisión sistemática respecto al uso de laxantes para el manejo del estreñimiento en el contexto de cuidados paliativos (194). El objetivo fue determinar la efectividad y eficacia diferencial de los laxantes lactulosa, senna, sales de magnesio, entre otros. Se incluyeron 5 estudios para el análisis. No se encontraron diferencias entre los diferentes tipos de laxantes, es decir, la efectividad fue similar entre ellos.

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológico para el manejo de la diarrea?

- | | |
|-----|---|
| 143 | <p>Se sugiere determinar el grado de diarrea por toxicidad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado 1: incremento de <4 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento leve de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 2: incremento de 4-6 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos moderados que no interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento moderado de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 3: incremento de ≥7 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos severos e incontinencia que interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento severo de salida de consistencia blanda o líquida. • Grado 4: incremento de >10 deposiciones al día y puede acompañarse de sangrado rectal o franca hematoquecia y requiere de soporte parenteral. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento que puede comprometer el estado hemodinámico del paciente y requerir de manejo hospitalario. <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 144 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 1, se recomienda brindar hidratación oral y reposición de electrolitos, e inicie loperamida (si no está recibiendo opioides).</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 145 | <p>Se sugiere administrar loperamida hasta conseguir 12 horas sin deposiciones y en el caso de la radioterapia, durante el tiempo que dure el tratamiento. No debe superarse la dosis máxima de 16 mg día.</p> <p>(Adoptada de la guía colombiana 2016)</p> |
| 146 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 2, se recomienda administrar líquidos vía endovenosa si no hay tolerancia a la vía oral, continuar con loperamida (o iniciarla) y considere uso de anticolinérgicos. Si se sospecha de diarrea por inmunoterapia o radioterapia, considere utilizar corticoesteroides.</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |
| 147 | <p>En paciente con diarrea por toxicidad Grado 3 o 4, se recomienda considerar hospitalizar de acuerdo con el criterio del médico tratante y plan de cuidados del final de vida, continuar antidiarreicos y/o anticolinérgicos, y considerar como alternativa el uso de análogos de somatostatina ante diarrea refractaria.</p> <p>(Adoptada de la guía NCCN 2020)</p> |

Evidencia seleccionada

Cherny en 2008 hace una revisión de la literatura acerca de la diarrea asociada al tratamiento en paciente con cáncer avanzado, de la que deriva las principales recomendaciones de la guía colombiana y de la NCCN (195). En esta revisión, se define diarrea como la presencia de deposiciones líquidas más frecuente y con sensación de urgencia, la cual puede ser leve, moderada o severa, amenazando inclusive la vida del paciente. En el contexto clínico del paciente en tratamiento activo para cáncer, la diarrea suele ser secundaria a la quimioterapia, especialmente por 5-fluorouracilo, irinotecan, capecitabina, docetaxel.

También se ha evidenciado diarrea asociada al uso de erlotinib, sorafenib, sunitinib, imatinib y bortezomib. Así mismo, la radioterapia dirigida a estructura abdomino-pélvica puede lesionar el colon generando colitis o proctitis, provocando diarrea.

Cherny describe los criterios de toxicidad para graduación de la diarrea, adoptados por la guía de la NCCN (195), los cuales brinda un marco clínico para diagnosticar la severidad de la diarrea y orienta el tratamiento a seguir.

Estos criterios son:

- Diarrea por toxicidad grado 1: incremento de <4 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento leve de salida de consistencia blanda o líquida.

- Diarrea por toxicidad grado 2: incremento de 4-6 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos moderados que no interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento moderado de salida de consistencia blanda o líquida.

- Diarrea por toxicidad grado 3: incremento de ≥ 7 deposiciones al día frente al hábito antes del tratamiento onco-específico, y puede acompañarse de cólicos severos e incontinencia que interfieren con las actividades cotidianas. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento severo de salida de consistencia blanda o líquida.

- Diarrea por toxicidad grado 4: incremento de >10 deposiciones al día y puede acompañarse de sangrado rectal o franca hematoquecia y requiere de soporte parenteral. Si el paciente tiene colostomía, hace referencia al aumento que puede comprometer el estado hemodinámico del paciente y requerir de manejo hospitalario.

En cuanto al manejo general, los pacientes deben rehidratarse tanto por vía oral (en la medida de lo posible) o por vía endovenosa si la condición del paciente así lo amerita. Los medicamentos que pueden utilizarse son: loperamida, análogos de somatostatina, o budesónida (en casos de colitis/proctitis).

¿Cuál es la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el manejo de la disnea?

- | | |
|-----|---|
| 148 | Se sugiere evaluar por causas potencialmente reversibles de disnea, como lo son las exacerbaciones de EPOC, crisis asmática, condiciones cardíacas, derrame pleural o pericárdico, síndrome de vena cava superior, u obstrucción de vía aérea.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 149 | Se recomienda el uso de morfina como medicamento de primera elección para el manejo de la disnea.

(Adaptada de la guía colombiana 2016) |
| 150 | Se sugiere el uso de benzodiazepinas si coexiste trastorno de ansiedad. Se debe tomar medidas para prevenir el riesgo de depresión respiratoria si el paciente ya viene recibiendo opioides.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |
| 151 | Se sugiere el uso de oxígeno solo en aquellos casos de hipoxia sintomática.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |
| 152 | Se puede complementar el manejo de disnea con medidas no farmacológicas como lo son: los abanicos, aires acondicionados, medidas de relajación y confort físico.

(Adaptada de la guía NCCN 2020) |

Evidencia seleccionada

Ben-Aharon y colaboradores, en 2012, publican una revisión sistemática con el objetivo de evaluar el rol de las intervenciones dirigidas para aliviar la disnea en paciente con cáncer (196). Se incluyeron 18 estudios para el análisis, y las intervenciones consistieron en opioides, oxígeno y benzodiazepinas. Se encontró un beneficio por parte de los opioides en 8 estudios, tanto a pacientes que reciben este tipo de medicamentos por primera vez (opioide-naïve) como los que ya vienen recibiendo. En relación con el oxígeno, seis estudios abordaron el efecto de este medicamento gaseoso, mostrando que el oxígeno es inferior a los opioides, y sin efecto estadísticamente significativo frente al placebo. Respecto a las benzodiazepinas, solo se identificaron dos estudios que comparaban el

midazolam frente a la morfina, sin evidenciarse diferencias estadísticamente significativa, excepto en la fase inicial (ambulatoria) de uno de los estudios, en el que el midazolam fue superior.

Barnes y colaboradores, en 2014, publicaron una revisión sistemática que buscaba determinar la efectividad de los opioides en aliviar la disnea en pacientes con enfermedad avanzada (se incluyeron estudios con pacientes con cáncer, neumopatías crónicas y enfermedad cardiovascular). Se incluyeron 26 estudios para el análisis. Los resultados del metaanálisis mostraron que el efecto agregado de los opioides fue beneficioso, medido a través de una Diferencias de medias estándar de -0.42 (IC95% -0.77, -0.26) con una

I2=54%; no se logró hacer análisis por subgrupo para determinar el efecto en función de la condición patológica. Los autores concluyeron que, si bien los estudios son de baja o muy baja calidad, hay evidencia que sugiere el efecto beneficioso de los opioides para el manejo paliativo de la disnea.

Finalmente, en lo referente a medidas no farmacológicas, Luckett y colaboradores desarrollaron un estudio cualitativo de las per-

cepciones de los pacientes con disnea crónica respecto al uso de ventiladores de mano o abanicos (197). Se realizaron entrevistas a 133 pacientes. Encontraron que los pacientes percibieron el uso del abanico como algo beneficioso relacionado con su portabilidad, la sensación de “empujar el aire” hacia el rostro, distracción, modulación de la ansiedad, entre otras categorías identificadas por los autores.

¿Cuál es el efecto del uso de diuréticos en comparación con paracentesis para el manejo de la ascitis?

153 Se sugiere el uso de paracentesis para el manejo sintomático de la ascitis peritoneal.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

154 Se sugiere el uso de diuréticos solamente en casos muy seleccionados, en los que se sospeche hipertensión portal concomitante.

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

Evidencia seleccionada

Hodge y Badwell realizaron una revisión de la literatura acerca del manejo paliativo en ascitis maligna, publicada en 2019 (198). Se describen varias opciones, las cuales se resumen a continuación:

- **Diuréticos:** si bien los diuréticos y la restricción de sodio son el manejo de primera línea en la ascitis secundaria a cirrosis, tiene menor eficacia cuando se trata de ascitis maligna. La espironolactona es el diurético más utilizado en este contexto clínico, y su eficacia se correlaciona con los niveles de renina-angiotensina plasmáticos, los cuales están elevados en hipertensión portal, pero permanecen normales en ascitis maligna. En este sentido, los diuréticos muestran un mejor desempeño en hipertensión portal secundaria a metástasis hepáticas.

- **Paracentesis:** es la modalidad terapéutica más utilizada para aliviar los síntomas por ascitis maligna. La paracentesis es eficaz en aliviar los síntomas de náuseas, vómito, disnea y discomfort abdominal, y provee alivio transitorio en alrededor del 90% de los pacientes. La desventaja es que la duración del efecto es transitoria, y retornar luego de 72 horas. Por ello, se requiere de paracentesis a repetición para un control efectivo. Esto conlleva riesgos de perforación visceral, hipotensión secundaria a cambios grandes de volumen, pérdida de proteínas y electrolitos, peritonitis secundaria y sangrado peritoneal.

- **Catéter tunelizados:** cumplen la función drenar el líquido peritoneal, sin la necesidad de reintervenir de manera repetitiva para ali-

viar los síntomas. Sus contraindicaciones son: ascitis loculada, coagulopatía, infección de cavidad peritoneal. Tiene los mismos riesgos de la paracentesis.

- Otras intervenciones: se incluyen otras medidas intervencionistas más complejas, más

riesgos y con menos evidencia de eficacia disponible, por lo que su uso es muy limitado. Estas son: puertos intraperitoneales, derivaciones peritoneo-venosas, catumaxomab intraperitoneal, y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica sin la citorreducción.

¿Cuáles serían las indicaciones de un dren peritoneal permanente para el manejo de ascitis?

- | | |
|-----|--|
| 155 | Se sugiere el uso de catéter peritoneal permanente en casos muy seleccionados en los que se haya documentado ascitis recurrente y refractaria al tratamiento, con el fin de evitar urgencias, complicaciones peritoneales por paracentesis a repetición, mejor confort en domicilio (con cuidador entrenado). Se debe descartar contraindicaciones como son: ascitis loculada, coagulopatía o infección de cavidad peritoneal. |
|-----|--|

Evidencia seleccionada

La evidencia disponible sobre el uso de catéter permanente para manejo de ascitis maligna se ha realizado en el contexto de refractariedad (198), con eficacia reportada entre 80% a 95% de éxito en control de la sintomatología por ascitis maligna luego de 8-10 semanas de colocación del catéter.

El equipo técnico para uso de tecnología en salud del NICE publicó en 2012 unos lineamientos respecto al uso del sistema de drenaje por catéter peritoneal PleurX® (199). En este documento, se hace la recomendación de considerar su uso en pacientes con ascitis maligna recurrente refractaria al tratamiento, fundamenta en la revisión de 9 estudios observacionales.

5.11. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL PACIENTES CON CÁNCER

¿Cuál es la indicación y beneficio de las intervenciones nutricionales en el paciente con cáncer avanzado?

- | | |
|-----|--|
| 156 | Se sugiere explicar como el peso corporal, los alimentos y la actividad física afectan el cáncer de colon y su tratamiento. |
| 157 | Se recomienda impartir consejos de alimentación dirigida por nutricionista en la que permita una adecuada tolerancia pensando siempre en el confort del paciente |
| 158 | Se sugiere remitir los enfermos con obesidad, desnutrición, sarcopenia o caquexia a nutricionistas, idealmente, con experiencia o entrenamiento acreditado en Oncología. |

- | | |
|-----|--|
| 159 | Se recomienda adaptar la intervención dietética a la situación individual, teniendo en cuenta las alteraciones metabólicas causados por el tumor y el tratamiento oncológico, y las propiedades nutraceúticas de los alimentos para regular el metabolismo celular. |
| 160 | Se recomienda evitar los regímenes hipercalóricos ricos en grasas saturadas y azúcares para mantener o recuperar el peso corporal. |
| 161 | Se recomienda ofrecer consejo personalizado para el uso correcto de suplementos nutricionales orales en situaciones de desnutrición e incapacidad de cubrir los requisitos nutricionales — los Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APMES) ordenados deben estar aprobados por el INVIMA para pacientes oncológicos. |
| 162 | Se sugiere pesquisar y corregir la deficiencia de vitamina D. |
| 163 | Se recomienda evitar dosis elevadas de elementos traza y vitaminas. |

Puntos de buena práctica clínica:

- Las intervenciones dietéticas y el soporte nutricional artificial antes, durante y después de la fase aguda del tratamiento, requiere un enfoque centrado en el paciente (evaluación de actitudes, creencias, motivaciones y deseos), y comprensión de los mecanismos plausibles por los cuales los alimentos influyen en el control del cáncer colorrectal, teniendo en cuenta la fisiopatología, etapa de la enfermedad, modalidad e intención del tratamiento.
- Se debe desaconsejar la automedicación de suplementos y vitaminas.
- De acuerdo con la funcionalidad del tracto digestivo, brindar apoyo nutricional perioperatorio a los enfermos desnutridos, o aquellos con inhabilidad para comer durante siete días luego de la cirugía.
- Se debe orientar el cuidado nutricional a satisfacer los deseos de pacientes en estado terminal.

Evidencia seleccionada

El Proyecto de Actualización Continua (CUP) es un programa continuo para analizar la investigación global sobre cómo la dieta, la nutrición y la actividad física afectan el riesgo de cáncer y la supervivencia. Es un recurso científico confiable y autorizado que recopila evidencia científica de todo el mundo de forma continua, revisada sistemáticamente por el equipo del Imperial Collage de Londres y evaluada por un panel independiente de expertos que elab-

boran conclusiones basadas en la evidencia para crear recomendaciones en prevención y supervivencia en cáncer (200). La calificación de la evidencia se apoya en criterios claramente definidos para juzgar que tan fuerte es la relación causal de la dieta, la nutrición y la actividad física con el cáncer, teniendo en cuenta calidad de los estudios (posibilidad de confusión, errores de medición y sesgo de selección), diferentes tipos de estudios y cohortes, heteroge-

neidad inexplicable entre los resultados de diferentes estudios o poblaciones, relación dosis-respuesta y si hay evidencia de mecanismos biológicos plausibles a niveles típicos de exposición, lo que permite jerarquizar la evidencia de causalidad como “fuerte” (convinciente, probable o efecto sustancial sobre el riesgo improbable) o “limitada” (limitada - sugestiva o limitada - sin conclusión) (201).

La calidad de la evidencia sobre las intervenciones preventivas en cáncer colorrectal se puede resumir en los siguiente puntos (202):

Evidencia solida en prevención:

- Estar físicamente activo disminuye el riesgo de cáncer de colorrectal.
- El consumo de granos enteros disminuye el riesgo de cáncer colorrectal.
- El consumo de alimentos que contienen fibra dietética disminuye el riesgo cáncer colorrectal.
- El consumo de productos lácteos disminuye el riesgo de cáncer colorrectal.
- Tomar suplementos de calcio disminuye el riesgo de cáncer colorrectal.
- El consumo de carne roja aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.
- El consumo de carne procesada aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.
- Consumir aproximadamente dos o más bebidas alcohólicas por día aumenta el riesgo del cáncer colorrectal.
- Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.

Hay alguna evidencia de que:

- Consumir alimentos que contengan vitamina C podría disminuir el riesgo de cáncer de colorrectal.
- El consumo de pescado podría disminuir el riesgo de cáncer colorrectal
- La vitamina D podría disminuir el riesgo de cáncer colorrectal.
- Consumir suplementos multivitamínicos podría disminuir el riesgo de cáncer colorrectal.
- Bajo consumo de vegetales sin almidón podría aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.
- Bajo consumo de fruta podría aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.
- El consumo de alimentos que contienen hierro hem podría aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.

Dieta, nutrición y actividad física en sobrevivientes de cáncer

El Panel de expertos está de acuerdo en que las conclusiones que sustentan las Recomendaciones de prevención del cáncer también pueden ser relevantes para los sobrevivientes de cáncer y recomiendan que, en la medida de lo posible, los sobrevivientes de cáncer tengan como objetivo seguir estas recomendaciones una vez que el tratamiento haya finalizado. Puede haber situaciones específicas en las que este consejo puede no aplicarse y puede ser necesaria la orientación de profesionales de la salud, por lo tanto:

- Todos los sobrevivientes de cáncer deben recibir atención nutricional y orientación sobre actividad física de profesionales capacitados.
- A menos que se indique lo contrario, y si pueden, se recomienda a todos los sobrevivientes de cáncer que sigan las recomendaciones de prevención del cáncer en la medida de lo posible después de la etapa aguda del tratamiento:
 - Tener un peso saludable
 - Estar físicamente activo
 - Comer más granos enteros, verduras, frutas y legumbres (como frijoles)
 - Evite las bebidas azucaradas y limite el consumo de 'comidas rápidas' y otros alimentos procesados con alto contenido de grasas, almidones o azúcares
 - Limitar el consumo de carnes rojas (como carne de res, cerdo y cordero)
 - Evitar las carnes procesadas y el alcohol
 - No usar suplementos para prevenir el cáncer

6. ROL Y PERSPECTIVAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

La evidencia ha mostrado que los equipos multidisciplinarios han tenido un efecto positivo en los desenlaces en salud de los pacientes con cáncer (203,204). En este sentido, el papel que cada profesional cumple en todo el ciclo de atención del paciente oncológico es fundamental para lograr los mejores resultados, a la vez que se hace brinda un manejo integral y óptimo. Sin embargo, el profesional de enfermería tiene un alcance particular que lo sitúan en el centro del equipo multidisciplinario, a la vez que tiene un contacto más estrecho con el paciente y su familia/cuidador.

El profesional de enfermería tiene unas funciones clave en el proceso de atención del paciente con cáncer, como son (205):

- **Enseñanza:** Fomentar en los pacientes y sus familias el desarrollo de habilidades y herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo del autocuidado, incluido el manejo de los síntomas.
- **Cuidador:** Relacionarse genuinamente con la dimensión humana de la experiencia de la enfermedad y proporcionar consuelo y apoyo físico, emocional y espiritual.
- **Coordinador:** Gestionar entre múltiples servicios hacia el desarrollo de objetivos compartidos (paciente-profesional de salud) y un plan de tratamiento coherente y transparente.
- **Defensor:** Representar las necesidades y preferencias de los pacientes y sus familia-

res al desarrollar e implementar un plan de tratamiento.

- **Movilizador:** Ser atento, asertivo e innovador para responder a las necesidades dinámicas de los pacientes y sus familias.

Transversal a estas funciones, los profesionales de enfermería cuentan con atributos esenciales para el cuidado de los pacientes: experiencia clínica, orientación a la familia, atención perceptiva, colaboración y deliberación (205).

Reconociendo que el profesional de enfermería cumple con un rol integrador dentro y fuera de los servicios de oncológicos, y un rol articulador intra- e interinstitucional, se realizó una actividad de grupo focal semiestructurado con profesionales de enfermería de la ciudad de Cali que están íntimamente vinculados con el proceso de atención del paciente con cáncer.

Se diseñó un marco conceptual desde el equipo asesor, el cual propone tres categorías para incorporar las percepciones laborales, cada una definida de la siguiente manera:

- **Perspectiva asistencial:** son aquellos profesionales de enfermería involucrados en proceso de atención clínica y contacto directo con el paciente y su familia. El campo de acción es en las IPS hospitalarias y oncológicas.
- **Perspectiva administrativa:** corresponde a los profesionales de enfermería cuya función esencial es el desarrollo del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) tanto de los servicios asistenciales como de la gestión de riesgo poblacional. El campo de acción habitualmente es en la coordinación o jefaturas de servicios espe-

cializados en IPS, o en los departamentos de gestión de riesgo de las EAPB.

- **Perspectiva clínico-administrativa:** representa a los profesionales de enfermería que tiene funciones tanto asistenciales como administrativas, como lo son los programas de navegación, o el personal de auditoría clínica.

A continuación se describe los elementos extraídos del grupo focal.

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva asistencial:

- Cuidado directo de los pacientes desde el ámbito ambulatorio y hospitalario.
- Coordinación de la quimioterapia, radioterapia u otras modalidades de tratamiento.
- Articulación con el profesional de enfermería de navegación para cumplir con los tiempos de ciclos, así como control con otros profesionales de salud.
- Educación al momento del diagnóstico, y especialmente durante el tratamiento.
- Seguimiento de los potenciales efectos secundarios del tratamiento.
- Atención de las complicaciones relacionadas con el tratamiento.
- Verificación de adherencia a las recomendaciones impartidas, en especial cuando la quimioterapia es oral.
- Activación de canales de comunicación para la transferencia del cuidado del paciente cuando se requiere de servicios prestados en instituciones diferentes.

- Realización, monitoreo y evaluación de los programas de tamización.
- Organización de los programas y rutas de prevención y detección temprana de la enfermedad.
- Gestión poblacional en cuanto a la identificación de grupos de riesgo alto para cáncer, priorización de los mismos y activación de intervenciones clínicas.
- Coordinación con actividades de promoción de la salud desde la atención primaria.
- Educación a los demás profesionales de la salud como uno de los componentes del trabajo de los equipos multidisciplinarios.

Retos desde la perspectiva asistencial:

- Falta de recurso humano para la multiplicidad de actividades de los programas asistenciales tanto de lo ambulatorio como del hospitalario que requiere de manera individual cada paciente.
- Barreras administrativas con los procesos para articular prestadores para la transferencia del cuidado.
- Desafíos operativos ante la alta demanda de servicios oncológicos y se satura la capacidad instalada de la IPS.
- Si bien se realizan procedimientos de priorización, el ideal es hacer un seguimiento de cada caso de la cohorte de sospechoso de cáncer y con diagnóstico establecido de cáncer.
- Dificultades para operar las rutas de atención cuando existen recursos limitados y no hay una adecuada gestión desde la EAPB o la Entidad Territorial.

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva administrativa:

- Monitoreo y seguimiento de las autorizaciones tanto de servicios PBS como No PBS.
- Programación de los ciclos de quimioterapia por cada paciente.
- Participar en los procesos de habilitación de servicios.
- Gestión del acceso y manejo de los pacientes durante su estancia hospitalaria.
- Planeación, coordinación y gestión documental de la junta de tumores.
- Comunicación con los familiares/cuidadores.
- Garantizar el egreso seguro de la hospitalización.
- Gestión de la información para el reporte de la Cuenta de Alto Costo.
- Planeación de la red de prestadores y los mecanismos de articulación desde la EAPB.
- Abordaje las condiciones psico-sociales que pueden afectar el proceso de atención.
- Gestión de servicios relacionados con la atención de salud si bien no son actividades sanitarias, como lo es el transporte y alojamiento mientras se encuentran en quimioterapia o radioterapia (aplica sólo para población pediátrica según lo establecido en la Ley 1388 de 2010).

Retos desde la perspectiva administrativa:

- La falta de voluntad política entre los prestadores y aseguradores para la creación de redes de atención integrales y funcionales.

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva clínico-administrativa (incluye el proceso de Navegación):

- Coordinación con los procesos de autorización y otras áreas administrativas que participan directa o indirectamente en la atención del paciente.
- Dirección y acompañamiento de los equipos de gestión de casos desde el aseguramiento.
- Activación entre los programas de atención domiciliar y otros extramurales con las necesidades en salud de los pacientes.
- Generación de sistemas de alertas.
- Monitoreo de los indicadores de proceso y resultado.
- Seguimiento a la oportunidad y disponibilidad de los servicios de la IPS oncológica, así como el cumplimiento por parte del paciente en cuanto a asistencia.

Retos desde la perspectiva clínico-administrativa:

- Limitación de los sistemas de información. Este punto es muy sensible para lograr los resultados esperados de la gestión del programa de navegación.
- Bagaje cultural y social del paciente, que puede dificultar el adecuado seguimiento y navegación.

- Hay algunos grupos de riesgo, como cáncer de pulmón o de páncreas, que dado su rápida progresión y pobre pronóstico, lleva al límite el tiempo de respuesta del equipo de navegación.

- Gestión de las comorbilidades y necesidad de interdisciplinario por fuera de los servicios oncológicos.

- Desafío en cumplir con los tiempos de empalme entre el tratamiento sistémico y la cirugía oncológico.

Programa de navegación

Uno de los temas recurrente en la actividad del grupo focal fue la necesidad de fortalecer los programas de navegación. Los profesionales de enfermería que dirigen la navegación de un paciente con cáncer tiene el potencial de impactar favorablemente en los desenlaces en salud, tales como mejor oportunidad de diagnóstico, reducción del tiempo para inicio del tratamiento, satisfacción del paciente, así como en la supervivencia y calidad de vida global (206,207). Esto se logra a través de (208):

- Continuidad de la información clínica del paciente.
- Continuidad en el manejo (transferencia efectiva del cuidado).
- Continuidad en el relacionamiento entre los prestadores y el asegurador.
- Activación de mecanismos de afrontamiento.
- Autocuidado en cáncer.
- Soporte psico-social del paciente.

En este orden de ideas, el grupo de profesionales de enfermería entrevistados proponen los siguientes elementos que pueden fortalecer los programas de navegación de la ciudad de Cali:

- Cabildeo, desde el punto de vista de salud pública, para lograr alinear los intereses de los actores clave de la ciudad.
- Visibilizar la importancia del impacto de la navegación en el logro de la triple meta (resultados en salud, optimización de recursos, mejor experiencia de la atención).
- Unificación de un modelo de navegación con alcance de ciudad y región.
- Consolidación de un sistema de alertas tempranas.
- Fomento de la investigación local para aportar evidencia respecto a la eficacia y costo-efectividad de un programa de navegación oncológico.

Plan de manejo de enfermería para el paciente oncológico

Todos los actores involucrados en la detección, confirmación diagnóstica y tratamiento del cáncer tienen la responsabilidad de garantizar la atención oportuna, sin demoras ni barreras de acceso a los pacientes. Esta integralidad en la atención cumplirá con los lineamientos de:

- Eliminar las barreras de acceso a los pacientes y sus familias.
- Simplificar los trámites administrativos para los pacientes y sus familias

- Garantizar el acceso a todos los servicios que requiere el paciente de ser posible en una misma IPS, evitando la fragmentación del servicio.

- Solicitar la autorización integral, por una única vez (dependiendo de la evolución del paciente, conforme al plan que determine el médico tratante) y por la totalidad del tratamiento de todos los servicios requeridos.

- Garantizar los servicios psicosociales complementarios en salud.

El personal de Enfermería tiene un rol muy importante en el equipo multidisciplinario, involucrado en el cuidado de pacientes con cáncer de colon y recto, ya que interviene en todo el proceso de la enfermedad, desde detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes, que involucra los lineamientos de integralidad de atención a los pacientes y su familia.

Las enfermeras en el grupo multidisciplinario deberán coordinar los recursos sanitarios, psicosociales y la continuidad de los cuidados en este tipo de paciente.

El objetivo del acompañamiento de Enfermería es el conocer paso a paso el proceso que lleva la persona durante el desarrollo de su enfermedad, logrando brindar una atención integral y humanizada al paciente y su familia, a través de:

- El establecimiento de estrategias de intervención, que propicien una relación de calidez con el paciente y a la vez, faciliten la educación en torno a sus necesidades en salud y empoderamiento en el manejo de su enfermedad.
- La identificación y mitigación de factores de riesgo que puedan comprometer la adherencia al tratamiento.

- La disminución de las barreras administrativas de atención, estableciendo canales de comunicación efectivos, entre Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), Institución Prestadora de Salud (EPS), el personal de salud y el paciente y su familia.

Es importante concentrar todas estas actividades hacia la orientación del equipo multidisciplinario en maximizar la calidad de vida de las pacientes, mientras están en el tratamiento. Revisemos los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento y cómo enfrentarlos. Los efectos secundarios físicos pueden permanecer después de terminado el tratamiento, efectos secundarios a largo plazo. A los efectos secundarios que suceden meses o años después del tratamiento, los denominan efectos tardíos. El tratamiento de los efectos secundarios a largo plazo y los efectos tardíos, son una parte importante de la atención para sobrevivientes.

Las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia: se recetarán medicamentos para ayudar a controlarlos. Se trabajará con la nutricionista, que puede proporcionar consejos sobre cómo comer y cómo mantenerse hidratado durante la quimioterapia.

La fatiga: La fatiga es una sensación de cansancio extremo. El médico puede tratar la fatiga con medicamentos recetados. El ejercicio también puede ayudarle.

El quimiocerebro: Problemas asociados con la memoria, la atención y la concentración. Recomendar ejercicios para conservar la memoria.

La pérdida ósea: Algunas terapias hormonales y quimioterapias pueden causar

pérdida ósea, aumentando así el riesgo de fracturas óseas; hay que ayudar a optimizar su salud ósea y ejercicios que fortalecen sus músculos.

La neuropatía periférica: Sensación de hormigueo en las manos y los pies, también puede ser doloroso. Interconsultar a especialista en neuropatía periférica y manejo del dolor, que brinde medicamentos para aliviar la neuropatía.

El riesgo de infección: Desarrollar un plan de control de infección es muy importante en la reducción de su riesgo, durante los tratamientos contra el cáncer y mejorar su calidad de vida durante la quimioterapia.

El dolor: Controlar el dolor puede exigir diferentes enfoques, por lo que es importante ser tan detallado como sea posible al describir el dolor, para poder controlarlo de la mejor manera.

Cambios físicos: Tanto el cáncer como su tratamiento pueden cambiar el aspecto e incluyen: Pérdida de cabello, Aumento o pérdida de peso, Cicatrices de cirugía.

Cambios emocionales: El cáncer interrumpe muchas partes de la vida de una persona, desde las relaciones hasta el trabajo y los pasatiempos. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de recuperación, también puede obligarlo a hacer cambios en su futuro y lidiar con la posibilidad de morir. Durante este tiempo, puede sentir muchas emociones diferentes: Tristeza, Ansiedad, Soledad o sensación de ser diferente de los demás, Miedo, Ira, Frustración, Culpa, Sentirse fuera de control, Un cambio en su forma de pensar sobre sí y el futuro.

Pero también muchos cambios positivos

emocionales, espirituales o intelectuales: Una apreciación por la fuerza de su cuerpo, Paz, Gratitud, Conciencia y apreciación de que la vida es corta y especial, Agradecido por nuevas relaciones importantes con cuidadores y otros pacientes, Un cambio en las prioridades, claridad sobre el significado en la vida y las metas personales.

Es importante dejarlo expresar todas estas emociones y brindar las herramientas y alternativas para manejarlas a través de la enfermera con rol integrativo.

Los cuidadores también cumplen un papel muy importante en el proceso de las pacientes, ellos asumen diferentes responsabilidades según se requieran:

- Proporcionar apoyo y aliento.
- Conversar con el equipo de atención en salud.

- Administrar medicamentos.
- Ayudar a manejar los síntomas y efectos secundarios.
- Coordinar las citas médicas.
- Llevar al paciente a las citas.
- Asistir con las comidas.
- Ayudar con las tareas domésticas.
- Manejar problemas con el seguro y la facturación.

Se puede aconsejar a los pacientes llevar un diario para hacer una lista de todos los medicamentos, quimioterapia y tratamientos específicos, incluyendo su dosis y la frecuencia con que se toman, y permitirle comunicarlo y expresar todas sus dudas al respecto y realizar seguimiento de su control.

7. REVISION DE EVALUACIONES ECONOMÓMICAS

Los sistemas de salud se ven enfrentados a dos tipos de cargas de la enfermedad oncológica, a saber: la carga epidemiológica del cáncer, y la carga económica del cáncer.

Ya se ha descrito algunos aspectos conceptuales en el capítulo de introducción. Es claro que la toma de decisiones en salud pública debe considerar aspectos tanto de efectividad como del costo de una determinada tecnología en salud. Es en este

escenario en que surge las evaluaciones económica como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones (209,210). En Colombia, las evaluaciones de tecnología en salud específicamente las evaluaciones económicas, brindan elementos críticos para comparar los beneficios y costos entre dos o más tecnologías, lo que a su vez permite generar políticas públicas en salud, planes de coberturas, protocolos de uso apropiados, y por supuesto, orientar las recomen-

daciones de guías de manejo clínico (211).

Una evaluación económica permite, entonces, identificar los factores determinantes del costo en salud, específicamente los costos directos médicos (212), en que incurre tanto el sistema como el paciente, comparándolos entre las tecnologías a evaluar. Esta información se empalma con la efectividad comparativa de las tecnologías, algo que ya conocemos desde la medicina basada en la evidencia. Ya sea que se trate de evaluaciones de tipo costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, o minimización de costos, se invoca el concepto de costo de oportunidad el cual se define como “los rendimientos que podrían haberse obtenido si un recurso concreto se hubiera utilizado en otro uso alternativo... [es decir] la aproximación a su medida suele hacerse de acuerdo con la cantidad de otros bienes o servicios que se sacrificarán por obtener unos resultados determinados” (210).

En el desarrollo de las recomendaciones, se identificaron aspectos de índole económico que pueden llegar a influir, positiva o negativamente, en la implementación de alguna de las recomendaciones. Por este motivo, se efectuó una revisión general de la literatura de evaluaciones económicas, con el fin de aportar elementos de juicio a los tomadores de decisión para el proceso de implementación de esta guía.

Se aclara que esta revisión no pretende sustituir los ejercicios de costo-efectividad y análisis presupuestal de los actores que fungen el rol de pagadores, sino que, por el contrario, busca señalar los elementos clave que determinan si una tecnología aporta una adecuada relación costo-beneficio.

Así mismo, no pretende ser exhaustiva. El objetivo es identificar los elementos

de costo o beneficio que determinaron la conclusión del estudio seleccionado. Expresado de otra forma, sabemos comparar los efectos de acuerdo con las medidas de asociación epidemiológicas y la estadística que las soporta, pero cuando adicionamos el componente del costo en la ecuación, se deben considerar los elementos que determinar el costo, principalmente, la frecuencia de uso y el precio de la tecnología.

7.1. COSTO-EFECTIVIDAD DE LA COLONOSCOPIA VERSUS COLONOGRAFIA POR TC

Van der Meulen y colaboradores publicaron en 2018 una evaluación económica con el objetivo de comparar la costo-efectividad de la colonografía por TC (también llamada colonoscopia virtual) con la colonoscopia (213). Se tomó un modelo de microsimulación específico para cáncer colorrectal que incorpora los resultados (beneficios) provenientes de varios estudios que estiman el efecto durante toda la vida de las intervenciones diagnósticas mencionadas. Por tanto, el horizonte de tiempo fue el periodo de toda la vida.

Adicionalmente, los autores ajustaron el modelo en cuatro estrategias de tamización en función del porcentaje de participación entre la colonoscopia y a la colonografía por CT. Los costos se tomaron desde la perspectiva de tercer pagador, teniendo en cuenta que los autores son procedentes del Alemania. Los desenlaces fueron medidos en AVAC (años de vida ajustados a calidad, o del inglés QALYs). La tasa de descuento se estableció en 3% por año tanto para los costos como para los AVAC.

Con base en la estrategia de tamización cada 10 años, dirigida a población entre 50 a 70 años, bajo un supuesto de 100% de

participación por cada tecnología en salud, los resultados fueron:

- Para el grupo de colonoscopia, se ganaron 106 AVACs, determinado por reducción en la mortalidad (según el modelo).
- Para el grupo de colonografía por TC, se ganaron 81 AVACs.
- Para el grupo de colonoscopia, los costos de tamización fueron de € 292,070 (euros de 2012).
- Para el grupo de colonografía por TC, los costos de tamización fueron de € 203,961.
- Los anterior determina un ICER (razón incremental de costo-efectividad) de € 3,535 per AVAC.
- En el análisis de sensibilidad, se evidenció que, a una frecuencia de 1 a 2 colonoscopias realizadas durante toda la vida, era una estrategia dominantes frene a la colonografía (mejores resultados a menor costo). Por otro lado, cuando se realizan más de 3 colonografía por CT durante la vida, ésta se vuelve dominante sobre la colonoscopia.

Con base en lo anterior, la primera conclusión es que la colonoscopia es una estrategia costo-efectiva, dominantes, en comparación con la colonografía por CT. Sin embargo, en Alemania se llevó a cabo un estudio, el COCOS trial, el cual determino la participación del uso de colonografía por TC en la población general mayor de 50 años y menor de 70 años como estrategia de tamización para cáncer de con y recto. Dado que la frecuencia de uso observada en este estudio fue de 6 durante la vida, dado que la estrategia de tamización planteada en el estudio fue de 3 años, en contraste con cada 5 a 10 años de la colonoscopia.

Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali

El estudio señala que la colonografía por CT podría ser costo-efectiva solo en caso de que se requiera de un intervalo de tamización menor a 5 años. En caso contrario, la colonoscopia se mantiene como estrategia dominante. En este sentido, las colonografía por CT, o colonoscopia virtual, sólo podría ser considerada como alternativa en pacientes con contradicciones absolutas para colonoscopia, lo cual es exótico.

7.2. COSTO-EFECTIVIDAD DEL BEVACIZUMAB

Se trate a estudio un artículo sobre la costo-efectividad del Bevacizumab teniendo en cuenta que este medicamento está aprobado en el Reino Unido. De hecho, la controversia surgió con las recomendaciones de la guía del NICE en el que el bevacizumab no está recomendado como tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, si bien tiene evidencia e indicación INVIMA para ser utilizado en esta población de pacientes en particular.

Goldstein y colaboradores publicaron en 2017 un análisis de la costo-efectividad global del bevacizumab (214). El objetivo del estudio fue evaluar la costo-efectividad del bevacizumab como tratamiento de primera línea en cáncer colorrectal metastásico desde la perspectiva del pagador de cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Israel.

Se utilizó un modelo de Markov previamente desarrollado para el contexto estadounidense, en el que se determina cuatro estados: primera línea con FOLFOX, primera línea con FOLFOX + Bevacizumab, se-

gunda línea con FOLFIRI (si hay falla en las anteriores mencionadas), o la muerte.

Los costos de los países fueron llevados a valores de dólar de 2015, que provenían de estudio de costeo por Medicare (para EEUU), del formulario nacional británico junto con el departamento de medicina y salud comercial para tarifas (para el Reino Unido), del formulario de beneficios de medicamentos de Ontario (para Canadá), del esquema de precios farmacéuticos (para Australia), y del ministerio de salud de Israel. En cuanto a los beneficios, se tomaron de una validación previa del modelo de Markov, el cual estima una ganancia de años de vida de 1.78 para el grupo FOLFOX, y 1.92 para el grupo FOLFOX+Bevacizumab. Así mismo, se estimó una ganancia de AVAC de 1.31 y 1.41, respectivamente (215).

Los resultados fueron los siguientes (caso base):

- Para EEUU, el ICER fue de \$213,292 por año de vida ganado, y de \$290,853 por AVAC ganado.
- Para Reino Unido, el ICER fue de \$136,076 por año de vida ganado, y de \$185,559 por AVAC ganado.
- Para Canadá, el ICER fue de \$133,808 por año de vida ganado, y de \$182,466 por AVAC ganado.
- Para Australia, el ICER fue de \$103,475 por año de vida ganado, y de \$141,102 por AVAC ganado.
- Para Israel, el ICER fue de \$135,111 por año de vida ganado, y de \$184,242 por AVAC ganado.
- Para un umbral de disponibilidad a pagar

de \$150,000/AVAC, la probabilidad de costo-efectividad de bevacizumab fue de 0%. En otras palabras, para una aceptabilidad del bevacizumab del 90% se debería aumentar el umbral al menos \$295,000.

Los autores concluyeron que el bevacizumab no mostró ser una estrategia costo-efectiva para los umbrales que manejan los países, el cual es de alrededor de \$150,000 por AVAC. El factor más importante de esta falta de costo-efectividad es el precio del medicamento.

Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali

El estudio, al igual que el grupo NICE, establece que el bevacizumab no es costo-efectivo para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico, principalmente por el alto costo del medicamento. La guía de práctica clínica colombiana incluyó una evaluación económica del bevacizumab (39). En este ejercicio, se llegó al resultado de un ICER de \$386,926,074 (pesos colombianos de 2011). Colombia no cuenta con un umbral de costo-efectividad, pero si se sigue las recomendaciones de la OMS de un umbral máximo equivalente a tres puntos del PIB per cápita, que para 2011 fue de \$40,117,212, el bevacizumab no sería costo-efectivo para el sistema de salud colombiano, en comparación con la quimioterapia con FOLFOX.

Al igual que concluye la guía colombiana, las consideraciones para la ciudad de Cali consisten en buscar aumentar el valor en salud del bevacizumab. La “ecuación” del valor en salud, definido como los resultados obtenidos por cada peso invertido (216), nos dice que una tecnología puede agregar valor al sistema si mejora los resultados en salud y/o reduce el costo. Toda estrategia que

apalanque los beneficios del bevacizumab más allá de lo reportado en los estudios, y si a ello se puede intervenir con control del precio a través de negociaciones de precio por volumen o uso de biosimilares (si aplica) entre otras alternativas, hará que esta tecnología en salud pueda ser costo-efectiva para la ciudad de Cali.

7.3. COSTO-EFECTIVIDAD DEL HIPEC O CIRUGIA CITORREDUCTIVA CON QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA

Hamilton y colaboradores publicaron en 2019 un análisis de costo-efectividad de la cirugía citorreductiva con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, o HIPEC, en el contexto de carcinomatosis peritoneal aislada por cáncer colorrectal metastásico (217). El propósito del estudio fue elaborar un análisis de costo-efectividad del HIPEC comparado con quimioterapia sistémica desde la perspectiva social de Estados Unidos.

Se utilizó un modelo de Markov diseñado por los autores, el cual determinaba 9 estados por los que “transita el paciente”, organizados de la siguiente manera: Los pacientes que eran tratados con HIPEC que posteriormente se les administra FOLFOX (o FOLFIRI) + Bevacizumab o solo FOLFOX (o FOLFIRI) o Cetuximab/Panitumumab. Los estados adicionales eran cuidados de soporte (paliativos) o la muerte. El horizonte de tiempo fue de 7 años. Los beneficios se tomaron a partir de 4 estudios tipo ensayo clínico.

Los costos se tomaron de estimaciones del dólar al año 2017 de Medicare y Medicaid. La tasa de descuento fue de 3% anual. Se estableció un umbral de costo-efectividad de \$100,000 por AVAC.

Los resultados del caso base fueron:

- Se ganan 0.76 años adicionales de vida para los que reciben quimioterapia.
- Se ganan 1.19 años adicionales de vida para los que fueron tratados con HIPEC.
- Se ganan 0.51 AVAC adicionales para los que reciben quimioterapia.
- Se ganan 0.86 AVAC adicionales de vida para los que fueron tratados con HIPEC.
- El costo total para el grupo de quimioterapia fue de \$32,637, y para el grupo HIPEC fue de \$64,499.
- El ICER fue de \$74,098 por años de vida ganado, y de \$91,034 por AVAC ganado.
- El análisis de sensibilidad mostró que la intervención del HIPEC predominó en rangos de costo-efectividad, por debajo del umbral establecido.
- El factor que más variabilidad tuvo en el análisis de sensibilidad univariado fue el costo del HIPEC, que oscilaba entre \$26,793 a \$51,721, seguido por la utilidad del HIPEC, con rango de 0.70 a 0.89.

Los autores concluyen que la intervención terapéutica del HIPEC es costo-efectiva, principalmente por los beneficios en años de vida ganados y AVAC adicionales, para un umbral de costo-efectividad de \$100,000 por año o por AVAC.

Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali

El procedimiento de HIPEC es una tecnología en salud costosa, tanto por el entrenamiento e infraestructura necesaria para su

realización, como las implicaciones de estancia hospitalaria y potenciales complicaciones. No obstante, el estudio presentado muestra que tiene ventajas en cuanto a los beneficios clínicos que otorga en supervivencia y calidad de vida.

La limitación de los estudios de costo-efectividad realizado en países desarrollados, con umbrales de costo-efectividad que superan los 3 puntos del PIB per cápita, es la dificultad de inferir la aplicabilidad de los resultados a un contexto como el colombiano. Sin embargo, el estudio establece ciertos lineamientos que pueden utilizarse para realizar ciertas consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali. En la medida que se logre una efectividad similar a la eficacia de los estudios (beneficio en mundo real) hará que el HIPEC se acerque a ser una tecnología costo-efectiva. Del mismo modo, toda estrategia para regular el costo como reducir el costo prevenible de las complicaciones, reducir el

costo de estancia hospitalaria, reducir el costo de insumos y materiales propios de la cirugía, se pueden optimizar el ICER.

Vale la pena mencionar un apartado del estudio de Hamilton: “Aunque los resultados de esta evaluación económica en salud son alentadores y muestran que el HIPEC es una opción de tratamiento costo-efectiva para la Carcinomatosis Peritoneal aislada en cáncer colorrectal metastásico, se debe enfatizar que esta opción de tratamiento no es beneficiosa para todos los pacientes con esta condición patológica. La decisión de proceder con HIPEC debe basarse en una discusión multidisciplinaria con consideraciones de edad, comorbilidades, extensión de la carga tumoral, intervalo libre de enfermedad, histología y estado funcional.” Los autores reconocen la selectividad de los estudios de eficacia, lo cual hace necesario llevar a cabo estudios locales para determinar la efectividad del HIPEC en la ciudad de Cali.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

8.1. ASPECTOS GENERALES

Las guías de práctica clínica tienen como propósito fundamentar brindar ciertas pautas para el apoyo en la toma de decisiones clínicas, de tal forma que reduzca la variabilidad médica relacionada con atención de pobre calidad. En este sentido, representa una herramienta que busca facilitar el acceso de la mejor evidencia disponible para afrontar los problemas clínicos del día a día de los equipos de salud, de tal manera que esto redunde en la atención óptima del paciente con cáncer. Para cumplir con este propósito, la presente guía debe implementarse por parte de todos aquellos actores que estén in-

volucrados en la atención de la población oncológica, sea de manera directa o indirecta. Pero la implementación propiamente dicha es el paso final de un proceso. Este proceso consiste en cuatro momentos (33):

- **Adopción:** hace referencia a la decisión y compromiso de los actores para incorporar en su práctica cotidiana, sea clínica o administrativa, las recomendaciones contenidas dentro de la guía.
- **Difusión:** hace referencia a los procedimientos de distribución de la información

que dan a conocer la guía y sus recomendaciones. Este paso corresponde a actividades de divulgación pasiva mediante la entrega de copias del manuscrito ya sea físico o por medio digital, presentación de medios de comunicación y eventos de socialización con un alcance de presentación de la guía.

- **Diseminación:** hace referencia a un proceso activo, sistemático y organizado, encaminado a la ejecución de actividades tendientes a trasladar el conocimiento a los usuarios finales de la guía. A diferencia del paso de difusión, este corresponde a todas aquellas actividades de comunicación y educación orientadas a la comprensión y aprehensión de las recomendaciones de la guía.

- **Implementación:** corresponde a la puesta en marcha real de la guía, esto es, se traslada las recomendaciones “desde el papel” a la toma de decisiones en la “realidad del día a día”. Para lograr este paso, aparte de pasar por los anteriores, se requiere de la identificación y abordaje de potenciales barreras para la efectiva implementación de la guía.

Existe evidencia desde principios de la década de los 90 de que las guías de práctica clínica tienen el potencial de mejorar los desenlaces en salud (218). En 2001 Smith y Hillner publicaron un estudio sobre el impacto de las guías de práctica clínica en cáncer, encontrando que efectos positivos sobre la estancia hospitalaria, tasas de complicaciones y costos asociados (219). En este último estudio, comentar los autores los factores que asociaron con el éxito del efecto de las guías: desarrollo de guías basadas en la evidencia, guías diseminadas a todos los profesionales de salud involucrados, implementación que incluye retroalimentación directa en el desempeño del médico o retroalimentación general sobre el desempeño del sistema, y responsabilidad para actuar acorde a las guías

por medio de incentivos (presión de pares).

Infortunadamente, existe una brecha importante entre la evidencia y la práctica, pues el mero hecho de que la guía (y por tanto la evidencia) esté disponible no implica que automáticamente la calidad en la atención mejorará, el denominado “abismo de la calidad”: la brecha entre la práctica actual frente a la atención óptima del paciente (220). De hecho, una publicación del 2017 evaluó el nivel de adherencia a guías de cáncer (221), encontrando que el promedio de adherencia varió entre 40% al 99%, y que dependía en algunos casos de guías específicas del grupo de riesgo (la adherencia a guías de cáncer de pulmón osciló entre 40% a 70%, mientras que la de cáncer de mama estuvo entre 90% a 100%) y en otros dependía de su alcance (mayor adherencia a la que se limitaron a manejo farmacológico vs guías con un mayor alcance, es decir, desde diagnóstico hasta tratamiento).

Grol publicó en 2003 un artículo en el que exponía algunos lineamientos para una implementación efectiva (222). Grol comenta que el cambio conductual hacia una adopción e implementación de las guías es posible, pero que tal cambio requiere de un abordaje en diferentes niveles (profesional, equipo de salud, institución, sistema de salud), y de un plan que depende tanto de la guía misma (su alcance) como de la identificación de barreras y facilitadores del cambio.

Con el fin de identificar actores clave, así como barreras potenciales para la implementación de la presente guía, se realizaron entrevistas grupales semiestructuradas con representantes de las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios -EAPB-. Se decantó por este actor ya que, desde su perspectiva de aseguramiento, definido éste como “la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de servicios que garantice

el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores” (223), tiene la visión más allá de un prestador y es el que concentra y responde por la gestión integral del riesgo de la población con cáncer.

8.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

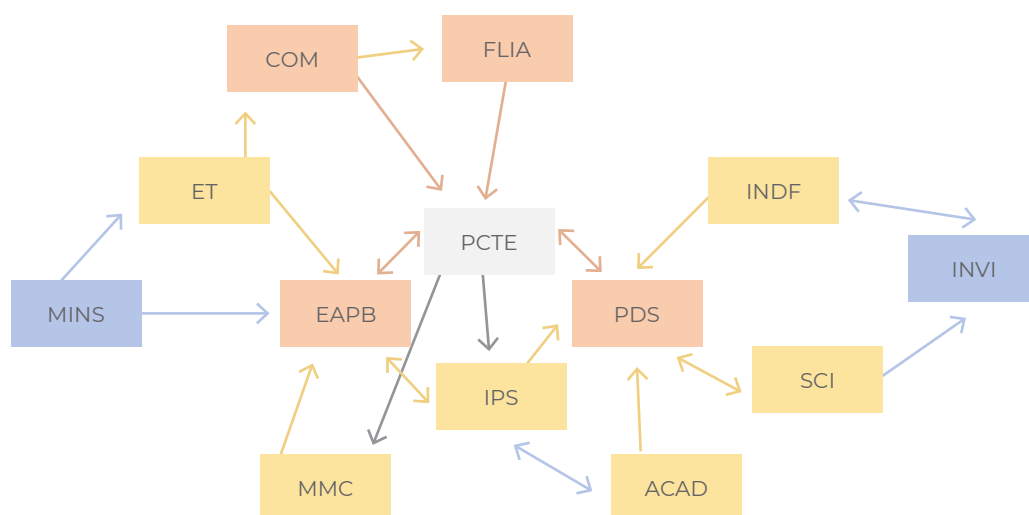
Con base en las entrevistas grupales, se identificaron actores que se consideran clave en el proceso de implementación de la guía, ya que están relacionados directa o indirectamente con la atención de los pacientes con cáncer. Estos actores son (organizados en orden alfabético):

- Comunidad
- El paciente
- Entidad territorial

- Entidades Administradoras del Plan de Beneficios -EAPB-
- Familia y red de apoyo al paciente
- Industria farmacéutica
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-
- INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)
- La academia
- Medios de comunicación masiva
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Profesionales de la salud
- Sociedades científicas

Así mismo, se elaboró el siguiente mapa de actores que no busca ser exhaustivo, pero sí evidenciar aquellos actores con influencia directa sobre el paciente (rojos), aquellos con influencia indirecta (amarillos) y aquellos con un rol regulador sobre otros actores diferentes al paciente (azul).

Ilustración 7 Mapa de actores clave



FUENTE: Elaboración propia. PCTE: paciente. EAPB: Entidad administradores del plan de beneficios. IPS: Institución prestadora de servicios de salud. PDS: profesionales de salud. ACAD: Academia. SCI: Sociedades científicas. INDI: industria farmacéutica. INVIMA: INVIMA. MMC: medio masivos de comunicación. FLIA: familia. COM: comunidad. ET: Entidad territorial. MINS: Ministerio de Salud.

Como actores del sistema de salud de la ciudad de Cali, tiene un papel sobre el proceso de implementación de la presente guía de práctica clínica. Una vez identificados, y de acuerdo con su rol sobre el paciente e influencia sobre el sistema, se proponen varias estrategias para vincular adecuadamente en los procesos de adopción, difusión, diseminación e implementación (224):

Monitoreo: Seguimiento o rastreo de las posiciones de los actores mediante investigación o discusión con otras partes.

Mensajes: Adaptar el alcance y la mensajería de las comunicaciones para satisfacer las expectativas de los actores, además de crear y dirigir mensajes a actores específicos.

Abogacía: Actividades para conseguir apoyo para un esfuerzo específico.

Consultoría: Solicitar comentarios o retroalimentación explícitos sobre el plan de implementación. Implica una expectativa por parte de los actores consultados de que la guía realizará cambios concretos con base en la consultoría efectuada.

Colaboración: Iniciar o participar en un diálogo bidireccional centrado en el aprendizaje mutuo y las soluciones. Puede incluir la creación conjunta de nuevas ideas y enfoques.

Innovación: Trabajo compartido sobre objetivos comunes de la guía y los actores. Puede incluir la co-creación, así como la co-implementación, de nuevas ideas.

8.3. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS

Mediante entrevistas grupales realizadas entre septiembre y octubre de 2020 con representantes del equipo de gestión de riesgo en salud de las EAPB, se identificaron potenciales barreras en el proceso de atención del paciente con cáncer. Estas barreras se clasificaron de acuerdo con las categorías propuestas en la guía metodológica para la elaboración de guías del Ministerio de Salud (32). Sin embargo, dada la multiplicidad de tipos de barreras encontradas en el contenido discursivo de los representantes de las EAPB, se procedió a realizar una sub-categorización, la cual se describe a continuación:

Tabla 3 Barreras potenciales de la atención del paciente con cáncer

CATEGORIA	SUB-CATEGORIA
Calidad de la guía	Ausencia de escalonamiento terapéutico
	Dificultades para el uso apropiado de la guía por parte de profesionales de salud no médicos.
	Desconocimiento en tiempos y frecuencias en el seguimiento
	Recomendaciones desactualizadas de las guías actuales.
Contexto organizacional	Deficiencias en los Canales de comunicación Paciente-EAPB-IPS
	Falta de Confianza entre EAPB-IPS
	Falta de Coordinación de la atención (navegación incompleta)

	Mal Funcionamiento de equipos y dispositivos que retrasan la atención (ej. Mal funcionamiento del resonador, o del acelerador lineal) Desconocimiento del Mecanismo de Puerta de entrada hacia la ruta oncológica Ausencia de un Prestador Integral Ineficiencias en el Proceso de autorizaciones y prestación no efectiva del servicio Fallas en la Red de prestadores: organización, articulación, integración servicios Mal Relacionamiento con el Ente Territorial Deficiencias en Sistemas de información
Contexto social	Cartera pendiente por la EAPB Falta de Gestión del No PBS: uso apropiado, uso de criterios de costo-efectividad Baja Oferta de servicios en salud especializados y sub-especializados Pagos prospectivos ausentes o no integrales Problemas en la Relación contractual IPS-EAPB Dificultades en el acceso de la población procedente de entorno rural
Individual profesional	Falta de Activación Temprana del Equipo de Cuidados Paliativos Falta de Adherencia a guías y protocolos Conocimiento escaso del sistema de salud en cuanto a rutas de atención, redes de prestadores Notas en historia clínica deficientes de información relevante Cambio inesperado de IPS de atención Variabilidad la práctica médica elevada Falta de formación y capacitación del RRHH de Atención Primaria para interpretación de tamizajes alterados y sospecha precoz de cáncer
Otros (categoría emergente)	Baja calidad y desempeño de las pruebas diagnósticas Carga de enfermedad elevada para la ciudad de Cali Uso inapropiado del sistema de clasificación CIE-10 Efectos adversos frecuentes que desincentivan a los pacientes de continuar el tratamiento. Ausencia de monitoreo de la cohorte de supervivientes asociado a incertidumbre de cuando finaliza el seguimiento por parte de la IPS Oncológica

	No priorización de población en riesgo alto
	Problemas jurídicos y operativos relacionados por reputación de la EAPB
	Falta de un programa estructurado por parte de la IPS oncológica que una atención más allá de la consulta
Paciente	Falta de adherencia o empoderamiento del paciente
	Complejidad elevada del caso relacionado con multimorbilidad o presentación atípica que retrasa el diagnóstico.
	Migración de domicilio recurrente que dificulta el seguimiento
	Mitos y creencias que pueden impedir el acceso temprano o la continuidad en el tratamiento
Proceso de implementación	Diseminación de guías deficiente
Tecnologías emergentes innovadoras	Falta de acuerdos en el uso de tecnologías recientes o costosas entre la IPS y la EAPB
	Rol del INVIMA poco claro en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, actualización de indicaciones terapéutica y socialización a sociedades científicas, profesionales de salud y EAPB del cabildeo de la industria farmacéutica.

8.4. Planteamiento de estrategias o facilitadores para resolver las barreras

Con las barreras identificadas por los representantes de las EAPB, se procedió a formular posibles estrategias o facilitadores que puedan resolver tales barreras. Con el fin de analizar las diferentes propuestas, se procedió a generar categorías fundamentadas teóricamente en los componentes de salud basada en valor de Michael Porter (225), junto con dos componentes del Modelo de Cuidados Crónicos (226). A continuación, se describen las propuestas de estrategias o facilitadores:

Equipo de salud multidisciplinario

- Aumentar la formación y capacitación en oncología por parte de los profesionales de auditoría clínica.
- Desarrollar consenso entre los profesiona-

les de la salud en cuanto al uso de tecnologías en salud No PBS de alto costo, respecto a uso apropiado, indicaciones sustentadas en la evidencia, limitaciones en el uso, y resultados esperados. Esta propuesta busca evitar barreras por procesos de auditoría de pertinencia y reprocesos interinstitucionales.

- Diseñar formatos de guías y protocolos teniendo en cuenta el usuario objetivo, esto con el fin de visibilizar y estandarizar la práctica clínica de los profesionales de salud que participan en el cuidado del paciente con cáncer (ej: profesionales de enfermería, personal administrativo, entre otros)

- Generar incentivos para que los profesionales de la salud se apoyen en las diferentes Sociedades Científicas a través el uso del formato UNIRS, con el fin de promover la inclusión de nuevas indicaciones INVIMA, o actualización de estas, por medicamentos de reciente

incorporación al mercado colombiano, o con un nuevo uso terapéutico no contemplado por el INVIMA.

- Involucrar a los actores de la academia para la discusión, disseminación y construcción de las recomendaciones de las guías
- Promover el uso adecuado de la plataforma MIPRES en aspectos como dosis, cantidad según dosis, tiempo de tratamiento, indicación INVIMA vs indicación en la prescripción (algunas tecnologías son PBS según el diagnóstico).
- Promover la satisfacción del profesional de la salud mediante contratación directa, capacitaciones, espacios para retroalimentación entre pares y compañeros, entre otros mecanismos que fomenten la preparación y empoderamiento del equipo de salud.

Gestión del riesgo en cáncer

- Coordinar las actividades propias de la Entidad Territorial con los mecanismos de captación e identificación de pacientes por parte de la EAPB
- Generar sistemas de alerta temprana cuando surja una prueba de tamización alterada.
- Proponer sistemas de clasificación de riesgo administrativo, esto es, un sistema que permita priorizar y/o agilizar procesos administrativos de tal forma que activen una ruta diferencial ante ciertos pacientes que por su condición clínica o psico-social requieran de tiempos de atención acortados y que pueden impactar directamente en desenlaces en salud. Este sistema estaría diseñado tanto por la EAPB en conjunto con su Prestador Oncológico y Prestador Primario.
- Formar personal administrativo “experto” o “gestor centinela” que puede no ser profesio-

nal de salud, pero sí altamente capacitado y entrenado en los requerimientos de la ruta de atención.

Mecanismos de pago

- Buscar los medios para que los mecanismos de pago involucren la sospecha de cáncer y no sólo desde el diagnóstico por histopatología del cáncer. Esto podría incluir en el pago servicios de tamización y la patología.
- Considerar la posibilidad de que los pagos prospectivos incluyan viáticos y traslados, especialmente en lo referente a población pediátrica.
- Generar alternativas a los mecanismos de pago prospectivos globales en cáncer por mecanismos que cubran sólo un grupo de riesgo (por ej, un PGP únicamente para Cáncer de Mama)
- Incentivar la migración de mecanismos de pago por actividad a presupuestos globales prospectivos, u otros mecanismos de pago prospectivos, que apalanquen las rutas de atención y coordinen la red de prestadores.
- Para aquellas atenciones que, mediante mecanismos de pago por actividad o evento, se propone mejorar los tiempos de radicación de facturas por parte de la IPS, así como mejorar los tiempos de glosas y conciliaciones por parte de la EAPB, con el propósito de mitigar cualquier caterva potencial que pueda afectar directa o indirectamente la prestación de servicios oncológicos.

Monitoreo y seguimiento

- Establecer pautas de seguimiento en el paciente con cáncer de la manera más detallada y especificando las frecuencias/intervalos de uso de tecnologías en salud, sean consul-

tas, laboratorios, imágenes, con el propósito de fortalecer los equipos de seguimiento de cohortes (tanto desde la IPS como de la EPAB).

- Fortalecer los equipos encargado de la navegación del paciente oncológico, mediante la formación y capacitación del personal, así como con la disponibilidad de usar tecnologías informáticas que faciliten el proceso de captura, procesamiento y análisis de la información.

- Promover los sistemas de farmacovigilancia por parte de la EAPB y la IPS.

- Promover programas para el seguimiento de la cohorte de supervivientes, y acordar cuándo y cómo se daría alta por parte de oncología, y qué pautas debería seguir el Prestador Primario en este tipo de pacientes.

Paciente, familia y comunidad

- Activar e involucrar a la red de apoyo del paciente, grupo familiar y/o cuidadores sobre la importancia y significados de los Cuidados Paliativos

- Generar mecanismos de activación de la comunidad cercana al paciente con cáncer dirigidos a fomentar la identificación de signos de alarma, utilización de pruebas de tamización, asistencia a programas, y reconocimiento de su IPS primaria.

Plataformas de información

- Fomentar el uso de un sistema de información común y unificado entre los actores del sistema de salud de la ciudad de Cali.

- Formar y capacitar al personal de salud respecto a las plataformas de información, su relevancia y dependencia de la historia clínica

ca como fuente primaria de datos. Se incluiría socializar la importancia e impacto que tiene el uso de los CIE-10.

- Proponer un repositorio de biopsias de la ciudad de Cali, similar al registro poblacional de cáncer, con un sistema de clasificación consensuado.

- Utilizar Apps u otras plataformas de TIC para facilitar procesos de autorizaciones, gestión de citas, entre otros.

Redes integrales e integradas en salud

- Ante eventualidades que impidan la adecuada prestación de servicios en salud, socializar y mantener al corriente a toda la red de prestadores aliadas a la EAPB para activar redireccionamiento o alternativas de prestador, en pro de la oportunidad y continuidad de la atención del paciente con cáncer.

- Articular de manera efectiva los programas de atención primaria, red de urgencias, red hospitalaria y red complementaria con la puerta de entrada al Prestador Oncológico.

- Considerando la importante carga de enfermedad (riesgo primario) del cáncer en la ciudad de Cali, se propone que las EAPB e IPS cuenten con el recurso humano necesario para operativizar las rutas, los acuerdos contractuales, los reportes de información, etc.

- Convocar a una mesa técnico-científica en la que participen las IPS, EAPB y Entidad Territorial, con el propósito de realizar un consenso de ciudad dirigido al uso escalonado de medicamentos de uso oncológico.

- Crear salas situacionales entre las IPS oncológicas con el fin de generar un espacio para la gestión del conocimiento en cáncer desde la perspectiva del prestador, esto es, unificar

criterios clínicos de diagnóstico y tratamiento, así como esquemas de seguimiento, apoyados por las guías de práctica clínica de cada institución, así como guías complementarias (como el presente documento).

- Crear salas situaciones entre las EAPB con el fin de generar un espacio para gestión del conocimiento, esto es, unificar criterios de gestión del riesgo en cáncer, lecciones aprendidas de casos de pacientes complejos, estrategias exitosas, entre otros elementos. Esta estrategia puede estar mediada por el Ente Territorial, así como otras organizaciones (ej ACEMI).
- Desarrollar rutas de atención por parte de las EAPB que integren las necesidades en salud de la población con cáncer, acompañado de actividades de socialización y disseminación que permitan articular la red de prestadores en términos estructurales y funcionales, y dirigidas al cumplimiento de indicadores de red (no indicadores por IPS).
- Establecer un contrato entre la EAPB y la IPS de tal forma que sea detallado en los servicios pactados, el uso de plataformas de información, frecuencia y contenidos de información entre ambas partes, y que en su construcción se involucre los equipos táctico-operativos.
- Fomentar el desarrollo de tecnologías que contengan información clínica sensible y relevante por parte del paciente, que facilite la articulación entre los prestadores que le brindan la atención.
- Fortalecer los espacios entre la IPS y la EAPB para la discusión de casos, encaminado a lograr resultados en salud mediante el ajuste y/o corrección de procesos y planes de mejoramiento. En esta estrategia estaría contemplado comités de seguridad del pa-

ciente, hospitalización potencialmente evitable, mortalidad evitable, casos atípicos o de alto costo, entre otros.

- Generar herramientas de apoyen la toma de decisiones clínica, como son las vías clínicas, algoritmos de tratamiento, protocolos, y demás elementos que disminuyan la variabilidad de la práctica médica. Esto podría ser la materialización de un estándar de ciudad y que evita cambios en el manejo si el paciente migra a otra IPS para su atención.
- Generar los canales de comunicación y equipos articuladores entre la alianza IPS-EAPB en el marco de generación/modificación contractual, de tal forma que el recurso humano involucrado en todos los procesos reconozca su par en la otra institución y su apoyo administrativo.

Unidad de práctica integrada en cáncer

- Crear mesas a nivel municipal o departamental en el que se realicen consensos respecto a la incorporación de una tecnología emergente o recién llegada al mercado, y que se articule con una dependencia del INVIMA (similar al proceso de ingreso de biosimilares).
- Desarrollar la post-consulta como mecanismo de validación tanto de puerta de entrada a ruta oncológica como de activación del paciente y red de apoyo.
- Explorar la inclusión en las guías la heterogeneidad o variabilidad esperada de los pacientes, ya que no todos siguen un mismo curso de enfermedad.
- Explorar la resolutiveidad esperada y alcance de especialidades frente a la demanda de sub-especialidades, con el fin de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los pa-

cientes y la capacidad instalada de la ciudad de Cali.

- Fortalecer los programas de atención domiciliar para garantizar el acceso a pacientes que residen en la periferia/zona rural de la ciudad de Cali
- Garantizar por parte de la EAPB los canales de comunicación para resolver dudas o inquietudes administrativas, y por parte de la IPS en cuanto a asignación de citas, es especial si el paciente requiere de múltiples servicios ofertados por el mismo prestador (ej, control con oncología, con cirugía oncológica, y con cuidados paliativos)
- Generar actualizaciones frecuentes de las guías para los grupos de riesgo priorizados.
- Generar los incentivos necesarios para la transformación de las IPS oncológicas en UFCA y UACAI.
- Para optimizar el recurso, se propone establecer acuerdos para agotar en primera instancia los medicamentos PBS, teniendo en cuenta aspectos de costo-efectividad.

- Realizar guías focalizadas en el uso apropiado de medicamentos especificados, ya sea por su alto volumen y/o su alto costo.

8.5. Evaluación de la implementación

Finalmente, en la medida que el proceso de implementación de la presente guía vaya tomando lugar entre los actores del sistema de salud de la ciudad de Cali, se debe ejecutar una evaluación de la línea base sobre la que se despliega a guía y, posteriormente, mediciones del impacto que va generando su uso.

La Cuenta de Alto Costo elaboró en 2017 un consenso basado en la evidencia de indicadores de gestión del riesgo, que contó con la participación de múltiples actores del sistema de salud, con el fin de “evaluar y monitorear la gestión del riesgo en cáncer [realizada por] entidades aseguradoras y prestadores de servicios de salud” (227). A partir de este documento, se propone los siguientes indicadores de proceso y resultados para evaluar la implementación:

Indicadores de proceso

Oportunidad de diagnóstico (tiempo entre la consulta o remisión para diagnóstico y el reporte histopatológico [días])

Definición	Sospecha: fecha de remisión de consulta por sospecha o síntomas. Diagnóstico: fecha de reporte histopatológico
Método de medición	Promedio de días que transcurre entre la fecha de remisión de consulta por síntomas hasta la fecha de reporte histopatológico.
Unidad de medida	Promedio del número de días

Fórmula	Sumatoria de días transcurridos entre remisión y el diagnóstico / total de diagnosticados con cáncer de colon y recto
Meta	< 30 días

Proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto clasificado in situ

Definición	carcinoma In Situ: Grupo de células anormales que permanecen en el mismo lugar en el que se formaron. No se diseminaron. Clasificación TNM 0.
Método de medición	Proporción de pacientes diagnosticados con cáncer gástrico in situ del total de pacientes diagnosticados en el periodo.
Unidad de medida	Proporción (%)
Fórmula	Pacientes con diagnóstico cáncer de colon y recto In situ x 100 / Total pacientes diagnosticados con cáncer de colon y recto
Meta	4%

Proporción de casos nuevos identificados en estadios tempranos

Definición	Estadios tempranos: Estadios I a IIA
Método de medición	Proporción de pacientes diagnosticados con diagnóstico de cáncer de colon y recto en estadios tempranos del total de pacientes diagnosticados en el periodo.
Unidad de medida	Proporción (%)
Fórmula	Pacientes con diagnóstico cáncer de colon y recto identificados en estadios tempranos x 100 / Total pacientes diagnosticados con cáncer de colon y recto
Meta	20%

Oportunidad de tratamiento

Definición	Tiempo entre el reporte histopatológico hasta el primer tratamiento reportado (días).
Método de medición	Promedio de días que transcurre entre la fecha de reporte histopatológico hasta el primer tratamiento.
Unidad de medida	Promedio del número de días
Fórmula	Número de días transcurridos entre dx y el 1º tratamiento / Total pacientes diagnosticados con cáncer de colon y recto
Meta	< 30 días

Indicadores de resultado

Supervivencia a 5 años

Definición	Seguimiento de cohortes a 5 años por estadio de la enfermedad.
Método de medición	Método Kaplan Meier
Unidad de medida	• Tiempo al evento: Tiempo entre la fecha del diagnóstico y la fecha de muerte. • Evento estudiado: Muerte: SI – NO. • Calculado por estadio al momento del diagnóstico.

Tasa de mortalidad general

Definición	Pacientes diagnosticados con cáncer colon y recto fallecidos en el periodo de reporte por cualquier causa.
Método de medición	Pacientes fallecidos en el periodo por 100.000 habitantes
Unidad de medida	Tasa de mortalidad x100.000 habitantes.
Fórmula	$\frac{\text{Número de personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto fallecidas en el periodo de reporte} \times 100.000}{\text{Total personas en el territorio (ciudad de Cali)}}$

9. PLAN DE ACTUALIZACIÓN

De acuerdo con lo establecido el manual metodológico del Ministerio de Salud y Protección Social (32), se recomienda realizar una revisión y actualización de esta guía dentro de 3 años, o antes, de acuerdo con la disponibilidad de nueva evidencia que pueda cambiar la fuerza o dirección de las recomendaciones.

De igual manera, se sugiere el establecimiento de un grupo técnico encargado del monitoreo regular de las guías desarrolladas

en el marco del proyecto C/CAN, con el fin de que frecuentemente exploren las publicaciones de estudios relevantes con resultados interinos, estudio finalizados posterior a la publicación de esta guía, desarrollo de nuevas guías o sus actualizaciones de las ya existentes tanto por instituciones nacionales como internacionales, o que identifique por parte de los expertos de la ciudad la necesidad de incorporar nueva evidencia (228).

ANEXOS

ANEXO 01. Declaración de conflicto de interés

A continuación, se reporta la declaración de conflicto de interés por cada uno de los participantes de la guía.

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Pedro Arguello	Cirujano gastrointestinal	SI ☐ NO ☒

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Interés económico personal | ☐ C. Interés No económico personal |
| ☐ B. Interés económico No personal | ☐ D. Interés económico personal de un familiar |

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA	ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO
☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión	Ninguno

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Sandra Avendaño	Coloproctóloga	SI ☐ NO ☒

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Interés económico personal | ☐ C. Interés No económico personal |
| ☐ B. Interés económico No personal | ☐ D. Interés económico personal de un familiar |

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA	ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO
☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión	Ninguno

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Ana Cristina Avendaño	Oncóloga clínica	SI ☐ NO ☒

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Interés económico personal | ☐ C. Interés No económico personal |
| ☐ B. Interés económico No personal | ☐ D. Interés económico personal de un familiar |

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA	ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO
☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión	Ninguno

NOMBRE

Juan Carlos Bravo

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Patólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Carlos Buelvas

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncólogo radioterápico

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Rodrigo Cárdenas

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Médico nuclear

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Francisco Antonio Escobar Aguilón

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Médico, Maestría en Salud Pública (c)

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☒ NO ☐**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☒ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

*Empleado como consultor para una compañía de salud.**Prevía vinculación a dos EPS en las cuales una de las funciones estaba relacionada con la gestión del riesgo en cáncer.***PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Juliana Escobar

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Patóloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Yaira Yobana Gil

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Enfermera oncóloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Frank Carrera-Gil

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Nutricionista

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Julian Agudelo Jiménez

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Paliativista

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Gabriel Marin

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncólogo radioterápico

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Juan Fernando Medina

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Coloproctólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Andres Monroy

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Cirujano coloproctólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

María Claudia Moreno

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Patóloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Juan Manuel Muñoz Acosta

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Médico nuclear

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Alexander Obando

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Coloproctólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Eduardo José Ortiz Hormaza

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Radiólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Luz Maritza Pabón Castilla

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Médica nuclear

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Juan Carlos Quesada

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Hemato-oncólogo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Eliana Rojas

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Gastroenteróloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Oscar Rojas

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Cirujano gastrointestinal

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Diego Villegas

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Paliativista

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Angela Regina Zambrano Harvey	Hemato-oncóloga	SI ☒ NO ☐

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- ☒ A. Interés económico personal
 ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal
 ☐ D. Interés económico personal de un familiar

*Apoyo para asistir a reuniones, congresos u otras actividades educativas.
Honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria de la salud.*

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA

- ☒ Participa
 ☐ Limitación Parcial
 ☐ Exclusión

ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO

Ninguno

ANEXO 02. Puntajes AGREE II

FECHA DE REVISION	30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA	Treatment of Patients With Early-Stage Colorectal Cancer: ASCO Resource-Stratified Guideline
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	Ainhoa Costas-Chavarri, Govind Nandakumar, Sarah Temin, Gilberto Lopes, Andres Cervantes, Marcia Cruz Correa, Rena Engineer, Chisato Hamashima, Gwo Fuang Ho, Fidel David Huitzil, Mona Malekzadeh Moghani, Ala I. Sharara, Mariana C. Stem, Catherine Teh, Sara E. Vázquez Manjarrez, Azmina Verjee, Rhonda Yantiss, and Manish A. Shah. Journal of Global Oncology 2019 ;5, 1-19
TOTAL EVALUADORES	3

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 3 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7	7		21
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	4	5		16
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	18	19	0	58
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 3 EVALUADORES	91%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7	7		21
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	7	7		21
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6	1	7		14
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7	6		20
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	7	7		21
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6	7	6		19
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	7	7		21
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	7	4		18
	Puntaje x Evaluador	54	50	51	0	155
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 3 EVALUADORES	91%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7	7		21
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7	7		21
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 3 EVALUADORES	100%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	7	3		17
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	5	7		19
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7	1	5		13
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	7	3	1		11
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	28	16	16	0	60
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 3 EVALUADORES	67%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7	7		21
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	14	14	14	0	42
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 3 EVALUADORES	100%				
	Puntaje la calidad global de la guía.	7	6	6		19
	PUNTAJE PARA 3 EVALUADORES	89%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X		X		
Comentarios	Sí, con modificaciones		X			
	NO					
		limitada a estadios tempranos		A pesar de algunas limitaciones, esta guía tiene una buena calidad metodológica. No obstante, su alcance es limitado al tratamiento en estadios tempranos en cáncer de colon y cáncer de recto, y su respectivo seguimiento. No aporta recomendaciones en cuanto a diagnóstico o manejo paliativo. Tiene algunas restricciones en especificar el manejo farmacológico en quimioterapia.		

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	91%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	91%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	67%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	89%

TOTAL EVALUADORES

2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	6			13
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	5			12
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	18	0	0	39
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	92%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	5			12
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	1			8
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	13	0	0	34
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	78%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7			14
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	5			12
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	1			8
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7			14
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	5			12
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	5			12
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	1			8
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	1			8
	Puntaje x Evaluador	56	32	0	0	88
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	75%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7			14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	21	20	0	0	41
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	97%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	2			9
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	2			9
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	6	1			7
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	7	5			12
	Puntaje x Evaluador	27	10	0	0	37
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	60%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	6			13
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	1			8
	Puntaje x Evaluador	14	7	0	0	21
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	71%				
	Puntúe la calidad global de la guía.	7	4			11
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	75%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	Sí, con modificaciones		X			
Comentarios	NO					
			Se puede utilizar esta guía con la seguridad de ser útil en las recomendaciones asociadas al manejo quirúrgico, siempre y cuando no haya otra guía mas reciente o de mejor calidad metodológica.			

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	92%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	78%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	75%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	97%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	60%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	71%
	CALIDAD GLOBAL	75%

TOTAL EVALUADORES

2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	6			13
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	5			12
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	18	0	0	39
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	92%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	5			12
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	1			8
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	13	0	0	34
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	78%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	5			12
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	2			9
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	1			8
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7			14
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	5			12
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	5			12
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	1			8
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	1			8
	Puntaje x Evaluador	56	27	0	0	83
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	70%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7			14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	21	20	0	0	41
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	97%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	2			9
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	2			9
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	6	1			7
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	7	5			12
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	27	10	0	0	37
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	60%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	6			13
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	1			8
	Puntaje x Evaluador	14	7	0	0	21
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	71%				
	Puntúe la calidad global de la guía.	7	4			11
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	75%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ					
Comentarios	Sí, con modificaciones	X	X			
	NO					
		Se debe usar la ultima edicion del TNM, 8va edicion desarrollada en dic 2016.	Se puede utilizar esta guía con la salvedad de ser útil en las recomendaciones asociadas al manejo quirúrgico, siempre y cuando no haya otra guía mas reciente o de mejor calidad metodológica.			

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	92%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	78%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	70%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	97%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	60%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	71%
	CALIDAD GLOBAL	75%

FECHA DE REVISION 30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA Protocol for the Examination of Specimens From Patients With Primary Carcinoma of the Colon and Rectum.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA College of AmericanPathologist, version Colon and Rectum Biopsy 4.1.0.0 (2020). Disponible en:
<https://documents.cap.org/protocols/cp-glower-colonrectum-biopsy-20-4100.pdf>
<https://documents.cap.org/protocols/cp-glower-colonrectum-resection-20-4100.pdf>

TOTAL EVALUADORES 3

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		JUAN CARLOS BRAVO	JULIANA ESCOBAR	MARIA CLAUDIA MORENO		
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 3 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7	7		21
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	7	7		21
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 3 EVALUADORES	100%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7	7		21
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	7	7		21
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6	6	6		18
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7	7		21
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	7	7		21
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	7	7		21
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	7	7		21
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	55	55	55	0	165
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 3 EVALUADORES	98%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7	7		21
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7	7		21
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 3 EVALUADORES	100%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	7	7		21
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	7	7		21
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	5	6	5		16
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	26	27	26	0	79
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 3 EVALUADORES	93%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7	7		21
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	14	14	14	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 3 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntaje la calidad global de la guía.	7	7	6		20
	PUNTAJE PARA 3 EVALUADORES	94%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SI	X	X	X		
	Si, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	100%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	98%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	93%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	94%

FECHA DE REVISION	30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA	Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de colon y recto Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia- Guía No 20 – Segunda edición
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de colon y recto. 2da edición. Guía No 20 [GPC en internet]. Bogotá D.C.: El Ministerio; 2017. Disponible en gpc.minsalud.gov.co
TOTAL EVALUADORES	2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1 SANDRA AVENDAÑO	EVALUADOR 2 FRANCISCO ESCOBAR	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	21	0	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7			14
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	7			14
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	21	0	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	100%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7			14
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	7			14
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	6			13
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7			14
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	7			14
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	7			14
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	7			14
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	56	54	0	0	110
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	98%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7			14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	21	0	0	42
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	100%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	7			14
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	7			14
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7	7			14
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	28	28	0	0	56
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	100%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7			14
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	14	14	0	0	28
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	100%				
	Puntúe la calidad global de la guía.	7	7			14
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	100%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X	X			
	Sí, con modificaciones					
	NO					
Comentarios						

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	100%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	98%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	100%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	100%

FECHA DE REVISION	30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA	Magnetic Resonance Imaging for Clinical Management of Rectal Cancer: Updated Recommendations From the 2016 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) Consensus Meeting
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	Beets-Tan RGH, Lambregts DMJ, Maas M, et al. Magnetic resonance imaging for clinical management of rectal cancer: Updated recommendations from the 2016 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) consensus meeting [published correction appears in Eur Radiol. 2018 Jan 10;]. Eur Radiol. 2018;28(4):1465-1475. doi:10.1007/s00330-017-5026-2
TOTAL EVALUADORES	4

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		RODRIGO CARDENAS	MARITZA PABON	EDUARDO ORTIZ	FRANCISCO ESCOBAR	
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	6	7	7	7	27
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	6	7	7	7	27
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	19	21	21	21	82
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 4 EVALUADORES	97%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7	6	5	25
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	1	5	4	1	11
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7	7	6	27
	Puntaje x Evaluador	15	19	17	12	63
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 4 EVALUADORES	71%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	5	7	6	4	22
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	3	7	6	4	20
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	1	6	6	7	20
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	6	7	7	7	27
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	1	7	5	5	18
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	3	7	4	7	21
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	1	7	5	3	16
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	6	7	1	1	15
	Puntaje x Evaluador	26	55	40	38	159
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 4 EVALUADORES	66%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7	7	7	28
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	1	7	5	6	19
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	6	7	7	6	26
	Puntaje x Evaluador	14	21	19	19	73
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 4 EVALUADORES	85%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	5	7	4	1	17
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	5	7	5	1	18
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	1	3	4	1	9
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	1	4	1	1	7
	Puntaje x Evaluador	12	21	14	4	51
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 4 EVALUADORES	36%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7	7	7	28
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	14	14	14	14	56
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 4 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	5	5	6	5	21
	PUNTAJE PARA 4 EVALUADORES	71%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X	X	X	X	
	SÍ, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios	El uso de esta guía es centrado para radiólogos que informen RM en pacientes con Ca rectal, no mucinoso. Es aplicable a un contexto muy específico dentro de esta patología.	no incluye estudios PET/CT solo se valida para Resonancia	Considerando la disponibilidad y accesibilidad a la RM en nuestro medio.	Considero que la GPC puede ser utilizada en recomendaciones en las cuales no haya evidencia suficiente para sustentarias, como herramienta para evitar el disenso en debates acerca del uso de la RMN en Ca de Recto.	

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	97%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	71%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	66%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	85%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	36%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	71%

TOTAL EVALUADORES 1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).		FRANCISCO ESCOBAR			4
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).		4			6
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.		5			5
	Puntaje x Evaluador	0	15	0	0	15
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	67%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.		6			6
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).		1			1
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.		1			1
	Puntaje x Evaluador	0	8	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	28%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.		1			1
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.		1			1
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.		1			1
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.		4			4
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.		6			6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.		4			4
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.		5			5
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.		2			2
	Puntaje x Evaluador	0	24	0	0	24
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	33%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.		6			6
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.		7			7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	19	0	0	19
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	89%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.		1			1
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.		5			5
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.		1			1
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.		1			1
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	0	8	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	17%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.		4			4
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	10	0	0	10
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	67%				
	Puntúe la calidad global de la guía.		3			3,00
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	33%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ					
	Sí, con modificaciones					
	NO		X			
Comentarios	No recomiendo esta GPC por dos motivos principales: uno, es que data de 2013; el segundo, no hay claridad de cómo se utilizó la evidencia para las recomendaciones enunciadas, por lo que el riesgo de sesgos o infravaloración de los riesgos genera una importante incertidumbre a la hora de adoptar alguna recomendación.					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	67%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	28%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	33%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	89%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	17%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	67%
	CALIDAD GLOBAL	33%

FECHA DE REVISION 30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA Metastatic Colorectal Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for Diagnosis, Treatment and Follow-Up

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, Arnold D; ESMO Guidelines Working Group. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up [published correction appears in Ann Oncol. 2015 Sep;26 Suppl 5:v174-7]. Ann Oncol. 2014;25 Suppl 3:iii1-iii9. doi:10.1093/annonc/mdl260

TOTAL EVALUADORES 1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).		4			4
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).		6			6
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	16	0	0	16
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	72%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.		6			6
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).		1			1
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.		1			1
	Puntaje x Evaluador	0	8	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	28%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.		1			1
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.		1			1
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.		1			1
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.		4			4
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.		6			6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.		4			4
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.		5			5
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.		2			2
	Puntaje x Evaluador	0	24	0	0	24
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	33%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.		6			6
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.		7			7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	19	0	0	19
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	89%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.		1			1
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.		5			5
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.		1			1
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.		1			1
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	0	8	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	17%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.		4			4
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	10	0	0	10
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	67%				
	Puntaje la calidad global de la guía.		3			3
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	33%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ					
Comentarios	Sí, con modificaciones					
	NO		X			
			No recomiendo esta GPC ya que no hay claridad de cómo se utilizó la evidencia para las recomendaciones enunciadas, por lo que el riesgo de sesgos o infra-valoración de los riesgos genera una importante incertidumbre a la hora de adoptar alguna recomendación.			

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	72%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	28%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	33%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	89%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	17%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	67%
	CALIDAD GLOBAL	33%

TOTAL EVALUADORES

1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x ítem
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Ítem 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).		5			5
	Ítem 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).		6			6
	Ítem 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	17	0	0	17
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	78%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Ítem 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.		5			5
	Ítem 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).		1			1
	Ítem 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.		1			1
	Puntaje x Evaluador	0	7	0	0	7
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	22%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Ítem 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.		1			1
	Ítem 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.		1			1
	Ítem 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.		1			1
	Ítem 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.		1			1
	Ítem 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.		5			5
	Ítem 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.		1			1
	Ítem 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.		1			1
	Ítem 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.		1			1
	Puntaje x Evaluador	0	12	0	0	12
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	8%				
	Ítem 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.		6			6
	Ítem 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.		7			7
	Ítem 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	20	0	0	20
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	94%				
	Ítem 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.		1			1
	Ítem 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.		5			5
	Ítem 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.		1			1
	Ítem 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.		1			1
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	0	8	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	17%				
	Ítem 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.		5			5
	Ítem 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.		6			6
	Puntaje x Evaluador	0	11	0	0	11
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	75%				
	Puntúe la calidad global de la guía.		3			3
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	33%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ					
	Sí, con modificaciones					
	NO		X			
Comentarios		A pesar de que la guía es del 2017, hay importante incertidumbre respecto al rigor metodológico empleado para sustentar las recomendaciones. No hay descripción de la metodología, así haya sido consenso, y preocupa el esquema "rígido" para abordar el tema de financiación.				

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	78%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	22%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	8%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	94%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	17%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	75%
	CALIDAD GLOBAL	33%

TOTAL EVALUADORES

2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	21	0	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7			14
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	6			13
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	20	0	0	41
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	97%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7			14
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	1	3			4
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	1	1			2
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7			14
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	7			14
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	5			12
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	4	1			5
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	1			8
	Puntaje x Evaluador	41	32	0	0	73
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	59%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7			14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	4	6			10
	Puntaje x Evaluador	18	20	0	0	38
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	89%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	6			13
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	6			13
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7	6			13
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	1	1			2
	Puntaje x Evaluador	22	19	0	0	41
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	69%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7			14
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	14	14	0	0	28
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	5	6			11
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	75%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ		X			
	Sí, con modificaciones	X				
	NO					
	Comentarios	La guía inicia ya con el diagnóstico, no hace referencia a como se llega a él, ni por endoscopia, ni por patología y menos como se realiza la estadificación del paciente y creo que esto se debe incluir, para luego partir de estado de ahí en adelante definir que se debe hacer con el paciente. La guía japonesa es muy útil por estar actualizada en la literatura en tratamiento endoscópicos y quirúrgicos así como quimioterapéuticos. Ellos no tienen sergos para las terapias dado que el sistema de salud japonés es publico 100% y la guía parte de ese hecho ofrecer terapia universal a los paciente.				

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	97%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	59%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	89%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	69%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	75%

FECHA DE REVISIÓN	30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUÍA	NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) - Colon cancer
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	National Comprehensive Cancer Network -NCCN- Colon Cancer, version 4.2020 (2020). Disponible en: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf

TOTAL EVALUADORES	4
-------------------	---

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1 ANGELA ZAMBRANO	EVALUADOR 2 ANA CRISTINA AVENDAÑO	EVALUADOR 3 FRANCISCO ESCOBAR	EVALUADOR 4 DIEGO VILLEGAS	Puntaje x ítem
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Ítem 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7	7	28
	Ítem 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7	7	28
	Ítem 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	21	84
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 4 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Ítem 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	6	7	7	27
	Ítem 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	3	7	3	20
	Ítem 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7	6	5	25
	Puntaje x Evaluador	21	16	20	15	72
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 4 EVALUADORES	83%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Ítem 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	6	7	6	26
	Ítem 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	6	7	5	25
	Ítem 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	3	6	1	17
	Ítem 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7	6	7	27
	Ítem 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7	7	7	7	28
	Ítem 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	7	7	6	27
	Ítem 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	7	7	7	28
	Ítem 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	56	50	54	46	206
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 4 EVALUADORES	91%				
	Ítem 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	6	7	7	7	27
	Ítem 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	6	7	7	7	27
	Ítem 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	19	21	21	21	82
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 4 EVALUADORES	97%				
	Ítem 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	6	4	4	4	18
	Ítem 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	7	5	7	26
	Ítem 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7	7	7	7	28
	Ítem 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	7	4	1	4	16
	Puntaje x Evaluador	27	22	17	22	88
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 4 EVALUADORES	75%				
	Ítem 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7	7	7	28
	Ítem 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7	7	7	28
	Puntaje x Evaluador	14	14	14	14	56
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 4 EVALUADORES	100%				
	Puntaje la calidad global de la guía.	7	6	7	6	26
	PUNTAJE PARA 4 EVALUADORES	92%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X	X	X	X	
	Sí, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	83%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	91%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	97%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	75%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	92%

TOTAL EVALUADORES

2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		ANGELA ZAMBRANO		FRANCISCO ESCOBAR		
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7		7		14
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7		7		14
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7		7		14
	Puntaje x Evaluador	21	0	21	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7		7		14
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7		7		14
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7		6		13
	Puntaje x Evaluador	21	0	20	0	41
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	97%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7		7		14
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7		7		14
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7		6		13
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7		6		13
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	7		7		14
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7		7		14
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7		7		14
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7		7		14
	Puntaje x Evaluador	56	0	54	0	110
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	98%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7		7		14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7		7		14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7		7		14
	Puntaje x Evaluador	21	0	21	0	42
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	100%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	6		4		10
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7		5		12
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7		7		14
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	7		1		8
	Puntaje x Evaluador	27	0	17	0	44
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	75%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7		7		14
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7		7		14
	Puntaje x Evaluador	14	0	14	0	28
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	7		7		14
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	100%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X		X		
	Sí, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	97%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	98%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	75%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	100%

FECHA DE REVISION

30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DE LA GUIA

Colorectal cancer. NICE guideline [NG151]

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

NICE (2020): Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng151>

TOTAL EVALUADORES

1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).		7			7
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).		7			7
	Item 3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	21	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.		7			7
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).		7			7
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	21	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.		7			7
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.		7			7
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.		7			7
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.		7			7
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.		7			7
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.		7			7
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.		7			7
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.		3			3
	Puntaje x Evaluador	0	52	0	0	52
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	92%				
	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.		7			7
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.		7			7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	21	0	0	21
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	100%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.		6			6
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.		6			6
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.		7			7
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	26	0	0	26
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	92%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.		7			7
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.		7			7
	Puntaje x Evaluador	0	14	0	0	14
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	100%				
	Puntaje la calidad global de la guía.		7			7,00
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	100%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ		X			
	Sí, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	100%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	92%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	92%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	100%

FECHA DE REVISION	30 DE JUNIO DE 2020
NOMBRE DE LA GUIA	Use of Magnetic Resonance Imaging in Rectal Cancer Patients: Society of Abdominal Radiology (SAR) Rectal Cancer Disease-Focused Panel (DFP) Recommendations 2017
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA	Gollub MJ, Arya S, Beets-Tan RG, et al. Use of magnetic resonance imaging in rectal cancer patients: Society of Abdominal Radiology (SAR) rectal cancer disease-focused panel (DFP) recommendations 2017. <i>Abdom Radiol (NY)</i> . 2018;43(11):2893-2902. doi:10.1007/s00261-018-1642-9

TOTAL EVALUADORES	3
-------------------	---

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7	7		21
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	21	21	0	63
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 3 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	6	6		19
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7	4	1		12
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	17	14	0	52
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 3 EVALUADORES	80%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	7	4		18
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	7	4		18
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	7	7		21
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	7	7		21
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6	6	7		19
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6	4	6		16
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	7	7		21
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	7	1	1		9
	Puntaje x Evaluador	54	46	43	0	143
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 3 EVALUADORES	83%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7	7		21
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	6	6		19
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	21	20	20	0	61
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 3 EVALUADORES	96%				
	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	7	5	1		13
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	6	1		14
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	6	5	1		12
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	5	4	1		10
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	25	20	4	0	49
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 3 EVALUADORES	51%				
	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7	7		21
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7	7		21
	Puntaje x Evaluador	14	14	14	0	42
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 3 EVALUADORES	100%				
	Puntaje la calidad global de la guía.	6	6	5		17,00
	PUNTAJE PARA 3 EVALUADORES	78%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X	X	X		
	Sí, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios		Considerando ciertos ajustes en lo referente a la aplicabilidad y accesibilidad a la RM en nuestro medio	Se puede utilizar en aquellos casos en los cuales no hay suficiente evidencia y la decisión final cuenta con una incertidumbre significativa para determinar la dirección de la recomendación.		

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	80%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	83%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	96%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	51%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	78%

ANEXO 03. CONSENSO DE EXPERTOS

Se realizaron dos momentos de consenso. En primera instancia, mediante un consenso informal, se determinó cuáles recomendaciones derivadas de las guías referentes se consideraban válidos y cuáles no. Posteriormente, se definió la necesidad de ajuste o modificación de las recomendaciones considerando aspectos de escritura, así como operativos propios del contexto de la ciudad de Cali.

Respecto a la fuerza de la recomendación, se definió por votación (consenso formal) de acuerdo con los siguientes criterios, modificados del manual metodológico para guías (32). En aquellos en que no hubo mayoría, o no hubo votación, se utilizó como proxy la calidad de evidencia más las consideraciones realizadas durante el consenso informal:

CRITERIO		DEFINICIÓN
Problema	¿Es un problema prioritario?	El problema es determinado por la importancia y la frecuencia del tema de salud que se aborda (carga de enfermedad, prevalencia, etc). Si el problema es de gran importancia una recomendación fuerte es más probable.
Balance entre los beneficios y los riesgos	¿El efecto deseado es grande? ¿El efecto indeseado es pequeño?	Esto requiere una evaluación del efecto absoluto tanto de los beneficios como de los daños y su importancia. Si el beneficio o el daño son mayores es más probable una recomendación fuerte.
Uso de recursos	¿Los recursos necesarios son pocos? ¿El costo incremental es pequeño en relación a los beneficios netos?	Se describe el uso de los recursos para las opciones, si es costo efectivo y si hay beneficio incremental. Si el uso de recursos es conveniente o no, es más probable que sea una recomendación fuerte.
Factibilidad	¿Es la opción factible de ser implementada?	Cuanto mayor sea la factibilidad de una opción para la mayoría de los implicados, es más probable que sea una recomendación fuerte.

A continuación de exponen las recomendaciones que requirieron ajustes, con su respectiva justificación.

Del bloque de proceso diagnóstico:

Recomendación original	Recomendación adaptada	Justificación
Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar una biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico, a menos que esté contraindicado (por ejemplo, en pacientes con trastornos de coagulación sanguínea).	Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico.	No es requisito para la toma de biopsia la medir tiempos de coagulación ni INR.
Se sugiere una colonografía por tomografía computarizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible con enema de bario, si el servicio local de radiología puede demostrar su competencia en esta técnica. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se sugiere ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado.	Se sugiere una colonografía por tomografía computarizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible con enema de bario, siempre y cuando las IPS cuenta con personal entrenado y capacitado para la realización e interpretación de Colonografías por TC. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se sugiere ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado.	Se hace énfasis en que se requiere de una IPS que no sólo tenga la tecnología para la realización de la Colonografía por TC, sino en el Recurso Humano entrenado para la adecuada realización de la misma.
Se recomienda ofrecer sedación a todos los pacientes, a menos que esté contraindicada. Los pacientes deben ser conscientes de que tienen el derecho de rechazar la sedación si así lo desean.	Se recomienda ofrecer sedación a todos los pacientes, a menos que esté contraindicada, lo cual está determinado por el profesional en Anestesiología. Los pacientes deben ser conscientes de que tienen el derecho de rechazar la sedación si así lo desean.	Anestesiología es el profesional competente para determinar las contraindicaciones de la sedación.

El equipo debe tener la capacidad de crear registros fotográficos, ya sean de papel o digitales. Se sugiere conservar documentación fotográfica auditable de que la colonoscopia fue completa: fotodocumentación de la válvula íleo-cecal y el ciego, o un videoclip con su respectiva foto instantánea.	Se sugiere que el equipo debe tener la capacidad de crear registros fotográficos, ya sean de papel o digitales, con el propósito de conservar documentación fotográfica auditable de que la colonoscopia fue completa: fotodocumentación de la válvula íleo-cecal y el ciego, o un videoclip con su respectiva foto instantánea. Así mismo, se debe realizar registro fotográfico así no haya hallazgos patológicos	Enfatizar en que el punto de buena práctica el registro de imagen haya o no hallazgos patológicos en la colonoscopia.
Se sugiere que los especialistas que realizan la endoscopia monitoricen sus tasas individuales de detección de adenomas, en pacientes sometidos a colonoscopia de tamización. Es deseable que cada centro o profesional, audite la tasa de detección de pólipos y la tasa de resección de pólipos en la población de tamizaje.	Se sugiere que los especialistas que realizan la endoscopia monitoricen sus tasas individuales de detección de adenomas, en pacientes sometidos a colonoscopia de tamización, y correlación con las biopsias positivas para cáncer. Así mismo, es deseable que cada centro o profesional, audite la tasa de detección de pólipos y la tasa de resección de pólipos en la población de tamizaje.	Se busca que exista una retroalimentación de los equipos de patología con los especialistas en endoscopia para medir efectivamente las tasas de detección de cáncer y no solo de adenomas.
Se sugiere, cuando sea posible, la preparación intestinal con dosificación dividida para mejorar la efectividad de la preparación intestinal. Se sugiere que los exámenes se realicen solamente después de una adecuada preparación del intestino, es decir, sin ningún residuo fecal o líquido en el lumen que pudiera enmascarar cualquier área sospechosa.	Se sugiere, cuando sea posible, la preparación intestinal con dosificación dividida para mejorar la efectividad de la preparación intestinal. Esto está condicionado a la hora de programación de la colonoscopia y a las comorbilidades (por ej., insuficiencia cardíaca). De igual manera, se sugiere que los exámenes se realicen solamente después de una adecuada preparación del intestino, es decir, sin ningún residuo fecal o líquido en el lumen que pudiera enmascarar cualquier área sospechosa.	Individualizar la dosificación de acuerdo con la preparación seleccionada y la hora del procedimiento.

Si una colonoscopia completa no se ha realizado ya sea porque la lesión primaria impide la colonoscopia total, o por cualquier otra razón, se sugiere visualizar radiológicamente el resto del colon antes de la cirugía, si es posible. Se sugiere que este procedimiento sea realizado idealmente por colonografía por tomografía computarizada, o si no está disponible, por enema de bario de doble contraste de alta calidad. Si por alguna razón el colon no se visualiza antes de la cirugía, se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los tres a seis meses posteriores a la colectomía.

Si una colonoscopia completa no se ha realizado ya sea porque la lesión primaria impide la colonoscopia total, o por cualquier otra razón, se sugiere visualizar radiológicamente el resto del colon antes de la cirugía, si es posible. Se sugiere que este procedimiento sea realizado idealmente por colonografía por tomografía computarizada, o si no está disponible, por enema de bario de doble contraste de alta calidad.

Se separa la recomendación original para dar mayor claridad en el enunciado.

Si una colonoscopia completa no se ha realizado ya sea porque la lesión primaria impide la colonoscopia total, o por cualquier otra razón, se sugiere visualizar radiológicamente el resto del colon antes de la cirugía, si es posible. Se sugiere que este procedimiento sea realizado idealmente por colonografía por tomografía computarizada, o si no está disponible, por enema de bario de doble contraste de alta calidad. Si por alguna razón el colon no se visualiza antes de la cirugía, se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los tres a seis meses posteriores a la colectomía.

Se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la colectomía, en aquellos casos en que no se logró visualización del colon antes de la cirugía.

Se separa la recomendación original para dar mayor claridad en el enunciado.

Del bloque de estratificación:

Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon. PET/CT is not routinely indicated (NCCN 2020)	Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.	Se hace claridad de que esta recomendación aplica para la población de cáncer de colon y no de cáncer de recto.
Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.	Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste	Se especifica la conducta a seguir en caso de contraindicación de TAC con contraste.
Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.	Se sugiere realizar RMN de pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de recto.	Se hace claridad de que esta recomendación aplica para la población de cáncer de recto y no de cáncer de colon.
Se sugiere hacer tomografía computarizada o resonancia magnética de pelvis para valorar el estado del margen mesorrectal.	Se sugiere realización de RMN de pelvis para valorar el estado del margen mesorrectal.	Se especifica la conducta a seguir en caso de contraindicación de TAC con contraste.

Se sugiere ofrecer estadiaje local preoperatorio por medio de resonancia magnética de pelvis a los pacientes con cáncer de recto detectado por tamización, con el fin de facilitar la planificación de la radioterapia preoperatoria, aunque también la tomografía computarizada multicorte de alta calidad puede dar información adecuada.	Se sugiere ofrecer estadiaje local preoperatorio por medio de resonancia magnética de pelvis a los pacientes con cáncer de recto detectado por tamización, aunque también la tomografía computarizada multicorte contrastada de alta calidad puede dar información adecuada.	Se hace énfasis en que en la población con cáncer de recto se prefiere realizar RMN de pelvis, independientemente de la planificación de radioterapia. La TC multicorte debe ser contrastada
No se sugiere usar los resultados de un examen digital rectal como parte de la evaluación de estadificación.	Se sugiere usar los resultados de un examen digital rectal como parte complementaria de los demás estudios. El examen digital rectal es de especial valor para el equipo de cirugía en relación con el explorar movilidad del recto, altura del tumor respecto al pubo-rectal, así como corroborar los hallazgos de la RMN de pelvis.	El grupo de expertos clínicos considera que este examen conserva su utilidad semiológica.
Se sugiere ofrecer tomografía axial computarizada o resonancia magnética de abdomen en lugar de ecografía para la detección de metástasis hepáticas.	Se sugiere ofrecer RMN o TAC de abdomen en lugar de ecografía para la detección de metástasis hepáticas. Si se evidencien lesiones inespecíficas en el TAC, se sugiere realizar RMN de abdomen.	Se especifica el caso en que el TAC no sea concluyente respecto a la presencia de metástasis, ante lo cual se indica la RMN.
Si la TAC con contraste es sugestiva de enfermedad metastásica en la pelvis, se sugiere una resonancia magnética de pelvis y la discusión de sus resultados con el equipo multidisciplinario.	En los casos de cáncer de colon, si la TAC con contraste es sugestiva de enfermedad metastásica en la pelvis, se sugiere una resonancia magnética de pelvis y la discusión de sus resultados con el equipo multidisciplinario.	Se asumen que para cáncer de recto ya se ha tomado una RMN de pelvis.

Del bloque de diagnóstico patológico:

Se debería consultar un equipo multidisciplinario sobre si es recomendable o no realizar resección quirúrgica de un adenocarcinoma pT1; si la resección quirúrgica se recomienda, se debe considerar la posibilidad de obtener la opinión de un segundo histopatólogo dado que existe variación en la evaluación de las características de alto riesgo.	Se debería consultar un equipo multidisciplinario sobre si es recomendable o no realizar resección quirúrgica de un adenocarcinoma pT1; si la resección quirúrgica se recomienda, se debe considerar la posibilidad de obtener la opinión de un segundo patólogo dado que existe variación en la evaluación de las características de alto riesgo. Esta evaluación la realiza la IPS que va a manejar el paciente por lo que se debe garantizar el envío de las placas de parafina si la histopatología se realizó en una institución diferente.	Se refuerza lo establecido en la recomendación de que, cuando la decisión es quirúrgica, el reporte final de patología va con doble opinión. Pero dada la responsabilidad que ello conlleva, si el diagnóstico se hace por fuera de la IPS “tratante”, el equipo de patología debe poder acceder a los bloques de parafina realizados por la institución que realizó el diagnóstico.
Considere reportar la correlación entre el diagnóstico histológico de biopsias y las resecciones. Cualquier falta de correlación debería ser discutida por un equipo multidisciplinario y los resultados de esta discusión deberían documentarse.	Considere reportar la correlación entre el diagnóstico histológico de biopsias y las resecciones. Cualquier falta de correlación, si bien son excepcionales, debería ser discutida por un equipo multidisciplinario y los resultados de esta discusión deberían documentarse.	Son excepcionales los casos de que una biopsia da cáncer y en la resección del espécimen definitivo no se encuentra neoplasia.
Debido a la mejorada reproducibilidad diagnóstica de la clasificación revisada de Viena, se sugiere el uso de esta clasificación en un formato modificado para lesiones detectadas en la tamización para así asegurar una comunicación internacional constante y la comparación de la histopatología de biopsias y especímenes de resección.	Debido a que la variabilidad de las displasias es grande, la concordancia no es buena y depende de la experiencia y especialización el profesional de patología gastrointestinal, se sugiere que se realicen acuerdos conceptuales entre patólogos y cirujanos oncólogos para determinar cuál clasificación se va a utilizar por parte de la institución, para así asegurar una comunicación constante y la comparación de la histopatología de biopsias y especímenes de resección.	Se dispone de otros sistemas de clasificación además del de la clasificación revisada de Viena, por lo que se propone fomentar acuerdos institucionales para monitorear la concordancia biopsia – espécimen.

Del bloque de Generalidades del tratamiento

For resectable colon cancer that is causing overt obstruction, stent (in selected patients) followed by colectomy are options. Stents are generally reserved for cases of distal lesions in which a stent can allow decompression of the proximal colon with later elective colectomy with primary anastomosis. (NCCN colon 2020)	Para pacientes con cáncer de colon resecable que esté causando obstrucción manifiesta, se puede considerar como opción la inserción de un stent (en pacientes seleccionados) seguido de colectomía. Los stent colónicos están reservados generalmente para aquellos casos con lesiones distales en las cuales el stent puede permitir la descompresión del colon proximal con posterior colectomía electiva con anastomosis primaria.	Traducción y validación
---	---	-------------------------

Del bloque de manejo in situ

Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) en pacientes con cáncer de colon que tengan las siguientes características: 1. Tumores bien o moderadamente diferenciados 2. Tumores no ulcerados 3. Tumores menores de 3 centímetros 4. Con viabilidad técnica para su realización 5. Que levanten a la inyección de lidocaína o solución salina. Se sugiere realizar resección local	(polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) en pacientes con cáncer de colon que tengan las siguientes características: 1. Tumores bien o moderadamente diferenciados 2. Tumores no ulcerados 3. Tumores menores de 3 centímetros, si bien la determinación de resecabilidad es la base de implantación 4. Con viabilidad técnica para su realización 5. Que levante a la infiltración y no presente una separación de las capas mucosas y submucosa para una resección segura. 6. Se prefiere la resección en bloque a la resección fragmentada. Se enfatiza que, si bien la recomenda-	ción es de 3 cm, esto es variable en la toma de decisiones por parte del tratante, que valorará la base de implantación y no únicamente el tamaño. Así mismo, se reitera la preferencia de resección en bloque.
En pacientes con estadio 0 (tumores In situ) de cáncer colorrectal se sugiere hacer resección endoscópica o local asegurando sus márgenes laterales y profundos negativos.	En pacientes con estadio 0 (tumores In situ) de cáncer colorrectal se sugiere hacer resección endoscópica o local corroborando con patología sus márgenes laterales y profundos negativos.	Aclaración de que el mecanismo de verificación es por parte del profesional de patología y no tanto por el endoscopista.

Del bloque de manejo temprano

En pacientes con cáncer de colon y recto, con lesiones de tamaño superior a 3 centímetros, que ocupen más del 30% de la circunferencia del intestino, pobremente diferenciada o con invasión linfovascular, se sugiere realizar resección radical.	En paciente con cáncer de recto, con lesiones de tamaño superior a 3 cm, que ocupen más del 30% de la circunferencia del intestino, pobremente diferenciada o con invasión linfovascular, se sugiere realizar resección radical	Se especifica que las medidas mencionadas aplica sólo para cáncer de recto.
En pacientes con cáncer de colon estadio 0 – I, con indicación de cirugía radical y con baja expectativa de vida o alto riesgo quirúrgico, se sugiere como una opción de tratamiento la escisión no oncológica (resección mesocólica no completa o segmentada).	En pacientes con cáncer de colon estadio 0-I, con indicación de cirugía radical pero con baja expectativa de vida o alto riesgo quirúrgico, se sugiere llevar caso a Junta Multidisciplinaria e individualizar cada caso para determinar balance beneficio/riesgo entre la intervención quirúrgica y dejar en observación.	No recomendar como primera opción el manejo quirúrgico no oncológico, teniendo en cuenta las implicaciones de ello, y considerando la situación compleja para decidir en un contexto de baja expectativa de vida.

Del bloque de manejo localmente avanzado

Se sugiere que el cáncer de colon sea tratado con cirugía radical con escisión mesocólica completa y ligadura alta de los vasos colónicos. The extent of lymph node dissection to be performed during colorectal cancer surgery is determined based on the preoperative clinical findings and on the extent of lymph node metastasis and depth of tumor invasion by the tumor observed intraoperatively. (JSCCR 2019)	Se sugiere que el cáncer de colon sea tratado con cirugía radical con escisión mesocólica completa. La extensión de la disección de los ganglios linfáticos durante la cirugía está determinada por los hallazgos clínicos pre-operatorios y la extensión de las metástasis linfáticas y en la profundidad de invasión del tumor observada intra-operatoriamente.	Se ajusta la recomendación para incluir el concepto de la guía japonesa. Así mismo, se incluirá la descripción de los abordajes D1, D2 y D3 acorde con esta misma guía.
---	---	---

En los pacientes candidatos para cirugía radical se sugiere escisión total del mesorrecto para los cánceres rectales. La escisión del mesorrecto debería ser total para los tumores de los tercios medio e inferior del recto, con cuidado de preservar los nervios autonómicos pélvicos siempre que ello sea posible sin comprometer la resección del tumor. Offer surgery to people with rectal cancer (cT1-T2, cN1-N2, M0, or cT3-T4, any cN, M0) who have a resectable tumour. (NICE 2019)	En los pacientes con cáncer de recto con un tumor resecable, se sugiere cirugía con escisión total del mesorrecto. La escisión del mesorrecto debería ser total para los tumores de los tercios medio e inferior del recto, con cuidado de preservar los nervios autonómicos pélvicos siempre que ello sea posible sin comprometer la resección del tumor.	Se ajusta para dejar explícito que la recomendación sólo aplica para cáncer de recto.
La quimiorradioterapia como terapia preoperatoria en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado estadios T3 y T4 es recomendada sobre el uso de radioterapia sola con fraccionamiento estándar, para mejorar tasas de respuesta tumoral y disminuir el riesgo de recurrencia local y regional. Offer preoperative radiotherapy or chemoradiotherapy to people with rectal cancer that is cT1-T2, cN1-N2, M0, or cT3-T4, any cN, M0. (NICE 2020)	En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento es la quimiorradioterapia como terapia preoperatoria en pacientes estadios T3 y T4, con cualquier N.	Se aclara que es la quimiorradioterapia neoadyuvante una de las opciones, pero no la única.
Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer colorrectal localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento: • 5-fluorouracilo infusional continuo o • 5-fluorouracilo/Leucovorina o • Capecitabina.	Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento: • 5-fluorouracilo infusional continuo o • 5-fluorouracilo/Leucovorina o • Capecitabina.	Especificación de que aplica sólo para Ca de recto

Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal estadio II de alto riesgo y en todos los estadios III para reducir el riesgo de recurrencia sistémica.	Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal estadio II de alto riesgo y en todos los estadios III para reducir el riesgo de recurrencia sistémica, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT).	Aclaración para especificar que la adyuvancia no aplica para los que entran en manejo con esquema TNT.
Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas.	Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)	Aclaración para especificar que la adyuvancia no aplica para los que entran en manejo con esquema TNT.
La elección del tratamiento adyuvante debería realizarse conjuntamente entre el paciente y los clínicos responsables del tratamiento. La decisión debe ser tomada posterior a una discusión informada entre los clínicos y el paciente; esta discusión debe tener en cuenta las contraindicaciones y el perfil de efectos secundarios del (los) agente(s) y el método de administración, como también el estado clínico y las preferencias del paciente.	La elección del tratamiento adyuvante debería realizarse a través de un enfoque multidisciplinario. La Junta Multidisciplinaria debe tener en cuenta las contraindicaciones y el perfil de efectos secundarios del (los) agente(s) y el método de administración, como también el estado clínico y las preferencias del paciente.	Modificar para dejar explícito que se trata de una Junta Multidisciplinaria.
Se recomienda radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal con tumor residual irresecable (márgenes positivos), según reporte de hallazgos anatomopatológicos del espécimen quirúrgico, o en pacientes con riesgo moderado o alto que no han recibido neoadyuvancia.	Se recomienda radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer rectal con tumor residual irresecable (márgenes positivos), según reporte de hallazgos anatomopatológicos del espécimen quirúrgico, o en pacientes con riesgo moderado o alto que no han recibido neoadyuvancia, si bien el mayor beneficio se obtiene con Radioterapia en neoadyuvancia.	Ajuste para dejar claridad de mayor beneficio en neoadyuvancia.

Los pacientes con cáncer colorrectal localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con quimiorradioterapia concomitante.	Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con quimiorradioterapia concomitante.	Claridad de que aplica para Ca de Recto.
Los pacientes con cáncer colorrectal localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con radioterapia de curso corto (hipofraccionada) en centros donde se pueda ofrecer radioterapia con acelerador lineal preferiblemente con técnica conformacional (IMRT).	Los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado irresecable con buen estado funcional que no hayan recibido tratamiento previo, pueden beneficiarse de tratamiento inicial con radioterapia de curso corto en centros donde se pueda ofrecer radioterapia con acelerador lineal con técnica conformacional (IMRT).	Claridad de que aplica para Ca de Recto y se restringe a uso de IMRT.

Del bloque de manejo metastásico

Si tanto el tumor primario como el metastásico son resecables, se sugiere que el equipo multidisciplinario considere tratamiento sistémico inicial seguido de cirugía, después de una discusión exhaustiva con el paciente. La decisión sobre si las cirugías se realizan al mismo tiempo o de manera separada, debería ser evaluada por el equipo multidisciplinario, en conjunto con el paciente. Consider resection, either simultaneous or sequential, after discussion by a multidisciplinary team with expertise in resection of disease in all involved sites. (NICE 2020)	Si tanto el tumor primario como el metastásico son resecables, se sugiere que el equipo multidisciplinario considere tratamiento sistémico inicial seguido de cirugía, después de una discusión exhaustiva con el paciente. La decisión sobre si las cirugías se realizan al mismo tiempo o de manera separada, debería ser evaluada por el equipo multidisciplinario, en conjunto con el paciente, considerando si se trata de un paciente oligometastásico o no.	Incluir que el equipo multidisciplinario debe evaluar si se trata de un caso con oligometástasis o no.
--	--	--

Se sugiere la citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), como una opción de tratamiento en pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a cáncer colorrectal, quienes cumplan todos los siguientes criterios: • Pacientes entre 18 y 70 años. • Sin comorbilidad de alto riesgo. • Con índice de carcinomatosis ≤ 17 en la presentación inicial, luego de la neoadyuvancia y en caso de una recidiva tardía. • Enfermedad confinada en el abdomen. • Menos de tres metástasis hepáticas fácilmente resecables. • Sin enfermedad retroperitoneal extensa. • ECOG (definir) menor de dos. • Sin oclusión intestinal.	En pacientes con cáncer de colon o de recto superior y medio, se sugiere la citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), como una opción de tratamiento en pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria al cáncer colorrectal, quienes cumplan todos los siguientes criterios: • Pacientes entre 18 y 70 años. • Sin comorbilidad de alto riesgo. • Con índice de carcinomatosis ≤ 17 en la presentación inicial, luego de la neoadyuvancia y en caso de una recidiva tardía. • Enfermedad confinada en el abdomen. • Menos de tres metástasis hepáticas fácilmente resecables. • Sin enfermedad retroperitoneal extensa. • ECOG < 2. • Sin oclusión intestinal.	Se especifica que aplica para todo Ca de colon y para Ca de recto superior y medio.
En pacientes con cáncer de colon estadio IV por carcinomatosis peritoneal que requieren cirugía de urgencia, y que son candidatos a citorreducción peritoneal más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), se sugiere realizar cirugía conservadora, tomar biopsia del peritoneo y de la lesión.	En pacientes con cáncer de colon estadio IV por carcinomatosis peritoneal que requieren cirugía de urgencia, se sugiere confirmar diagnóstico histopatológico, derivar, y posteriormente definir si es candidato o no a procedimiento de HIPEC.	Especificar que el contexto clínico habitualmente es, primero, manejar la urgencia, y segundo, determinar si es candidato para HIPEC.
Consider metastasectomy, ablation or stereotactic body radiation therapy for people with lung metastases that are suitable for local treatment, after discussion by a multidisciplinary team that includes a thoracic surgeon and a specialist in non-surgical ablation. (NICE 2020)	Se sugiere realizar metastasectomía o radiación corporal estereotáctica para pacientes con oligo-metástasis pulmonares que son susceptibles de manejo local. El caso debe ser discutido por el equipo multidisciplinario.	Traducción y ajuste a oligometástasis.

Se sugiere considerar la terapia oral con capecitabina como una opción para el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico. Oral therapy with capecitabine is recommended as an option for the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. (NICE 2020)	Se sugiere considerar la terapia oral con capecitabina o infusión de 5-FU como tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico.	Aclaración de equivalencia de eficacia entre capecitabina y 5-FU.
El uso de FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) no se recomienda como una opción quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico.	El uso de FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) se sugiere como una opción quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, en casos seleccionados.	Aclaración de que el esquema FOLFOXIRI ya tiene algunas indicaciones en 2ª línea.
La monoterapia con cetuximab o panitumumab se recomienda como una opción de tratamiento en segunda o tercera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con KRAS y NRAS nativos que han fallado a otros tratamientos previos.	La monoterapia con cetuximab o panitumumab se recomienda como una opción de tratamiento en tercera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con KRAS y NRAS nativos que han fallado a otros tratamientos previos.	Ajusta para sólo tercera línea.
En cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable) se sugiere realizar estudio de biología molecular para determinar mutación de KRAS, y en aquellos pacientes con resultado de KRAS nativo, determinar mutación de NRAS. Test for RAS and BRAF V600E mutations in all people with metastatic colorectal cancer suitable for SACT systemic anti-cancer therapy. (NICE 2020)	En cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable) se sugiere realizar estudio de biología molecular para determinar mutación de RAS y BRAF (RAS extendido).	Se cambia la secuencia de estudios genéticos (KRAS y luego NRAS) para uno sólo (RAS extendido)

Del bloque de seguimiento

Considere detener el seguimiento regular cuando el paciente y el médico tratante han discutido y acordado que los posibles beneficios no compensan los riesgos de nuevas pruebas o cuando el paciente no puede tolerar otros tratamientos.	Considere detener el seguimiento regular cuando el paciente y el médico tratante han discutido y acordado que los posibles beneficios no compensan los riesgos de nuevas pruebas o cuando el paciente no puede tolerar otros tratamientos, luego de 5 años desde la culminación de tratamiento primario.	Aclaración de considerar suspender o prologar intervalos de seguimiento luego de 5 años, no antes.
Se sugiere programar visita de seguimiento a todos los pacientes con cáncer colorrectal, 8 a 12 semanas después de haber terminado el tratamiento potencialmente curativo. Se sugiere realizar una visita de seguimiento que incluya exploración física y prueba de antígeno carcinoembrionario cada seis meses durante cinco años. (For all stages), who have undergone successful treatment (ie, no known residual disease), history and physical examination should be given every 3-6 months for 2 years, and then every 6 months for a total of 5 years. A CEA test is recommended at baseline and every 3 to 6 months for 2 years, then every 6 months for a total of 5 years. (NCCN 2020)	Luego de haber terminado el tratamiento potencialmente curativo, se sugiere programar visita de seguimiento a todos los pacientes con cáncer colorrectal que incluya exploración física y prueba de antígeno carcinoembrionario, en las siguientes frecuencias por periodo: • Año 1 y 2: cada 3-6 meses. • Año 3, 4 y 5: cada 6 meses.	Se especifica frecuencia de controles clínicos y con CEA.

Se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen cada año durante tres años. También se sugiere una tomografía computarizada pélvica con la misma frecuencia si el tumor primario se localizaba en el recto. Surveillance: Stage I disease: imaging is not routinely indicated and should only be based on symptoms and clinical concern for recurrent/metastatic disease: Stage II and III disease: Chest, abdomen and pelvis CT every 6-12 months for a total of 5 years. PET/CT is not indicated. Stage IV disease: Chest, abdomen and pelvis CT every 3-6 months x 2 years, then every 6-12 months for a total of 5 years (NCCN 2020)	En paciente con cáncer colorrectal con estadios II-III que se encuentran en seguimiento, se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen-pelvis cada año durante 5 años. En estadio IV, se sugiere toma de TAC cada 6 meses durante los primeros 2 años. Luego cada año hasta completar 5 años.	Se especifica frecuencia de controles de imágenes.
Se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen cada año durante tres años. También se sugiere una tomografía computarizada pélvica con la misma frecuencia si el tumor primario se localizaba en el recto. Surveillance in Rectal Cancer: Stage II, III and IV: MRI of the rectum every 3-6 months for 2 years, then every 6 months for a total of 5 years (for patients with transanal local excision only) (NCCN 2020)	En paciente con cáncer de recto estadios II, III y IV, se recomienda la toma de RMN cada 3-6 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta completar 5 años, únicamente en aquellos en que se les haya realizado una escisión local trans-anal.	Se especifica que la RMN aplica para aquellos que tuvieron un procedimiento de resección vía anal.

Si los recursos locales y/o las preferencias del paciente excluyen el uso de la tomografía axial computarizada, se sugiere sustituir con un ultrasonido la tomografía de abdomen y de pelvis y sustituir con una radiografía de tórax la tomografía de tórax. Una frecuencia razonable para estas pruebas es cada seis a doce meses durante los tres primeros años y luego anualmente durante el cuarto y quinto año de seguimiento.	En casos excepcionales y como última opción, si los recursos locales y/o las preferencias del paciente excluyen el uso de la tomografía axial computarizada, se sugiere sustituir con un ultrasonido la tomografía de abdomen y de pelvis y sustituir con una radiografía de tórax la tomografía de tórax.	Aclaración de se una medida de última opción, y que es muy excepcional.
Se sugiere realizar una colonoscopia de seguimiento aproximadamente un año después de la cirugía inicial. La frecuencia de las colonoscopias de vigilancia posteriores debería depender de los resultados de la anterior, pero por lo general se debería realizar cada cinco años si los resultados de la anterior colonoscopia son normales. Colonoscopy at 1 year after surgery: ·If advance adenoma, repeat in 1 y ·If no advance adenoma, repeat in 3 y, then every 5 y (NCCN 2020) Se sugiere realizar una colonoscopia	de seguimiento aproximadamente un año después de la cirugía inicial. La frecuencia de las colonoscopias de vigilancia posteriores debería depender de los resultados de la anterior, esto es, repetir al año si se evidenció adenoma avanzado, de lo contrario, repetir al 3er año, y después cada 5 años. Ajuste para especificar frecuencia	de seguimiento de la colonoscopia.
Los pacientes con cáncer colorrectal podrían beneficiarse de un programa de rehabilitación basado en actividad física cardiovascular que se encuentre dentro de un programa integral de manejo.	Los pacientes con cáncer colorrectal podrían beneficiarse de un programa de rehabilitación basado en actividad física cardiovascular y rehabilitación de piso pélvico (si aplica), que se encuentre dentro de un programa integral de manejo.	Adición de rehabilitación de piso pélvico en aquellos casos en los que se requiera.

En pacientes con cáncer colorrectal a quienes se haya realizado tratamiento con preservación de esfínter anal, se sugiere realizar valoración especializada por fisiatría para direccionar el proceso de rehabilitación. Así mismo, se sugiere la realización de ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico direccionados por terapeuta e idealmente a través de la realización de terapia biofeedback del piso pélvico como estrategia de rehabilitación para el manejo de incontinencia esfinteriana.

En pacientes con cáncer colorrectal a quienes se haya realizado tratamiento con preservación de esfínter anal, se sugiere realizar valoración especializada por fisiatría, o terapia de piso pélvico, para direccionar el proceso de rehabilitación. Así mismo, se sugiere la realización de ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico direccionados por terapeuta e idealmente a través de la realización de terapia biofeedback del piso pélvico como estrategia de rehabilitación para el manejo de incontinencia esfinteriana.

Ajuste para que no depende únicamente del concepto de fisiatría.

ANEXO 04.

RECOMENDACIONES NO VALIDAS PARA SER ADAPTADAS

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Proceso diagnóstico

RECOMENDACIÓN

Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar una biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico, a menos que esté contraindicado (por ejemplo, en pacientes con trastornos de coagulación sanguínea).

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Se pueden tomar Bx así el pcte tenga una coagulopatía o esté tomando antiagregantes o anticoagulantes. No es requisito INR o tiempos.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Proceso diagnóstico

RECOMENDACIÓN

Se sugiere una sigmoidoscopia flexible con enema de bario en pacientes con comorbilidad importante. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere realizar una biopsia a menos que esté contraindicado.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

La sigmoidoscopia es limitada. El enema de bario es limitada. Se podría preferir un TAC en caso de contraindicación de Colonoscopia.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Proceso diagnóstico

RECOMENDACIÓN

En los pacientes que han tenido una colonoscopia incompleta se sugiere repetir la colonoscopia o hacer colonografía por tomografía computarizada (si el servicio radiológico puede demostrar competencia en esta técnica) o enema de bario.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

En caso de tumor grande que limite el paso del colonoscopia, se puede complementar con TAC doble contraste.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Estratificación

RECOMENDACIÓN

Si la tomografía axial computarizada muestra únicamente enfermedad metastásica hepática y el paciente no tiene contraindicaciones para el tratamiento posterior, se sugiere que un especialista hepato-biliar decida si se requieren imágenes adicionales para confirmar si la cirugía es adecuada para el paciente o potencialmente adecuada después de un tratamiento.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Se considera que no es necesario que haya una valoración por hepato-biliar para determinar estudio de imágenes adicionales para definir la cx.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Diagnóstico histopatológico

RECOMENDACIÓN

Los programas de patología deberían tener una política sobre la metodología de las mediciones de tamaño de las lesiones removidas endoscópicamente, y deberían monitorizar regularmente la exactitud de las mismas. La desviación entre el tamaño real y las mediciones de los patólogos y endoscopistas debería ser minimizada.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Proceso de fijación puede hacer que el tamaño varíe. La NO concordancia de tamaño es remota. En lesiones pequeñas puede que si haya discrepancias en el tamaño.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Diagnóstico histopatológico

RECOMENDACIÓN

Las decisiones de tratamiento que dependen del tamaño de la lesión deberían tener en cuenta el potencial de imprecisión en la medición del tamaño. El equipo multidisciplinario debería considerar apartarse de las categorías de tamaño recomendadas en los algoritmos de tratamiento y vigilancia, si la revisión de un caso indica que hay suficiente razón para dudar de la exactitud de la medición. Tales casos deberían ser llevados a junta de expertos para la toma de decisiones.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

En cuanto a los polipos, la variabilidad de tamaño no es aplicable pues patología no ve el tamaño como lo ve el endoscopista.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Est. Temprano

RECOMENDACIÓN

Se debe utilizar la ultrasonografía endoscópica rectal durante la evaluación de las lesiones tempranas del recto, antes de la resección quirúrgica, con el fin de definir la invasión de la lesión y determinar la estrategia terapéutica indicada.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

La US ha entrado en desuso. La RMN marca la pauta. No en toda la ciudad hay endosonografos. Poca experiencia en Ca recto temprano.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Locamente avanzado

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

RECOMENDACIÓN

Cuando se requiere una escisión abdominoperineal del recto para cáncer de recto inferior que no pueda ser adecuadamente realizada con una escisión total del mesorrecto, se sugiere realizar la resección con la técnica extraelevadora.

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Hay ambigüedad en la redacción de la recomendación y se debe aclarar la acción a seguir

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastático

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

RECOMENDACIÓN

En pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastático o irresecable) con KRAS y NRAS nativos o no mutados, se sugiere la realización de estudio mutacional de BRAF para determinar terapia anti-EGFR, teniendo en cuenta su disponibilidad y de acuerdo con la decisión de una junta médica.

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Actualmente, RAS extendido.

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastático

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

RECOMENDACIÓN

Bevacizumab in combination with oxaliplatin and either fluorouracil plus folinic acid or capecitabine is not recommended for the treatment of metastatic colorectal cancer.

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

El Bevacizumab sí está recomendación en Ca metastático

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastático

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

RECOMENDACIÓN

Bevacizumab in combination with 5-FU 5-fluorouracil plus folinic acid, with or without irinotecan, is not recommended for the first-line treatment of metastatic colorectal cancer.

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

El Bevacizumab sí está recomendación en Ca metastático

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastásico

RECOMENDACIÓN

The My5-FU assay is only recommended for use in research for guiding dose adjustment in people having fluorouracil chemotherapy by continuous infusion. The My5-FU assay shows promise and the development of robust evidence is recommended to demonstrate its utility in clinical practice.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

No disponibilidad en Colombia

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastásico

RECOMENDACIÓN

Trifluridine–tipiracil is recommended, within its marketing authorisation, as an option for treating metastatic colorectal cancer, that is:

- * in adults who have had previous treatment with available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- or irinotecan-based chemotherapies, anti-vascular endothelial growth factor agents and anti-epidermal growth factor receptor agents, or when these therapies are not suitable, and
- * only when the company provides trifluridine–tipiracil with the discount agreed in the patient access scheme.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

No disponibilidad en Colombia

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastásico

RECOMENDACIÓN

Aflibercept in combination with irinotecan and fluorouracil-based therapy is not recommended within its marketing authorisation for treating metastatic colorectal cancer that is resistant to or has progressed after an oxaliplatin-containing regimen.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

No disponibilidad en Colombia

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastásico

RECOMENDACIÓN

People currently receiving aflibercept in combination with irinotecan and fluorouracil-based therapy for treating metastatic colorectal cancer that is resistant to or has progressed after an oxaliplatin-containing regimen should be able to continue treatment until they and their clinician consider it appropriate to stop.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?
NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

No disponibilidad en Colombia

NOMBRE DE LA GPC
COL MINSALUD 2017

BLOQUE TEMÁTICO
Metastásico

RECOMENDACIÓN

Do not offer selective internal radiation therapy (SIRT) as first-line treatment for people with colorectal liver metastases that are unsuitable for local treatment. For advice on SIRT in line with the NICE interventional procedures guidance, see managing liver metastases in the NICE Pathway on colorectal cancer. This recommends that SIRT should only be offered:

- * with special arrangements for clinical governance, consent, and audit or research to people who are chemotherapy intolerant or who have liver metastases that are refractory to chemotherapy
- * in the context of research to people who can have chemotherapy.

¿LA RECOMENDACIÓN SIGUE VIGENTE?

NO

Si la respuesta es NO:
¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Solo para investigación.

ANEXO 05. PROTOCOLO DE PATOLOGÍA

Protocolo para resecciones de carcinoma primario de colon y recto

Procedimiento:

Hemicolectomía derecha
Colectomía transversa
Hemicolectomía izquierda
Sigmoidectomía
Resección anterior baja
Colectomía abdominal total
Resección abdominoperineal
Escisión de disco transanal (escisión local)
Resección endoscópica de la mucosa
Otra (especificar):
No especificado

Sitio de tumor (seleccione todas las que aplique):

Ciego
Válvula ileocecal

Colon ascendente
Ángulo hepático
Colon transverso
Ángulo esplénico
Colon descendente
Colon sigmoide
Rectosigmoide
Recto
Colon, no especificado
No se puede determinar (explicar):

Ubicación del tumor (aplica solo a primarios de recto)

Completamente por encima de la reflexión peritoneal anterior
Completamente por debajo de la reflexión peritoneal anterior
Se extiende por encima y por debajo de la reflexión peritoneal anterior
No especificado

Tamaño tumoral:

La mayor dimensión (centímetros): ____ cm

+ Dimensiones adicionales (centímetros):

____ x ____ cm

No se puede determinar (explicar):

Perforación macroscópica del tumor:

No identificado

Presente

No puede ser determinado

Evaluación macroscópica del mesorrecto (requerido para cáncer de recto)

Completo

Casi completo

Incompleto

No puede ser determinado

Tipo histológico:

Adenocarcinoma

Adenocarcinoma mucinoso

Carcinoma de células en anillo de sello (carcinoma pobremente cohesivo)

Carcinoma medular

Adenocarcinoma serrado

Carcinoma micropapilar

Carcinoma adenoescamoso

Carcinoma indiferenciado

Carcinoma con componente sarcomatoide

Carcinoma neuroendocrino de células grandes

Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas

Neoplasia mixta neuroendocrina - no neuroendocrina (especificar componentes):

Otro tipo histológico no listado (especificar):

Carcinoma, no se puede determinar el tipo

Grado histológico:

G1: bien diferenciado

G2: moderadamente diferenciado

G3: pobremente diferenciado

G4: Indiferenciado

Otros (especificar)

GX: no se puede evaluar

No aplica

Extensión tumoral:

No hay evidencia de tumor primario

Sin invasión (displasia de alto grado)

El tumor invade la lámina propia / muscularis mucosa (carcinoma intramucoso)

El tumor invade la submucosa

El tumor invade la muscularis propia

El tumor invade a través de la muscularis propia en el tejido pericolicorectal

El tumor invade el peritoneo visceral (incluido el tumor continuo con superficie serosa a través del área de inflamación)

El tumor invade directamente las estructuras adyacentes (especifique:)

No se puede evaluar

Márgenes:

Nota: Use esta sección únicamente si todos los márgenes no están comprometidos y todos los márgenes se puedan evaluar.

+Todos los márgenes están libres de carcinoma invasivo, displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

+Márgenes examinados: proximal, distal, radial (circunferencial) o mesentérico, profundo, mucoso y otros.

+ Distancia del carcinoma invasivo desde el margen más cercano (milímetros o centímetros): ____ mm o ____ cm

+ Especifique el margen más cercano:

+Distancia del tumor desde el margen radial (circunferencial) (requerido solo para tumores rectales) (milímetros o centímetros):

____ mm o ____ cm

+ Distancia del tumor desde el margen distal (recomendado para tumores rectales) (milímetros o centímetros):

____ mm o ____ cm

Se requiere un informe de margen individual si hay márgenes involucrados o si no se puede evaluar la participación de márgenes

Solo para muestras de resección

Margen Proximal

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo, displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

+ Distancia del tumor desde el margen (milímetros o centímetros): ___ mm o ___ cm

Comprometido por carcinoma invasivo

Margen distal

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo, displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

+ Distancia del tumor desde el margen (milímetros o centímetros): ___ mm o ___ cm

Comprometido por carcinoma invasivo

Margen radial (circunferencial) o mesentérico

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo, displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

+ Distancia del tumor desde el margen (milímetros o centímetros): ___ mm o ___ cm

Comprometido por carcinoma invasivo (tumor presente 0-1 mm desde el margen)

Estado del tumor no invasivo en los márgenes

Compromiso por displasia de alto grado / carcinoma intramucoso

Especifique los márgenes:

Compromiso por displasia de bajo grado

Especifique los márgenes:

Otro (s) margen (es) (únicamente si aplica)

Especifique los márgenes:

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo

Comprometido por carcinoma invasivo

Solo para muestras de escisión de disco transanal

Margen profundo

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo

+ Distancia del tumor desde el margen (milímetros o centímetros): ___ mm o ___ cm

Comprometido por carcinoma invasivo

Margen de la mucosa

No se puede evaluar

Sin evidencia de carcinoma invasivo, displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

+ Distancia del carcinoma invasivo desde el margen mucoso más cercano (milímetros o centímetros):

___ mm o ___ cm

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

Sin evidencia de carcinoma invasivo

+ Distancia del carcinoma invasivo desde el margen mucoso más cercano (milímetros o centímetros):

___ mm o ___ cm

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

Implicado por:

+ Displasia de alto grado / carcinoma intramucoso

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

+ Displasia de bajo grado

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

___ Comprometido por carcinoma invasivo

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

Sin compromiso por displasia de alto grado / carcinoma intramucoso y displasia de bajo grado

O

Comprometido por:

Displasia de alto grado / carcinoma intramucoso

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

Displasia de bajo grado

+ Especifique la ubicación (por ejemplo, la posición en el reloj), si es posible:

Efecto del tratamiento:

No se conoce terapia prequirúrgica

Presente

+ Sin células cancerosas viables (respuesta completa, puntaje 0)

+ Células individuales o pequeños grupos de células cancerosas (respuesta casi completa, puntaje 1)

+ Cáncer residual con regresión tumoral evidente, pero más que células individuales o pequeños grupos de células cancerosas (respuesta parcial, puntaje 2)

Ausente

+ Cáncer residual extenso sin evidencia de regresión tumoral (pobre o sin respuesta, puntaje 3)

No puede ser determinado

Invasión linfovascular:

No identificado

Presente

+ ___ Invasión linfovascular de vasos pequeños

+ ___ Invasión de grandes vasos (venosos)

+ ___ Intramural

+ ___ Extramural

No puede ser determinado

Invasión perineural:

No identificado

Presente

No puede ser determinado

Budding tumoral:

Número de grupos tumorales en un área de 0.785 mm²:

+ ___ Puntaje bajo (0-4)

+ ___ Puntaje intermedio (5-9)

+ ___ Puntaje alto (10 o más)

+ ___ No se puede determinar

Tipo de pólipo en el que se origina el carcinoma invasivo:

Ninguno identificado

Adenoma tubular

Adenoma vellosa

Adenoma tubulovelloso

Adenoma serrado tradicional

Adenoma serrado sésil / pólipo serrado sésil

Pólipo hamartomatoso

Otro (especificar):

Depósitos tumorales:

No identificado

Presente

+Especifique el número de depósitos:

___ El número no se puede determinar (explique):

___ No puede ser determinado

Ganglios linfáticos regionales

No hay ganglios linfáticos enviados o encontrados

Número de ganglios linfáticos comprometidos

+El número no se puede determinar (explique): _____

Número de ganglios linfáticos examinados:

+El número no se puede determinar (explique): _____

Clasificación del estadio patológico (pTNM, AJCC 8th Edition)

pTNM

Hallazgos patológicos adicionales:

Ninguno identificado

Adenoma (s)

Colitis ulcerosa

Enfermedad de Crohn

Diverticulosis

Displasia que surge en la enfermedad
inflamatoria intestinal

Otro (especificar):

ANEXO 06.

REVISIÓN DE PARES EXTERNOS

Como parte del proceso de validación de calidad de la guía, la presente guía fue evaluada por pares externos expertos temáticos de manera independiente del grupo desarrollador multidisciplinario, con el fin de que brindaran aportes, comentarios y sugerencias respecto a las recomendaciones desarrolladas.

En una primera instancia, se realizó una asistencia técnica por parte de expertos

metodológicos del Instituto Nacional de Cancerología que, en el marco de su competencia, brindaron valiosos elementos para el ajuste de la estructura y contenido de la presente guía. Esta asistencia se realizó en cuatro reuniones realizadas entre noviembre de 2020 a enero de 2021.

La siguiente tabla muestra un resumen de las sugerencias dadas por el Instituto Nacional de Cancerología.

No. 1 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Se comenta que es importante y necesario aclarar que las recomendaciones no están basadas en la evidencia, teniendo en cuenta que el hizo modificaciones al proceso de elaboración de guías tal y como está establecido en los manuales metodológicos. Por ello, se debe hablar de recomendaciones clínicas y de guía de manejo.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aclaración de términos	Alcance	Incluida

No. 2 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Se debe aclarar que las recomendaciones no incluyeron aspectos de tamización, manejo de complicaciones relacionadas con el tratamiento, ni aspectos de rehabilitación. Por tanto, no se debe hablar de manejo integral.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aclaración de términos	Alcance	Incluida

No. 3 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Se sugiere modificar los verbos hacia “elaborar”, “formular” o similares ya que no se trata de establecer un proceso o modelo de atención sino de emitir recomendaciones.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aclaración de términos	Objetivos	Incluida

No. 4 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Incluir los médicos en formación de primera y segunda especialidad.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Población objetivo	Incluida

No. 5 Institución a la que representa
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Aclarar el rol de los representantes de las EAPB. Si bien se describe en el apartado de Plan de Implementación, es importante que desde el inicio del documento cuál y cómo fue su participación.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aclaración de términos	Metodología	Incluida

No. 6 Institución a la que representa
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Se recomienda que se hagan modificaciones en el apartado de metodología con el fin de aclarar que no hubo una revisión sistemática inicial para la selección de guías, que el proceso de elaboración de las recomendaciones fue una evaluación de valides y contextualización, y que lo anterior no fue llevado a cabo por un consenso formal.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

Adicionalmente, el día 17 de febrero de 2021 se hizo una consulta a profesionales locales especialistas en el campo de la oncología, así como con cinco EAPB, con el fin de que se realizara una revisión de las recomendaciones clínicas, así como comentarios, sugerencias o críticas, en el marco de su conocimiento, alcance y participación dentro del sistema de salud. Se dio un plazo de 4 semanas para tal fin. Los profesionales consultados fueron:

Especialidad o proceso que representa	Número de profesionales consultados
Enfermería	2
Físico Medico	2
Gestión de riesgo de Cáncer EAPB Comfenalco	1
Gestión de riesgo de Cáncer EAPB Coomeva	1
Gestión de riesgo de Cáncer EAPB Emssanar	1
Gestión de riesgo de Cáncer EAPB Nueva EPS	1
Gestión de riesgo de Cáncer EAPB SOS	1
Hemato-Oncólogo - Jefe de investigaciones	1
Hemato-Oncólogo Jefe de servicio de una IPS	1
Medicina Nuclear	2
Medico Anestesiología Paliativista	1
Patología	5
Radiólogo	1
Radiólogo en fundación Valle del Lili	1

Al cabo de este tiempo, no se recibieron comentarios dirigidos a modificar, adicionar o retirar apartados de la guía de manejo, ni tampoco críticas negativas.

ANEXO 07. REVISIÓN DE PARES EXTERNOS INTERNACIONALES

En el marco de los manuales metodológicos utilizados como referentes para el desarrollo de la presente guía (31,33), también se realizó una consulta con expertos clínicos internacionales con el propósito de realizar una revisión desde su perspectiva como expertos, así como desde su conocimiento de la patología en el ámbito internacional.

Gracias al apoyo brindado por City Cancer Challenge Foundation, se logró contar con la participación de los siguientes expertos internacionales:

- Eloy Espín, surgery - Val'd Hebron (Barcelona, España)
- Francisca Redondo, radiotherapy - Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez (Chile).
- Higinia Cárdenas, radiotherapy - Weill Cornell Medical College (EUA)

- Luz Esperanza Ayala, nursing - International Society of Nursing in Cancer Care

- Mike Cusnir, systemic treatment) - Mount Sinai, (Miami, EUA)

- Paola Ruiz, supportive and palliative care – Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos ALCP

- Pepe Jessurun, pathology – Cornell (EUA)

La siguiente tabla muestra un resumen de las opiniones manifestadas por los pares externos internacionales durante el periodo Abril – Mayo del año 2021, las cuales se han organizado de acuerdo con los apartados de la presente guía, y fueron recopilados de los comentarios y escritos que los expertos realizaron sobre el manuscrito en una versión preliminar (versión marzo de 2021):

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

INTRODUCCIÓN

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

21

Opinión

Suena extremadamente bajo, varios factores pueden influir que el numero este subestimado

Párrafo / Recomendación

Desde la perspectiva económica en salud, el manejo del cáncer conlleva una carga económica importante (20). Por ejemplo, el costo promedio de un caso de cáncer de colon en estadio I es de \$5,099,760, para el estadio II-IIC es de \$17,165,865, para el estadio III es de \$51,348,984, y para el estadio IV de \$76,418,512 (valores monetarios del 2013).

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

INTRODUCCIÓN

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

21

Opinión

Suena extremadamente bajo, varios factores pueden influir que el numero este subestimado

Párrafo / Recomendación

Desde la perspectiva económica en salud, el manejo del cáncer conlleva una carga económica importante (20). Por ejemplo, el costo promedio de un caso de cáncer de colon en estadio I es de \$5,099,760, para el estadio II-IIC es de \$17,165,865, para el estadio III es de \$51,348,984, y para el estadio IV de \$76,418,512 (valores monetarios del 2013).

Categoría de la opinión

Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

METODOLOGÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

24

Opinión

Se debería incluir recomendaciones de screening en la población de alto riesgo (definir en el contexto de Cali) ¿ - imagino q esto es parte de Tamización?

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

METODOLOGÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

37

Opinión

Hacer comentario con respecto a estadiaje, en caso de diagnostico avanzado

Párrafo / Recomendación

¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico en individuos con sospecha de cáncer colorrectal?

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

METODOLOGÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

34

Opinión

No se comenta nada de prevención o tamizaje?

Párrafo / Recomendación

Preguntas del bloque de diagnóstico :

Categoría de la opinión

Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES: Diagnóstico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

37

Opinión

Entiendo que la guía clínica debe tener la evidencia, pero hay puntos que no tienen evidencia porque son “evidentes”. Creo que esta es una de ellas y que quizás una solución sería añadir en alguna de ellas un comentario de “Opinion de expertos, o opinión del grupo de revisión” (o como se quiera señalar, en la que se señalen comentarios. Por ejemplo en esta yo pondría:

Aunque la evidencia es baja, ningún paciente debería tratarse de forma electiva de neoplasia de colon o recto sin un estudio endoscópico previo a menos que esté contraindicado por alguna razón. Es importante completar el estudio con una biopsia de la lesión.

Párrafo / Recomendación

Para confirmar un diagnóstico de cáncer colorrectal se sugiere colonoscopia en pacientes sin mayor comorbilidad

Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico.

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES: Diagnóstico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

37

Opinión

Alternativa sugerida:

La colonografía por tomografía computarizada puede ser utilizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible, siempre y cuando las IPS cuenten con personal entrenado y capacitado para la realización e interpretación de Colonografías por TC. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se debe ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado.

Párrafo / Recomendación

Se sugiere una colonografía por tomografía computarizada como alternativa a la colonoscopia o a la sigmoidoscopia flexible con enema de bario, siempre y cuando las IPS cuenta con personal entrenado y capacitado para la realización e interpretación de Colonografías por TC. Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada en la colonografía por tomografía computarizada, se sugiere ofrecer una colonoscopia con biopsia para confirmar el diagnóstico, a menos que esté contraindicado

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

46

Opinión

Se refiere a cuando se realiza una colectomía de urgencias en un paciente en el que no se disponía de diagnóstico de cáncer colo-rectal antes de la cirugía?

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar una colonoscopia completa dentro de los 3 a 6 meses posteriores a la colectomía, en aquellos casos en que no se logró visualización del colon antes de la cirugía.

Categoría de la opinión

Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

40

Opinión

- *Recomendaría que esta sección se reorganizara de forma que sea mas fluida*
 - o Experiencia del Endoscopista*
 - o Preparación del Paciente*
 - § Preparación intestinal*
 - § Evaluación para Anestesia*
 - § Tiempo de ayunas...*
 - o Tipo de Anestesia y monitorización durante el procedimiento*
 - o Calidad de colonoscopia*
 - § Información que se debe obtener: pólipos, lesiones sospechosas...Incluyendo localización, tamaño, características*
 - § Obtener fotografías*
 - § Procesos añadidos: resección endoscópica de pólipos y localización – aspecto de los mismos*
 - o Monitorización después del procedimiento:*
 - § Tipo y duración*
 - § Instrucciones a la hora de ser dado de alta*
 - o Documento final de la colonoscopia: Sería apropiado diseñar un Template en el que se documente todo lo anterior*

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión

Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

118

Opinión

se han indicado en algún lugar de las guías como se recomienda que se haga y se reporten los hallazgos de la MRI ?

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realización de RMN de pelvis para valorar el estado del margen mesorrectal.

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES: Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
47

Opinión

Cual es el papel del PET/CT en esta situación?

Párrafo / Recomendación

Se recomienda las siguientes consideraciones para estadificar con TAC de tórax y abdomen (o RMN):

- Evaluar la extensión local del tumor o infiltración a estructuras adyacentes.
- Evaluar la presencia de metástasis distantes en pulmón, nódulos linfáticos del tórax y abdomen, hígado, cavidad peritoneal, y otros órganos.
- La realización del TAC debe ser con contraste oral e intravenoso.
- Considerar RMN con gadolinio en caso de alergia o contraindicación a los medios de contraste yodados.
- Tomar las precauciones necesarias para pacientes con Enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 sin diálisis.
- En caso de que haya contraindicación tanto para medio yodados como agentes basados en gadolinio, considere realizar RMN sin contraste IV.

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES: Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
44

Opinión

Para el estadije, en falta de TAC creo que es mas recomendable la realización de Rad de Torax y ecografía abdominal. La RNM de abdomen solo si hay lesiones abdominales en la ecografía.

Párrafo / Recomendación

Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES: Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
45

Opinión

O ecografía para dsepistaje de metastasis

Párrafo / Recomendación

En caso de que haya contraindicación tanto para medio yodados como agentes basados en gadolinio, considere realizar RMN sin contraste IV .

Categoría de la opinión

Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
45

Opinión

En los casos de lesiones tempranas se debe recomendar realizar tanto RNM como ultrasonografía. El TAC no tiene fiabilidad para determinar el estadiaje local del cáncer de recto.

Párrafo / Recomendación

Se sugiere ultrasonografía endorrectal a los pacientes con cáncer de recto si la resonancia magnética está contraindicada (por ejemplo, uso de marcapasos) y se sospecha de un tumor en estadio temprano. De lo contrario, y ante la contraindicación de RMN, se sugiere realización de TAC.

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
46

Opinión

Ecografía endorrectal. No el TAC

Párrafo / Recomendación

Se sugiere ofrecer estadiaje local preoperatorio por medio de resonancia magnética de pelvis a los pacientes con cáncer de recto detectado por tamización, aunque también la tomografía computarizada multicorte contrastada de alta calidad puede dar información adecuada.

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
47

Opinión

La RNM de hgado como despistaje a nivel nacional es excesivo. Si no se puede realizar el TAC recomendaría una ecografía, en caso de que la ecografía detecte lesiones, entonces realizar la RNM

Párrafo / Recomendación

Se sugiere ofrecer RMN o TAC de abdomen en lugar de ecografía para la detección de metástasis hepáticas.

Si se evidencien lesiones inespecíficas en el TAC, se sugiere realizar RMN de abdomen.

Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Estratificación</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 47	Opinión <i>Se puede considerar MRI con Gadavist en pacientes con enfermedad renal crónica – menos riesgo de Necrosis tubular aguda – Confirmen con sus radiólogos que esta disponible</i> Párrafo / Recomendación <i>Se recomienda las siguientes consideraciones para estadificar con TAC de tórax y abdomen (o RMN):</i> • <i>Evaluar la extensión local del tumor o infiltración a estructuras adyacentes.</i> • <i>Evaluar la presencia de metástasis distantes en pulmón, nódulos linfáticos del tórax y abdomen, hígado, cavidad peritoneal, y otros órganos.</i> • <i>La realización del TAC debe ser con contraste oral e intravenoso.</i> • <i>Considerar RMN con gadolinio en caso de alergia o contraindicación a los medios de contraste yodados.</i> • <i>Tomar las precauciones necesarias para pacientes con Enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 sin diálisis.</i> • <i>En caso de que haya contraindicación tanto para medio yodados como agentes basados en gadolinio, considere realizar RMN sin contraste IV. Cual es el papel del PET/CT en esta situación?</i>
Categoría de la opinión <i>Aporte</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Estratificación</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 48	Opinión <i>Comentario con respecto a biopsia (de posible metatasis)confirmatoria si la información es equivocada con respecto a enfermedad metastasica,</i> Párrafo / Recomendación <i>n/a</i>
Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Estratificación</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 47	Opinión <i>No hay ninguna evidencia para estadio I</i> Párrafo / Recomendación <i>No se sugiere el uso rutinario de la tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico o estadiaje clínico del cáncer colorrectal en los estadios I a III.</i>

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

44

Opinión

Torax es controversial excepto en recto, hay distinta evidencia para torax que para abdomen y pelvis

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax , abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

42

Opinión

NCCN 2021

En pacientes siendo etapificados por cáncer de colon o recto, se recomienda el uso de PET/CT con 18F-FDG en las siguientes circunstancias:

- Hallazgos equívocos > 1 cm en CT o MR, o en pacientes con contraindicación de uso de contrastes yodado y gadolinio
- Pacientes M1 con lesión/es secundaria/s potencialmente resecable/s
- Pacientes seleccionados para terapias hepáticas dirigidas por imágenes (ablaciones)

Párrafo / Recomendación

Si la TAC muestra que el paciente puede presentar metástasis extra-hepáticas que sean susceptibles de cirugía radical, se sugiere que un equipo multidisciplinario decida si una tomografía por emisión de positrones- tomografía computarizada (PET-CT) de cuerpo completo es adecuada.

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

41

Opinión

Con contraste oral y yodado endovenoso

Párrafo / Recomendación

Se sugiere ultrasonografía endorrectal a los pacientes con cáncer de recto si la resonancia magnética está contraindicada (por ejemplo, uso de marcapasos) y se sospecha de un tumor en estadio temprano. De lo contrario, y ante la contraindicación de RMN, se sugiere realización de TAC .

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

40

Opinión

Categoría de evidencia NCCN 2A

Párrafo / Recomendación

Consenso de expertos

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

40

Opinión

Con gadolinio

Párrafo / Recomendación

Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

40

Opinión

Por antecedente de reacción alérgica al medio de contraste yodado endovenoso

Párrafo / Recomendación

Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Estratificación

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

40

Opinión

Contraste oral y yodado endovenoso

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar tomografía computarizada con contraste de tórax, abdomen y pelvis para estimar el estadio de la enfermedad a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de colon a menos que esté contraindicado. Ninguna imagen rutinaria adicional es necesaria para los pacientes con cáncer de colon.

Categoría de la opinión

Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico patológico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

54

Opinión

Sugeriría que en algún momento de la discusión de tratamiento se diera una clara definición de que se considera cáncer colon y recto. Hay que tener en cuenta que la re-flexión peritoneal anterior y posterior se localizan a diferente nivel y también varía entre hombres y mujeres Quizás un diagrama de localización anatómica, así como por CT y MRI serían de gran ayuda.

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión

Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico patológico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

51

Opinión

Sería importante disponer de un Template que incluya todos los aspectos del Informe de Anatomía Patológica que se consideran relevantes a la hora de tomar decisiones terapéuticas tales como necesidad de cirugía adicional, tratamiento adyuvante ... El colegio de Patólogos, así como NCCN guidelines ofrece tal información y sería bueno añadirla a las Guías

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión

Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico patológico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

125

Opinión

Todos los tumores deben ser evaluados para la detección de inestabilidad microsatelital a través de inmunohistoquímica. Esto puede hacerse en material de biopsia o en la resección quirúrgica. En tumores avanzados o metastásicos, es conveniente realizar estudios moleculares para la detección de mutaciones en oncogenes, sobre todo KRAS, ya que esta información se utiliza para el diseño del plan terapéutico.

Párrafo / Recomendación

Se adopta el protocolo del Colegio Americano de Patología

Categoría de la opinión

Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico patológico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)

122

Opinión

Por convención, no se mide sino que se estima si invade el tercio cercano a la muscular de la mucosa SM1, dos tercios SM2 o la totalidad del espesor de la submucosa SM3

Párrafo / Recomendación

Dadas las pequeñas dimensiones de la capa submucosa, la infiltración dentro del nivel de la submucosa se sugiere medir en milímetros o en micras desde la línea de fondo de la muscularis mucosae.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
121

Opinión

La medición, aunque recomendable en las resecciones endoscópicas, es relativamente irrelevante y nunca las hacemos.

Párrafo / Recomendación

Se sugiere que el patólogo mida cuidadosamente el tamaño de las lesiones al milímetro más próximo en la lámina de hematoxilina y eosina, o en el espécimen fijado cuando la mayor dimensión de la lesión no puede ser medida en la lámina. Las mediciones de endoscopia son menos precisas y solo deberían utilizarse cuando sea estrictamente necesario; por ejemplo, si la lesión está fragmentada.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
121

Opinión

Nuevamente, esto se puede realizar únicamente en resecciones endoscópicas cuando existe evidencia de invasión submucosa. Debe de incluir, además de la evaluación de los márgenes quirúrgicos, grado de diferenciación del tumor, invasión vascular, presencia de gemación ("budding"), y, para los pólipos sésiles, profundidad de la invasión a la submucosa (SM1, SM2 o SM3).

Párrafo / Recomendación

Se sugiere reportar las características de alto riesgo para enfermedad residual de acuerdo con el Protocolo de resección establecido por el Colegio Americano de Patólogos.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
121

Opinión

La evaluación de la remoción completa no se puede hacer en especímenes de biopsia. Este párrafo debe ser modificado para especificar que la evaluación de los márgenes quirúrgicos e invasión de la submucosa solo es factible en especímenes de polipectomía o mucosectomías endoscópicas.

Párrafo / Recomendación

Se sugiere que el patólogo verifique la remoción completa de las lesiones neoplásicas (márgenes libres) y la ausencia de invasión de la submucosa en especímenes de biopsias, de acuerdo con la orientación dada por el endoscopista. Si hay resección fragmentada, no se puede describir márgenes.

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
50

Opinión

Se debería sugerir el estudio completo del colon antes de la intervención. Es decir, en las lesiones estenosantes distales a angulo esplénico se debería completar el estudio con colonografía virtual antes de la intervención

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
120

Opinión

Este párrafo en realidad no comunica nada importante. Sugiero sea eliminado.

Párrafo / Recomendación

Debido a que la variabilidad de las displasias es grande, la concordancia no es buena y depende de la experiencia y especialización el profesional de patología gastrointestinal, se sugiere que se realicen acuerdos conceptuales entre patólogos y cirujanos oncólogos para determinar cuál clasificación se va a utilizar por parte de la institución, para así asegurar una comunicación constante y la comparación de la histopatología de biopsias y especímenes de resección

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Diagnóstico
patológico

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
49

Opinión

Cambiaría a vigente, no se que tan frecuente se va a revisar la guía

Párrafo / Recomendación

Se sugiere reportar los adenocarcinomas colorrectales de acuerdo con la clasificación TNM establecida la 8ª edición y al protocolo del College of American Pathologist, al momento del diagnóstico.

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Gnal Tratamiento

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
128

Opinión

Esta recomendación se refiere al uso de stent en pacientes con cáncer de colon resecable, la evidencia mencionada en la pregunta anterior hace referencia a esta recomendación

Párrafo / Recomendación

Para pacientes con cáncer de colon resecable que esté causando obstrucción manifiesta, se puede considerar como opción la inserción de un stent (en pacientes seleccionados) seguido de colectomía. Los stent colónicos están reservados generalmente para aquellos casos con lesiones distales en las cuales el stent puede permitir la descompresión del colon proximal con posterior colectomía electiva con anastomosis primaria.

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Gnal Tratamiento

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
52

Opinión

Esta recomendación no responde la pregunta de manejo quirúrgico... se refiere a no uso de estudios de contraste con enema.

Párrafo / Recomendación

No se sugiere utilizar estudios de contraste con enema como la única modalidad de imagen en pacientes con obstrucción aguda del intestino grueso.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Gnal Tratamiento

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
52

Opinión

Se debería utilizar en su lugar una TAC abdominal

Párrafo / Recomendación

No se sugiere utilizar estudios de contraste con enema como la única modalidad de imagen en pacientes con obstrucción aguda del intestino grueso.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx in situ

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
54

Opinión

En pacientes con cáncer de recto, con lesión estadio 0 o T1 sm1 (hasta tercio superficial de la submucosa) no susceptibles de resección local endoscópica, se sugiere realizar resección local transanal si la lesión es cercana al ano (subrayado para eliminación) Dicha resección local debe realizarse por medio de TEM, TEO o TAMIS. Los resultados oncológicos de la resección transanal clásica frente a TEM, TAMIS y TEO son inferiores.

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer de recto, con lesión estadio 0 o T1 sm1 (hasta tercio superficial de la submucosa) no susceptibles de resección local endoscópica, se sugiere realizar resección local transanal si la lesión es cercana al ano.

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx in situ

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
54

Opinión

Esto es altamente debatible.

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer de colon, con lesiones más grandes (2 a 3 centímetros), altamente sospechosas de ser estadio 0 (tumor in situ) y que no sean susceptibles de polipectomía o resección local, se sugiere realizar resección segmentada.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
60

Opinión

A estos pacientes se les debe ofrecer tratamiento neoadyuvante y non-operativo management (W&W)

Párrafo / Recomendación

Con una anastomosis rectal baja (menor de 5 cm de la unión anorrectal) se recomienda realizar un estoma desfuncionalizante.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
60

Opinión

Consideración de tratamiento neoadyuvante en pacientes con cancer de recto 1/3 inferior si se desea preservación de esfínteres

Párrafo / Recomendación

En los pacientes con cáncer de recto con un tumor resecable, se sugiere cirugía con escisión total del mesorrecto. La escisión del mesorrecto debería ser total para los tumores de los tercios medio e inferior del recto, con cuidado de preservar los nervios autonómicos pélvicos siempre que ello sea posible sin comprometer la resección del tumor.

Categoría
de la opinión
Aclaración de
términos

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:

Mx temprano

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
59

Opinión

Hay alguna limitación en lo que se refiere a la distancia del margen anal (aspecto mas proximal del tumor)?

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucosectomía o disección endoscopia submucosa) abierta o con técnicas endoscópicas, en pacientes con cáncer de recto que tengan las siguientes características:

1. Tumores que comprometan hasta T1 sm2
2. Tumores bien o moderadamente diferenciados
3. Tumores no ulcerados
4. Tumores menores de 3 centímetros
5. Con viabilidad técnica para su realización
6. Que levante a la infiltración

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
57

Opinión

Consideración para comentario de lesiones de 2-5 cm

Párrafo / Recomendación

Con una anastomosis rectal baja (menor de 5 cm de la unión anorrectal) se recomienda realizar un estoma desfuncionalizante.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
57

Opinión

Esto, según los últimos estudios NO es así. La línea actual es realizar anastomosis Termino-terminal

Párrafo / Recomendación

Con una anastomosis rectal baja después de una escisión total del mesorrecto (TME), se sugiere considerar un reservorio colónico .

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
57

Opinión

Creo que solo debería recomendarse cirugía radical en estos casos si hay ausencia de afectación ganglionar. La QRT solo cuando sean estadios mas avanzados

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer de recto que fueron llevados a resección local, con hallazgos patológicos como márgenes no claros e invasión del tercio profundo de la submucosa (T1/sm3) o más profundo (T2), mala diferenciación, o invasión linfoscavular o perineural, se sugiere realizar resección radical, quimiorradioterapia o ambas.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
56

Opinión

Abierta no. Solo TEM, TAMIS, TEO o endoscópicas

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar resección local (polipectomía, mucossectomía o disección endoscopia submucosa) abierta o con técnicas endoscópicas, en pacientes con cáncer de recto que tengan las siguientes características:

1. Tumores que comprometan hasta T1 sm2
2. Tumores bien o moderadamente diferenciados
3. Tumores no ulcerados
4. Tumores menores de 3 centímetros
5. Con viabilidad técnica para su realización
6. Que levante a la infiltración

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx temprano

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
55

Opinión

TODOS los pacientes diagnosticados de cáncer de colon o recto deben ser presentados en el Comité Multidisciplinario antes de ser tratados.

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer de colon estadio 0-I, con indicación de cirugía radical pero con baja expectativa de vida o alto riesgo quirúrgico, se sugiere llevar caso a Junta Multidisciplinaria e individualizar cada caso para determinar balance beneficio/riesgo entre la intervención quirúrgica y dejar en observación.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
68

Opinión

para ser consistente hay que definir que se considera localmente avanzado como en la recomendación anterior siguiente: T1-T3 cualquier N (se recomienda en la actualidad añadir "con margen radial circunferencial negativo por MRI)

Párrafo / Recomendación

En paciente con cáncer de recto con T3 o T4, con cualquier N, una opción apropiada es ofrecer un curso corto de Radioterapia (25 Gy en 5 fracciones) seguida por 12-16 semanas de quimioterapia con FOLFOX o CAPEOX.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente
avanzado

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
68

Opinión

para ser consistente hay que definir que se considera localmente avanzado como en la recomendación siguiente: T1-T3 cualquier N (se recomienda en la actualidad añadir "con margen radial circunferencial negativo por MRI

Párrafo / Recomendación

En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento consiste en un curso corto de Radioterapia, el cual brinda un control local de la enfermedad con un impacto similar en la supervivencia global en comparación con el esquema convencional.

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente
avanzado

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
67

Opinión

Quizás lo han indicado pero no lo veo: Hay que tener una sección en papel de la radioterapia en Tratamiento Adyuvante en Cancer the recto, completamente resecado (sin tumor grosero residual – R0 resection) T3, T4, N(+), postive margins

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente
avanzado

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
67

Opinión

Quizás lo han indicado pero no lo veo: Hay que tener una sección en papel de la radioterapia en Tratamiento Adyuvante en Cancer the recto, completamente resecado (sin tumor grosero residual – R0 resection) T3, T4, N(+), postive margins

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente
avanzado

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
66

Opinión

Esta recomendación esta ya indicada en le sección previa – a no ser que quieran repetirla para el recto solo, en cuyo caso la sección previa se debería referir a Cancer de Colon (en lugar de Colorectal)

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
66

Opinión

Esta recomendación esta ya indicada en le sección previa – a no ser que quieran repetirla para el recto solo, en cuyo caso la sección previa se debería referir a Cancer de Colon (en lugar de Colorectal)

Párrafo / Recomendación

Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
65

Opinión

En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento es la quimiorradioterapia como terapia preoperatoria en pacientes estadios T3 y T4 (cualquier N), o (cualquier T) N (+) con cualquier N.

Párrafo / Recomendación

En paciente con cáncer de recto localmente avanzado, una alternativa de tratamiento es la quimiorradioterapia como terapia preoperatoria en pacientes estadios T3 y T4 con cualquier N.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
63

Opinión

necesita definición de bajo y alto riesgo

Párrafo / Recomendación

Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
63

Opinión

Habría que diferenciar entre estadio II de alto y bajo riesgo: ambos tienen que ser claramente definidos con el objeto de hacer recomendaciones de tratamient sistémico adyuvante

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar quimioterapia adyuvante posterior a cirugía en pacientes con cáncer de colon estadio II de alto riesgo. Se deberían discutir todos los riesgos y beneficios con el paciente

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
64

Opinión

Hacer comentario con respecto a selección de estudio RNM or Endosonograma

Párrafo / Recomendación

Se recomienda que, luego de aplicar el curso corto de radioterapia y las 12-16 semanas de quimioterapia, se realice una re-estadificación del paciente antes del tratamiento quirúrgico. La resección debe realizarse luego de 5-12 semanas de haberse completado la terapia neoadyuvante .

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
61

Opinión

No hay comentario con respecto a uso de radiación en adyuvancia en caso que no se haya dado en neoadyuvancia

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
140

Opinión

Sugiero separar las recomendaciones en tres subgrupos: Recomendaciones de uso de tratamiento común para los dos tipos de cáncer (colorrectal) otro que se refiere al tratamiento que solo está indicado en cáncer de colon y otro para cáncer de recto. Así se evita repetir recomendaciones en dos secciones distintas y queda más claro.

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión

RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
63

Opinión

Igual comentario que los anteriores

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer colorrectal estadio III, el uso de capecitabina en combinación con oxaliplatino como terapia adyuvante, puede considerarse como una alternativa al 5-fluorouracilo más oxaliplatino

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
62

Opinión

Idéntica a la recomendación en la parte de cáncer de colon

Párrafo / Recomendación

Se sugiere el uso de monoterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo/folinato de calcio (Leucovorina) solo en pacientes con cáncer colorrectal estadio III, en quienes están contraindicados los regímenes basados en oxaliplatino.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
62

Opinión

Idéntica a la de cáncer de colon

Párrafo / Recomendación

Para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer colorrectal estadio III posterior a cirugía para esta condición, se sugiere el uso de oxaliplatino en combinación con 5-fluorouracilo y ácido folínico, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
62

Opinión

Estas recomendaciones son idénticas a las que se formulan en relación con cáncer de colon. Si se refieren a cáncer colorrectal, se justifica repetirlas en los dos tipos de cáncer?

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo, se sugiere considerar el uso de capecitabina como alternativa al 5-fluorouracilo en terapia adyuvante, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
59

Opinión

Discutible. Debería recomendarse si hay ganglios afectados, en tercio distal o por afectación de margen radial. En T3 sin afectación de margen radial NO esta claro.

Párrafo / Recomendación

Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento:

- 5-fluorouracilo infusional continuo o
- 5-fluorouracilo/Leucovorina o
- Capecitabina

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
62

Opinión

Esta recomendación es idéntica a la que se presenta en la página 60, en el título de Enfoque convencional de Cáncer de colon. Pueden hacerse recomendaciones conjuntas para cáncer de colon y recto, cuando aplican a los dos tipos de cáncer

Párrafo / Recomendación

Los pacientes con cáncer colorrectal estadio II de alto riesgo se benefician de la quimioterapia adyuvante con 5-fluorouracilo/folinato de calcio (leucovorina) para disminuir el riesgo de recaídas, si se ha escogido el enfoque convencional (diferente al esquema TNT)

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
58

Opinión

La recomendación está ubicada en el título de cáncer de colon, pero hace referencia a cáncer de recto

Párrafo / Recomendación

Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento:

- 5-fluorouracilo infusional continuo o
- 5-fluorouracilo/Leucovorina o
- Capecitabina.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx localmente avanzado

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
58

Opinión

La recomendación está ubicada en el título de cáncer de colon, pero hace referencia a cáncer de recto

Párrafo / Recomendación

Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento:

- 5-fluorouracilo infusional continuo o
- 5-fluorouracilo/Leucovorina o
- Capecitabina.

Categoría de la opinión <i>Aporte</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Mx metastásico</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 75	Opinión <i>Tenemos hora nivel I evidencia en el uso de IT (Pembrolizumab en el manejo de cancer de colon metastásico MMRd - KEYNOTE-177</i> Párrafo / Recomendación <i>n/a</i>
Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Mx metastásico</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 70	Opinión <i>Estadio II también debería tener MSI</i> Párrafo / Recomendación <i>Se sugiere la determinación rutinaria de la inestabilidad microsatelital como estudio molecular predictor de respuesta en pacientes con cáncer colorrectal avanzado (metastásico o irresecable).</i>
Categoría de la opinión <i>Aclaración de términos</i>RECO- Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Mx metastásico</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 68	Opinión <i>Después de adyucancia?</i> Párrafo / Recomendación <i>El uso de FOLFOXIRI (ácido folínico más fluoracilo más oxaliplatino más irinotecan) se sugiere como una opción quimioterapéutica en segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, en casos seleccionados.</i>
Categoría de la opinión <i>Edición</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión RECOMENDACIONES: <i>Mx metastásico</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 68	Opinión <i>Agregar para pacientes que no son candidatos a combinacion</i> Párrafo / Recomendación <i>Se sugiere considerar la terapia oral con capecitabina o infusión de 5-FU como tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal metastásico .</i>

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx metastásico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
68

Opinión

Uso selecto de FOLFOXIRI, debería haber comentario sobre biológicos

Párrafo / Recomendación

Al ofrecer múltiples drogas quimioterapéuticas a pacientes con cáncer colorrectal avanzado, irresecable o metastásico, se recomienda considerar una de las siguientes secuencias de quimioterapia, a menos que estén contraindicadas:

- FOLFOX (folinato de calcio más fluorouracilo más oxaliplatino) oXELOX (capecitabina más oxaliplatino) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en irinotecán (irinotecán o FOLFIRI) como tratamiento de segunda línea.

- FOLFIRI (folinato de calcio más fluorouracilo más irinotecán) como tratamiento de primera línea, seguido de un régimen basado en oxaliplatino (FOLFOX oXELOX) como tratamiento de segunda línea.

Se debería decidir la combinación y secuencia de quimioterapia a emplear después de una evaluación y discusión completa de los posibles efectos secundarios y las preferencias del paciente.

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx metastásico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
67

Opinión

Comentario con respecto a resección del primario en todos los otros casos

Párrafo / Recomendación

Se sugiere realizar biopsia en aquellos pacientes con una única lesión pulmonar para descartar cáncer de pulmón primario.

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
RECOMENDACIONES:
Mx metastásico

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
66

Opinión

También se sugiere que el cirujano identifique y clasifique el grado de Índice de Carcinomatosis en el cto operatorio y lo especifique en la hoja operatoria

Párrafo / Recomendación

En pacientes con cáncer de colon estadio IV por carcinomatosis peritoneal que requieren cirugía de urgencia, se sugiere confirmar diagnóstico histopatológico, derivar, y posteriormente definir si es candidato o no a procedimiento de HIPEC.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
198

Opinión

no es opioide fuerte

Párrafo / Recomendación

En caso de que no haya adecuada respuesta al manejo inicial, se sugiere complementar con opioides fuertes con perfil de manejo de dolor neuropático: metadona, oxicodona, tapendadol o tramadol.

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

197

Opinión

falta texto para darle sentido a la oración. "se recomendando descenso progresivo"

Párrafo / Recomendación

*Se recomienda la administración titulada de analgésicos y adecuar dosis de según res-
puesta del paciente. Así mismo, en caso de que se decida reducir dosis ante desaparición
del dolor, con el fin de evitar síndrome de abstinencia a opioides , aunque prescribiendo
siempre dosis de rescate.*

Categoría
de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

197

Opinión

con toxicidad limitante para la titulación del primer fármaco.

Párrafo / Recomendación

*En paciente en situación terminal con dolor intenso no controlado a pesar del tratamien-
to inicial , se sugiere una rotación o cambio de opioide, teniendo en cuenta equipotencia
analgésica, iniciar con un 25% menos de la dosis calculada para el nuevo opioide, y ajustar
según eventos adversos.*

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

197

Opinión

en pacientes sin IR

Párrafo / Recomendación

*Se recomienda el uso de morfina oral como el medicamento de primera línea para el alivio
del dolor moderado o severo o dolor irruptivo .*

(Adaptada de la guía colombiana 2016)

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

185

Opinión

no aplica a consejo nutricional en CP. Debería estar en otra parte de la guía. Fuera de tema.

Párrafo / Recomendación

no aplica a consejo nutricional en CP. Debería estar en otra parte de la guía. Fuera de tema.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
182

Opinión

Puede ser útil en el ámbito de control de la enfermedad, en el ámbito de los CP, intentamos quitar presión sobre los aspectos nutricionales dado que en etapas avanzadas la anorexia es una fuente de sufrimiento agregado que requiere intervenciones de

Párrafo / Recomendación

Se sugiere aplicar la herramienta de cribado NRS-2002 en cada consulta oncológica para detectar pacientes en riesgo nutricional .

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
182

Opinión

En pacientes con cáncer avanzado esta meta puede ser inalcanzable. Acuerdo con impartir consejos de alimentación sin ambición de un objetivo que para pacientes en CP puede ser contraproducente, mas en casos de anorexia/caquexia.

Párrafo / Recomendación

Se recomienda impartir consejos de alimentación sana y actividad física para tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 25 kg/m2 .

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
177

Opinión

Entiendo que la recomendación es débil a favor basada sobre la evidencia analizada y el impacto sutil favorable observado en la revisión. En los sistemas de salud de los países desarrollados gran parte del apoyo psicosocial y el seguimiento clínico de calidad de estos pacientes se logra satisfactoriamente sin cuidados paliativos. En los países en vías de desarrollo con sistemas de salud fragmentados y precarios, muchas veces el equipo de CP es quien brinda el apoyo psicosocial y el seguimiento clínico adecuado, motivo por lo cual, a pesar del bajo impacto de la evidencia considero que se debería analizar en la región de Cali si los equipos de CP satisfacen esa necesidad potencialmente no resuelta por otros ámbitos de atención

Párrafo / Recomendación

Se recomienda la derivación temprana de pacientes para cuidados paliativos con el fin de mejorar la calidad de vida, brindar bienestar al paciente y sus familiares, mejorar el control de los síntomas, mejorar la adherencia a los tratamientos instaurados, y mejorar las complicaciones afectivas y socio-familiares.

Fuerza de la recomendación: Débil a favor

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
175

Opinión

en este caso no sería derivación temprana, sino indicación de derivación a CP

Párrafo / Recomendación

En paciente con estadio temprano de la enfermedad, se sugiere realizar interconsulta al Equipo de Cuidados Paliativos, si presenta uno o más de los siguientes criterios:

- Síntomas incontrolados.
- Angustia de moderada a grave relacionada con el diagnóstico y la terapia del cáncer.
- Enfermedades físicas y psicosociales comórbidas graves.
- Necesidades psicosociales complejas.
- Conciencia de pronóstico pobre.
- Enfermedad potencialmente fatal o de alta mortalidad.
- Inquietudes del paciente / familia / cuidador sobre el curso de la enfermedad y la toma de decisiones.
- Solicitud de cuidados paliativos del paciente / familia / cuidador.
- Solicitud del paciente de muerte anticipada.

(Criterios adoptados de la NCCN 2020)

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
211

Opinión

Uso restringido a enfermedad terminal, aumenta mortalidad

Párrafo / Recomendación

Se sugiere el uso de catéter peritoneal permanente en casos muy seleccionados en los que se haya documentado ascitis recurrente y refractaria al tratamiento, con el fin de evitar urgencias, complicaciones peritoneales por paracentesis a repetición, mejor confort en domicilio (con cuidador entrenado). Se debe descartar contraindicaciones como son: ascitis loculada, coagulopatía o infección de cavidad peritoneal.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
185

Opinión

Más evidencia para enfermedad temprana que avanzada

Párrafo / Recomendación

A menos que se indique lo contrario, y si pueden, se recomienda a todos los sobrevivientes de cáncer que sigan las recomendaciones de prevención del cáncer en la medida de lo posible después de la etapa aguda del tratamiento:

- Tener un peso saludable
- Estar físicamente activo
- Comer más granos enteros, verduras, frutas y legumbres (como frijoles)
- Evite las bebidas azucaradas y limite el consumo de 'comidas rápidas' y otros alimentos procesados con alto contenido de grasas, almidones o azúcares
- Limitar el consumo de carnes rojas (como carne de res, cerdo y cordero)
- Evitar las carnes procesadas y el alcohol
- No usar suplementos para prevenir el cáncer

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
184

Opinión

Bastante controversial, mezcla de algo de evidencia y otras sin evidencia clínica

Párrafo / Recomendación

La calidad de la evidencia sobre las intervenciones preventivas en cáncer colorrectal se puede resumir en los siguiente puntos (163): (recomendaciones sobre nutrición)

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
93

Opinión

Inicio temprano en caso de terapia con irinotecan, primera dosis de 4 mg y 2 mg dosis subsecuentes (cada 2 horas)

Párrafo / Recomendación

Se sugiere administrar loperamida hasta conseguir 12 horas sin deposiciones y en el caso de la radioterapia, durante el tiempo que dure el tratamiento. No debe superarse la dosis máxima de 16 mg día.

(Adoptada de la guía colombiana 2016)

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
79

Opinión

Comentario con respecto a erythropoietina en estado temprano o avanzado

Párrafo / Recomendación

Se recomienda individualizar cada paciente frente a la necesidad de soporte transfusional en aquellos pacientes con anemia y síntomas asociados (fatiga, disnea) de acuerdo con sus características clínicas, estado funcional, pronóstico y preferencias .

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
206

Opinión

Especificar si esta recomendación es aplicable para todos los pacientes que presentan diarrea, o para algún grado en particular

Párrafo / Recomendación

Se sugiere administrar loperamida hasta conseguir 12 horas sin deposiciones y en el caso de la radioterapia, durante el tiempo que dure el tratamiento. No debe superarse la dosis máxima de 16 mg día.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
185

Opinión

*No me queda claro cómo pueden ser relevantes.
¿Hay evidencia de la utilidad de esas recomendaciones en pacientes con cáncer colorrectal??*

Párrafo / Recomendación

Dieta, nutrición y actividad física en sobrevivientes de cáncer

El Panel de expertos está de acuerdo en que las conclusiones que sustentan las Recomendaciones de prevención del cáncer también pueden ser relevantes para los sobrevivientes de cáncer y recomiendan que, en la medida de lo posible, los sobrevivientes de cáncer tengan como objetivo seguir estas recomendaciones una vez que el tratamiento haya finalizado. Puede haber situaciones específicas en las que este consejo puede no aplicarse y puede ser necesaria la orientación de profesionales de la salud, por lo tanto:

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
184

Opinión

En la guía no se aborda la prevención como parte de las intervenciones a realizar en cáncer colorrectal. ¿Cómo se usaría esta información en el contexto de la atención a pacientes con este tipo de cáncer?

Párrafo / Recomendación

*La calidad de la evidencia sobre las intervenciones preventivas en cáncer colorrectal se puede resumir en los siguiente puntos (163):
Evidencia sólida en prevención:*

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
179

Opinión

No es claro el fin de mejorar adherencia a tratamientos oncológicos, de la implementación de un programa de cuidado del estoma

Párrafo / Recomendación

Se recomienda la implementación de un programa del cuidado del estoma, en el que se incluya intervenciones educativas, con el fin de con el fin de reducir las complicaciones, mejorar la adaptación psicosocial y mejorar la adherencia a los tratamientos oncológicos.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
178

Opinión

Se plantea en la pregunta la efectividad de terapias n el impacto emocional y la recomendación se orienta a la adherencia al tratamiento médico. Valdría la pena identificar realmente si algunas terapias tienen impacto emocional....

Párrafo / Recomendación

¿Cuál es la efectividad de las terapias de grupo (pares, red de apoyo) respecto al manejo del impacto emocional por la colostomía?

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
93

Opinión

Especificar en el enunciado de esta recomendación, para todos los pacientes que presentan diarrea...

Párrafo / Recomendación

Se sugiere administrar loperamida hasta conseguir 12 horas sin deposiciones y en el caso de la radioterapia, durante el tiempo que dure el tratamiento. No debe superarse la dosis máxima de 16 mg día.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
83

Opinión

No se determina en qué casos aplicaría esta recomendación. Aplica para todos los pacientes con cáncer colorrectal?

Párrafo / Recomendación

Se sugiere que la cantidad de líquidos administrados para el soporte de hidratación debe ser en la cantidad mínima posible.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
80

Opinión

No es claro este aspecto.

Párrafo / Recomendación

Se sugiere explicar como el peso corporal, los alimentos y la actividad física afectan el cáncer de colon y su tratamiento.

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
79

Opinión

No encuentro recomendaciones sobre el efecto del consumo de ciertos alimentos como parte del cuidado posoperatorio en pacientes ostomizados

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría
de la opinión
Edición

Opinión

Incluir el favorecer la calidad de vida

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Párrafo / Recomendación

Se recomienda la implementación de un programa del cuidado del estoma, en el que se incluya intervenciones educativas, con el fin de con el fin de reducir las complicaciones, mejorar la adaptación psicosocial y mejorar la adherencia a los tratamientos oncológicos

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

79

Categoría
de la opinión
Comentario

Opinión

Debería ser encaminada a favorecer la adaptabilidad a los cambios en su estilo y calidad de vida

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
CUIDADOS
PALIATIVOS

Párrafo / Recomendación

Se sugiere la vinculación de pares como intervención complementaria a las acciones individuales del equipo psicosocial, encaminada a mejorar la adherencia al tratamiento médico.

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

78

Categoría
de la opinión
Aporte

Opinión

*Quizás me lo he pasado pero no he visto recomendaciones específicas the seguimiento para pacientes tratados con TNT + NOM-WW.
Cada cuanto tiempo evaluación endoscópica, MRI...?*

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
SEGUIMIENTO

Hay alguna sección dedicada a "Survivorship"?

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

79

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría
de la opinión
Aclaración
de términos

Opinión

Comentario sin importar si era negativo inicialmente

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
SEGUIMIENTO

Párrafo / Recomendación

Luego de haber terminado el tratamiento potencialmente curativo, se sugiere programar visita de seguimiento a todos los pacientes con cáncer colorrectal que incluya exploración física y prueba de antígeno carcinoembrionario, en las siguientes frecuencias por periodo:

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)

71

- Año 1 y 2: cada 3-6 meses.
- Año 3, 4 y 5: cada 6 meses.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
SEGUIMIENTO

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
66

Opinión

No recomendado en guías internacionales

Párrafo / Recomendación

En casos excepcionales y como última opción, si los recursos locales y/o las preferencias del paciente excluyen el uso de la tomografía axial computarizada, se sugiere sustituir con un ultrasonido la tomografía de abdomen y de pelvis y sustituir con una radiografía de tórax la tomografía de tórax.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
SEGUIMIENTO

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
66

Opinión

Cáncer de recto:

1. Estadios II y III: CT tórax, abdomen y pelvis con medio de contraste yodado ev cada 6-12 meses (categoría 2B para frecuencia < 12 meses) x 5 años. En pacientes con resección transanal: RM de pelvis o ultrasonografía endorectal cada 3-6 meses x 2 años y luego cada 6 meses hasta completar 5 años.

2. Estadio IV: CT tórax, abdomen y pelvis con medio de contraste yodado ev cada 3-6 meses (categoría 2B para frecuencia < 6 meses) x 2 años, luego cada 6-12 meses hasta completar 5 años. En pacientes con resección transanal: RM de pelvis o ultrasonografía endorectal cada 3-6 meses x 2 años y luego cada 6 meses hasta completar 5 años.

PET/CT puede considerarse en pacientes candidatos a terapias dirigidas de MTS hepáticas (ablaciones)

Párrafo / Recomendación

En paciente con cáncer de recto estadios II, III y IV, se recomienda la toma de RMN cada 3-6 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta completar 5 años, únicamente en aquellos en que se les haya realizado una escisión local trans-anal.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
SEGUIMIENTO

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
65

Opinión

Ca de colon:

Estadios II y III: se recomienda CT de tórax, abdomen y pelvis con contraste yodado ev cada 6-12 meses (categoría 2B para frecuencia < 12 meses) x 5 años.

Estadio IV: se recomienda CT de tórax, abdomen y pelvis con contraste yodado ev cada 3-6 meses (categoría 2B para frecuencia < 6 meses) x 2 años, luego cada 6-12 meses hasta completar 5 años.

PET/CT puede considerarse en pacientes candidatos a terapias dirigidas de MTS hepáticas (ablación/embolización)

Párrafo / Recomendación

En paciente con cáncer colorrectal con estadios II-III que se encuentran en seguimiento, se sugiere una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen-pelvis cada año durante 5 años.

En estadio IV, se sugiere toma de TAC cada 6 meses durante los primeros 2 años. Luego cada año hasta completar 5 años.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
220

Opinión

¿Qué papel juega enfermería en relación con los cuidadores familiares, de pacientes con cáncer colorrectal?

Párrafo / Recomendación

Los cuidadores también cumplen un papel muy importante en el proceso de las pacientes, ellos asumen diferentes responsabilidades según se requieran:

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
219

Opinión

En relación con este aspecto, Cuál debe ser la intervención de enfermería?, ¿Cómo identifica necesidades relacionadas?, Cuáles son las actuaciones o intervenciones a realizar?

Párrafo / Recomendación

Cambios emocionales: El cáncer interrumpe muchas partes de la vida de una persona, desde las relaciones hasta el trabajo y los pasatiempos.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
218

Opinión

Es enfermería o el médico tratante quien realiza la formulación

Párrafo / Recomendación

Las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia: se recetarán medicamentos para ayudar a controlarlos.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
218

Opinión

Además del tratamiento, ¿cuál debe ser la actuación de enfermería frente a cada uno de los problemas señalados? Se requiere evidencia científica para determinar cuáles actuaciones producen mejores resultados en los pacientes. Otra opción es seleccionar los protocolos de cuidado de enfermería específicos para cada una de las condiciones mencionadas a continuación.

Párrafo / Recomendación

El tratamiento de los efectos secundarios a largo plazo y los efectos tardíos, son una parte importante de la atención para sobrevivientes.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
218

Opinión

Se requiere identificar los problemas y necesidades más frecuentes e impactantes en estos pacientes, e incluir los protocolos de cuidado de enfermería específicos. El abordaje de estos, es muy básico.

Párrafo / Recomendación

Revisemos los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento y cómo enfrentarlos .

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
218

Opinión

Vale la pena revisar si es este el propósito o debería ser más general...

Párrafo / Recomendación

Es importante concentrar todas estas actividades hacia la orientación del equipo multidisciplinario en maximizar la calidad de vida de las pacientes, mientras están en el tratamiento .

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
218

Opinión

La atención integral implica que se definan y realicen acciones de cuidado específicas para identificar y aliviar las molestias derivadas de la enfermedad y del tratamiento.

Párrafo / Recomendación

*Las enfermeras en el grupo multidisciplinario deberán coordinar los recursos sanitarios, psicosociales y la continuidad de los cuidados en este tipo de paciente.
El objetivo del acompañamiento de Enfermería es el conocer paso a paso el proceso que lleva la persona durante el desarrollo de su enfermedad, logrando brindar una atención integral y humanizada al paciente y su familia, a través de:*

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
217

Opinión

El enfoque del plan es predominantemente de gestión administrativa, no se evidencia el cuidado clínico específico y especializado que enfermería debe brindar la paciente con cáncer colorrectal en cada momento de evolución de su enfermedad y frente a los efectos que producen los distintos tratamientos.

Párrafo / Recomendación

Plan de manejo de enfermería

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
216

Opinión

La guía hace referencia a cáncer colorrectal, cómo asumir esta situación?

Párrafo / Recomendación

Hay algunos grupos de riesgo, como cáncer de pulmón o de páncreas, que dado su rápida progresión y pobre pronóstico, lleva al límite el tiempo de respuesta del equipo de navegación.

Categoría de la opinión
ración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
216

Opinión

No se evidencian las funciones clínicas de enfermería, son todas administrativas

Párrafo / Recomendación

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva clínico-administrativa (incluye el proceso de Navegación):

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
216

Opinión

Plantear ¿cuál sería la gestión a desarrollar por enfermería?

Párrafo / Recomendación

La falta de voluntad política entre los prestadores y aseguradores para la creación de redes de atención integrales y funcionales.

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
215

Opinión

Debería ser responsabilidad de trabajo social u otro personal, diferente a enfermería

Párrafo / Recomendación

Gestión de servicios relacionados con la atención de salud si bien no son actividades sanitarias, como lo es el transporte y alojamiento mientras se encuentran en quimioterapia o radioterapia (aplica sólo para población pediátrica según lo establecido en la Ley 1388 de 2010).

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS
ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
215

Opinión

Especificar la información sobre procedimientos y procesos administrativos, esta función puede ser asumida por otro personal, no por enfermería

Párrafo / Recomendación

Comunicación con los familiares/cuidadores.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS
ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
215

Opinión

Revisar cuáles funciones podrían ser realizadas por otro tipo de personal como asistentes administrativos, para priorizar el escaso recurso profesional y especializado de enfermería en funciones de cuidado directo y gestión directa del cuidado.

Párrafo / Recomendación

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva administrativa:

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS
ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
215

Opinión

Sugiero plantear los puntos como retos: lo que se pretende hacer para cambiar las condiciones actuales que son mencionadas.

Párrafo / Recomendación

Retos desde la perspectiva asistencial:

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS
ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

Educación sobre qué aspectos?

Párrafo / Recomendación

Educación a los demás profesionales de la salud como uno de los componentes del trabajo de los equipos multidisciplinarios.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

Educación sobre qué aspectos?

Párrafo / Recomendación

Educación a los demás profesionales de la salud como uno de los componentes del trabajo de los equipos multidisciplinarios.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

Por el enfoque de la Guía de manejo, no se ve la posibilidad de cumplir estas funciones en las IPS...

Párrafo / Recomendación

Coordinación con actividades de promoción de la salud desde la atención primaria

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

En dónde sería aplicable esta función?

Párrafo / Recomendación

Gestión poblacional en cuanto a la identificación de grupos de riesgo alto para cáncer, priorización de los mismos y activación de intervenciones clínicas.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

No es un objetivo de la guía, valdría la pena revisar la inclusión de esta función

Párrafo / Recomendación

No es un objetivo de la guía, valdría la pena revisar la inclusión de esta función.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

Especificar tamización de qué? Pacientes para diagnóstico temprano o para confirmación de diagnóstico. En la guía no se mencionan

Párrafo / Recomendación

Realización, monitoreo y evaluación de los programas de tamización

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
ROL Y PERSPECTIVAS ENFERMERÍA

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
214

Opinión

Especificar la educación para quién, paciente, familia personal auxiliar?

Párrafo / Recomendación

Funciones esenciales del profesional de enfermería desde la perspectiva asistencial:

Educación al momento del diagnóstico, y especialmente durante el tratamiento.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
REVISION EVAL. ECONÓMICAS

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
224

Opinión

Información cambiante con biosimilares, no se todavía aplican esas cifras

Párrafo / Recomendación

Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
234

Opinión

¿Exclusivamente en relación con Cuidados Paliativos? ¿El cuidado y apoyo familiar durante las distintas etapas y tratamientos de la enfermedad?

Párrafo / Recomendación

Activar e involucrar a la red de apoyo del paciente, grupo familiar y/o cuidadores sobre la importancia y significados de los Cuidados Paliativos

Categoría de la opinión
Comentario

Opinión

Tener en cuenta formación específica en oncología

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Párrafo / Recomendación

Promover la satisfacción del profesional de la salud mediante contratación directa, capacitaciones, espacios para retroalimentación entre pares y compañeros, entre otros mecanismos que fomenten la preparación y empoderamiento del equipo de salud.

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
233

Categoría de la opinión
Comentario

Opinión

Necesario hacer explícita la visibilización del cuidado clínico- asistencial de enfermería-

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Párrafo / Recomendación

Diseñar formatos de guías y protocolos teniendo en cuenta el usuario objetivo, esto con el fin de visibilizar y estandarizar la práctica clínica de los profesionales de salud que participan en el cuidado del paciente con cáncer (ej: profesionales de enfermería , personal administrativo, entre otros)

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
232

Categoría de la opinión
Comentario

Opinión

Este bloque se debería mover con la sección the cancer de Recto mas abajo. Todas las recomendaciones que siguen se refieren a tx adyuvante

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Párrafo / Recomendación

Al ofrecer quimioterapia neoadyuvante concomitante con radioterapia a pacientes con cáncer de recto localmente avanzado estadio T3 y T4, se sugiere considerar las siguientes opciones de tratamiento:

- 5-fluorouracilo infusional continuo o
- 5-fluorouracilo/Leucovorina o
- Capecitabina.

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
62

Categoría de la opinión
Comentario

Opinión

- Convendría hacer un sumario de las recomendaciones de esta guía en relación con
- Estudio de extensión en cancer de colon y recto
- Papel de la MRI vs EUS en cancer de recto
- Cuando estaría indicado hacer PET

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Párrafo / Recomendación

n/a

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
51

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
46

Opinión

Como es posible que sea débil en pacientes con alergia al contraste y Fuerte cuando no hay alergia? Ambos tienen que ser estudiados. Si CT con IV contraste no es posible, hay que hacer MRI abdomen y pelvis + CT tórax

Párrafo / Recomendación

Si hay contraindicación para la realización del TAC con contraste, se sugiere RMN de abdomen y pelvis y TAC de tórax sin contraste

Fuerza de la recomendación: Débil a favor

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
39

Opinión

como puede ser la recomendación de fuerza débil? Quien no recomienda tomar biopsia de una lesión sospechosa o hacer una colonoscopia par el diagnostico de cancer colo-rectal

Párrafo / Recomendación

Si una lesión sospechosa de cáncer es detectada, se sugiere tomar biopsia para obtener una prueba histológica del diagnóstico.

Fuerza de la recomendación: Debil

Categoría
de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
38

Opinión

Es muy confusa la forma en la que se presenta esta sección con Recomendaciones originales y adaptadas

Párrafo / Recomendación

n/a

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
124

Opinión

Nuevamente, el tamaño del pólipo en la práctica es irrelevante si no hay carcinoma invasor.

Párrafo / Recomendación

En 2010, Rubio y colaboradores estudiaron las variaciones intra-observador e inter-observador en relación con el tamaño de los pólipos de colon (74), ya que se ha postulado que el tamaño de los pólipos podrían predecir la ocurrencia de carcinoma invasivo. Es por ello que tomaron las imágenes endoscópicas de 148 pólipos (adenomas según la histopatología ulterior) resecados endoscópicamente y fueron sometidos a evaluación por tres patólogos de manera independiente. Los resultados fueron que el 50% de los valores obtenidos, de los 148 adenomas, fueron congruentes entre los 3 patólogos en el primer ensayo, y 62% en un segundo ensayo. Los autores reconocen que, si bien los patólogos se apoyan en una regla milimétrica, este procedimiento puede estar influenciado por factores como son: la habilidad y experiencia del patólogo, el tiempo dado para la medición del pólipo, y el requerimiento o no de un doble chequeo. El estudio concluye que hay una congruencia baja en cuanto al tamaño estimado de los pólipos resecados, por lo que sugieren que la utilización de las medidas del pólipo removidos por endoscopia no es confiable para predecir el riesgo de carcinoma de colon.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
123

Opinión

En la práctica, la asignación del grado de displasia es irrelevante. En ausencia de carcinoma invasor probablemente lo único que idicaría sería la frecuencia de las colonoscopías futuras.

Párrafo / Recomendación

Respecto a la variabilidad para clasificar los grados de displasia, Osmond y colaboradores en 2014 (72), publicaron un estudio el cual tuvo como objetivo evaluar la variabilidad inter-observador en la clasificación de las displasias de adenomas colorrectal y determinar si tal variabilidad podría mejorar por la adopción de unos criterios específicos establecidos en las guías (este estudio fue desarrollado en Canadá). Con base en la valoración de 40 imágenes histopatológicas de adenomas por parte de 12 patólogos, los autores estimaron un grado de acuerdo en la línea base de un $K=0.4700$ (IC95% 0.4427, 0.4972) para la arquitectura, y un $K=0.5680$ (0.5299, 0.6062) para el grado de displasia. Luego de la implementación de los criterios basados en las guías canadienses, la variabilidad inter-observador mejoró en arquitectura con un $K=0.5403$ (0.5133, 0.5674). Para el grado de displasia, la variabilidad disminuyó con un $K=0.4833$ (0.4452, 0.5215). Se concluye que el grado de acuerdo inter-observador es moderado, y que el uso de guías logra mejorar el grado de acuerdo en el reporte de arquitectura mas no en el grado de displasia.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
73

Opinión

Doble negativo, no es claro si el grupo esta en contra de la recomendación

Párrafo / Recomendación

Fuerza de la recomendación: Débil en contra

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
69

Opinión

Baja?

Párrafo / Recomendación

Calidad de la evidencia: Baja .

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
53

Opinión

Hay estudios en contra de stent, no entiendo la relación de la recomendación original y la adaptada

Párrafo / Recomendación

Fuerza de la recomendación: Débil a favor.

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
159

Opinión

Un trabajo publicado por Chiaravalloti en 2016 en que se evaluaron con FDG PET/CT 100 pacientes con sospecha de recurrencia de carcinoma colorectal por elevación del CEA o Ca19-9, demostró que un valor de CEA ≥ 3.5 ng/ml se asociaba a una tasa de detección (DR) de lesiones secundarias de 79%, versus DR de 35% en pacientes con CEA < 3.5 ng/ml. Oncol Lett. 2016 Nov; 12(5): 4209–4213.

Otro estudio por Huang et al del año 2015, demostró una DR de 97.9% en pacientes con CEA > 13 ng/ml, versus 60.9% en pacientes con CEA ≤ 13 ng/ml. Clinical Nuclear Medicine: October 2015 - Volume 40 - Issue 10 - p e465-e469

Párrafo / Recomendación

Por otro lado, en cuanto al uso de PET CT en el seguimiento, Patel y col publicaron una revisión sistemática en 2013 que abordó este tema (140). Basados en la revisión de 12 estudios, hallaron que la mayoría reportaba una sensibilidad con rango de 90-100%, si bien los estudios eran muy heterogéneos entre sí. En este orden de ideas, Lu y demás publicaron en ese mismo año una revisión sistemática con metaanálisis (141), la cual evidenció que, para detección de recurrencia de cáncer colorrectal, el PET CT con FDG y elevación de CAE muestra una sensibilidad de 94.1 (IC95% 89.4-97.1) y una especificidad de 77.2% (IC95% 66.4-85.9). Este último estudio aporta evidencia de la utilidad diagnóstica del PET CT en el contexto de elevación del CAE .

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
109

Opinión

Evaluating local lymph node metastasis with magnetic resonance imaging, endoluminal ultrasound and computed tomography in rectal cancer: a meta-analysis
<https://doi.org/10.1111/codi.12909>

Párrafo / Recomendación

La ultrasonografía endorrectal (UER) se ha propuesto para abordar la limitante de la RMN en cuanto a la detección de compromiso ganglionar en cáncer de recto. Puli y colaboradores en 2009 publican una revisión sistemática en la cual buscar determinar la precisión de la UER para detectar y establecer la presencia de compromiso ganglionar en pacientes con cáncer rectal (62).

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
109

Opinión

Referencia más reciente
Diagnostic Accuracy of MRI for Assessment of T Category and Circumferential Resection Margin Involvement in Patients With Rectal Cancer
Zhang, Ge M.B.1; Cai, Yu-zhe M.B.2; Xu, Guo-hui M.D.
Diseases of the Colon & Rectum: August 2016 - Volume 59 - Issue 8 - p 789-799

Párrafo / Recomendación

Respecto al papel de la RMN para estratificar el paciente con cáncer de recto, Al-Sukhni y colaboradores realizaron en 2012 una revisión sistemática con metaanálisis acerca de la precisión diagnóstica de la RMN para determinar la categoría T, metástasis a ganglios linfáticos, y compromiso del margen de resección circunferencial (60).

Categoría
de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a
la pertenece la opinión
Comentario
general

Página del
documento al que hace re-
ferencia la opinión (versión
preliminar de marzo 2021)
109

Opinión

Agregaría referencia más reciente.
When is a Ghost Really Gone? A Systematic Review and Meta-analysis of the Accuracy of Imaging Modalities to Predict Complete Pathological Response of Colorectal Cancer Liver Metastases After Chemotherapy
<https://doi.org/10.1245/s10434-021-09824-z>

Párrafo / Recomendación

En este mismo sentido, un metaanálisis de 2012 evaluó el desempeño de estas ayudas de imagenología en el contexto de un paciente para re-estadificar previo a la cirugía y luego de neoadyuvancia (58).

Categoría de la opinión
Aporte

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
108

Opinión

Yo pondría una referencia más reciente.

Puede ser Imaging of colorectal cancer liver metastases using contrast-enhanced US, multidetector CT, MRI, and FDG PET/CT: a meta-analysis. <https://doi.org/10.1177/0284185120925481>

Diagnostic performance of CT, gadoxetate disodium-enhanced MRI, and PET/CT for the diagnosis of colorectal liver metastasis: Systematic review and meta-analysis <https://doi.org/10.1002/jmri.25852>

Diagnostic performance of magnetic resonance imaging for colorectal liver metastasis: A systematic review and meta-analysis <https://doi.org/10.1038/s41598-020-58855-1>

Párrafo / Recomendación

Niekel y colaboradores publicaron en 2010 una revisión sistemática cuyo objetivo fue determinar el desempeño diagnóstico de la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones con fluorin-18-deoxiglucosa para la detección de metástasis hepáticas en paciente con cáncer colorrectal I sin tratamiento previo (57).

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
67

Opinión

Categoría 2A NCCN 2021

Párrafo / Recomendación

Calidad de la evidencia: Baja

Categoría de la opinión
Edición

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
40

Opinión

Categoría de evidencia NCCN 2A

Párrafo / Recomendación

Calidad de la evidencia: Moderada

Categoría de la opinión <i>Aporte</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión <i>Comentario general</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 96	Opinión <i>TODOS LOS FLUJOGRAMAS DEBERIAN LLEVAR ANTES DE TRATAMIENTO LA PRESENCIA DEL PACIENTE EN EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO</i> Párrafo / Recomendación <i>n/a</i>
Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión <i>Comentario general</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 231	Opinión <i>No se aborda en la guía</i> Párrafo / Recomendación <i>No priorización de población en riesgo alto</i>
Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión <i>Comentario general</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 231	Opinión <i>Faltaría la escasa o nula educación que reciben los pacientes para la identificación temprana de efectos adversos y su manejo adecuado</i> Párrafo / Recomendación <i>Efectos adversos frecuentes que desincentivan a los pacientes de continuar el tratamiento.</i>
Categoría de la opinión <i>Comentario</i> Apartado de la GPC a la pertenece la opinión <i>Comentario general</i> Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021) 231	Opinión <i>Es un asunto no atendido en la Guía</i> Párrafo / Recomendación <i>Falta de formación y capacitación del RRHH de Atención Primaria para interpretación de tamizajes alterados y sospecha precoz de cáncer</i>

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
219

Opinión

¿En qué medida se presenta esta pérdida en pacientes con cáncer colorrectal? ¿Con qué tipo de tratamiento?

Párrafo / Recomendación

La pérdida ósea: Algunas terapias hormonales y quimioterapias pueden causar pérdida ósea, aumentando así el riesgo de fracturas óseas; hay que ayudar a optimizar su salud ósea y ejercicios que fortalecen sus músculos.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
219

Opinión

En los pacientes con cáncer colorrectal, señalar en qué casos es posible que se presente

Párrafo / Recomendación

El linfedema: Acumulación anormal de líquido en los tejidos blandos debido a un bloqueo en el sistema linfático, inflamación dolorosa.

Categoría de la opinión
Comentario

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
219

Opinión

Es un abordaje simple y muy general. Si se incluye el manejo de la fatiga en los pacientes con cáncer colorrectal, se requiere mostrar su incidencia, y los resultados de investigación sobre el impacto de los cuidados de enfermería en su manejo.

Párrafo / Recomendación

La fatiga : La fatiga es una sensación de cansancio extremo. El médico puede tratar la fatiga con medicamentos recetados. El ejercicio también puede ayudarle.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
161

Opinión

Si hay una diferencia de casi 10 meses en la supervivencia, ¿puede decirse que es esencialmente igual?

Párrafo / Recomendación

Verwaal y su equipo de investigación publicó en 2008 un seguimiento a 8 años de su estudio primario (121). Con una mediana de seguimiento de 8 años (rango 72-115 meses) se evidenció un tiempo libre de enfermedad de 7.7 meses en el grupo control y de 12.6 meses en el grupo intervención ($p=0.020$). La supervivencia fue esencialmente igual, con 12.6 meses para el grupo control y de 22.2 meses para el grupo intervención.

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
149

Opinión

Revisar la forma de presentación del primer párrafo, para que sea coherente con el contenido de esta sección

Párrafo / Recomendación

Terapia adyuvante en cáncer de recto no metastásico

Categoría de la opinión
Aclaración de términos

Apartado de la GPC a la pertenece la opinión
Comentario general

Página del documento al que hace referencia la opinión (versión preliminar de marzo 2021)
147

Opinión

No queda claro si el retraso en el inicio de la quimioterapia, o su uso más prolongado, o los dos aspectos sean el factor que se asocia a disminución de supervivencia global

Párrafo / Recomendación

Biagi y colaboradores publicaron en 2011 una revisión sistemática con metaanálisis con el fin de determinar la relación entre el tiempo de la quimioterapia adyuvante y la supervivencia (99). Incluyeron 10 estudios para el análisis (para 15,410 pacientes). Encontraron que un aumento de 4 semanas en el tiempo de quimioterapia adyuvante (es decir, un retraso en iniciar la terapia) estuvo asociado a una disminución significativa de la supervivencia global (HR 1.14; IC95% 1.10-1.17; I2=15.3%) y del tiempo libre de enfermedad (HR 1.14; IC95% 1.10-1.18; I2=0%). Con esto, se demostró que tiempos prolongados de quimioterapia adyuvante estuvo asociado a peor supervivencia entre pacientes con cáncer colorrectal.

Los expertos clínicos del grupo desarrollador se reunieron con los pares internacionales en un encuentro virtual sincrónico el 03 de Junio de 2021, en el que se tuvo oportunidad de intercambiar conceptos, ideas y ampliar los comentarios realizados por los pares, así como brindar las aclaraciones de alcance y contenido de la guía.

Con estos elementos, el grupo desarrollador de la guía evaluaron la necesidad de realizar o no ajuste en el manuscrito, los cuales fueron más de aclaración de conceptos y estructura de algunos párrafos para dar mejor claridad de la recomendación que se está enunciando. Todos los ajustes que se consideraron apropiados están incorporados en la presente versión.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018 Nov;68(6):394–424.
2. Bray F, Piñeros M. Cancer patterns, trends and projections in Latin America and the Caribbean: a global context. *Salud Publica Mex*. 2016;58:104–17.
3. Pardo C, Cendales R. Cancer incidence estimates and mortality for the top five cancer in Colombia, 2007-2011. *Colomb Med*. 2018;49(1):16–22.
4. Bravo LE, Collazos T, Collazos P, Stella L, Correa P. Trends of cancer incidence and mortality in Cali, Colombia. 50 years experience (Octubre-Diciembre). *Colomb Med*. 2012;43(4):246–55.
5. Dekker E, Tanis PJ, Vleugels JLA, Kasi PM, Wallace MB. Colorectal cancer. *Lancet*. 2019;394(10207):1467–80.
6. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. *Gut*. 2017;66:683–91.
7. Cortés A, Bravo LE, García LS, Collazos P. Incidencia, mortalidad y supervivencia por cáncer colorrectal en Cali, Colombia, 1962-2012. *Salud Publica Mex*. 2014;56:457–64.
8. Acuña L, Fuentes JC, Ramirez PX, Gil AM, Castillo J, Castillo A. Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia 2017 [Internet]. Vol. 1, Cuenta de Alto Costo. Bogotá DC: Fondo Colombiano de Enfermedad de Alto Costo Cuenta de Alto Costo (CAC); 2018. p. 124–6. Available from: https://cuentadealtocosto.org/site/images/Publicaciones/2018/Situacion_cancer_pediatico_Colombia_2017.pdf
9. Valencia O, Lopes G, Sánchez P, Acuña L, Uribe D, González J. Incidence and Prevalence of Cancer in Colombia: The Methodology Used Matters. *Journal of Global Oncology* [Internet]. 2018 Dec [cited 2020 Jul 23];4. Available from: <https://ascopubs.org/go/authors/open-access>
10. Organización Mundial de la Salud. Control del cáncer. Prevención. Aplicación de los conocimientos Control del cáncer: Guía de la OMS para desarrollar programas eficaces [Internet]. Geneva; 2007 [cited 2020 Aug 3]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44022/9789243547114_spa.pdf?sequence=1
11. Brenner H, Chen C. The colorectal cancer epidemic: challenges and opportunities for primary, secondary and tertiary prevention. *Br J Cancer*. 2018;119:785–92.
12. Zauber AG. The Impact of Screening on Colorectal Cancer Mortality and Incidence-Has It Really Made a Difference? *Dig Dis Sci*. 2015;60(3):681–91.
13. Hewitson P, Glasziou P, Irwig L, Towler B, Watson E. Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(1).
14. Holme O, Bretthauer M, Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Hoff G. Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;9(CD009259).
15. Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Cancerología. PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA, 2012 - 2021 [Internet]. Bogotá, DC; 2012 [cited 2020 Jul 23]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/plan-nacional-control-cancer.pdf>
16. Congreso de la República de Colombia. LEY 1384 DE 2010 “SANDRA CEBALLOS”, POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER EN COLOMBIA. [Internet]. Bogotá DC; 2010 Apr [cited 2020 Aug 3]. Available from: https://www.ins.gov.co/Normatividad/Leyes/LEY_1384_DE_2010.pdf
17. Pardo C, de Vries E. Supervivencia global de pacientes con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología (INC). *Rev Colomb Cancerol*. 2017;21(1):12–8.
18. Campo-Sánchez SM, Camargo-Trillos J, Calle-Ramírez JA, Gómez-Wolff LR, Sánchez-Patiño LA, García-García HI. Colorectal cancer survival at an oncologic center in Colombia. A historic cohort study.

- Rev Gastroenterol México (English Ed. 2019 Apr 1;84(2):174–84.
19. Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, Harewood R, Matz M, Nikšić M, et al. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. *Lancet*. 2018;391(10125):1023–75.
20. Orangio GR. The Economics of Colon Cancer. *Surg Oncol Clin N Am*. 2018;27(2):327–47.
21. León E, Gamboa Ó, Lozano T, Gamboa C, Gil M, Fuentes J. Estudio de costo de la enfermedad en pacientes con cáncer de colon y recto en Colombia. *Rev Colomb Cancerol*. 2013;17(4):184.
22. Sanabria Rojas A, Martínez JI, Díaz Rojas JA. Cáncer de colon: análisis del costo de enfermedad para los estadios III y IV en Cansercoop ips. *Rev colomb ciencias quim farm*. 2009;38(2):193–214.
23. Murillo R, Wiesner C, Acosta J, Piñeros M, Pérez JJ, Orozco M. Modelo de cuidado del paciente con cáncer [Internet]. Bogotá DC; 2015 Jun [cited 2020 Aug 3]. Available from: <https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/modelo>
24. Ceballos CW, Suárez A, Henríquez G, Aguilera López J. Servicios Oncológicos en Colombia [Internet]. Bogotá DC; 2016 Dec [cited 2020 Aug 3]. Available from: <https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/Servicios Oncologicos Boletín.pdf>
25. Warren JL, Mariotto AB, Meekins A, Topor M, Brown ML. Current and Future Utilization of Services From Medical Oncologists. *J Clin Oncol*. 2008;26:3242–7.
26. Prada SI, Contreras JF. Gasto en el último año de vida para pacientes que mueren con cáncer. *Rev Colomb Cancerol*. 2018;22(1):3–7.
27. Crooks P. Managing High-Risk, High-Cost Patients: The Southern California Kaiser Permanente Experience in the Medicare ESRD Demonstration Project. *Perm Journal/ Spring*. 2005;9(2):93–7.
28. Bodenheimer T, Sinsky C. From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. *Ann Fam Med*. 2014;12(6):573–6.
29. Sikka R, Morath JM, Leape L. The Quadruple Aim: care, health, cost and meaning in work. *BMJ Qual Saf*. 2015;24:608–10.
30. City Cancer Challenge - Driving local innovation for global impact. : City Cancer Challenge [Internet]. [cited 2020 Aug 4]. Available from: <https://citycancer-challenge.org/>
31. Ministerio de Salud y Protección Social. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADOPCIÓN-ADAPTACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADAS EN EVIDENCIA [Internet]. Bogotá DC; 2017 [cited 2020 Jul 23]. Available from: https://www.iets.org.co/Archivos/79/Guia_de_Adopcion_VF.pdf
32. Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia, en instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia [Internet]. Bogotá DC; 2014 [cited 2020 Jul 23]. Available from: http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos compartidos/Manual_de_implementacion.pdf
33. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Directriz para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías informadas por la evidencia [Internet]. Washington DC; 2018 [cited 2020 Jul 23]. Available from: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49145/9789275320167_spa.pdf
34. Cabana M, Rand C, Powe N, Wu A, Wilson M, Aboud P-A, et al. Why Don't Physicians Follow Clinical Practice Guidelines? *JAMA*. 1999;282(15):1458–65.
35. Costas-Chavarri A, Nandakumar G, Temin S, Lopes G, Cervantes A, Correa MC, et al. Treatment of patients with early-stage colorectal cancer: ASCO resource-stratified guideline. *J Glob Oncol*. 2019;2019(5):1–19.
36. Vogel JD, Eskicioglu C, Weiser MR, Feingold DL, Steele SR. The American society of colon and rectal surgeons clinical practice guidelines for the treatment of colon cancer. *Dis Colon Rectum*. 2017;60(10):999–1017.
37. Monson JRT, Weiser MR, Buie WD, Chang GJ, Rafferty JF. Practice parameters for the management of rectal cancer (revised). *Dis Colon Rectum*. 2013;56(5):535–50.
38. College of American Pathologist. Protocol for the Examination of Resection Specimens From Patients With Primary Carcinoma of the Colon and Rectum [Internet]. College of American Pathologist; 2020. Available from: <https://documents.cap.org/protocols/cp-gilower-colonrectum-resection-20-4100.pdf>

39. Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Cancerología, Salud I de ET en. Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de colon y recto. 2da edición [Internet]. Bogotá DC: Ministerio de Salud y Protección Social; 2017. Available from: gpc.mimsalud.gov.co
40. Beets-Tan RGH, Lambregts DMJ, Maas M, Bipat S, Barbaro B, Curvo-Semedo L, et al. Magnetic resonance imaging for clinical management of rectal cancer: Updated recommendations from the 2016 European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) consensus meeting. *Eur Radiol*. 2018;28(4):1465–75.
41. Labianca R, Nordlinger B, Beretta GD, Mosconi S, Mandalà M, Cervantes A, et al. Early colon cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* [Internet]. 2013;24(SUPPL.6):vi64–72. Available from: <http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdt354>
42. Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, Arnold D, The ESMO Guidelines Working Group. Metastatic colorectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* [Internet]. 2014;25(April 2002):iii1–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdu260>
43. Glynne-Jones R, Wyrwicz L, Tiret E, Brown G, Rödel C, Cervantes A, et al. Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2017;28(Supplement 4):iv22–40.
44. Hashiguchi Y, Muro K, Saito Y, Ito Y, Ajioka Y, Hamaguchi T, et al. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2019 for the treatment of colorectal cancer [Internet]. Vol. 25, International Journal of Clinical Oncology. Springer Singapore; 2020. 1–42 p. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10147-019-01485-z>
45. NCCN. NCCN Guidelines: Colon cancer v 4.2020 [Internet]. National Comprehensive Cancer Network; 2020. Available from: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf
46. NCCN. NCCN Guidelines: Rectal cancer v5.2020. National Comprehensive Cancer Network; 2020.
47. The National Institute for Health and Care Excellence. Recommendations in Colorectal Cancer (NG151). NICE Clin Guid Color Cancer [Internet]. 2020;(January). Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng151>
48. Gollub MJ, Arya S, Beets-Tan RG, dePrisco G, Gonen M, Jhaveri K, et al. Use of magnetic resonance imaging in rectal cancer patients: Society of Abdominal Radiology (SAR) rectal cancer disease-focused panel (DFP) recommendations 2017. *Abdom Radiol* [Internet]. 2018;43(11):2893–902. Available from: <https://doi.org/10.1007/s00261-018-1642-9>
49. Pickhardt PJ, Hassan C, Halligan S, Marmo R. Colorectal cancer: CT colonography and colonoscopy for detection-systematic review and meta-analysis. *Radiology*. 2011;259(2):393–405.
50. Reumkens A, Rondagh EJA, Bakker CM, Winkens B, Masclee AAM, Sanduleanu S. Post-colonoscopy complications: A systematic review, time trends, and meta-analysis of population-based studies. *Am J Gastroenterol* [Internet]. 2016;111(8):1092–101. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2016.234>
51. Liang PS, Dominitz JA. Colorectal Cancer Screening: Is Colonoscopy the Best Option? *Med Clin North Am* [Internet]. 2019;103(1):111–23. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2018.08.010>
52. Tinmouth J, Kennedy EB, Baron D, Burke M, Feinberg S, Gould M, et al. Colonoscopy quality assurance in Ontario: Systematic review and clinical practice guideline. *Can J Gastroenterol Hepatol*. 2014;28(5):251–74.
53. Rosman AS, Korsten MA. Meta-analysis Comparing CT Colonography, Air Contrast Barium Enema, and Colonoscopy. *Am J Med*. 2007;120(3):203–10.
54. Plumb AA, Halligan S, Pendsé DA, Taylor SA, Mallett S. Sensitivity and specificity of CT colonography for the detection of colonic neoplasia after positive faecal occult blood testing: Systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol*. 2014;24(5):1049–58.
55. Niekel MC, Bipat S, Stoker J. Diagnostic imaging of colorectal liver metastases with CT, MR imaging, FDG PET, and/or FDG PET/CT: A meta-analysis of prospective studies including patients who have not previously undergone treatment. *Radiology*. 2010;257(3):674–84.
56. Van Kessel CS, Buckens CFM, Van Den Bosch MAAJ, Van Leeuwen MS, Van Hillegersberg R, Verkoijen HM. Preoperative imaging of colorectal liver metastases after neoadjuvant chemotherapy: A me-

ta-analysis. *Ann Surg Oncol*. 2012;19(9):2805–13.

57. Floriani I, Torri V, Rulli E, Garavaglia D, Compagnoni A, Salvolini L, et al. Performance of imaging modalities in diagnosis of liver metastases from colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. *J Magn Reson Imaging*. 2010;31(1):19–31.

58. Al-Sukhni E, Milot L, Fruitman M, Beyene J, Victor JC, Schmock S, et al. Diagnostic accuracy of MRI for assessment of T category, lymph node metastases, and circumferential resection margin involvement in patients with rectal cancer: A systematic review and meta-analysis. *Ann Surg Oncol*. 2012;19(7):2212–23.

59. Hoshino N, Murakami K, Hida K, Sakamoto T, Sakai Y. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging and computed tomography for lateral lymph node metastasis in rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. *Int J Clin Oncol* [Internet]. 2019;24(1):46–52. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s10147-018-1349-5>

60. Nasser Y, Langenfeld SJ. Imaging for Colorectal Cancer. *Surg Clin North Am* [Internet]. 2017;97(3):503–13. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.suc.2017.01.002>

61. Horvat N, Rocha CCT, Oliveira BC, Petkovska I, Gollub MJ. MRI of rectal cancer: Tumor staging, imaging techniques, and management. *Radiographics*. 2019;39(2):367–87.

62. Tanaka A, Sadahiro S, Suzuki T, Okada K, Saito G. Comparisons of rigid proctoscopy, flexible colonoscopy, and digital rectal examination for determining the localization of rectal cancers. *Dis Colon Rectum*. 2018;61(2):202–6.

63. Quirke P, Risio M, Lambert R, Von Karsa L, Vieth M. Quality assurance in pathology in colorectal cancer screening and diagnosis-European recommendations. *Virchows Arch*. 2011;458(1):1–19.

64. Dixon M. Gastrointestinal epithelial neoplasia: Vienna revisited. *Gut*. 2002;51:130–1.

65. Nagtegaal ID, Odze RD, Klimstra D, Paradis V, Rugge M, Schirmacher P, et al. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. *Histopathology*. 2020 Jan 13;76(2):182–8.

66. Endoscopic Classification Review Group. Update on the Paris Classification of Superficial Neoplastic Lesions in the Digestive Tract. *Endoscopy*.

2005;37(6):570–8.

67. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum. Japanese Classification of Colorectal, Appendiceal, and Anal Carcinoma: the 3d English Edition [Secondary Publication]. *J Anus Rectum Colon*. 2019;3(4):175–95.

68. Güenaga KF, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;9:1–58.

69. Koskenvuo L, Lehtonen T, Koskensalo S, Rasilainen S, Klintrup K, Ehrlich A, et al. Mechanical and oral antibiotic bowel preparation versus no bowel preparation for elective colectomy (MOBILE): a multicentre, randomised, parallel, single-blinded trial. *Lancet* [Internet]. 2019;394(10201):840–8. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31269-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31269-3)

70. Gould MK, Garcia DA, Wren SM, Karanicolas PJ, Arcelus JI, Heit JA, et al. Prevention of VTE in Nonorthopedic Surgical Patients (ACCP GUIDELINES 9TH ED). *Chest*. 2012;141:e227S–e277S.

71. Matsuda A, Miyashita M, Matsumoto S, Matsutani T, Sakurazawa N, Takahashi G, et al. Comparison of Long-Term Outcomes of Colonic Stent as “Bridge to Surgery” and Emergency Surgery for Malignant Large-Bowel Obstruction: A Meta-Analysis. *Ann Surg Oncol*. 2015;22(2):497–504.

72. Arezzo A, Balague C, Targarona E, Borghi F, Giraudo G, Ghezzi L, et al. Colonic stenting as a bridge to surgery versus emergency surgery for malignant colonic obstruction: results of a multicentre randomised controlled trial (ESCO trial). *Surg Endosc*. 2017;31(8):3297–305.

73. Deijen CL, Vasmel JE, de Lange-de Klerk ESM, Cuesta MA, Coene PLO, Lange JF, et al. Ten-year outcomes of a randomised trial of laparoscopic versus open surgery for colon cancer. *Surg Endosc*. 2017;31(6):2607–15.

74. Kennedy RH, Francis EA, Wharton R, Blazeby JM, Quirke P, West NP, et al. Multicenter randomized controlled trial of conventional versus laparoscopic surgery for colorectal cancer within an enhanced recovery programme: EnROL. *J Clin Oncol*. 2014;32(17):1804–11.

75. Theophilus M, Platell C, Spilsbury K. Long-term survival following laparoscopic and open colectomy

for colon cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Color Dis.* 2014;16(3):75–81.

76. Simillis C, Lal N, Thoukididou SN, Kontovounisios C, Smith JJ, Hompes R, et al. Open Versus Laparoscopic Versus Robotic Versus Transanal Mesorectal Excision for Rectal Cancer: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *Ann Surg.* 2019;270(1):59–68.

77. Yoshii S, Nojima M, Noshio K, Omori S, Kusumi T, Okuda H, et al. Factors associated with risk for colorectal cancer recurrence after endoscopic resection of T1 tumors. *Clin Gastroenterol Hepatol* [Internet]. 2014;12(2):292-302.e3. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2013.08.008>

78. Kouyama Y, Kudo S ei, Miyachi H, Ichimasa K, Matsudaira S, Misawa M, et al. Risk factors of recurrence in T1 colorectal cancers treated by endoscopic resection alone or surgical resection with lymph node dissection. *Int J Colorectal Dis.* 2018;33(8):1029–38.

79. De Ceglie A, Hassan C, Mangiavillano B, Matsuda T, Saito Y, Ridola L, et al. Endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection for colorectal lesions: A systematic review. *Crit Rev Oncol Hematol* [Internet]. 2016;104:138–55. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2016.06.008>

80. Kotake K, Mizuguchi T, Moritani K, Wada O, Ozawa H, Oki I, et al. Impact of D3 lymph node dissection on survival for patients with T3 and T4 colon cancer. *Int J Colorectal Dis.* 2014;29(7):847–52.

81. Kontovounisios C, Kinross J, Tan E, Brown G, Rasheed S, Tekkis P. Complete mesocolic excision in colorectal cancer: A systematic review. *Color Dis.* 2015;17(1):7–16.

82. Athanasiou CD, Markides GA, Kotb A, Jia X, Gonsalves S, Miskovic D. Open compared with laparoscopic complete mesocolic excision with central lymphadenectomy for colon cancer: a systematic review and meta-analysis. *Color Dis.* 2016;18(7):O224–35.

83. Delibegovic S. Introduction to Total Mesorectal Excision. *Med Arch (Sarajevo, Bosnia Herzegovina).* 2017;71(6):434–8.

84. Kidane B, Chadi SA, Kanters S, Colquhoun PH, Ott MC. Local resection compared with radical resection in the treatment of T1N0M0 rectal adenocarcinoma: A systematic review and meta-analysis. *Dis Colon Rectum.* 2015;58(1):122–40.

85. Vennix S, Pelzers L, Bouvy N, Gl B, Jp P, Wiggers T, et al. Laparoscopic versus open total mesorectal excision for rectal cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;(4).

86. Lei PR, Ruan Y, Yang X, Fang J, Chen T. Trans-anal or trans-abdominal total mesorectal excision? A systematic review and meta-analysis of recent comparative studies on perioperative outcomes and pathological result. *Int J Surg* [Internet]. 2018;60:113–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.11.003>

87. Sajid MS, Farag S, Leung P, Sains P, Miles WFA, Baig MK. Systematic review and meta-analysis of published trials comparing the effectiveness of transanal endoscopic microsurgery and radical resection in the management of early rectal cancer. *Color Dis.* 2014;16(1):2–14.

88. Farag S, Rehman S, Sains P, Baig M, Sajid M. Early versus delayed closure of loop defunctioning ileostomy in patients undergoing distal colorectal resections: an integrated systematic review and meta-analysis of published randomized, controlled trials. *Color Dis.* 2017;19(12):1050–7.

89. André T, Boni C, Navarro M, Tabernero J, Hickish T, Topham C, et al. Improved overall survival with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment in stage II or III colon cancer in the MOSAIC trial. *J Clin Oncol.* 2009;27(19):3109–16.

90. André T, De Gramont A, Vernerey D, Chibaudel B, Bonnetain F, Tijeras-Raballand A, et al. Adjuvant fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin in stage II to III colon cancer: Updated 10-year survival and outcomes according to BRAF mutation and mismatch repair status of the MOSAIC study. *J Clin Oncol.* 2015;33(35):4176–87.

91. Haller DG, Tabernero J, Maroun J, De Braud F, Price T, Van Cutsem E, et al. Capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil and folinic acid as adjuvant therapy for stage III colon cancer. *J Clin Oncol.* 2011;29(11):1465–71.

92. Biagi JJ, Raphael MJ, Mackillop WJ, Kong W, King WD, Booth CM. Association between time to initiation of adjuvant chemotherapy and survival in colorectal cancer a systematic review and meta-analysis. *JAMA - J Am Med Assoc.* 2011;305(22):2335–42.

93. Grothey A, Sobrero AF, Shields AF, Yoshino T,

- Paul J, Taieb J, et al. Duration of Adjuvant Chemotherapy for Stage III Colon Cancer. *N Engl J Med*. 2018;378(13):1177–88.
94. Madoff RD. Chemoradiotherapy for Rectal Cancer — When, Why, and How? *N Engl J Med*. 2004;351(17):1790–2.
95. McCarthy K, Pearson K, Fulton R, Hewitt J. Pre-operative chemoradiation for non-metastatic locally advanced rectal cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(12).
96. Rahbari NN, Elbers H, Askoxyllakis V, Motschall E, Bork U, Bü Chler MW, et al. Neoadjuvant radiotherapy for rectal cancer: Meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Surg Oncol*. 2013;20(13):4169–82.
97. De Caluwé L, Van Nieuwenhove Y, Ceelen WP. Preoperative chemoradiation versus radiation alone for stage II and III resectable rectal cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2013(2).
98. Sauer R, Liersch T, Merkel S, Fietkau R, Hohenberger W, Hess C, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: Results of the German CAO/ARO/AIO-94 randomized phase III trial after a median follow-up of 11 years. *J Clin Oncol*. 2012;30(16):1926–33.
99. Gérard JP, Conroy T, Bonnetain F, Bouché O, Chapet O, Closon-Dejardin MT, et al. Preoperative radiotherapy with or without concurrent fluorouracil and leucovorin in T3-4 rectal cancers: Results of FFCD 9203. *J Clin Oncol*. 2006;24(28):4620–5.
100. Hofheinz RD, Wenz F, Post S, Matzdorff A, Laechelt S, Hartmann JT, et al. Chemoradiotherapy with capecitabine versus fluorouracil for locally advanced rectal cancer: A randomised, multicentre, non-inferiority, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2012;13(6):579–88.
101. Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Beart RW, Wozniak TF, Pitot HC, et al. Neoadjuvant 5-FU or capecitabine plus radiation with or without oxaliplatin in rectal cancer patients: A phase III randomized clinical trial. *J Natl Cancer Inst*. 2015;107(11):2–9.
102. Carvalho C, Glynne-Jones R. Challenges behind proving efficacy of adjuvant chemotherapy after preoperative chemoradiation for rectal cancer. *Lancet Oncol* [Internet]. 2017;18(6):e354–63. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045\(17\)30346-7](http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30346-7)
103. Petersen SH, Harling H, Kirkeby LT, Wille-Jørgensen P, Mocellin S. Postoperative adjuvant chemotherapy in rectal cancer operated for cure. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(3).
104. Bujko K, Glimelius B, Valentini V, Michalski W, Spalek M. Postoperative chemotherapy in patients with rectal cancer receiving preoperative radio(chemo)therapy: A meta-analysis of randomized trials comparing surgery ± a fluoropyrimidine and surgery + a fluoropyrimidine ± oxaliplatin. *Eur J Surg Oncol*. 2015;41(6):713–23.
105. Breugom AJ, Swets M, Bosset JF, Collette L, Sainato A, Cionini L, et al. Adjuvant chemotherapy after preoperative (chemo)radiotherapy and surgery for patients with rectal cancer: A systematic review and meta-analysis of individual patient data. *Lancet Oncol*. 2015;16(2):200–7.
106. Petrelli F, Coinu A, Lonati V, Barni S. A systematic review and meta-analysis of adjuvant chemotherapy after neoadjuvant treatment and surgery for rectal cancer. *Int J Colorectal Dis*. 2015;30(4):447–57.
107. Cercek A, Goodman KA, Hajj C, Weisberger E, Segal NH, Reidy-Lagunes DL, et al. Neoadjuvant chemotherapy first, followed by chemoradiation and then surgery, in the management of locally advanced rectal cancer. *JNCCN J Natl Compr Cancer Netw*. 2014;12(4):513–9.
108. Bujko K, Partycki M, Pietrzak L. Neoadjuvant Radiotherapy (5 x 5 Gy): Immediate Versus Delayed Surgery. *Recent Results Cancer Res*. 2014;203:171–87.
109. Hospers G, Bahadoer RR, Dijkstra EA, van Etten B, Marijnen C, Putter H. Short-course radiotherapy followed by neo-adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer - the RAPIDO trial. *J Clin Oncol*. 2020;38((suppl; abstr 4006)).
110. van der Valk M, van Etten B, Marijnen C, Dijkstra E, Hilling D, Klein Kranenbarg EM-, et al. Compliance, acute toxicity and postoperative complications of short-course radiotherapy followed by chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer. results of the randomized RAPIDO-trial. *Eur J Surg Oncol*. 2020;46(2):e20.
111. Kanas GP, Taylor A, Primrose JN, Langeberg WJ, Kelsh MA, Mowat FS, et al. Survival after liver resection in metastatic colorectal cancer: Review and meta-analysis of prognostic factors. *Clin Epidemiol*.

2012;4(1):283–301.

112. Gonzalez M, Poncet A, Combescure C, Robert J, Ris HB, Gervaz P. Risk factors for survival after lung metastasectomy in colorectal cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *Ann Surg Oncol*. 2013;20(2):572–9.

113. Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, van Slooten GW, van Tinteren H, Boot H, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. *J Clin Oncol*. 2003;21(20):3737–43.

114. Verwaal VJ, Bruin S, Boot H, Van Slooten G, Van Tinteren H. 8-Year follow-up of randomized trial: Cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic chemotherapy in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. *Ann Surg Oncol*. 2008;15(9):2426–32.

115. Yan TD, Black D, Savady R, Sugarbaker PH. Systematic review on the efficacy of cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from colorectal carcinoma. *J Clin Oncol*. 2006;24(24):4011–9.

116. Sugarbaker PH, Ryan DP. Cytoreductive surgery plus hyperthermic perioperative chemotherapy to treat peritoneal metastases from colorectal cancer: Standard of care or an experimental approach? *Lancet Oncol* [Internet]. 2012;13(8):e362–9. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045\(12\)70210-3](http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(12)70210-3)

117. Van Oudheusden TR, Nienhuijs SW, Luyer MD, Nieuwenhuijzen GA, Lemmens VE, Rutten HJ, et al. Incidence and treatment of recurrent disease after cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy for peritoneally metastasized colorectal cancer: A systematic review. *Eur J Surg Oncol* [Internet]. 2015;41(10):1269–77. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejso.2015.05.018>

118. Brandi G, De Lorenzo S, Nannini M, Curti S, Ottone M, Dall'Olio FG, et al. Adjuvant chemotherapy for resected colorectal cancer metastases: Literature review and meta-analysis. *World J Gastroenterol*. 2016;22(2):519–33.

119. Tournigand C, André T, Achille E, Lledo G, Flesh M, Mery-Mignard D, et al. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: A randomized GERCOR study. *J Clin Oncol*.

2004;22(2):229–37.

120. Koopman M, Antonini NF, Douma J, Wals J, Honkoop AH, Erdkamp FL, et al. Sequential versus combination chemotherapy with capecitabine, irinotecan, and oxaliplatin in advanced colorectal cancer (CAIRO): a phase III randomised controlled trial. *Lancet*. 2007;370(9582):135–42.

121. Cassidy J, Clarke S, Díaz-Rubio E, Scheithauer W, Figer A, Wong R, et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol*. 2008;26(12):2006–12.

122. Allegra CJ, Rumble RB, Hamilton SR, Mangu PB, Roach N, Hantel A, et al. Extended RAS gene mutation testing in metastatic colorectal carcinoma to predict response to anti-epidermal growth factor receptor monoclonal antibody therapy: American society of clinical oncology provisional clinical opinion update 2015. *J Clin Oncol*. 2016;34(2):179–85.

123. Sepulveda AR, Hamilton SR, Allegra CJ, Grody W, Cushman-Vokoun AM, Funkhouser WK, et al. Molecular Biomarkers for the Evaluation of Colorectal Cancer: Guideline From the American Society for Clinical Pathology, College of American Pathologists, Association for Molecular Pathology, and American Society of Clinical Oncology. *J Mol Diagnostics* [Internet]. 2017;19(2):187–225. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2016.11.001>

124. Kirstein MM, Lange A, Prenzler A, Manns MP, Kubicka S, Vogel A. Targeted Therapies in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Assessment of Currently Available Data. *Oncologist*. 2014;19(11):1156–68.

125. Pietrantonio F, Cremolini C, Petrelli F, Di Bartolomeo M, Loupakakis F, Maggi C, et al. First-line anti-EGFR monoclonal antibodies in panRAS wild-type metastatic colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. *Crit Rev Oncol Hematol* [Internet]. 2015;96(1):156–66. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2015.05.016>

126. Botrel TEA, Clark LG de O, Paladini L, Clark OAC. Efficacy and safety of bevacizumab plus chemotherapy compared to chemotherapy alone in previously untreated advanced or metastatic colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. *BMC Cancer* [Internet]. 2016;16(1):1–19. Available from: <http://dx.doi.org/10.1186/s12957-016-0911-1>

org/10.1186/s12885-016-2734-y

127. Seo SI, Lim SB, Yoon YS, Kim CW, Yu CS, Kim TW, et al. Comparison of recurrence patterns between ≤5 years and >5 years after curative operations in colorectal cancer patients. *J Surg Oncol*. 2013;108(1):9–13.

128. Pita-Fernández S, Alhayek-Aí M, González-Martín C, López-Calviño B, Seoane-Pillado T, Pérttega-Díaz S. Intensive follow-up strategies improve outcomes in nonmetastatic colorectal cancer patients after curative surgery: A systematic review and meta-analysis. *Ann Oncol*. 2015;26(4):644–56.

129. Duineveld LAM, van Asselt KM, Bemelman WA, Smits AB, Tanis PJ, van Weert HCPM, et al. Symptomatic and asymptomatic colon cancer recurrence: A multicenter cohort study. *Ann Fam Med*. 2016;14(3):215–20.

130. Lepage C, Phelip JM, Cany L, Faroux R, Manfredi S, Ain JF, et al. Effect of 5 years of imaging and CEA follow-up to detect recurrence of colorectal cancer: The FFCD PRODIGE 13 randomised phase III trial. *Dig Liver Dis*. 2015;47(7):529–31.

131. Nicholson BD, Shinkins B, Pathiraja I, Roberts NW, James TJ, Mallett S, et al. Blood CEA levels for detecting recurrent colorectal cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;2014(6).

132. Kahi CJ, Boland CR, Dominitz JA, Giardiello FM, Johnson DA, Kaltenbach T, et al. Colonoscopy Surveillance after Colorectal Cancer Resection: Recommendations of the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. *Gastroenterology*. 2016;150(3):758–768.e11.

133. Patel K, Hadar N, Lee J, Siegel BA, Hillner BE, Lau J. The lack of evidence for PET or PET/CT surveillance of patients with treated lymphoma, colorectal cancer, and head and neck cancer: A systematic review. *J Nucl Med*. 2013;54(9):1518–27.

134. Lu YY, Chen JH, Chien CR, Chen WTL, Tsai SC, Lin WY, et al. Use of FDG-PET or PET/CT to detect recurrent colorectal cancer in patients with elevated CEA: A systematic review and meta-analysis. *Int J Colorectal Dis*. 2013;28(8):1039–47.

135. Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Globler G, Beale EA, Kudelka AP. SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer. *Oncologist*. 2000;5(4):302–11.

136. Dean A, Willis S. The use of protocol in breaking bad news: evidence and ethos. *Int J Palliat Nurs*. 2016;22(6):265–71.

137. O'Brien MA, Whelan TJ, Vilhsis-Keever M, Gafni A, Charles C, Roberts R, et al. Are cancer-related decision aids effective? a Systematic review and meta-analysis. *J Clin Oncol*. 2009;27(6):974–85.

138. El-Jawahri A, Traeger L, Park ER, Greer JA, Pirl WF, Lennes IT, et al. Associations among prognostic understanding, quality of life, and mood in patients with advanced cancer. *Cancer*. 2014;120(2):278–85.

139. Rodin G, MacKay JA, Zimmermann C, Mayer C, Howell D, Katz M, et al. Clinician-patient communication: A systematic review. *Support Care Cancer*. 2009;17(6):627–44.

140. NCCN. NCCN Guidelines. Palliative Care [Internet]. Vol. Version 1. National Comprehensive Cancer Network; 2020. Available from: <http://www.ninr.nih.gov/sites/www.ninr.nih.gov/files/palliative-care-brochure.pdf>

141. Hui D, Mori M, Watanabe SM, Caraceni A, Strasser F, Saarto T, et al. Referral criteria for outpatient specialty palliative cancer care: an international consensus. *Lancet Oncol* [Internet]. 2016;17(12):e552–9. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045\(16\)30577-0](http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30577-0)

142. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X, Espauella J, Espinosa J, Pascual J FMP. Proyecto NECPAL CCOMS-ICO©: Identificación y Atención Integral-Integrada de Personas con Enfermedades Crónicas Avanzadas en Servicios de Salud y Sociales. [Internet]. Institut Català d'Oncologia; 2012. p. 1–44. Available from: <http://www.iconcologia.net>

143. Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X, et al. Utility of the NECPAL CCOMS-ICO© tool and the Surprise Question as screening tools for early palliative care and to predict mortality in patients with advanced chronic conditions: A cohort study. *Palliat Med*. 2017;31(8):754–63.

144. Tripodoro VA, Llanos V, DE LELLIS S, Salazar Güemes C, DE SIMONE GG, Gómez-Batiste X. Prognostic factors in cancer patients with palliative needs identified by the necpal CCOMS-ICO© tool. *Medicina (B Aires)*. 2019;79(2):95–103.

145. Calsina-Berna A, Martínez-Muñoz M, Bardés Robles I, Beas Alba E, Madariaga Sánchez R, Alentorn XGB. Intrahospital Mortality and Survival of Patients with Advanced Chronic Illnesses in a Tertiary Hospital Identified with the NECPAL CCOMS-ICO© Tool. *J Palliat Med*. 2018;21(5):665–73.
146. Haun MW, Estel S, Rücker G, Friederich HC, Vilalobos M, Thomas M, et al. Early palliative care for adults with advanced cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(6).
147. Ayaz-Alkaya S. Overview of psychosocial problems in individuals with stoma: A review of literature. *Int Wound J*. 2019;16(1):243–9.
148. Silva NM, Santos MA Dos, Rosado SR, Galvão CM, Sonobe HM. Psychological aspects of patients with intestinal stoma: integrative review. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2017;25:e2950.
149. Sun V, Bojorquez O, Grant M, Wendel CS, Weinstein R, Krouse RS. Cancer survivors' challenges with ostomy appliances and self-management: a qualitative analysis. *Support Care Cancer*. 2020;28(4):1551–4.
150. Kanters AE, Morris AM, Abrahamse PH, Mody L, Suwanabol PA. The effect of peer support on colorectal cancer patients' adherence to guideline-concordant multidisciplinary care. *Dis Colon Rectum*. 2018;61(7):817–23.
151. Folguera-Arnau M, Gutiérrez-Vilaplana JM, González-María E, Moreno-Casbas MT, Obarrio-Fernández S, Lorente-Granados G, et al. Implementation of best practice guidelines for ostomy care and management: Care outcomes. *Enfermería Clínica* (English Ed). 2020;30(3):176–84.
152. Faury S, Koleck M, Foucaud J, M'Bailara K, Quintard B. Patient education interventions for colorectal cancer patients with stoma: A systematic review. *Patient Educ Couns* [Internet]. 2017;100(10):1807–19. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.034>
153. Preston NJ, Hurlow A, Brine J, Bennett MI. Blood transfusions for anaemia in patients with advanced cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(2).
154. Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica para la atención de pacientes en Cuidado Paliativo (adopción). 2016. p. 1–412.
155. Raijmakers NJH, van Zuylen L, Costantini M, Caraceni A, Clark J, Lundquist G, et al. Artificial nutrition and hydration in the last week of life in cancer patients. A systematic literature review of practices and effects. *Ann Oncol* [Internet]. 2011;22(7):1478–86. Available from: <https://doi.org/10.1093/annonc/mdq620>
156. Yamaguchi T, Morita T, Shinjo T, Inoue S, Takigawa C, Aruga E, et al. Effect of parenteral hydration therapy based on the Japanese national clinical guideline on quality of life, discomfort, and symptom intensity in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage* [Internet]. 2012;43(6):1001–12. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.06.028>
157. Bruera E, Hui D, Dalal S, Torres-Vigil I, Trumble J, Roosth J, et al. Parenteral hydration in patients with advanced cancer: A multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. *J Clin Oncol*. 2013;31(1):111–8.
158. Good P, Richard R, Syrmiss W, Jenkins-Marsh S, Stephens J. Medically assisted hydration for adult palliative care patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;2014(4).
159. Raijmakers NJH, Fradsham S, Van Zuylen L, Mayland C, Ellershaw JE, Van Der Heide A. Variation in attitudes towards artificial hydration at the end of life: A systematic literature review. *Curr Opin Support Palliat Care*. 2011;5(3):265–72.
160. Maltoni M, Scarpi E, Rosati M, Derni S, Fabbri L, Martini F, et al. Palliative sedation in end-of-life care and survival: A systematic review. *J Clin Oncol*. 2012;30(12):1378–83.
161. Beller EM, van Driel ML, McGregor L, Truong S, Mitchell G. Palliative pharmacological sedation for terminally ill adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2017(6).
162. Ciancio AL, Mirza RM, Ciancio AA, Klinger CA. The Use of Palliative Sedation to Treat Existential Suffering: A Scoping Review on Practices, Ethical Considerations, and Guidelines. *J Palliat Care*. 2020;35(1):13–20.
163. Congreso de Colombia. LEY 1733 DE 2014. LEY CONSUELO DAVIS SAAVEDRA, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónica, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. [Internet]. Bogotá DC; 2014 [cited 2020 Oct 22]. Available from: http://wsp.presidencia.gov.co/normas/leyes/leyes_detalle.aspx?id=1733

- gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY 1733 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014.pdf
164. Sykes N, Thorns A. The use of opioids and sedatives at the end of life. *Lancet Oncol*. 2003;4(5):312–8.
 165. Fearon K, Strasser F, Anker SD, Bosaeus I, Bruera E, Fainsinger RL, et al. Definition and classification of cancer cachexia: An international consensus. *Lancet Oncol* [Internet]. 2011;12(5):489–95. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045\(10\)70218-7](http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(10)70218-7)
 166. Miller S, McNutt L, McCann MA, McCorry N. Use of corticosteroids for anorexia in palliative medicine: A systematic review. *J Palliat Med*. 2014;17(4):482–5.
 167. Ruiz García V, López-Briz E, Carbonell Sanchis R, González Perales JL, Bort-Martí S. Megestrol acetate for treatment of anorexia-cachexia syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2017(7).
 168. Ruiz-García V, López-Briz E, Carbonell-Sanchis R, Bort-Martí S, González-Perales JL. Megestrol acetate for cachexia–anorexia syndrome. A systematic review. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2018;9(3):444–52.
 169. Strasser F, Luftner D, Possinger K, Ernst G, Rühstaller T, Meissner W, et al. Comparison of orally administered cannabis extract and delta-9- tetrahydrocannabinol in treating patients with cancer-related anorexia-cachexia syndrome: A multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial from the Cannab. *J Clin Oncol*. 2006;24(21):3394–400.
 170. Bar-Sela G, Zalman D, Semenysty V, Ballan E. The Effects of Dosage-Controlled Cannabis Capsules on Cancer-Related Cachexia and Anorexia Syndrome in Advanced Cancer Patients: Pilot Study. *Integr Cancer Ther*. 2019;18.
 171. OMS. Alivio del dolor en el cáncer. Con una guía sobre la disponibilidad de opioides [Internet]. Organización Mundial de la Salud. Ginebra; 1996. p. 1–70. Available from: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41854/1/9243544829.pdf>
 172. Azevedo Sao Leao Ferreira K, Kimura M, Jacobsen Teixeira M. The WHO analgesic ladder for cancer pain control, twenty years of use. How much pain relief does one get from using it? *Support Care Cancer*. 2006;14(11):1086–93.
 173. Schüchen RH, Mücke M, Marinova M, Kravchenko D, Häuser W, Radbruch L, et al. Systematic review and meta-analysis on non-opioid analgesics in palliative medicine. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2018;9(7):1235–54.
 174. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, Mcnicol ED, Bell RF, Carr DB, et al. Oral paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(7).
 175. Derry S, Pj W, Ra M, Ed M, Rf B, Db C, et al. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults (Review). *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;7.
 176. Schmidt-Hansen M, Bromham N, Taubert M, Arnold S. Buprenorphine for treating cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2013(12).
 177. Schremmer C, Derry S, Jackson KC, Wiffen PJ, Bell RF, Strassels S, et al. Codeine, alone and with paracetamol (acetaminophen), for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2013(5).
 178. Skorga P, Young CF, Fowler SB. Transdermal fentanyl for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;10:1–37.
 179. Bao YJ, Hou W, Kong XY, Yang L, Xia J, Hua BJ, et al. Hydromorphone for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;2016(10).
 180. Nicholson AB, Watson GR, Derry S, Wiffen PJ. Methadone for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(2).
 181. Wiffen PJ, Wee B, Moore RA. Oral morphine for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;2016(4).
 182. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS. Oxycodone for cancer-related pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(8).
 183. Wiffen PJ, Derry S, Naessens K, Bell RF. Oral tapentadol for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(1).
 184. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA. Tramadol with or without paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(5).
 185. Mishra S, Bhatnagar S, Goyal GN, Rana SPS, Upadhyay SP. A Comparative Efficacy of Amitriptyline, Gabapentin, and Pregabalin in Neuropathic Cancer Pain: A Prospective Randomized Double-Blind

- Placebo-Controlled Study. *Am J Hosp Palliat Med*. 2012;29(3):177–82.
186. Jongen JLM, Huijsman ML, Jessurun J, Ogenio K, Schipper D, Verkouteren DRC, et al. The evidence for pharmacologic treatment of neuropathic cancer pain: Beneficial and adverse effects. *J Pain Symptom Manage* [Internet]. 2013;46(4):581–590.e1. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.10.230>
187. NCCN. Adult Cancer Pain Guidelines version 1.2020. National Comprehensive Cancer Network; 2020.
188. Sindt JE, Brogan SE. Interventional Treatments of Cancer Pain. *Anesthesiol Clin* [Internet]. 2016;34(2):317–39. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.anclin.2016.01.004>
189. Kurita GP, Sjøgren P, Klepstad P, Mercadante S. Interventional techniques to management of cancer-related pain: Clinical and critical aspects. *Cancers* (Basel). 2019;11(4):1–12.
190. Bhaskar A. Interventional pain management in patients with cancer-related pain. *Postgrad Med* [Internet]. 2020;00(00):1–4. Available from: <https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1807796>
191. Silverman JE, Gulati A. An overview of interventional strategies for the management of oncologic pain. *Pain Manag*. 2018;8(5):389–403.
192. Vayne-Bossert P, Afsharimani B, Good P, Gray P, Hardy J. Interventional options for the management of refractory cancer pain—what is the evidence? *Support Care Cancer*. 2016;24(3):1429–38.
193. Wickham RJ. Managing constipation in adults with cancer. *J Adv Pr Oncol*. 2017;8:149–61.
194. Candy B, Jones L, Larkin PJ, Vickerstaff V, Tookman A, Stone P. Laxatives for the management of constipation in people receiving palliative care. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2015(5).
195. Cherny NI. Evaluation and Management of Treatment-Related Diarrhea in Patients with Advanced Cancer: A Review. *J Pain Symptom Manage*. 2008;36(4):413–23.
196. Ben-Aharon I, Gafter-Gvili A, Leibovici L, Stemmer SM. Interventions for alleviating cancer-related dyspnea: A systematic review and meta-analysis. *Acta Oncol* (Madr). 2012;51(8):996–1008.
197. Luckett T, Phillips J, Johnson MJ, Farquhar M, Swan F, Assen T, et al. Contributions of a hand-held fan to self-management of chronic breathlessness. *Eur Respir J* [Internet]. 2017;50(2):1–10. Available from: <http://dx.doi.org/10.1183/13993003.00262-2017>
198. Hodge C, Badgwell BD. Palliation of malignant ascites. *J Surg Oncol*. 2019;120(1):67–73.
199. NICE. PleurX Peritoneal Catheter Drainage System for Vacuum-Assisted Drainage of Treatment-Resistant, Recurrent Malignant Ascites [Internet]. London: NICE; 2012. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/mtg9/resources/pleurx-peritoneal-catheter-drainage-system-for-vacuumassisted-drainage-of-treatmentresistant-recurrent-malignant-ascites-pdf-1788120827845>
200. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective [Internet]. Continuous Update Project Expert Report 2018. 2018. p. 1–53. Available from: <https://www.wcrf.org/sites/default/files/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.pdf>
201. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Judging the evidence. Available at dietandcancerreport.org.
202. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Diet, nutrition, physical activity and colorectal cancer. Available at dietandcancerreport.org.
203. Munro A, Brown M, Niblock P, Steele R, Carey F. Do Multidisciplinary Team (MDT) processes influence survival in patients with colorectal cancer? A population-based experience. *BMC Cancer*. 2015;15(1):1–9.
204. Amir Z, Scully J, Borrill C. The professional role of breast cancer nurses in multi-disciplinary breast cancer care teams. *Eur J Oncol Nurs*. 2004;8(4):306–14.
205. Pavlish C, Ceronsky L. Oncology nurses' perceptions of nursing roles and professional attributes in palliative care. *Clin J Oncol Nurs*. 2009;13(4):404–12.
206. Crane-Okada R. Evaluation and outcome measures in patient navigation. *Semin Oncol Nurs*. 2013;29(2):128–40.

207. Moreno-Castro A, Carrillo-González G-M. El enfermero navegador: un rol innovador en oncología. Revisión de alcance. Arch Med. 2021;21(1):en prensa.
208. Fillion L, Cook S, Veillette AM, Aubin M, De Serres M, Rainville F, et al. Professional navigation framework: Elaboration and validation in a Canadian context. Oncol Nurs Forum. 2012;39(1).
209. Espinoza MA. Evaluación Económica para la toma de decisiones sobre cobertura en salud: ¿qué debe saber el profesional de la salud? Rev Chil Cardiol. 2017;36(2):144–53.
210. García-Altés A, Navas E, Soriano MJ. Evaluación económica de intervenciones de salud pública. Gac Sanit. 2011;25(SUPPL. 1):25–31.
211. Mejía Mejía A, Viscaya MM. Evaluación económica para la toma de decisiones en salud en Colombia. Monit estratégico. 2014;5(5):70–5.
212. Pisu M, Henrikson NB, Banegas MP, Yabroff KR. Costs of cancer along the care continuum: What we can expect based on recent literature. Cancer. 2018;124(21):4181–91.
213. van der Meulen M, Goede SL, Kuipers EJ, Stocker J. Colorectal Cancer : Cost- effectiveness of Colonoscopy versus CT Colonography Screening with. Radiology. 2018;287(3):901–11.
214. Goldstein DA, Chen Q, Ayer T, Chan KKW, Virik K, Hammerman A, et al. Bevacizumab for Metastatic Colorectal Cancer: A Global Cost-Effectiveness Analysis. Oncologist. 2017;22(6):694–9.
215. Goldstein DA, Chen Q, Ayer T, Howard DH, Lipscomb J, El-Rayes BF, et al. First- and second-line bevacizumab in addition to chemotherapy for metastatic colorectal cancer: A United States-based cost-effectiveness analysis. J Clin Oncol. 2015;33(10):1112–8.
216. Porter M. Perspective - What Is Value in Health Care? NEJM. 2010;363(26):2477–81.
217. Hamilton TD, MacNeill AJ, Lim H, Hunink MGM. Cost-Effectiveness Analysis of Cytoreductive Surgery and HIPEC Compared With Systemic Chemotherapy in Isolated Peritoneal Carcinomatosis From Metastatic Colorectal Cancer. Ann Surg Oncol. 2019;26(4):1110–7.
218. Grimshaw J, Russell I. Effect of clinical guidelines on medical practice : review of rigorous evaluations. Lancet. 1993;342:1317–22.
219. Smith TJ, Hillner BE. Ensuring quality cancer care by the use of clinical practice guidelines and critical pathways. J Clin Oncol. 2001;19(11):2886–97.
220. Pierson DJ. Translating evidence into practice. Respir Care. 2009;54(10):1386–401.
221. Heins MJ, De Jong JD, Spronk I, Ho VKY, Brink M, Korevaar JC. Adherence to cancer treatment guidelines: Influence of general and cancer-specific guideline characteristics. Eur J Public Health. 2017;27(4):616–20.
222. Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: Effective implementation of change in patients' care. Lancet. 2003;362(9391):1225–30.
223. Congreso de Colombia. LEY 1122 DE 2007. "Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" [Internet]. Bogotá DC; 2007 [cited 2020 Nov 3]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf>
224. Taylor A. Five-Step Approach to Stakeholder Engagement. Bus Soc Responsib [Internet]. 2019;41. Available from: <https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/stakeholder-engagement-five-step-approach-toolkit>
225. Porter M, Lee T. The Strategy that will fix health-care. Harv Bus Rev. 2014;(October 2013):1–19.
226. Organización Panamericana de la Salud. Cuidados innovadores para las condiciones crónicas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2013. p. 105.
227. Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Consenso basado en la evidencia: indicadores de gestión del riesgo en pacientes con cáncer gástrico y cáncer de colon y recto en Colombia. [Internet]. Costo C de A, editor. Vol. 1, Cuenta de Alto Costo. Bogotá DC; 2017. 1–86 p. Available from: www.cuenta-dealtocosto.org
228. Brouwers MC, Spithoff K, Kerkvliet K, Alonso-Coeillo P, Burgers J, Cluzeau F, et al. Development and Validation of a Tool to Assess the Quality of Clinical Practice Guideline Recommendations. JAMA Netw open. 2020;3(5):e205535.

**GUÍA DE MANEJO PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO,
SEGUIMIENTO Y PALIACIÓN DEL CÁNCER DE
COLON Y RECTO, ADAPTADA A LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA**



CALI - COLOMBIA